

Buku Ajar **KEPERAWATAN DASAR**

Tioma Naibaho • Dwi Susilowati • Prima Trisna Aji • Yohanes Zenriano Tarigan
Gita Adelia • Ria Tri H. D. Rusiawati • Vera Sesrianty

Editor : Prof. Ns. Tantut Susanto, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep. Kom., Ph



Buku Ajar : Keperawatan Dasar

Penulis:

Tioma Naibaho. S.Kep., Ns., M.Kep.

Dwi Susilowati, APPd., M.Kes.

Ns. Prima Trisna Aji, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB.

Ns. Yohanes Zenriano Tarigan, S.Kep., M.Kep.

Ns. Gita Adelia, M.Kep

Ria Tri Harini Dwi Rusiawati, S.ST., M.Pd.

Ns. Vera Sesrianty, M.Kep.

Editor :

Prof. Ns. Tantut Susanto, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep. Kom., Ph



Buku Ajar:

Keperawatan Dasar

Penulis:

Tioma Naibaho. S.Kep., Ns., M.Kep.
Dwi Susilowati, APPd., M.Kes.
Ns. Prima Trisna Aji, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB.
Ns. Yohanes Zenriano Tarigan, S.Kep., M.Kep.
Ns. Gita Adelia, M.Kep
Ria Tri Harini Dwi Rusiawati, S.ST., M.Pd.
Ns. Vera Sesrianty, M.Kep.

Editor : Prof. Ns. Tantut Susanto, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep. Kom., Ph

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7756-90-9

Cetakan Pertama: September, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI



Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar berjudul “Keperawatan Dasar” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ajar ini disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami konsep dasar, prinsip, nilai profesional, serta keterampilan berpikir yang diperlukan dalam praktik keperawatan.

Keperawatan dasar merupakan fondasi penting dalam pembentukan kompetensi calon perawat. Melalui pemahaman terhadap konsep sehat-sakit, kebutuhan dasar manusia, proses keperawatan, komunikasi terapeutik, etika, hukum, keselamatan pasien, serta pencegahan dan pengendalian infeksi, mahasiswa diharapkan mampu membangun pola pikir profesional dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, bermutu, humanis, dan berpusat pada kebutuhan klien.

Buku ajar ini disusun secara sistematis ke dalam tujuh bab. Bab 1 membahas pengantar keperawatan dasar dan profesionalisme perawat sebagai landasan dalam memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab perawat. Bab 2 menguraikan konsep sehat-sakit, homeostasis, dan kebutuhan dasar manusia yang menjadi dasar dalam mengenali respons klien terhadap masalah kesehatan. Bab 3 membahas proses keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi sebagai kerangka kerja ilmiah dalam pemberian asuhan keperawatan.

Selanjutnya, Bab 4 membahas berpikir kritis, *clinical reasoning*, dan pengambilan keputusan keperawatan yang diperlukan dalam menganalisis masalah klien secara tepat. Bab 5 menguraikan komunikasi terapeutik dan hubungan perawat–klien sebagai bagian penting dalam membangun kepercayaan dan kerja sama selama proses asuhan. Bab 6 membahas etik, hukum, dan keselamatan pasien dalam praktik keperawatan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan yang bertanggung jawab dan sesuai standar profesi. Adapun Bab 7 membahas pencegahan dan pengendalian infeksi serta kewaspadaan standar sebagai upaya penting dalam menjaga keselamatan klien, perawat, dan lingkungan pelayanan kesehatan.

Penyusunan buku ajar ini diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami materi secara bertahap, tidak hanya dari aspek teori, tetapi juga dari sisi penerapan dalam praktik keperawatan. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan oleh dosen sebagai bahan pendukung dalam proses pembelajaran, diskusi, penugasan, maupun penguatan kompetensi dasar keperawatan.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya. Semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi keperawatan, serta semua pihak yang berperan dalam pengembangan pendidikan dan pelayanan keperawatan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan buku ajar ini. Semoga buku ini dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran keperawatan dan menghasilkan calon perawat yang profesional, beretika, kompeten, serta siap menghadapi kebutuhan pelayanan kesehatan di masyarakat.

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
---------------------	-----

Daftar Isi.....	v
-----------------	---

BAB 1 PENGANTAR KEPERAWATAN DASAR DAN PROFESIONALISME PERAWAT

.....	1
A. Konsep Dasar Keperawatan.....	4
B. Profesionalisme Perawat	8
C. Peran Perawat dalam Pelayanan	12
D. Komunikasi Terapeutik dalam Perilaku/Praktik Profesional	15
E. Etika dan Legal Keperawatan.....	15
F. Batas Praktik dan Patient Safety	18
G. Perilaku Profesional dalam Praktik Keperawatan	21
H. RINGKASAN	22
I. Latihan soal	25
Referensi	32

BAB 2 KONSEP SEHAT-SAKIT, HOMEOSTASIS, DAN KEBUTUHAN DASAR

MANUSIA	36
A. Teori Dasar	40
B. AKTIVITAS BELAJAR (SCAFFOLDING).....	45
C. ASESMEN (OBE – PIRAMIDA MILLER).....	49
D. PORTOFOLIO	52
E. Refleksi Patient Safety	57
F. Ringkasan.....	59
Referensi	66

BAB 3 PROSES KEPERAWATAN: PENGKAJIAN, DIAGNOSA, PERENCANAAN, IMPLEMENTASI, EVALUASI.....

.....	68
A. Proses Keperawatan.....	73
B. Komponen Proses Keperawatan.....	76
C. Diagnosa Keperawatan	92
D. Perencanaan.....	103
E. Implementasi.....	110
F. Evaluasi	114
G. Ringkasan.....	139

Referensi	142
------------------------	------------

BAB 4 BERPIKIR KRITIS, CLINICAL REASONING, DAN PENGAMBILAN

KEPUTUSAN KEPERAWATAN	148
------------------------------------	------------

A. Berpikir Kritis dalam Keperawatan	155
B. Clinical Reasoning dalam Keperawatan	162
C. Pengambilan Keputusan Keperawatan	167
D. Latihan Soal	167
E. Ringkasan.....	173

Glosarium	175
------------------------	------------

Referensi	176
------------------------	------------

BAB 5 KOMUNIKASI TERAPEUTIK DAN HUBUNGAN PERAWAT-KLIEN

A. Konsep Komunikasi Terapeutik.....	183
B. Komunikasi Terapeutik Sesuai Fase Hubungan Perawat – Klien	189
C. Empati, Batas Profesional, Dan Respons Terhadap Hambatan Komunikasi	192
D. Ringkasan.....	204

GLOSARIUM	208
------------------------	------------

Referensi	209
------------------------	------------

BAB 6 ETIKA, HUKUM DAN KESELAMATAN PASIEN DALAM PRAKTIK

KEPERAWATAN	211
--------------------------	------------

A. Pengertian Etika Keperawatan.....	214
B. Prinsip Etika Keperawatan.....	216
C. Issue Etik Legal	217
D. Hak Pasien dalam Pelayanan Dasar.....	218
E. Jenis Isu Etik-Legal dalam Pelayanan Dasar	218
F. Cara Mengidentifikasi Isu Etik-Legal	219
G. Kode Etik Keperawatan Di Indonesia.....	219
H. Penerapan Etika Dalam Praktik Keperawatan.....	220
I. Hukum Dalam Praktik Keperawatan	221
J. Dasar Hukum Penyelenggaraan Praktik Keperawatan	222
K. Keselamatan Pasien.....	223
L. Sasaran Keselamatan Pasien	224
M. Peran Perawat dalam Keselamatan Pasien	225
N. Penerapan Keselamatan Pasien dalam Praktik Keperawatan	225
O. Etika dan Penerapan Keselamatan Pasien dalam Praktik Keperawatan	226
P. RINGKASAN	248

Referensi	253
------------------------	------------

BAB 7 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI) SERTA

KEWASPADAAN STANDAR.....	256
---------------------------------	------------

A. KEWASPADAAN BERDASARKAN TRANSMISI.....	260
B. EPIDEMIOLOGI HAIs	263
C. KEWASPADAAN STANDAR.....	268
D. KEWASPADAAN TRANSMISI.....	273
E. PENGENDALIAN LINGKUNGAN.....	275
F. PENGGUNAAN ANTI MIKROBA RASIONAL PROFILAKSIS DAN TERAUPETIK...	275
G. Bundle Care HAIs	277
H. AUDIT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI PPI.....	279
I. PENEMPATAN PASIEN	280
J. Latihan soal	289
K. RANGKUMAN.....	295

GLOSARIUM.....	296
-----------------------	------------

Referensi	298
------------------------	------------

Profil Penulis.....	299
----------------------------	------------

BAB 1

PENGANTAR KEPERAWATAN DASAR DAN PROFESIONALISME PERAWAT

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar keperawatan, profesionalisme, etika–legal, dan keselamatan pasien sebagai landasan praktik.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6
CPL-2	Mampu menerapkan proses keperawatan secara sistematis (pengkajian–diagnosis–perencanaan–implementasi–evaluasi) berbasis kebutuhan dasar manusia.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-7
CPL-3	Mampu melakukan pengkajian dasar (tanda vital, nyeri, pemeriksaan fisik) serta dokumentasi yang akurat dan dapat diaudit.	CPMK-3; CPMK-7
CPL-4	Mampu melaksanakan keterampilan keperawatan dasar (oksigenasi, nutrisi, eliminasi, mobilisasi, integumen, pemberian obat) secara aman dan sesuai standar.	CPMK-4; CPMK-6
CPL-5	Mampu berkomunikasi terapeutik, memberikan edukasi kesehatan, dan melakukan discharge planning dasar yang berpusat pada pasien–keluarga.	CPMK-5; CPMK-7
CPL-6	Mampu berpikir kritis dan clinical reasoning untuk pengambilan keputusan, pencegahan risiko, serta perbaikan mutu praktik keperawatan dasar.	CPMK-2; CPMK-6; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan pengantar keperawatan dasar, profesionalisme perawat, peran, nilai, dan standar perilaku dalam pelayanan.
CPMK-2	Menjelaskan konsep sehat–sakit, homeostasis, kebutuhan dasar manusia, serta menerapkan berpikir kritis/clinical reasoning dalam pengambilan keputusan keperawatan.
CPMK-3	Melakukan proses keperawatan (pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, evaluasi) dan mendokumentasikan secara sistematis.
CPMK-4	Melaksanakan keterampilan keperawatan dasar untuk pemenuhan kebutuhan dasar (oksigenasi, nutrisi, cairan, eliminasi, istirahat–tidur, mobilisasi, integumen) sesuai standar.
CPMK-5	Menerapkan komunikasi terapeutik dan hubungan perawat–klien secara profesional untuk mendukung asuhan dan edukasi.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Menerapkan etik–hukum, patient safety, PPI, pencegahan jatuh, dan keselamatan medikasi dalam praktik keperawatan dasar.
CPMK-7	Melaksanakan edukasi kesehatan, discharge planning, dan handover SBAR, serta mengevaluasi luaran asuhan dan menyusun perbaikan rencana berbasis data.

C. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Pengantar Keperawatan Dasar dan Profesionalisme Perawat	1.1 Menjelaskan peran, nilai, dan standar profesionalisme perawat dalam pelayanan.	1.2 Mengidentifikasi perilaku profesional dan batas praktik yang aman dalam skenario dasar.	CPMK-1	CPMK-6; CPMK-7

D. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (CBT/essay terstruktur)	Persentase jawaban benar konsep profesionalisme dan akurasi respons pada skenario perilaku profesional.	10	Nilai ujian; lembar jawaban
CPMK-6	OSCE keselamatan (PPI, jatuh, 6 benar medikasi) + checklist	Persentase kepatuhan prosedur keselamatan dan ketiadaan kesalahan kritis.	15	Checklist keselamatan; log error (jika ada)
CPMK-7	Portofolio edukasi–discharge plan–SBAR	Kelengkapan edukasi (teach-back), kualitas discharge plan, dan kelengkapan SBAR (skor rubrik/checklist).	15	Materi edukasi; discharge plan; SBAR

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep profesionalisme (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Akurasi respons pada skenario perilaku profesional	Respons keliru/berisiko	Respons cukup; alasan lemah	Respons tepat; alasan logis	Respons sangat tepat; alasan kuat & konsisten standar

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan problem list & prioritas	Prioritas tidak sesuai; banyak masalah kunci terlewat	Prioritas cukup; masih ada ketidaktepatan bermakna	Prioritas tepat; masalah kunci tercakup	Prioritas sangat tepat; masalah kunci lengkap & terurut
2.2 Konsistensi alasan berbasis risiko/bukti dasar	Tanpa alasan; tidak berbasis risiko	Alasan umum; risiko belum jelas	Alasan logis; risiko jelas	Alasan sangat kuat; mengaitkan risiko, bukti dasar, dan keselamatan

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Ketepatan diagnosis/prioritas	Tidak sesuai data; prioritas keliru	Sebagian sesuai; prioritas kurang konsisten	Sesuai data; prioritas jelas	Sangat sesuai; prioritas sangat logis & tervalidasi
3.2 Kualitas tujuan SMART & evaluasi terukur	Tujuan tidak SMART; evaluasi tidak jelas	Sebagian SMART; evaluasi terbatas	SMART; evaluasi jelas	SMART sangat kuat; evaluasi komprehensif dan operasional

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan langkah keterampilan dasar (checklist)	≤60% langkah benar; ada kesalahan kritis	61–75% benar; kekurangan bermakna	76–90% benar; kesalahan minor	>90% benar; aman tanpa kesalahan bermakna
4.2 Ketepatan evaluasi respons pasien	Tidak mengevaluasi/keliru	Mengevaluasi terbatas; indikator kurang tepat	Evaluasi jelas; indikator tepat	Evaluasi sangat jelas; indikator tepat & tindak lanjut cepat

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kinerja komunikasi terapeutik (checklist)	≤60% perilaku tercapai; hubungan tidak terbina	61–75% tercapai; hubungan terbina sebagian	76–90% tercapai; hubungan efektif	>90% tercapai; empatik, adaptif, profesional

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.2 Batas profesional & respons terhadap hambatan komunikasi	Tidak menjaga batas; respons tidak tepat	Batas sebagian; respons kurang konsisten	Batas jelas; respons tepat	Batas sangat jelas; respons sangat efektif & aman

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Kepatuhan PPI & kewaspadaan standar	Banyak langkah terlewat; risiko tinggi	Langkah inti ada; kurang konsisten	Langkah tepat; konsisten	Langkah sangat tepat; konsisten tanpa pelanggaran
6.2 Kepatuhan keselamatan jatuh & 6 benar medikasi	Sering melanggar; ada kesalahan kritis	Cukup patuh; masih ada kekurangan	Patuh; tanpa kesalahan kritis	Sangat patuh; antisipatif risiko dan terdokumentasi

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan edukasi–discharge plan (teach-back)	Tidak terstruktur; pemahaman tidak terbukti	Terstruktur sebagian; bukti pemahaman terbatas	Terstruktur; bukti pemahaman memadai	Sangat terstruktur; bukti pemahaman kuat & terdokumentasi
7.2 Kelengkapan SBAR & dokumentasi terintegrasi	Informasi kritis hilang; tidak dapat diaudit	Informasi inti ada; masih kurang spesifik	Lengkap; runtut; dapat ditindaklanjuti	Sangat lengkap; ringkas; risiko terantisipasi; sangat dapat diaudit

AKTIVITAS BELAJAR (SCAFFOLDING OBE)

A. Konsep Dasar Keperawatan

1. Definisi Keperawatan

Keperawatan merupakan suatu profesi kesehatan yang memiliki landasan ilmiah, praktik berbasis bukti, serta orientasi pelayanan kepada individu, keluarga, dan komunitas secara holistik. Definisi keperawatan terus berkembang mengikuti dinamika sistem kesehatan global, kemajuan ilmu pengetahuan, serta kebutuhan masyarakat.

Menurut laporan terbaru dari International Council of Nurses (ICN), keperawatan didefinisikan sebagai profesi yang memiliki body of knowledge, regulasi, dan praktik yang berorientasi pada kepentingan manusia serta berperan dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara

global.(White, Gunn, Chiarella, Stewart, & Salmon, 2025) Definisi ini menegaskan bahwa keperawatan bukan sekadar pekerjaan teknis, melainkan suatu profesi yang memiliki tanggung jawab moral, ilmiah, dan sosial.

Secara konseptual, keperawatan juga dipahami sebagai disiplin ilmu yang mengintegrasikan berbagai bidang, seperti biologi, psikologi, sosial, dan humaniora, untuk memberikan asuhan yang komprehensif. Praktik keperawatan modern menekankan pendekatan evidence-based practice (EBP), di mana setiap intervensi didasarkan pada hasil penelitian ilmiah yang valid.(Gasper et al., 2025)

Selain itu, perkembangan literatur terbaru menunjukkan bahwa keperawatan tidak hanya berfokus pada individu yang sakit, tetapi juga mencakup:

- Promosi kesehatan
- Pencegahan penyakit
- Rehabilitasi
- Perawatan paliatif

Pendekatan ini menempatkan perawat sebagai aktor utama dalam sistem kesehatan yang berkelanjutan dan berpusat pada pasien.

2. Karakteristik Keperawatan sebagai Profesi

Sebagai suatu profesi, keperawatan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari pekerjaan lain. Karakteristik tersebut meliputi:

Keperawatan diakui sebagai profesi karena memiliki seperangkat karakteristik yang membedakannya dari pekerjaan teknis atau vokasional. Karakteristik ini mencerminkan tingkat otonomi, tanggung jawab, serta landasan ilmiah yang kuat dalam praktik keperawatan. Dalam konteks modern, profesionalisme keperawatan tidak hanya ditentukan oleh keterampilan klinis, tetapi juga oleh integrasi antara pengetahuan, nilai, dan perilaku profesional dalam praktik sehari-hari (Žiaková et al., 2024).

Secara umum, suatu profesi ditandai oleh adanya pendidikan formal, standar praktik, kode etik, serta komitmen terhadap pelayanan publik. Keperawatan memenuhi seluruh kriteria tersebut dan terus berkembang sebagai profesi berbasis ilmu pengetahuan dan evidence-based practice (Swift et al., 2025).

Berikut merupakan karakteristik utama keperawatan sebagai profesi:

a. *Body of Knowledge* (Landasan Ilmiah Keperawatan)

Keperawatan memiliki dasar ilmu yang sistematis dan terus berkembang melalui penelitian. Hal ini menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan klinis berbasis bukti.

Keperawatan memiliki *body of knowledge* yang khas dan terus berkembang melalui penelitian ilmiah. Pengetahuan ini mencakup konsep dasar keperawatan, ilmu biomedis, ilmu perilaku, serta ilmu sosial yang terintegrasi dalam praktik asuhan keperawatan.

Perkembangan ilmu keperawatan saat ini sangat dipengaruhi oleh pendekatan **evidence-based practice (EBP)**, yaitu penggunaan bukti ilmiah terbaik dalam pengambilan keputusan klinis. Hal ini memastikan bahwa intervensi keperawatan yang diberikan bersifat efektif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pasien (Rosa et al., 2021).

Selain itu, perkembangan penelitian keperawatan juga memperkuat identitas profesi, karena menghasilkan teori dan model praktik yang menjadi dasar dalam pelayanan keperawatan secara global.

b. Pelayanan Berbasis Nilai (*Value-Based Care*)

Pelayanan keperawatan berorientasi pada nilai kemanusiaan, seperti empati, caring, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Keperawatan merupakan profesi yang sangat kental dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pelayanan yang diberikan tidak hanya berfokus pada penyembuhan penyakit, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan emosional, sosial, dan spiritual pasien.

Konsep *value-based care* dalam keperawatan menekankan bahwa kualitas pelayanan diukur dari:

- Kepuasan pasien
- Kualitas hidup
- Keamanan pasien
- Outcome klinis

Nilai-nilai seperti empati, caring, dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi inti dalam praktik keperawatan. Hal ini sejalan dengan definisi keperawatan global yang menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan (ICN, 2025).

c. Otonomi Profesional (*Professional Autonomy*)

Perawat memiliki kewenangan dalam praktik sesuai dengan kompetensi dan regulasi yang berlaku.

Salah satu ciri utama profesi adalah adanya otonomi dalam praktik. Perawat memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan klinis dalam lingkup praktiknya berdasarkan kompetensi dan standar yang berlaku.

Otonomi profesional ini mencakup:

- Pengambilan keputusan keperawatan
- Penetapan diagnosis keperawatan

- Perencanaan dan evaluasi asuhan

Namun, otonomi ini tetap berada dalam kerangka kolaborasi interprofesional dan regulasi hukum yang berlaku. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat otonomi yang tinggi pada perawat berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan kerja (Žiaková et al., 2024).

d. Kode Etik dan Standar Praktik

Keperawatan diatur oleh standar etik yang mengikat perilaku profesional dalam praktik.

Keperawatan sebagai profesi memiliki kode etik yang menjadi pedoman dalam berperilaku profesional. Kode etik ini mengatur hubungan perawat dengan pasien, keluarga, sesama tenaga kesehatan, masyarakat.

Kode etik juga berfungsi sebagai landasan dalam pengambilan keputusan etis dalam situasi klinis yang kompleks.

Selain itu, praktik keperawatan diatur oleh standar praktik yang memastikan bahwa pelayanan yang diberikan: 1) Aman; 2) Berkualitas; 3) Konsisten; 4) Dapat dipertanggungjawabkan.

Standar ini menjadi acuan dalam evaluasi kinerja perawat serta dalam sistem akreditasi layanan kesehatan (American Nurses Association, 2021).

e. Pendidikan Formal dan Berkelanjutan

Profesionalisme perawat dibentuk melalui pendidikan formal dan pengembangan kompetensi berkelanjutan (*lifelong learning*).

Karakteristik ini diperkuat oleh penelitian yang menyatakan bahwa profesionalisme keperawatan merupakan konsep multidimensional yang mencakup pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam praktik klinis. (Cao et al., 2023)

Keperawatan mensyaratkan pendidikan formal sebagai dasar pembentukan kompetensi profesional. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap dan keterampilan klinis.

Selain pendidikan formal, perawat juga dituntut untuk melakukan Continuing Professional Development (CPD) sebagai bentuk pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*). Hal ini penting mengingat perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan yang sangat cepat.

Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan profesional berkelanjutan berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi klinis, keselamatan pasien, dan kualitas pelayanan (Swift et al., 2025).

f. Orientasi pada Pelayanan Publik (Service Orientation)

Keperawatan memiliki orientasi utama pada pelayanan masyarakat. Tujuan utama profesi ini adalah meningkatkan derajat kesehatan individu dan komunitas.

Perawat tidak hanya bekerja di rumah sakit, tetapi juga di: puskesmas, komunitas, sekolah dan layanan *home care*

Hal ini menunjukkan bahwa keperawatan memiliki peran strategis dalam sistem kesehatan, terutama dalam upaya promotif dan preventif.

g. Identitas dan Sosialisasi Profesional

Karakteristik lain dari profesi adalah adanya identitas profesional yang terbentuk melalui proses pendidikan dan sosialisasi. Mahasiswa keperawatan belajar untuk menginternalisasi nilai, norma, dan perilaku profesional melalui:

- Pembelajaran akademik
- Praktik klinik
- Role model (dosen dan perawat klinis)

Proses ini disebut sebagai *professional socialization*, yang sangat penting dalam membentuk sikap profesional sejak dini. Studi menunjukkan bahwa sosialisasi profesional yang baik berhubungan dengan peningkatan profesionalisme dan kesiapan praktik klinis (Garmy, 2025).

B. Profesionalisme Perawat

1. Definisi Profesionalisme Keperawatan

Profesionalisme merupakan konsep fundamental dalam praktik keperawatan yang mencerminkan kualitas perilaku, komitmen, dan tanggung jawab seorang perawat dalam memberikan asuhan kepada pasien. Dalam konteks keperawatan modern, profesionalisme tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga sebagai integrasi antara pengetahuan ilmiah, nilai moral, dan praktik klinis yang berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan pasien.

Analisis konsep terbaru menunjukkan bahwa profesionalisme keperawatan merupakan konstruksi multidimensional yang mencakup aspek kognitif (pengetahuan), afektif (nilai dan sikap), serta psikomotor (perilaku praktik) (Žiaková et al., 2024). Profesionalisme juga didefinisikan sebagai kemampuan perawat untuk memberikan pelayanan berdasarkan prinsip *caring*, altruism, *accountability*, dan integritas dalam konteks pelayanan kesehatan yang kompleks.

Lebih lanjut, profesionalisme erat kaitannya dengan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat profesionalisme perawat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan keselamatan pasien, kepuasan pasien, serta efektivitas sistem pelayanan kesehatan (Rosa et al., 2021). Oleh karena itu, profesionalisme menjadi indikator penting dalam evaluasi kinerja perawat dan mutu layanan keperawatan.

2. Nilai-Nilai Profesional Keperawatan

Nilai profesional merupakan landasan moral yang membimbing perilaku perawat dalam praktik. Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi harus terinternalisasi dalam setiap tindakan keperawatan.

Beberapa nilai utama dalam profesionalisme keperawatan meliputi:

a. Altruisme

Altruisme mengacu pada sikap mendahulukan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi. Nilai ini menjadi dasar dalam praktik keperawatan yang berorientasi pada pelayanan dan kepedulian.

b. Human Dignity (Martabat Manusia)

Perawat wajib menghormati setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, agama, maupun kondisi kesehatan. Penghormatan terhadap martabat manusia menjadi prinsip utama dalam pemberian asuhan yang humanistik.

c. Integritas

Integritas mencerminkan kejujuran, konsistensi, dan komitmen terhadap standar profesional. Perawat harus mampu menjaga kepercayaan pasien melalui tindakan yang etis dan transparan.

d. Keadilan (Justice)

Perawat harus memberikan pelayanan secara adil tanpa diskriminasi. Prinsip ini penting dalam menjamin akses pelayanan kesehatan yang setara bagi semua pasien.

e. Tanggung Jawab (Accountability)

Setiap tindakan keperawatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, baik secara etik maupun hukum.

Penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai profesional ini berhubungan dengan peningkatan kualitas hubungan terapeutik antara perawat dan pasien serta menurunkan risiko kesalahan klinis (Betriana, 2021).

3. Atribut dan Karakteristik Profesionalisme

Profesionalisme keperawatan diwujudkan melalui berbagai atribut yang dapat diamati dalam praktik klinis. Atribut ini menjadi indikator penting dalam menilai tingkat profesionalisme seorang perawat.

a. Caring

Caring merupakan inti dari praktik keperawatan. Konsep ini mencakup empati, perhatian, dan komitmen untuk memenuhi kebutuhan pasien secara holistik.

b. Kompetensi

Kompetensi meliputi kemampuan kognitif, keterampilan klinis, serta kemampuan pengambilan keputusan yang berbasis bukti ilmiah.

c. Komunikasi Efektif

Komunikasi terapeutik merupakan bagian integral dari profesionalisme, yang memungkinkan terciptanya hubungan saling percaya antara perawat dan pasien.

d. Kolaborasi Interprofesional

Perawat harus mampu bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain dalam memberikan pelayanan yang terintegrasi.

e. Komitmen terhadap Pembelajaran Berkelanjutan

Perawat dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan.

f. Perilaku Etis

Setiap tindakan harus sesuai dengan prinsip etik dan standar praktik.

Studi menunjukkan bahwa atribut-atribut ini merupakan indikator utama dalam evaluasi profesionalisme perawat di berbagai setting pelayanan kesehatan (Swift et al., 2025).

4. Profesionalisme dalam Praktik Klinis

Profesionalisme harus tercermin secara nyata dalam praktik sehari-hari. Implementasi profesionalisme dalam praktik klinis meliputi:

- Menjaga kerahasiaan informasi pasien
- Memberikan asuhan sesuai standar praktik
- Menghormati hak pasien dalam pengambilan keputusan
- Menghindari tindakan di luar kompetensi
- Mendokumentasikan tindakan secara akurat

Dalam praktik klinis, profesionalisme juga berkaitan erat dengan penerapan prinsip keselamatan pasien (*patient safety*). Perawat profesional tidak hanya fokus pada tindakan klinis, tetapi juga pada pencegahan risiko dan kesalahan medis.

Penelitian menunjukkan bahwa perilaku profesional perawat memiliki hubungan langsung dengan penurunan insiden keselamatan pasien dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (Rosa et al., 2021).

5. Pengembangan Profesionalisme Perawat

Profesionalisme merupakan proses yang berkembang sepanjang karier perawat. Pembentukan profesionalisme dimulai sejak pendidikan dan terus berkembang melalui pengalaman praktik.

Beberapa faktor yang memengaruhi pengembangan profesionalisme antara lain:

a. Pendidikan Formal

Pendidikan menjadi fondasi dalam pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan nilai profesional.

b. Sosialisasi Profesional

Interaksi dengan lingkungan klinis dan role model berperan penting dalam membentuk identitas profesional.

c. Refleksi Praktik

Refleksi membantu perawat dalam mengevaluasi pengalaman dan meningkatkan kualitas praktik.

d. *Continuing Professional Development* (CPD)

Pengembangan kompetensi secara berkelanjutan penting untuk mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan.

e. Lingkungan Kerja

Budaya organisasi dan kepemimpinan juga memengaruhi tingkat profesionalisme perawat.

Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara pendidikan, pengalaman klinis, dan dukungan organisasi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan profesionalisme perawat (Žiaková et al., 2024).

6. Tantangan Profesionalisme di Era Modern

Perkembangan teknologi dan kompleksitas sistem kesehatan menimbulkan berbagai tantangan dalam menjaga profesionalisme, antara lain:

- Beban kerja tinggi
- Tekanan emosional
- Perkembangan teknologi digital
- Isu etik yang semakin kompleks

Dalam menghadapi tantangan ini, perawat dituntut untuk tetap mempertahankan standar profesional melalui peningkatan kompetensi, refleksi diri, dan kepatuhan terhadap kode etik.

C. Peran Perawat dalam Pelayanan

1. Konsep Peran Perawat

Peran perawat merupakan manifestasi dari fungsi dan tanggung jawab profesional dalam memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam sistem pelayanan kesehatan modern, perawat tidak hanya berperan sebagai pelaksana tindakan klinis, tetapi juga sebagai pengambil keputusan, advokat pasien, serta anggota tim interprofesional.

Menurut kajian terkini, peran perawat berkembang secara dinamis seiring dengan kompleksitas kebutuhan kesehatan masyarakat dan transformasi sistem pelayanan kesehatan global (Labrague et al., 2019). Perawat dituntut untuk memiliki kemampuan klinis, komunikasi, kepemimpinan, serta kemampuan berpikir kritis dalam menjalankan perannya secara optimal.

Selain itu, organisasi profesi seperti International Council of Nurses (ICN) menegaskan bahwa perawat memiliki peran strategis dalam mencapai sistem kesehatan yang efektif, aman, dan berorientasi pada pasien (ICN, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa peran perawat tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

2. Klasifikasi Peran Perawat

Peran perawat dalam pelayanan kesehatan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori utama sebagai berikut:

a. Care Provider (Pemberi Asuhan Keperawatan)

Peran utama perawat adalah sebagai pemberi asuhan keperawatan (*care provider*), yaitu memberikan pelayanan langsung kepada pasien berdasarkan proses keperawatan yang sistematis (pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi).

Asuhan yang diberikan harus:

- Berbasis kebutuhan dasar manusia
- Berorientasi pada pasien (*patient-centered care*)
- Menggunakan pendekatan holistik

Penelitian menunjukkan bahwa kualitas asuhan keperawatan yang baik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan outcome pasien dan keselamatan pasien (Aiken et al., 2018).

b. Educator (Pendidik Kesehatan)

Perawat berperan sebagai edukator dalam memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga. Edukasi ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan pengetahuan pasien
- Mendukung kepatuhan terapi

- Mencegah komplikasi

Peran edukator menjadi sangat penting dalam konteks penyakit kronis dan perawatan jangka panjang. Studi menunjukkan bahwa edukasi yang efektif oleh perawat dapat meningkatkan self-care dan kualitas hidup pasien (Bastable, 2020).

c. Advocate (Advokat Pasien)

Sebagai advokat, perawat bertanggung jawab untuk melindungi hak dan kepentingan pasien. Hal ini meliputi:

- Menjamin hak pasien dalam pengambilan keputusan
- Melindungi pasien dari tindakan yang tidak aman
- Menyuarakan kebutuhan pasien dalam tim kesehatan

Peran advokasi sangat penting dalam menjaga keselamatan pasien dan memastikan pelayanan yang etis (Vaartio et al., 2019).

d. Collaborator (Kolaborator Tim Kesehatan)

Perawat bekerja dalam tim interprofesional yang terdiri dari dokter, apoteker, fisioterapis, dan tenaga kesehatan lainnya. Kolaborasi yang efektif diperlukan untuk:

- Meningkatkan koordinasi pelayanan
- Mengurangi kesalahan medis
- Meningkatkan kualitas pelayanan

Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi interprofesional yang baik berhubungan dengan peningkatan keselamatan pasien dan efisiensi layanan (Reeves et al., 2017).

e. Manager (Pengelola Asuhan Keperawatan)

Perawat juga memiliki peran sebagai manajer dalam mengelola asuhan keperawatan, termasuk:

- Mengatur prioritas tindakan
- Mengelola waktu dan sumber daya
- Mengkoordinasikan pelayanan

Peran ini menuntut kemampuan kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang baik, terutama dalam situasi klinis yang kompleks.

f. Researcher (Pengembang Ilmu Keperawatan)

Perawat berperan dalam pengembangan ilmu melalui penelitian dan penerapan evidence-based practice. Keterlibatan perawat dalam penelitian penting untuk:

- Meningkatkan kualitas praktik
- Mengembangkan inovasi pelayanan
- Mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti

3. Peran Perawat dalam Pendekatan Patient-Centered Care

Pendekatan *patient-centered care* menempatkan pasien sebagai pusat pelayanan. Dalam pendekatan ini, perawat berperan dalam:

- a. Menghormati preferensi pasien
- b. Melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan
- c. Memberikan pelayanan yang individual

Pendekatan ini terbukti meningkatkan kepuasan pasien, kepatuhan terapi, serta outcome kesehatan (Santana et al., 2018).

4. Peran Perawat dalam Keselamatan Pasien

Perawat memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan pasien (*patient safety*), antara lain:

- a. Mengidentifikasi risiko pasien
- b. Mencegah kesalahan medis
- c. Melakukan monitoring kondisi pasien
- d. Melaporkan insiden keselamatan

Karena perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi dengan pasien, peran ini menjadi krusial dalam sistem pelayanan kesehatan (WHO, 2021).

5. Peran Perawat dalam Pelayanan Berbasis Komunitas

Perawat tidak hanya bekerja di rumah sakit, tetapi juga di komunitas. Dalam konteks ini, perawat berperan dalam:

- Promosi kesehatan
- Pencegahan penyakit
- Edukasi masyarakat
- Pemberdayaan komunitas

Peran ini sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara luas.

6. Tantangan dalam Pelaksanaan Peran Perawat

Dalam praktiknya, perawat menghadapi berbagai tantangan, seperti:

- Beban kerja tinggi
- Keterbatasan sumber daya
- Kompleksitas kasus pasien
- Tuntutan profesional yang tinggi

Penelitian menunjukkan bahwa beban kerja yang tinggi dapat memengaruhi kualitas pelayanan dan keselamatan pasien (Labrague et al., 2019). Oleh karena itu, diperlukan dukungan sistem dan manajemen yang baik untuk memastikan perawat dapat menjalankan perannya secara optimal.

D. Komunikasi Terapeutik dalam Perilaku/Praktik Profesional

Komunikasi terapeutik merupakan proses komunikasi yang direncanakan secara sadar dengan tujuan membantu pasien mencapai kondisi kesehatan yang optimal. Dalam praktik keperawatan, komunikasi terapeutik menjadi dasar dalam membangun hubungan profesional antara perawat dan pasien.

1. Komunikasi terapeutik memiliki beberapa tujuan utama:

- a. Membangun hubungan saling percaya
- b. Menggali informasi pasien secara akurat
- c. Memberikan dukungan emosional
- d. Meningkatkan kepatuhan terapi

2. Fase komunikasi terapeutik meliputi:

- a. Fase orientasi → membangun hubungan awal
- b. Fase kerja → eksplorasi masalah
- c. Fase terminasi → evaluasi dan penutupan

3. Teknik komunikasi terapeutik meliputi:

- a. Mendengarkan aktif
- b. Empati
- c. Klarifikasi
- d. Refleksi
- e. Validasi

4. Hambatan komunikasi:

- a. Emosi pasien
- b. Perbedaan budaya
- c. Lingkungan tidak kondusif

E. Etika dan Legal Keperawatan

1. Konsep Etika dalam Keperawatan

Etika keperawatan merupakan seperangkat prinsip moral yang menjadi pedoman bagi perawat dalam menentukan tindakan yang benar dan bertanggung jawab dalam praktik profesional. Etika tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai kerangka berpikir dalam menghadapi dilema klinis yang kompleks.

Dalam praktik keperawatan modern, etika dipandang sebagai bagian integral dari profesionalisme, karena setiap tindakan keperawatan selalu melibatkan interaksi manusia yang sarat dengan nilai, hak, dan kepentingan individu. Oleh karena itu, perawat dituntut untuk mampu mengintegrasikan

pertimbangan etik dalam setiap pengambilan keputusan klinis (Numminen et al., 2017).

Selain itu, perkembangan sistem pelayanan kesehatan yang semakin kompleks menyebabkan meningkatnya potensi konflik etik, seperti konflik antara kepentingan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Hal ini menuntut perawat untuk memiliki kemampuan *ethical reasoning* yang baik dalam praktik sehari-hari.

2. Prinsip-Prinsip Etika Keperawatan

Prinsip etik merupakan dasar dalam pengambilan keputusan etik. Beberapa prinsip utama dalam keperawatan meliputi:

a. *Autonomy* (Otonomi)

Menghormati hak pasien untuk membuat keputusan terkait kesehatannya sendiri. Perawat harus memberikan informasi yang cukup agar pasien dapat mengambil keputusan secara sadar (*informed decision*).

b. *Beneficence* (Berbuat Baik)

Perawat wajib melakukan tindakan yang memberikan manfaat bagi pasien.

c. *Non-maleficence* (Tidak Merugikan)

Perawat harus menghindari tindakan yang dapat membahayakan pasien.

d. *Justice* (Keadilan)

Memberikan pelayanan secara adil tanpa diskriminasi.

e. *Veracity* (Kejujuran)

Perawat harus menyampaikan informasi secara jujur dan transparan kepada pasien.

Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam penyelesaian dilema etik serta dalam menjaga kualitas pelayanan keperawatan (Beauchamp & Childress, dikembangkan dalam literatur keperawatan modern).

3. Kode Etik Keperawatan

Kode etik keperawatan merupakan pedoman resmi yang mengatur perilaku profesional perawat. Kode etik berfungsi untuk:

- Menjaga standar moral profesi
- Melindungi pasien
- Menjadi dasar dalam pengambilan keputusan etik

Kode etik perawat mencakup tanggung jawab terhadap: Pasien, Praktik keperawatan, Profesi, Masyarakat

Menurut International Council of Nurses (ICN), kode etik perawat menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, serta tanggung jawab profesional dalam memberikan asuhan (ICN, 2021).

4. Konsep Legal dalam Keperawatan

Aspek legal dalam keperawatan berkaitan dengan aturan hukum yang mengatur praktik keperawatan. Tujuan utama aspek legal adalah:

- Melindungi pasien
- Melindungi perawat
- Menjamin kualitas pelayanan

Praktik keperawatan harus dilakukan sesuai dengan:

- Standar profesi
- Standar prosedur operasional (SPO)
- Regulasi hukum yang berlaku

Pelanggaran terhadap aspek legal dapat berimplikasi pada sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

5. Isu Legal dalam Praktik Keperawatan

Beberapa isu legal yang sering muncul dalam praktik keperawatan antara lain:

a. Informed Consent

Persetujuan tindakan medis yang diberikan setelah pasien mendapatkan informasi yang lengkap. Perawat berperan dalam memastikan bahwa pasien memahami informasi tersebut.

b. Negligence (Kelalaian)

Kelalaian terjadi ketika perawat tidak memberikan standar pelayanan yang seharusnya sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien.

c. Malpraktik

Tindakan profesional yang tidak sesuai standar sehingga menyebabkan cedera atau kerugian pada pasien.

d. Dokumentasi Keperawatan

Dokumentasi merupakan bukti legal dari tindakan keperawatan. Dokumentasi yang tidak lengkap dapat menimbulkan masalah hukum.

e. Kerahasiaan (Confidentiality)

Perawat wajib menjaga kerahasiaan informasi pasien kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum.

Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kasus hukum dalam keperawatan berkaitan dengan dokumentasi yang tidak adekuat dan komunikasi yang buruk (Jafree et al., 2021).

6. Hubungan Etika dan Legal dalam Praktik Keperawatan

Etika dan hukum merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam praktik keperawatan. Etika memberikan panduan moral, sedangkan hukum memberikan batasan formal yang mengikat.

Dalam praktiknya:

- Tidak semua tindakan yang legal bersifat etis
- Tidak semua tindakan etis memiliki dasar hukum

Oleh karena itu, perawat harus mampu menyeimbangkan antara pertimbangan etik dan legal dalam pengambilan keputusan klinis.

7. Pengambilan Keputusan Etik dalam Keperawatan

Pengambilan keputusan etik merupakan proses sistematis yang melibatkan:

- a. Identifikasi masalah etik
- b. Pengumpulan data
- c. Analisis alternatif tindakan
- d. Pengambilan keputusan
- e. Evaluasi hasil

Kemampuan ini sangat penting dalam menghadapi dilema etik yang kompleks, seperti:

- Penolakan tindakan oleh pasien
- Konflik antara keluarga dan pasien
- Keputusan akhir kehidupan (*end-of-life care*)

Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan ethical decision-making dapat meningkatkan kompetensi perawat dalam menghadapi dilema klinis (Park et al., 2020).

8. Tantangan Etika dan Legal di Era Modern

Perkembangan teknologi dan sistem kesehatan modern membawa tantangan baru, seperti:

- Telemedicine
- Privasi data pasien
- Teknologi informasi kesehatan
- Kompleksitas keputusan klinis

Perawat dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi etik dan legal agar dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut.

F. Batas Praktik dan Patient Safety

1. Konsep Batas Praktik Keperawatan

Batas praktik (*scope of practice*) keperawatan merupakan batasan kewenangan profesional yang mengatur tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perawat sesuai dengan kompetensi, pendidikan, serta regulasi yang berlaku. Batas praktik ini menjadi landasan penting dalam menjamin keselamatan pasien dan perlindungan hukum bagi perawat.

Dalam praktik klinis, batas praktik tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga oleh kemampuan individu perawat, standar profesi, serta kebijakan institusi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, perawat harus memiliki kesadaran profesional untuk mengenali batas kompetensinya dan menghindari tindakan di luar kewenangan (ANA, 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas praktik dapat meningkatkan risiko kesalahan klinis dan insiden keselamatan pasien (Woo et al., 2017). Dengan demikian, pemahaman yang jelas tentang batas praktik merupakan bagian integral dari profesionalisme keperawatan.

2. Komponen Batas Praktik Keperawatan

Batas praktik keperawatan terdiri dari beberapa komponen utama:

a. Kompetensi Individu

Perawat hanya diperbolehkan melakukan tindakan yang sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki.

b. Standar Profesi dan SOP

Tindakan keperawatan harus mengacu pada standar praktik dan prosedur operasional yang telah ditetapkan.

c. Regulasi dan Hukum

Praktik keperawatan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Delegasi dan Kolaborasi

Perawat dapat melakukan tindakan tertentu berdasarkan delegasi dari tenaga medis, namun tetap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tindakan tersebut.

e. Konteks Klinis

Kondisi pasien dan situasi klinis juga memengaruhi batas praktik yang aman. Ketidakesesuaian antara kompetensi dan tindakan yang dilakukan dapat berpotensi menimbulkan kelalaian (*negligence*) dalam praktik keperawatan.

3. Konsep Patient Safety dalam Keperawatan

Keselamatan pasien (*patient safety*) merupakan prinsip fundamental dalam pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mencegah cedera yang dapat dihindari selama proses pelayanan.

Menurut World Health Organization (WHO), patient safety adalah:

“Ketiadaan cedera yang dapat dicegah selama proses pelayanan kesehatan serta upaya untuk mengurangi risiko bahaya seminimal mungkin.”

Keselamatan pasien menjadi tanggung jawab seluruh tenaga kesehatan, namun perawat memiliki peran yang sangat penting karena keterlibatan langsung dan berkelanjutan dalam perawatan pasien.

Penelitian menunjukkan bahwa mayoritas insiden keselamatan pasien berkaitan dengan kesalahan komunikasi, kesalahan prosedur, dan kurangnya kepatuhan terhadap standar keselamatan (Slatyer et al., 2018)

4. Prinsip-Prinsip Patient Safety

Dalam praktik keperawatan, prinsip keselamatan pasien meliputi:

a. Identifikasi Pasien Secara Tepat

Menggunakan minimal dua identitas pasien untuk mencegah kesalahan tindakan.

b. Komunikasi Efektif

Menggunakan metode komunikasi standar seperti SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*).

c. Keamanan Obat

Menerapkan prinsip "6 benar" dalam pemberian obat.

d. Pencegahan Infeksi

Melaksanakan kewaspadaan standar, seperti *hand hygiene*.

e. Pencegahan Risiko Jatuh

Melakukan asesmen risiko jatuh dan intervensi pencegahan.

f. Keselamatan Tindakan

Memastikan prosedur dilakukan sesuai standar.

Implementasi prinsip-prinsip ini terbukti dapat menurunkan angka kejadian tidak diinginkan (*adverse events*) dalam pelayanan kesehatan (WHO, 2021).

5. Peran Perawat dalam Patient Safety

Perawat memiliki peran kunci dalam menjaga keselamatan pasien, antara lain:

- Melakukan pengkajian risiko secara kontinu
- Memantau kondisi pasien secara berkala
- Mengidentifikasi perubahan klinis secara dini
- Melaporkan insiden keselamatan
- Mengedukasi pasien dan keluarga

Karena perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi dengan pasien, maka mereka berada pada posisi strategis dalam mendeteksi dan mencegah kesalahan klinis.

Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi perawat dalam patient safety berhubungan dengan penurunan insiden keselamatan pasien (Jafree et al., 2021).

6. Hubungan Batas Praktik dan Patient Safety

Batas praktik dan patient safety merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat. Pelanggaran terhadap batas praktik dapat meningkatkan risiko terjadinya insiden keselamatan pasien.

Sebaliknya, pemahaman yang baik tentang batas praktik dapat:

- Mencegah tindakan yang tidak aman
- Mengurangi risiko kesalahan medis
- Meningkatkan kualitas pelayanan
- Dengan demikian, kepatuhan terhadap batas praktik merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan pasien.

7. Tantangan dalam Implementasi Patient Safety

Beberapa tantangan dalam implementasi patient safety antara lain:

- Beban kerja perawat yang tinggi
- Keterbatasan sumber daya
- Kurangnya budaya keselamatan
- Komunikasi yang tidak efektif

Penelitian menunjukkan bahwa faktor organisasi dan lingkungan kerja memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi patient safety (Slatyer et al., 2018).

G. Perilaku Profesional dalam Praktik Keperawatan

1. Konsep Perilaku Profesional

Perilaku profesional dalam keperawatan merupakan manifestasi nyata dari nilai, etika, dan kompetensi yang dimiliki oleh perawat dalam praktik klinis. Perilaku ini mencerminkan bagaimana seorang perawat menerapkan pengetahuan dan nilai profesional dalam interaksi dengan pasien, keluarga, serta tim kesehatan.

Profesionalisme tidak hanya bersifat konseptual, tetapi harus dapat diamati melalui tindakan nyata, seperti komunikasi yang empatik, kepatuhan terhadap standar praktik, serta kemampuan menjaga batas profesional. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku profesional perawat memiliki hubungan langsung dengan kualitas pelayanan, keselamatan pasien, dan kepuasan pasien (Woo et al., 2017).

Dengan demikian, perilaku profesional menjadi indikator penting dalam evaluasi kompetensi mahasiswa keperawatan, khususnya dalam konteks pembelajaran berbasis OBE.

2. Komponen Perilaku Profesional

Perilaku profesional dalam praktik keperawatan mencakup beberapa komponen utama:

- a. Komunikasi Terapeutik
Perawat harus mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan menghargai pasien. Komunikasi terapeutik menjadi dasar dalam membangun hubungan saling percaya.
 - b. Sikap Empati dan Caring
Empati memungkinkan perawat memahami kondisi pasien secara emosional dan psikologis, sehingga dapat memberikan asuhan yang lebih humanistik.
 - c. Kepatuhan terhadap Standar
Perawat harus menjalankan tindakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan pedoman praktik.
 - d. Tanggung Jawab Profesional
Setiap tindakan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan legal.
 - e. Menjaga Batas Profesional
Perawat harus menjaga hubungan profesional dengan pasien dan menghindari konflik kepentingan maupun hubungan yang tidak sesuai.
 - f. Kerja Sama Tim
Kemampuan bekerja dalam tim interprofesional menjadi bagian penting dari perilaku profesional.
3. Perilaku Profesional dalam Berbagai Situasi Klinis
- Perilaku profesional harus diterapkan dalam berbagai situasi klinis, termasuk:
- Saat memberikan asuhan rutin
 - Saat menghadapi pasien dengan kondisi kritis
 - Saat menghadapi konflik dengan pasien/keluarga
 - Saat bekerja dalam tim kesehatan
- Dalam situasi kompleks, perawat dituntut untuk tetap mempertahankan sikap profesional, meskipun berada dalam tekanan kerja yang tinggi.

H. RINGKASAN

Pengantar Keperawatan Dasar dan Profesionalisme Perawat

Keperawatan merupakan profesi kesehatan yang memiliki landasan ilmiah, nilai kemanusiaan, serta tanggung jawab profesional dalam memberikan asuhan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Sebagai profesi, keperawatan memiliki karakteristik utama berupa *body of knowledge*, standar praktik, kode etik, serta komitmen terhadap pelayanan publik.

Profesionalisme perawat merupakan inti dari praktik keperawatan yang mencerminkan integrasi antara pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam

memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan berpusat pada pasien. Nilai-nilai profesional seperti altruisme, integritas, keadilan, dan tanggung jawab menjadi dasar dalam setiap tindakan keperawatan.

Peran perawat dalam pelayanan kesehatan sangat luas, meliputi sebagai pemberi asuhan (*care provider*), pendidik (*educator*), advokat (*advocate*), kolaborator, manajer, dan peneliti. Peran ini menuntut kemampuan klinis, komunikasi, serta kerja sama tim yang baik.

Dalam praktiknya, perawat harus menjunjung tinggi prinsip etika dan hukum. Prinsip etika seperti autonomy, beneficence, non-maleficence, justice, dan veracity menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis, sedangkan aspek legal memberikan batasan formal dalam praktik keperawatan.

Batas praktik (*scope of practice*) menjadi pedoman penting agar perawat bekerja sesuai kompetensi dan kewenangan. Kepatuhan terhadap batas praktik berkaitan erat dengan keselamatan pasien (*patient safety*), yang merupakan prioritas utama dalam pelayanan kesehatan.

Perilaku profesional merupakan manifestasi nyata dari profesionalisme perawat dalam praktik sehari-hari, termasuk komunikasi terapeutik, empati, kepatuhan terhadap standar, serta kemampuan menjaga batas profesional.

Dengan demikian, penguasaan konsep dasar keperawatan dan profesionalisme menjadi fondasi penting bagi mahasiswa dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas, aman, dan berorientasi pada pasien.

RED FLAG (HAL KRITIS YANG HARUS DIHINDARI)

Mahasiswa harus memahami dan menghindari perilaku berikut karena berisiko tinggi terhadap keselamatan pasien dan pelanggaran profesional:

1. Pelanggaran Etik
 - Membocorkan informasi pasien
 - Tidak menghormati keputusan pasien
 - Bersikap diskriminatif
2. Pelanggaran Batas Praktik
 - Melakukan tindakan di luar kompetensi
 - Tidak mengikuti SOP
 - Mengabaikan instruksi medis
3. Risiko Patient Safety
 - Salah identifikasi pasien
 - Kesalahan pemberian obat
 - Tidak melakukan monitoring pasien
4. Perilaku Tidak Profesional
 - Komunikasi tidak empatik
 - Tidak menjaga batas profesional
 - Tidak bertanggung jawab terhadap tindakan

ASESMEN (PIRAMIDA MILLER)

Level	Metode
Knows	Soal Pilihan Ganda /Quiz
Knows How	Mini-case
Shows How	OSCE

I. Latihan soal

Pengantar Keperawatan Dasar dan Profesionalisme Perawat

Soal 1

Keperawatan sebagai profesi ditandai dengan...

- a. Fokus pada tindakan teknis
- b. Berbasis pengalaman kerja
- c. Hanya membantu dokter
- d. Tidak memerlukan pendidikan formal
- e. Memiliki body of knowledge, standar, dan kode etik

Soal 2

Seorang pasien mengalami kecemasan selain nyeri fisik. Perawat memberikan dukungan emosional.

Pendekatan yang digunakan adalah...

- a. Kuratif
- b. Medis
- c. Holistik
- d. Rehabilitatif
- e. Preventif

Soal 3

Profesionalisme perawat mencerminkan...

- a. Integrasi pengetahuan, sikap, dan perilaku
- b. Pengalaman kerja
- c. Keterampilan teknis saja
- d. Kepatuhan pada dokter
- e. Kecepatan tindakan

Soal 4

Perawat tetap melayani pasien kasar.

Nilai profesional yang ditunjukkan adalah...

- a. Justice
- b. Veracity
- c. Altruisme
- d. Autonomy
- e. Accountability

Soal 5

Perawat mengakui kesalahan pemberian obat.

Perilaku ini menunjukkan...

- a. Empati
- b. Integritas
- c. Caring
- d. Justice
- e. Autonomy

Soal 6

Peran educator adalah...

- a. Memberikan obat
- b. Manajemen
- c. Tindakan invasif
- d. Mengedukasi pasien
- e. Dokumentasi

Soal 7

Perawat menjelaskan diet rendah garam.

Peran yang dilakukan adalah...

- a. Care provider
- b. Educator
- c. Manager
- d. Collaborator
- e. Researcher

Soal 8

Perawat berdiskusi dengan dokter.

Peran ini adalah...

- a. Educator
- b. Manager
- c. Collaborator
- d. Advocate
- e. Caregiver

Soal 9

Prinsip “tidak merugikan” adalah...

- a. Autonomy
- b. Justice
- c. Beneficence
- d. Non-maleficence
- e. Veracity

Soal 10

Perawat tetap empatik saat pasien marah.

Ini menunjukkan...

- a. Perilaku profesional
- b. Komunikasi verbal
- c. Perilaku vokasional
- d. Pelanggaran etik
- e. Ketidaktegasaan

JAWABAN & PEMBAHASAN:**1. Jawaban: e****Pembahasan:**

Keperawatan disebut profesi karena memiliki dasar ilmu (body of knowledge), standar praktik, dan kode etik. Ini menjadi pembeda utama dengan pekerjaan teknis.

2. Jawaban: c**Pembahasan:**

Pendekatan holistik memperhatikan aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pasien, bukan hanya penyakit.

3. Jawaban: a**Pembahasan:**

Profesionalisme bersifat multidimensional: mencakup pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam praktik.

4. Jawaban: c**Pembahasan:**

Altruisme berarti mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi, termasuk dalam kondisi sulit.

5. **Jawaban: b**

Pembahasan:

Integritas berarti jujur, bertanggung jawab, dan berani mengakui kesalahan.

6. **Jawaban: d**

Pembahasan:

Educator berarti memberikan edukasi kesehatan kepada pasien/keluarga.

7. **Jawaban: b**

Pembahasan:

Memberikan edukasi = peran educator.

8. **Jawaban: c**

Pembahasan:

Kolaborasi antar tenaga kesehatan adalah peran collaborator.

9. **Jawaban: d**

Pembahasan:

Non-maleficence = tidak menimbulkan bahaya bagi pasien.

10. **Jawaban: a**

Pembahasan:

Perilaku profesional ditunjukkan dengan empati dan kontrol diri.

AKTIVITAS 1 — KNOWS HOW

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus (mini case tertulis) yang diberikan.

Kasus 1 (Profesionalisme & Komunikasi)

Seorang pasien menolak tindakan pemasangan infus karena takut nyeri. Keluarga pasien mendesak perawat untuk tetap melakukan tindakan tersebut.

Tugas Mahasiswa:

1. Identifikasi masalah etik dalam kasus tersebut
2. Tentukan prinsip etik yang terlibat
3. Jelaskan respon profesional perawat
4. Jelaskan teknik komunikasi terapeutik yang digunakan
5. Prinsip etika apa yang harus dipertimbangkan?
6. Apa tindakan yang paling tepat?

Kasus 2 (Patient Safety)

Perawat memberikan obat tanpa melakukan identifikasi pasien secara lengkap.

Tugas:

1. Identifikasi kesalahan
2. Jelaskan risiko terhadap pasien
3. Jelaskan prinsip patient safety yang dilanggar

Kasus 3 (Komunikasi, Etik, Legal)

Seorang perawat menceritakan kondisi pasien kepada temannya di luar rumah sakit.

Pertanyaan Diskusi:

1. Apakah tindakan tersebut profesional?
2. Risiko apa yang dapat terjadi?
3. Bagaimana tindakan yang seharusnya?

Diskusikan jawaban kasus tersebut bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Integrasi dengan OSCE (CPMK-1)

Stasiun OSCE: Perilaku Profesional

Instruksi Mahasiswa:

Mahasiswa diminta merespons skenario:

- pasien menolak tindakan
- keluarga menekan keputusan

- situasi konflik komunikasi

Checklist Penilaian OSCE

No	Komponen	Skor
1	Komunikasi empatik	☐
2	Menjelaskan hak pasien	☐
3	Menjaga batas profesional	☐
4	Respons sesuai etika	☐
5	Memberikan solusi aman	☐

Rubrik Penilaian (CPMK-1)

Mengacu langsung pada **Rubrik CPMK-1**

Indikator 1: Ketepatan Konsep Profesionalisme

- Skor 1: <60% benar
- Skor 2: 60–74%
- Skor 3: 75–89%
- Skor 4: ≥90%

Indikator 2: Respons Skenario Profesional

- Skor 1: Tidak tepat / berisiko
- Skor 2: Cukup / alasan lemah
- Skor 3: Tepat / alasan logis
- Skor 4: Sangat tepat / alasan kuat & konsisten

DOPS (Direct Observation of Procedural Skills)

Mahasiswa dinilai secara langsung saat praktik:

Aspek yang Dinilai:

- Sikap profesional
- Komunikasi dengan pasien
- Kepatuhan SOP
- Respons terhadap situasi klinis

Portofolio Mahasiswa

Mahasiswa diminta menyusun:

1. Refleksi pengalaman profesional
2. Analisis kasus etik
3. Evidence komunikasi terapeutik

Kesalahan Umum (Red Flag)

- Melanggar privasi pasien
- Bersikap tidak empatik
- Bertindak di luar kompetensi
- Komunikasi tidak profesional
- Tidak mengikuti SOP

AKTIVITAS 2 — SHOWS HOW (Simulasi / Skill Lab)

Simulasi: Komunikasi Terapeutik

Mahasiswa diminta melakukan simulasi:

- Komunikasi dengan pasien cemas
- Edukasi sederhana kepada pasien
- Respon terhadap pasien yang menolak tindakan

Fokus Penilaian:

- Komunikasi terapeutik
- Empati
- Profesionalisme
- Keselamatan pasien

CHECKLIST PEMBELAJARAN MAHASISWA

Gunakan checklist ini sebagai evaluasi diri untuk memastikan capaian pembelajaran:

No	Indikator	Ya	Tidak
1	Memahami konsep dasar keperawatan	☐	☐
2	Menjelaskan profesionalisme perawat	☐	☐
3	Mengidentifikasi nilai profesional	☐	☐
4	Menjelaskan peran perawat	☐	☐
5	Memahami prinsip etik dan legal	☐	☐
6	Menjelaskan patient safety	☐	☐
7	Mengidentifikasi batas praktik	☐	☐
8	Menunjukkan perilaku profesional	☐	☐

Referensi

- Aiken, L. H., et al. (2018). Nurse staffing and education and hospital mortality. *The Lancet*.
[https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736\(14\)61480-X.pdf](https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(14)61480-X.pdf)
- Alharbi, J., Jackson, D., & Usher, K. (2020). The potential for COVID-19 to contribute to compassion fatigue in critical care nurses. *Journal of Clinical Nursing*, 29(15–16), 2762–2764.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocn.15314>
- American Nurses Association. (2021). *Nursing: Scope and standards of practice* (4th ed.).
<https://www.nursingworld.org/practice-policy/workforce/what-is-nursing/>
- Bastable, S. B. (2020). *Nurse as educator: Principles of teaching and learning for nursing practice*.
<https://www.jblearning.com/catalog/productdetails/9781284127201>
- Betrian, F. (2021). Reflections on International Nurses Day: Current status of nursing. *Belitung Nursing Journal*.
https://www.belitungraya.org/BRP/index.php/bnj/article/download/1500/364/5021?_cf_chl_tk=quVtZ1Onv0sjgZqs.fXrhy3XuW_E2cJpFTPel4SHT_Ew-1777519154-1.0.1.1-58ZTkUuo.sB5VX.yidShfj7vo2GOcFXJthfbIxLsGk
- Cao, H., Song, Y., Wu, Y., Du, Y., He, X., Chen, Y., ... Yang, H. (2023). What is nursing professionalism? a concept analysis. *BMC Nursing*, 22(1), 1–14.
<https://doi.org/10.1186/s12912-022-01161-0>
- Carayon, P., et al. (2020). Human factors systems approach to patient safety. *Applied Ergonomics*.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000368701830613X>
- Catton, H. (2021). Global nursing leadership and policy. *International Nursing Review*.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/inr.12702>
- European Federation of Nurses Associations. (2022). *Policy statement on advanced nursing practice*.
<https://efn.eu/wp-content/uploads/2022/04/EFN-Policy-Statement-on-APN-April-2022.pdf>
- Garmy, P. (2025). Nursing for justice: Reflections on the new ICN definition. *International Nursing Review*.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12568527/>
- Gaspar, I. A., Yauri, I., Rohana, Listautin, Keintjem, F., Handayani, G. L., ... Kristiani, A. (2025). *Konsep Dasar Keperawatan*. (L. O. Alifariki, Ed.) (I). Cilacap-Jawa

Tengah: PT MEDIA PUSTAKA INDO. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/618036-konsep-dasar-keperawatan-d3f2e38f.pdf?utm_source

Grace, P. J., & Milliken, A. (2018). Educating nurses for ethical practice. *Nursing Ethics*, 25(7), 899–911. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0969733017700234>

International Council of Nurses. (2025). *Renewing the definitions of nursing and a nurse*. <https://www.icn.ch/resources/publications-and-reports/renewing-definitions-nursing-and-nurse>

International Council of Nurses. (2025). *Current nursing definitions*. <https://www.icn.ch/resources/nursing-definitions/current-nursing-definitions>

International Council of Nurses. (2025). ICN launches new definition of a nurse. <https://www.nursinginpractice.com/latest-news/icn-launches-new-definition-of-a-nurse/>

International Council of Nurses. (2021). *The ICN code of ethics for nurses*. https://www.icn.ch/system/files/2021-10/ICN_Code-of-Ethics_EN_Web_0.pdf

Jafree, S. R., et al. (2021). Nurse negligence and patient safety: A systematic review. *BMC Nursing*. <https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-021-00572-5>

Kim, J., & Bates, D. W. (2019). Medication administration errors. *BMJ Quality & Safety*. <https://qualitysafety.bmj.com/content/28/3/176>

Labrague, L. J., et al. (2019). Organizational and professional turnover intention among nurses: A systematic review. *International Nursing Review*. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/inr.12536>

Milliken, A. (2018). Ethical awareness: What it is and why it matters. *Online Journal of Issues in Nursing*, 23(1). <https://ojin.nursingworld.org/MainMenuCategories/EthicsStandards/ethical-awareness.html>

Numminen, O., Repo, H., & Leino-Kilpi, H. (2017). Moral courage in nursing: A concept analysis. *Nursing Ethics*, 24(8), 878–891. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0969733016634155>

Park, M., Kjervik, D., Crandell, J., & Oermann, M. H. (2020). The relationship of ethics education to moral sensitivity. *Nursing Ethics*, 27(2), 447–460. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0969733019832947>

Park, M., et al. (2020). Ethics education and moral sensitivity. *Nursing Ethics*.

<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0969733019832947>

- Poorchangizi, B., et al. (2019). The importance of professional values in nursing. *BMC Nursing*, 18(1).
<https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-019-0351-1>
- Reeves, S., et al. (2017). Interprofessional collaboration to improve healthcare outcomes. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
<https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD000072.pub3/full>
- Rosa, W. E., et al. (2021). The ICN Global Nursing Leadership Institute. *Nursing Outlook*.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8768889/>
- Santana, M. J., et al. (2018). How to practice person-centred care. *BMJ Open*.
<https://bmjopen.bmj.com/content/8/2/e019333>
- Slatyer, S., et al. (2018). Nurse workload and patient safety. *Journal of Nursing Management*.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jonm.12596>
- Swift, L. M., et al. (2025). Defining registered nurse competence: A contemporary concept analysis. *Collegian*.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1322769625000447>
- Tanaka, M., Taketomi, K., Yonemitsu, Y., & Kawamoto, R. (2016). Professional behaviours and factors contributing to nursing professionalism among nurse managers. *Journal of Nursing Management*, 24(1), 12–20.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jonm.12264>
- Vaartio, H., et al. (2019). Nursing advocacy in procedural pain care. *Nursing Ethics*.
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0969733017703690>
- Vaismoradi, M., et al. (2020). Patient safety culture in nursing. *BMC Nursing*.
<https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-020-00440-2>
- Varkey, B. (2021). Principles of clinical ethics and their application. *Medical Principles and Practice*, 30(1), 17–28.
<https://www.karger.com/Article/FullText/509119>
- White, J., Gunn, M., Chiarella, M., Stewart, D., & Salmon, M. (2025). *Renewing The Definitions of 'Nursing/ and "a Nurse."* ICN - International Council of Nurses. Geneva, Switzerland. Retrieved from
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16410321>
<https://academic.oup.com/bioinformatics/article/22/7/874/202031>
- World Health Organization. (2021). *Global patient safety action plan 2021–2030*.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240032705>

- Woo, B. F. Y., Lee, J. X. Y., & Tam, W. W. S. (2017). The impact of the professional identity of nurses on patient outcomes: A systematic review. *Journal of Nursing Management*, 25(7), 567–579.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jonm.12489>
- Žiaková, K., Gurková, E., & Jarošová, D. (2024). Professionalism from the perspective of nurses with advanced practice: A qualitative study. *Kontakt*, 26(1), 13–20.
https://kont.zsf.jcu.cz/artkey/knt-202401-0002_professionalism-from-the-perspective-of-nurses-with-advanced-practice.php

BAB 2

KONSEP SEHAT-SAKIT, HOMEOSTASIS, DAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar keperawatan, profesionalisme, etika–legal, dan keselamatan pasien sebagai landasan praktik.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6
CPL-2	Mampu menerapkan proses keperawatan secara sistematis (pengkajian–diagnosis–perencanaan–implementasi–evaluasi) berbasis kebutuhan dasar manusia.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-7
CPL-3	Mampu melakukan pengkajian dasar (tanda vital, nyeri, pemeriksaan fisik) serta dokumentasi yang akurat dan dapat diaudit.	CPMK-3; CPMK-7
CPL-4	Mampu melaksanakan keterampilan keperawatan dasar (oksigenasi, nutrisi, eliminasi, mobilisasi, integumen, pemberian obat) secara aman dan sesuai standar.	CPMK-4; CPMK-6
CPL-5	Mampu berkomunikasi terapeutik, memberikan edukasi kesehatan, dan melakukan discharge planning dasar yang berpusat pada pasien–keluarga.	CPMK-5; CPMK-7
CPL-6	Mampu berpikir kritis dan clinical reasoning untuk pengambilan keputusan, pencegahan risiko, serta perbaikan mutu praktik keperawatan dasar.	CPMK-2; CPMK-6; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan pengantar keperawatan dasar, profesionalisme perawat, peran, nilai, dan standar perilaku dalam pelayanan.
CPMK-2	Menjelaskan konsep sehat–sakit, homeostasis, kebutuhan dasar manusia, serta menerapkan berpikir kritis/clinical reasoning dalam pengambilan keputusan keperawatan.
CPMK-3	Melakukan proses keperawatan (pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, evaluasi) dan mendokumentasikan secara sistematis.
CPMK-4	Melaksanakan keterampilan keperawatan dasar untuk pemenuhan kebutuhan dasar (oksigenasi, nutrisi, cairan, eliminasi, istirahat–tidur, mobilisasi, integumen) sesuai standar.
CPMK-5	Menerapkan komunikasi terapeutik dan hubungan perawat–klien secara profesional untuk mendukung asuhan dan edukasi.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Menerapkan etik–hukum, patient safety, PPI, pencegahan jatuh, dan keselamatan medikasi dalam praktik keperawatan dasar.
CPMK-7	Melaksanakan edukasi kesehatan, discharge planning, dan handover SBAR, serta mengevaluasi luaran asuhan dan menyusun perbaikan rencana berbasis data.

D. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 2. Konsep Sehat–Sakit, Homeostasis, dan Kebutuhan Dasar Manusia	2.1 Menjelaskan konsep sehat–sakit dan homeostasis sebagai dasar respon tubuh.	2.2 Mengaitkan kebutuhan dasar manusia dengan prioritas asuhan pada skenario sederhana.	CPMK-2	CPMK-3; CPMK-4

E. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	Ujian kasus clinical reasoning	Ketepatan problem list/prioritas (skor rubrik) dan konsistensi alasan berbasis risiko/bukti dasar.	10	Lembar jawaban kasus
CPMK-3	Tugas proses keperawatan tertulis (mini care plan)	Ketepatan diagnosis/prioritas dan kualitas tujuan SMART serta evaluasi terukur (skor rubrik).	15	Mini care plan
CPMK-4	OSCE keterampilan dasar (TV, oksigenasi, eliminasi, luka) + checklist	Persentase langkah benar pada skill station dan ketepatan evaluasi respons pasien.	25	Checklist OSCE; catatan tindakan

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep profesionalisme (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Akurasi respons pada skenario perilaku profesional	Respons keliru/berisiko	Respons cukup; alasan lemah	Respons tepat; alasan logis	Respons sangat tepat; alasan kuat & konsisten standar

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan problem list & prioritas	Prioritas tidak sesuai; banyak masalah kunci terlewat	Prioritas cukup; masih ada ketidaktepatan bermakna	Prioritas tepat; masalah kunci tercakup	Prioritas sangat tepat; masalah kunci lengkap & terurut
2.2 Konsistensi alasan berbasis risiko/bukti dasar	Tanpa alasan; tidak berbasis risiko	Alasan umum; risiko belum jelas	Alasan logis; risiko jelas	Alasan sangat kuat; mengaitkan risiko, bukti dasar, dan keselamatan

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Ketepatan diagnosis/prioritas	Tidak sesuai data; prioritas keliru	Sebagian sesuai; prioritas kurang konsisten	Sesuai data; prioritas jelas	Sangat sesuai; prioritas sangat logis & tervalidasi
3.2 Kualitas tujuan SMART & evaluasi terukur	Tujuan tidak SMART; evaluasi tidak jelas	Sebagian SMART; evaluasi terbatas	SMART; evaluasi jelas	SMART sangat kuat; evaluasi komprehensif dan operasional

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan langkah keterampilan dasar (checklist)	≤60% langkah benar; ada kesalahan kritis	61–75% benar; kekurangan bermakna	76–90% benar; kesalahan minor	>90% benar; aman tanpa kesalahan bermakna
4.2 Ketepatan evaluasi respons pasien	Tidak mengevaluasi/keliru	Mengevaluasi terbatas; indikator kurang tepat	Evaluasi jelas; indikator tepat	Evaluasi sangat jelas; indikator tepat & tindak lanjut cepat

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kinerja komunikasi terapeutik (checklist)	≤60% perilaku tercapai; hubungan tidak terbina	61–75% tercapai; hubungan terbina sebagian	76–90% tercapai; hubungan efektif	>90% tercapai; empatik, adaptif, profesional

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.2 Batas profesional & respons terhadap hambatan komunikasi	Tidak menjaga batas; respons tidak tepat	Batas sebagian; respons kurang konsisten	Batas jelas; respons tepat	Batas sangat jelas; respons sangat efektif & aman

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Kepatuhan PPI & kewaspadaan standar	Banyak langkah terlewat; risiko tinggi	Langkah inti ada; kurang konsisten	Langkah tepat; konsisten	Langkah sangat tepat; konsisten tanpa pelanggaran
6.2 Kepatuhan keselamatan jatuh & 6 benar medikasi	Sering melanggar; ada kesalahan kritis	Cukup patuh; masih ada kekurangan	Patuh; tanpa kesalahan kritis	Sangat patuh; antisipatif risiko dan terdokumentasi

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan edukasi–discharge plan (teach-back)	Tidak terstruktur; pemahaman tidak terbukti	Terstruktur sebagian; bukti pemahaman terbatas	Terstruktur; bukti pemahaman memadai	Sangat terstruktur; bukti pemahaman kuat & terdokumentasi
7.2 Kelengkapan SBAR & dokumentasi terintegrasi	Informasi kritis hilang; tidak dapat diaudit	Informasi inti ada; masih kurang spesifik	Lengkap; runtut; dapat ditindaklanjuti	Sangat lengkap; ringkas; risiko terantisipasi; sangat dapat diaudit

Capaian Pembelajaran Bab (CP Bab)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

1. Menganalisis konsep sehat–sakit secara holistik meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual.
2. Menjelaskan dan menginterpretasikan mekanisme homeostasis serta respon adaptasi tubuh terhadap perubahan kondisi.
3. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kebutuhan dasar manusia berdasarkan teori Maslow, Henderson, dan Orem.
4. Menganalisis hubungan antara gangguan kebutuhan dasar dengan kondisi klinis pasien.
5. Menerapkan clinical reasoning dalam menentukan masalah dan prioritas kebutuhan pasien pada kasus sederhana.
6. Menganalisis peran perawat dalam mendukung self-care dan kemandirian pasien.

7. Mengevaluasi kondisi pasien secara sederhana berdasarkan konsep sehat–sakit dan kebutuhan dasar manusia.

A. Teori Dasar

1. Konsep Sehat dan Sakit

Sehat tidak hanya diartikan sebagai ketiadaan penyakit, tetapi merupakan kondisi kesejahteraan yang menyeluruh meliputi aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menurut World Health Organization (WHO), sehat adalah keadaan sejahtera secara utuh yang memungkinkan individu menjalani kehidupan secara produktif dan bermakna.

Konsep sehat–sakit bersifat kontinum, di mana individu tidak selalu berada pada kondisi sehat atau sakit secara absolut, melainkan bergerak secara dinamis di antara kedua kondisi tersebut. Seseorang dengan penyakit kronis tetap dapat berada pada kondisi “sehat adaptif” apabila mampu mengelola penyakitnya secara efektif, memiliki coping yang baik, serta mempertahankan kualitas hidup yang optimal.

Sakit merupakan kondisi terganggunya fungsi normal tubuh yang dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, sosial, maupun lingkungan. Dalam praktik keperawatan, sakit tidak hanya dilihat berdasarkan diagnosis medis, tetapi juga berdasarkan respons individu terhadap penyakit yang dialaminya. Oleh karena itu, perawat dituntut untuk memahami pasien secara holistik dan komprehensif.

2. Faktor yang Mempengaruhi Status Kesehatan

Status kesehatan individu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, antara lain:

- a. Faktor biologis, meliputi usia, jenis kelamin, genetika, dan kondisi fisiologis tubuh.
- b. Faktor psikologis, meliputi tingkat stres, kecemasan, persepsi terhadap penyakit, serta mekanisme coping.
- c. Faktor sosial, meliputi dukungan keluarga, status ekonomi, pendidikan, dan budaya.
- d. Faktor lingkungan, meliputi sanitasi, tempat tinggal, akses terhadap fasilitas kesehatan, serta kondisi lingkungan sekitar.
- e. Faktor perilaku, meliputi pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, kepatuhan terhadap pengobatan, serta gaya hidup secara umum.

Pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut sangat penting bagi perawat dalam melakukan pengkajian secara menyeluruh serta menentukan intervensi keperawatan yang tepat, efektif, dan berpusat pada pasien.

3. Homeostasis dan Regulasi Tubuh

Homeostasis merupakan kemampuan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan internal yang relatif stabil meskipun terjadi perubahan pada lingkungan eksternal. Keseimbangan ini sangat penting untuk menjaga fungsi fisiologis tubuh tetap optimal. Mekanisme homeostasis dikendalikan oleh beberapa sistem utama, yaitu:

- a. Sistem saraf
- b. Sistem endokrin
- c. Mekanisme umpan balik (feedback mechanism)

Terdapat dua jenis mekanisme umpan balik dalam homeostasis, yaitu:

- a. Negative feedback, yaitu mekanisme yang berfungsi untuk mempertahankan kestabilan kondisi tubuh, misalnya pengaturan suhu tubuh.
- b. Positive feedback, yaitu mekanisme yang memperkuat respons tubuh hingga tercapai suatu kondisi tertentu, misalnya pada proses persalinan.

Gangguan homeostasis dapat menyebabkan berbagai kondisi patologis, antara lain:

- a. Hipertensi, akibat gangguan regulasi tekanan darah
- b. Diabetes melitus, akibat gangguan regulasi kadar glukosa darah
- c. Gagal napas, akibat gangguan pertukaran oksigen dan karbon dioksida

Dalam praktik keperawatan, pemahaman terhadap homeostasis menjadi dasar dalam mengidentifikasi perubahan kondisi pasien serta menentukan tindakan keperawatan yang tepat.

4. Kebutuhan Dasar Manusia

a. Teori Hierarki Kebutuhan Maslow

Menurut Maslow, kebutuhan manusia tersusun secara hierarkis, yaitu:

- 1) Kebutuhan fisiologis (oksigen, nutrisi, cairan, eliminasi)
- 2) Kebutuhan keamanan dan keselamatan
- 3) Kebutuhan cinta dan rasa memiliki
- 4) Kebutuhan harga diri
- 5) Kebutuhan aktualisasi diri
- 6) Pemenuhan kebutuhan dimulai dari tingkat paling dasar hingga tingkat tertinggi.

b. Teori Virginia Henderson

Virginia Henderson mengidentifikasi 14 kebutuhan dasar manusia yang menjadi dasar dalam praktik keperawatan, di antaranya:

- 1) Bernapas secara normal
- 2) Makan dan minum yang adekuat
- 3) Eliminasi
- 4) Bergerak dan mempertahankan posisi tubuh
- 5) Istirahat dan tidur

Teori ini menekankan bahwa perawat berperan membantu individu dalam memenuhi kebutuhan dasar yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri.

- c. Teori Orem (Self-Care) Teori Orem menekankan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk melakukan perawatan diri (self-care) guna mempertahankan kesehatan dan kesejahteraannya. Peran perawat dalam teori ini meliputi:

- 1) Memberikan bantuan ketika pasien tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya
- 2) Mendukung dan meningkatkan kemandirian pasien
- 3) Memberikan edukasi untuk meningkatkan kemampuan self-care

Pendekatan ini sangat relevan dalam praktik keperawatan modern, terutama pada pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan pengelolaan jangka panjang.

5. Integrasi Konsep dalam Praktik Keperawatan

Dalam praktik keperawatan, perawat harus mampu mengintegrasikan konsep sehat-sakit, homeostasis, dan kebutuhan dasar manusia dalam proses pengambilan keputusan klinis. Perawat perlu mengaitkan:

- a. Gangguan homeostasis dengan munculnya tanda dan gejala klinis
- b. Gangguan kebutuhan dasar dengan prioritas asuhan keperawatan Sebagai contoh, pada pasien dengan hipertensi dapat ditemukan beberapa gangguan kebutuhan dasar, seperti:
 - 1) Gangguan oksigenasi akibat peningkatan beban kerja jantung
 - 2) Gangguan istirahat dan tidur akibat ketidaknyamanan
 - 3) Gangguan nutrisi akibat pola makan yang tidak terkontrol

Melalui pendekatan ini, perawat dapat menentukan prioritas masalah serta memberikan asuhan keperawatan yang tepat, komprehensif, dan berpusat pada pasien.

6. Integrasi SDKI-SIKI-SLKI Dalam Asuhan Keperawatan

Dalam konteks praktik keperawatan di Indonesia, penggunaan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI), dan Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) merupakan komponen yang sangat penting dan wajib diintegrasikan dalam proses pembelajaran maupun praktik klinik. Ketiga standar ini menjadi acuan nasional

dalam memberikan asuhan keperawatan yang sistematis, terukur, dan berbasis evidensi (PPNI, 2021).

Integrasi SDKI–SIKI–SLKI dalam bab ini bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami bagaimana konsep sehat–sakit, homeostasis, dan kebutuhan dasar manusia dapat diterjemahkan ke dalam praktik keperawatan yang nyata dan terstandar. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam bentuk diagnosis, intervensi, dan luaran keperawatan secara tepat.

a. Diagnosis Keperawatan (SDKI)

Diagnosis keperawatan merupakan pernyataan klinis mengenai respons individu terhadap masalah kesehatan yang dialami, baik aktual maupun potensial. Diagnosis ini disusun berdasarkan hasil pengkajian yang komprehensif dan menjadi dasar dalam perencanaan intervensi keperawatan.

Berdasarkan kasus pada bab ini (pasien dengan hipertensi, pusing, mudah lelah, dan sulit tidur), beberapa diagnosis keperawatan yang dapat diidentifikasi antara lain:

- 1) Gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan peningkatan tekanan darah
- 2) Gangguan pola tidur berhubungan dengan ketidaknyamanan fisik dan kecemasan
- 3) Ansietas berhubungan dengan kondisi kesehatan yang dialami
- 4) Ketidakefektifan manajemen kesehatan berhubungan dengan kurangnya pengetahuan

Penentuan diagnosis ini mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan clinical reasoning, yaitu menghubungkan data klinis dengan konsep teoritis secara sistematis dan logis.

b. Intervensi Keperawatan (SIKI)

Intervensi keperawatan merupakan tindakan yang direncanakan dan dilakukan oleh perawat untuk mengatasi masalah keperawatan yang telah diidentifikasi. Intervensi harus disesuaikan dengan kondisi pasien, berbasis evidensi, serta berorientasi pada keselamatan pasien.

Contoh intervensi yang dapat dilakukan pada kasus ini antara lain:

- 1) Manajemen tekanan darah: memonitor tekanan darah secara berkala dan mencatat perubahan
- 2) Manajemen istirahat dan tidur: menciptakan lingkungan yang nyaman dan memberikan edukasi tentang pola tidur
- 3) Manajemen ansietas: memberikan dukungan emosional dan teknik relaksasi

- 4) Edukasi kesehatan: memberikan informasi tentang pola hidup sehat, diet rendah garam, dan kepatuhan pengobatan

Intervensi ini mencerminkan peran perawat dalam membantu pasien memenuhi kebutuhan dasar serta mengembalikan keseimbangan homeostasis tubuh.

c. Luaran Keperawatan (SLKI)

Luaran keperawatan merupakan hasil yang diharapkan setelah dilakukan intervensi keperawatan. Luaran digunakan untuk mengevaluasi efektivitas tindakan yang telah diberikan.

Contoh luaran pada kasus ini antara lain:

- 1) Tekanan darah dalam batas normal atau mendekati normal
- 2) Pola tidur pasien membaik
- 3) Tingkat kecemasan menurun
- 4) Pasien menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap kondisi kesehatannya

Luaran ini harus bersifat spesifik, terukur, dan dapat diamati, sehingga memudahkan perawat dalam melakukan evaluasi secara objektif.

d. Integrasi SDKI–SIKI–SLKI dalam Clinical Reasoning

Penggunaan SDKI–SIKI–SLKI dalam proses keperawatan menunjukkan bahwa mahasiswa telah mampu mengintegrasikan konsep teoritis dengan praktik klinik secara sistematis. Proses ini melibatkan tahapan:

- 1) Pengkajian data pasien
- 2) Penentuan diagnosis (SDKI)
- 3) Perencanaan intervensi (SIKI)
- 4) Penetapan luaran (SLKI)
- 5) Evaluasi hasil asuhan

Pendekatan ini memperkuat kemampuan clinical reasoning mahasiswa dalam menentukan keputusan keperawatan yang tepat dan aman.

e. Makna Integrasi dalam OBE

Dalam pendekatan Outcome-Based Education (OBE), integrasi SDKI–SIKI–SLKI merupakan indikator bahwa mahasiswa telah mencapai kompetensi pada level tinggi, yaitu mampu menerapkan pengetahuan dalam praktik nyata. Mahasiswa tidak hanya memahami konsep sehat–sakit dan homeostasis, tetapi juga mampu menerjemahkannya ke dalam tindakan keperawatan yang terstandar dan profesional.

Integrasi ini juga memastikan bahwa lulusan keperawatan memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional serta siap menghadapi tuntutan praktik klinik di lapangan.

B. AKTIVITAS BELAJAR (SCAFFOLDING)

Pendekatan pembelajaran pada bab ini menggunakan prinsip scaffolding learning, yaitu proses pembelajaran bertahap yang dirancang untuk membantu mahasiswa berkembang dari tingkat pemahaman dasar menuju kemampuan berpikir tingkat tinggi dan penerapan klinis. Dalam pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi dibimbing secara sistematis untuk membangun pengetahuan, mengaitkan konsep, serta mengaplikasikannya dalam situasi nyata.

Scaffolding learning dalam pendidikan keperawatan selaras dengan piramida Miller, yang terdiri dari empat level kompetensi, yaitu *knows*, *knows how*, *shows how*, dan *does*. Pada tahap awal, mahasiswa memahami konsep (*knows*), kemudian meningkat pada kemampuan analisis (*knows how*), selanjutnya mampu mendemonstrasikan keterampilan (*shows how*), hingga akhirnya mampu menerapkan secara mandiri di praktik klinik (*does*) (Ten Cate et al., 2021; Yardley et al., 2022).

aktivitas belajar pada bab ini, mahasiswa diarahkan untuk mengintegrasikan konsep sehat-sakit, homeostasis, dan kebutuhan dasar manusia dalam proses clinical reasoning, yaitu kemampuan berpikir sistematis dalam menginterpretasikan data pasien, mengidentifikasi masalah, serta menentukan prioritas tindakan keperawatan secara tepat dan aman. Kemampuan ini menjadi fondasi penting dalam praktik keperawatan profesional (Levett-Jones et al., 2021).

Selain itu, pembelajaran dirancang berbasis student-centered learning, di mana mahasiswa aktif berdiskusi, menganalisis, dan merefleksikan pembelajaran. Dosen berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan, umpan balik, serta penguatan konsep untuk memastikan tercapainya capaian pembelajaran secara optimal.

1. Aktivitas 1 - Knows / Knows How

Mini Case Diskusi (Diskusi Kelompok)

Seorang pasien laki-laki usia 55 tahun datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan keluhan utama pusing sejak beberapa hari terakhir. Pasien juga mengeluhkan mudah lelah, sulit tidur, dan merasa cemas terhadap kondisi kesehatannya. Pasien menyatakan bahwa keluhan tersebut semakin mengganggu aktivitas sehari-hari.

Hasil pengkajian awal menunjukkan:

- Tekanan darah: 160/100 mmHg
- Nadi: 92 kali/menit
- Pasien tampak gelisah dan cemas

Kasus ini menunjukkan adanya kemungkinan gangguan pada sistem regulasi tubuh, khususnya terkait homeostasis tekanan darah, serta adanya keterkaitan antara aspek fisiologis dan psikologis pasien. Kondisi hipertensi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan ketidakseimbangan sistem kardiovaskular, yang berdampak pada munculnya gejala seperti pusing dan kelelahan. Selain itu, kondisi psikologis seperti kecemasan juga dapat memperburuk respon fisiologis tubuh melalui aktivasi sistem saraf simpatis (Hinkle & Cheever, 2022; Potter et al., 2021).

Dalam konteks ini, mahasiswa diharapkan memahami bahwa kondisi pasien tidak dapat dianalisis secara parsial, tetapi harus menggunakan pendekatan holistik, yang mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan kebutuhan dasar manusia. Hal ini sejalan dengan paradigma keperawatan yang menempatkan pasien sebagai individu yang utuh. Mahasiswa diminta untuk berdiskusi dalam kelompok kecil guna menganalisis kasus secara komprehensif dengan mengintegrasikan konsep teoritis yang telah dipelajari.

Pertanyaan Diskusi:

- a. Analisis kondisi sehat–sakit pasien berdasarkan pendekatan holistik (biologis, psikologis, sosial, dan spiritual).
- b. Jelaskan gangguan homeostasis yang terjadi pada pasien serta mekanisme fisiologis yang mendasarinya.
- c. Identifikasi kebutuhan dasar manusia yang terganggu berdasarkan teori Maslow, Henderson, atau Orem.
- d. Tentukan prioritas masalah keperawatan berdasarkan kondisi pasien dan tingkat urgensi.
- e. Jelaskan hubungan antara kondisi fisiologis dan psikologis pasien dalam kasus tersebut.

Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan critical thinking dan clinical reasoning, yaitu kemampuan untuk menghubungkan data klinis dengan konsep teoritis secara logis, sistematis, dan berbasis evidensi. Proses diskusi ini juga melatih kemampuan komunikasi, kolaborasi, serta pengambilan keputusan dalam konteks keperawatan (Levett-Jones et al., 2021).

Hasil diskusi dipresentasikan di kelas untuk mendapatkan umpan balik dari dosen dan kelompok lain, sehingga terjadi proses pembelajaran reflektif yang memperkuat pemahaman mahasiswa.

2. Aktivitas 2 - Shows How

Simulasi / Skill Lab

Pada tahap ini, mahasiswa memasuki level “shows how”, yaitu kemampuan untuk mendemonstrasikan pengetahuan dalam bentuk keterampilan klinik yang

terstruktur dan terukur. Kegiatan dilakukan melalui simulasi di laboratorium keterampilan (skill lab) dengan menggunakan skenario kasus yang telah diberikan.

Simulasi dirancang untuk menyerupai kondisi klinis nyata, sehingga mahasiswa dapat berlatih mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional secara simultan. Dalam kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya dinilai dari hasil akhir, tetapi juga dari proses berpikir dan tindakan yang dilakukan.

Mahasiswa diminta untuk:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan dasar pasien secara sistematis berdasarkan data pengkajian
- b. Menentukan prioritas masalah keperawatan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan risiko
- c. Menjelaskan hubungan antara gangguan homeostasis dengan tanda dan gejala yang muncul
- d. Mengkomunikasikan hasil analisis secara jelas, logis, dan terapeutik
- e. Menunjukkan sikap profesional, termasuk menjaga keselamatan pasien dan etika komunikasi

Simulasi ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam mengintegrasikan pengetahuan teoritis dengan praktik klinik secara aman dan efektif. Selain itu, mahasiswa juga dilatih untuk mengembangkan clinical judgment, yaitu kemampuan dalam mengambil keputusan klinis berdasarkan data yang tersedia (INACSL Standards Committee, 2021; Yardley et al., 2022).

Dalam pelaksanaannya, dosen memberikan umpan balik langsung (feedback) setelah simulasi, yang bersifat konstruktif dan berorientasi pada perbaikan performa. Mahasiswa juga didorong untuk melakukan refleksi diri terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

Pendekatan ini penting untuk membangun kompetensi klinik yang berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa, serta mempersiapkan mahasiswa menghadapi situasi nyata di lahan praktik (Cant & Cooper, 2021).

KESIMPULAN AKTIVITAS BELAJAR

Melalui rangkaian aktivitas belajar berbasis scaffolding ini, mahasiswa diharapkan mampu berkembang secara bertahap dari pemahaman konsep menuju kemampuan analisis dan demonstrasi keterampilan klinik. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup aspek psikomotor dan afektif yang sangat penting dalam praktik keperawatan.

Integrasi antara teori dan praktik melalui pendekatan kasus dan simulasi memungkinkan mahasiswa untuk memahami keterkaitan antara konsep sehat–

sakit, homeostasis, dan kebutuhan dasar manusia dengan kondisi klinis pasien. Hal ini akan memperkuat kemampuan mahasiswa dalam melakukan clinical reasoning, menentukan prioritas masalah, serta memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan berpusat pada pasien.

Dengan demikian, aktivitas belajar pada bab ini menjadi landasan penting dalam membentuk kompetensi mahasiswa sebagai calon perawat profesional yang mampu berpikir kritis, bertindak tepat, serta menjunjung tinggi keselamatan dan kualitas pelayanan keperawatan.

Keterkaitan CPL, Aktivitas Pembelajaran, dan Asesmen (OBE Alignment)

Dalam pendekatan Outcome-Based Education (OBE), setiap capaian pembelajaran (CPL) harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan aktivitas pembelajaran dan metode asesmen. Keterkaitan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan benar-benar mengarah pada pencapaian kompetensi yang diharapkan, serta dapat diukur secara objektif melalui asesmen yang sesuai (Biggs & Tang, 2022).

Alignment antara CPL, aktivitas, dan asesmen merupakan prinsip utama dalam constructive alignment, di mana seluruh komponen pembelajaran dirancang secara selaras dan terintegrasi. Dengan adanya keterkaitan ini, mahasiswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks klinik secara nyata.

Makna Alignment dalam OBE

Keterkaitan antara CPL, aktivitas pembelajaran, dan asesmen menunjukkan bahwa proses pembelajaran dirancang secara sistematis dan berorientasi pada hasil. Setiap aktivitas yang dilakukan mahasiswa memiliki tujuan yang jelas dan diukur melalui metode asesmen yang relevan.

Pendekatan ini memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan klinik, kemampuan berpikir kritis, serta sikap profesional dalam praktik keperawatan.

Keunggulan Pendekatan Ini

Dengan adanya alignment ini, pembelajaran menjadi:

1. Terarah dan sistematis
2. Terukur dan objektif
3. Berbasis kompetensi
4. Selaras dengan standar akreditasi LAMDIK dan OBE
5. Mendukung kesiapan mahasiswa dalam praktik klinik nyata

C. ASESMEN (OBE – PIRAMIDA MILLER)

Asesmen pada bab ini dirancang berdasarkan prinsip Outcome-Based Education (OBE) dan mengacu pada Piramida Miller, yang menekankan bahwa kompetensi mahasiswa harus dinilai secara bertahap mulai dari pengetahuan hingga performa nyata dalam praktik klinik. Penilaian tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup aspek psikomotor dan afektif secara terintegrasi.

Dalam konteks ini, asesmen dilakukan melalui beberapa metode utama, yaitu analisis kasus (knows how), Objective Structured Clinical Examination (OSCE) pada level shows how, serta Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada level does. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya secara aman, tepat, dan profesional dalam situasi klinik nyata (Ten Cate et al., 2021; INACSL Standards Committee, 2021).

1. ASESMEN BERDASARKAN PIRAMIDA MILLER

Level Miller	Tujuan	Metode Penilaian
Knows	Memahami konsep	Self-check
Knows How	Analisis kasus	Diskusi & mini-case
Shows How	Demonstrasi keterampilan	OSCE
Does	Praktik nyata	DOPS

2. OSCE (OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION)

No	Komponen	Isi
1	Nomor station	(Diisi oleh panitia)
2	Judul Station	Analisis Kebutuhan Dasar dan Homeostasis Pasien
3	Waktu	12–15 menit
4	Tujuan	Menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan analisis kondisi pasien berdasarkan konsep sehat–sakit, homeostasis, dan kebutuhan dasar manusia
5	Kompetensi	1. Pengkajian 2. Clinical reasoning 3. Penentuan prioritas 4. Komunikasi terapeutik 5. Profesionalisme
6	Kategori	Fisiologis, psikologis, kebutuhan dasar, keselamatan pasien

3. Instruksi Untuk Peserta

Skenario Klinik:

Seorang laki-laki usia 55 tahun datang ke fasilitas kesehatan dengan keluhan pusing, mudah lelah, sulit tidur, dan merasa cemas. Hasil pengkajian menunjukkan tekanan darah 160/100 mmHg dan nadi 92x/menit.

Tugas Peserta:

- Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario
- Identifikasi kebutuhan dasar yang terganggu
- Tentukan masalah keperawatan prioritas
- Jelaskan hubungan gangguan homeostasis dengan gejala
- Lakukan komunikasi terapeutik kepada pasien

4. Instruksi Untuk Penguji

Penguji menilai:

- Ketepatan mahasiswa dalam mengidentifikasi data klinis
- Kemampuan menganalisis gangguan homeostasis
- Kemampuan menentukan prioritas kebutuhan pasien
- Kemampuan menjelaskan kondisi pasien secara logis
- Perilaku profesional dan komunikasi

5. Critical Items (Wajib Lulus)

Mahasiswa dinyatakan tidak lulus apabila tidak memenuhi poin berikut:

- Tidak melakukan hand hygiene
- Tidak menjaga keselamatan pasien
- Salah menentukan prioritas masalah
- Tidak mampu mengidentifikasi kondisi klinis utama

6. Form Penilai OSCE

No	Kompetensi	Indikator	Skor (0-3)	Bobot	Nilai
1	Pengkajian	Mengidentifikasi data pasien secara sistematis		2	
2	Analisis	Clinical Reasoning (analisis logis dan tepat)		3	
3	Prioritas	Penentuan masalah keperawatan utama		3	
4	Komunikasi	Komunikasi Teraupetik		1	
5	Profesionalisme	Etika dan Keselamatan		1	

Keterangan:

- Skor (0–3) diisi oleh penguji berdasarkan performa mahasiswa
- Bobot menunjukkan tingkat kepentingan setiap kompetensi

c. Nilai akhir dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Nilai} = \text{Skor} \times \text{Bobot}$$

Rubrik Penilaian OSCE

Deskripsi Skor:

Skor	Kriteria
0	Tidak dilakukan
1	Tidak tepat
2	Cukup tepat
3	Tepat, lengkap dan sistematis

Deskripsi Performa:

1. Pengkajian

- 0: Tidak melakukan pengkajian
- 1: Tidak lengkap
- 2: Cukup
- 3: Lengkap dan sistematis

2. Clinical Reasoning

- 0: Tidak logis
- 1: Banyak kesalahan
- 2: Cukup logis
- 3: Sangat logis dan tepat

3. Prioritas Masalah

- 0: Salah total
- 1: Tidak tepat
- 2: Cukup
- 3: Tepat dan prioritas

4. Komunikasi

- 0: Tidak komunikatif
- 1: Kurang
- 2: Cukup
- 3: Empatik dan jelas

5. Profesionalisme

- 0: Tidak profesional
- 1: Kurang
- 2: Cukup
- 3: Sangat profesional

DOPS (DIRECT OBSERVATION OF PROCEDURAL SKILLS)

A. Deskripsi DOPS

DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa mahasiswa dalam situasi klinik nyata. Metode ini menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam praktik keperawatan.

B. Komponen OBE

Komponen	Deskripsi
Pengkajian	Mengidentifikasi kondisi pasien
Analisis	Clinical reasoning
Tindakan	Penentuan Prioritas
Komunikasi	Teraupetik
Profesionalisme	Etika dan Keselamatan

C. Format Penilaian OBE

Aspek	Kompeten	Perlu Supervisi	Remedia
Pengkajian			
Analisis			
Tindakan			
Komunikasi			
Profesionalisme			

D. Umpan Balik

Umpan balik diberikan segera setelah observasi, meliputi:

1. Kekuatan mahasiswa
2. Area yang perlu diperbaiki
3. Rekomendasi tindak lanjut

Makna Asesmen Dalam OBE

Asesmen ini memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa:

- a. Tidak hanya memahami teori
- b. Tetapi mampu menerapkan dalam praktik nyata
- c. Menunjukkan performa klinik yang konsisten

Pendekatan ini memastikan bahwa lulusan keperawatan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

D. PORTOFOLIO

Portofolio merupakan salah satu metode asesmen autentik dalam pendekatan Outcome-Based Education (OBE) yang digunakan untuk menilai perkembangan kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan dan komprehensif. Portofolio tidak

hanya berisi hasil akhir pembelajaran, tetapi juga mencerminkan proses belajar, kemampuan analisis, keterampilan klinik, serta sikap profesional mahasiswa dalam praktik keperawatan (Ten Cate et al., 2021).

Dalam pendidikan keperawatan, portofolio memiliki peran penting sebagai bukti bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam situasi klinik nyata. Portofolio memungkinkan dosen dan pembimbing klinik untuk menilai konsistensi performa mahasiswa dari waktu ke waktu, sehingga memberikan gambaran yang lebih valid terhadap pencapaian capaian pembelajaran (Levett-Jones et al., 2021).

Bukti yang Dikumpulkan dalam Portofolio

Portofolio pada bab ini mencakup beberapa komponen utama yang saling melengkapi, yaitu:

1. Analisis Kasus

Analisis kasus merupakan bagian penting dalam portofolio yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan clinical reasoning. Mahasiswa diminta untuk menganalisis kasus pasien secara sistematis, meliputi pengkajian data subjektif dan objektif, identifikasi masalah, penentuan prioritas, serta perencanaan intervensi keperawatan.

Melalui analisis kasus, mahasiswa belajar untuk menghubungkan konsep sehat-sakit, homeostasis, dan kebutuhan dasar manusia dengan kondisi klinik pasien secara nyata. Kemampuan ini sangat penting dalam praktik keperawatan karena perawat dituntut untuk mampu mengambil keputusan berbasis data dan evidensi (Potter et al., 2021; Hinkle & Cheever, 2022).

2. Hasil OSCE (Objective Structured Clinical Examination)

Hasil OSCE menjadi bukti kemampuan mahasiswa dalam mendemonstrasikan keterampilan klinik secara terstruktur dan terstandar. OSCE menilai aspek pengkajian, analisis, komunikasi, serta perilaku profesional mahasiswa dalam situasi simulasi yang menyerupai kondisi klinik nyata.

Dalam portofolio, hasil OSCE tidak hanya dilihat dari skor akhir, tetapi juga dari umpan balik yang diberikan oleh penguji. Hal ini bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan performa pada kesempatan berikutnya (INACSL Standards Committee, 2021).

3. Refleksi Pembelajaran

Refleksi merupakan komponen penting dalam portofolio yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan evaluasi diri terhadap pengalaman belajar dan praktik klinik. Melalui refleksi, mahasiswa mengidentifikasi hal-hal yang

telah dilakukan dengan baik, kesalahan yang mungkin terjadi, serta rencana perbaikan di masa mendatang.

Refleksi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap keselamatan pasien (patient safety) dan tanggung jawab profesional. Proses reflektif ini terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan klinis (Yardley et al., 2022).

4. Feedback Dosen / Clinical Instructor

Umpan balik dari dosen atau clinical instructor (CI) merupakan bagian integral dari portofolio yang berfungsi sebagai panduan dalam pengembangan kompetensi mahasiswa. Feedback yang diberikan bersifat spesifik, konstruktif, dan berorientasi pada perbaikan performa.

Melalui feedback, mahasiswa dapat mengetahui area kekuatan yang perlu dipertahankan serta area yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, feedback juga membantu mahasiswa dalam membangun sikap reflektif dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan secara berkelanjutan (Cant & Cooper, 2021).

Karakteristik Penilaian Portofolio

Penilaian portofolio memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

1. Berkelanjutan (continuous assessment), dilakukan secara bertahap selama proses pembelajaran
2. Komprehensif, mencakup aspek kognitif, psikomotor, dan afektif
3. Berbasis performa nyata, menilai kemampuan mahasiswa dalam praktik
4. Reflektif, mendorong mahasiswa untuk mengevaluasi diri

Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih holistik dibandingkan dengan metode evaluasi tradisional yang hanya berfokus pada hasil ujian.

Makna Portofolio dalam OBE

Dalam konteks OBE, portofolio merupakan bukti autentik bahwa mahasiswa telah mencapai capaian pembelajaran secara nyata. Portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya mampu memahami konsep sehat-sakit, homeostasis, dan kebutuhan dasar manusia, tetapi juga mampu menerapkannya secara konsisten dalam analisis kasus, simulasi klinik, dan praktik lapangan.

Dengan demikian, portofolio menjadi alat penting dalam memastikan bahwa lulusan keperawatan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan, yaitu mampu berpikir kritis, bertindak tepat, serta menjunjung tinggi keselamatan pasien.

CASE REPORT

Case report merupakan salah satu metode pembelajaran dan asesmen dalam pendekatan Outcome-Based Education (OBE) yang bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam mengintegrasikan pengetahuan teoritis dengan praktik klinik secara sistematis. Melalui penyusunan case report, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan clinical reasoning, yaitu kemampuan untuk menganalisis data pasien, mengidentifikasi masalah, menentukan intervensi, serta mengevaluasi hasil asuhan keperawatan secara logis dan berbasis evidensi (Levett-Jones et al., 2021).

Dalam konteks pembelajaran keperawatan dasar, case report tidak hanya berfungsi sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk pola pikir klinis yang terstruktur. Mahasiswa dilatih untuk melihat pasien secara holistik dengan mempertimbangkan aspek fisiologis, psikologis, sosial, dan kebutuhan dasar manusia, sehingga dapat memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif (Potter et al., 2021; Hinkle & Cheever, 2022).

1. Tujuan Case Report

Penyusunan case report bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan kemampuan analisis klinis mahasiswa
- b. Melatih penerapan konsep sehat–sakit, homeostasis, dan kebutuhan dasar manusia
- c. Meningkatkan kemampuan dokumentasi ilmiah dalam keperawatan
- d. Membiasakan mahasiswa berpikir sistematis dan berbasis data
- e. Mengintegrasikan teori dengan praktik keperawatan

2. Struktur Case Report

Mahasiswa menyusun laporan kasus secara sistematis dengan komponen sebagai berikut:

a. Data Pasien

Mahasiswa mengumpulkan data pasien secara komprehensif, meliputi:

- 1) Identitas pasien (inisial, usia, jenis kelamin)
- 2) Keluhan utama
- 3) Riwayat penyakit sekarang
- 4) Data subjektif (keluhan pasien)
- 5) Data objektif (tanda vital, hasil pemeriksaan fisik)

Contoh: Pasien laki-laki usia 55 tahun dengan keluhan pusing, mudah lelah, sulit tidur, tekanan darah 160/100 mmHg, dan tampak cemas.

Pengumpulan data yang lengkap dan akurat menjadi dasar dalam menentukan analisis masalah dan intervensi keperawatan yang tepat.

b. Analisis Kebutuhan (Clinical Reasoning)

Mahasiswa melakukan analisis terhadap data pasien untuk mengidentifikasi:

- 1) Gangguan homeostasis yang terjadi
- 2) Kebutuhan dasar manusia yang terganggu
- 3) Faktor risiko yang mempengaruhi kondisi pasien

Contoh analisis: Gangguan homeostasis: peningkatan tekanan darah (hipertensi)

Kebutuhan dasar terganggu:

- a) Istirahat dan tidur
- b) Oksigenasi
- c) Kebutuhan psikologis (cemas)

Pada tahap ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan clinical reasoning, yaitu menghubungkan data klinis dengan konsep teoritis secara logis dan sistematis (Levett-Jones et al., 2021).

c. Intervensi Keperawatan

Mahasiswa merencanakan dan menjelaskan intervensi keperawatan yang sesuai berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi.

Contoh intervensi:

- 1) Monitoring tekanan darah secara berkala
- 2) Edukasi pasien tentang pola hidup sehat
- 3) Manajemen stres dan relaksasi
- 4) Anjuran istirahat yang cukup

Intervensi yang direncanakan harus bersifat:

- 1) Relevan dengan kondisi pasien
- 2) Berbasis evidensi
- 3) Berorientasi pada keselamatan pasien

d. Evaluasi

Mahasiswa mengevaluasi hasil intervensi yang telah dilakukan, meliputi:

- 1) Perubahan kondisi pasien
- 2) Respon pasien terhadap tindakan
- 3) Pencapaian tujuan keperawatan

Contoh evaluasi:

- 1) Pasien melaporkan penurunan keluhan pusing
- 2) Pasien tampak lebih rileks
- 3) Tekanan darah menunjukkan perbaikan

Evaluasi menjadi bagian penting untuk menilai efektivitas asuhan keperawatan serta menentukan tindak lanjut yang diperlukan.

3. Contoh Format Case Report

- a. Identitas Pasien: Laki-laki, 55 tahun
- b. Keluhan Utama: Pusing, mudah lelah, sulit tidur
- c. Data Objektif: TD: 160/100 mmHg, Nadi: 92x/menit
- d. Analisis: Gangguan homeostasis tekanan darah, kebutuhan istirahat dan psikologis terganggu
- e. Intervensi: Monitoring tekanan darah, edukasi, relaksasi
- f. Evaluasi: Keluhan berkurang, kondisi lebih stabil

4. Fokus Penilaian Case Report

Penilaian case report mencakup beberapa aspek, yaitu:

- a. Ketepatan pengumpulan data
- b. Kejelasan analisis masalah
- c. Logika clinical reasoning
- d. Ketepatan intervensi
- e. Kemampuan evaluasi
- f. Keterampilan dokumentasi

5. Makna Case Report dalam OBE

Dalam pendekatan OBE, case report memberikan bukti bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam analisis kasus nyata. Case report menjadi indikator penting bahwa mahasiswa telah mencapai capaian pembelajaran pada level *knows how* hingga *shows how*, yaitu mampu mengintegrasikan pengetahuan dengan praktik secara sistematis. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan klinis, serta tanggung jawab profesional dalam memberikan asuhan keperawatan.

E. Refleksi Patient Safety

Refleksi patient safety merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran keperawatan berbasis Outcome-Based Education (OBE) yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kesadaran profesional, serta tanggung jawab mahasiswa terhadap keselamatan pasien. Refleksi tidak hanya berisi deskripsi pengalaman, tetapi juga analisis mendalam terhadap risiko, tindakan yang dilakukan, serta pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman tersebut (Levett-Jones et al., 2021).

Dalam praktik keperawatan, keselamatan pasien (patient safety) merupakan prioritas utama. Setiap tindakan yang dilakukan oleh perawat memiliki potensi risiko yang dapat berdampak pada kondisi pasien. Oleh karena itu, mahasiswa perlu dilatih

untuk mampu mengidentifikasi risiko secara dini, menganalisis penyebabnya, serta merencanakan tindakan pencegahan yang tepat (World Health Organization, 2021).

Refleksi patient safety membantu mahasiswa untuk memahami bahwa praktik keperawatan tidak hanya berfokus pada tindakan, tetapi juga pada upaya mencegah terjadinya kesalahan (error prevention) dan meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Proses refleksi ini terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan clinical reasoning dan pengambilan keputusan yang aman dalam praktik klinik (Yardley et al., 2022).

1. Tujuan Refleksi Patient Safety

Refleksi patient safety bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap risiko keselamatan pasien
- b. Mengembangkan kemampuan analisis terhadap potensi masalah klinis
- c. Melatih kemampuan berpikir kritis dan reflektif
- d. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keperawatan
- e. Menumbuhkan sikap profesional dan tanggung jawab etik

2. Komponen Refleksi Patient Safety

Mahasiswa diminta untuk menuliskan refleksi secara sistematis dengan mencakup beberapa komponen berikut:

a. Risiko Pasien

Mahasiswa mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi berdasarkan kondisi pasien. Risiko dapat berasal dari gangguan fisiologis, psikologis, maupun faktor lingkungan.

Contoh pada kasus:

- 1) Risiko krisis hipertensi akibat tekanan darah tinggi
- 2) Risiko gangguan perfusi jaringan
- 3) Risiko kelelahan akibat kurang istirahat
- 4) Risiko peningkatan kecemasan

Mahasiswa diharapkan mampu mengaitkan risiko tersebut dengan konsep homeostasis dan kebutuhan dasar manusia, sehingga dapat memahami akar masalah secara komprehensif.

b. Tindakan Pencegahan

Mahasiswa menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko yang telah diidentifikasi.

Contoh tindakan pencegahan:

- 1) Monitoring tekanan darah secara berkala
- 2) Edukasi pasien mengenai pola hidup sehat
- 3) Manajemen stres dan teknik relaksasi
- 4) Anjuran istirahat yang cukup

Tindakan pencegahan harus bersifat:

- 1) Berbasis evidensi
- 2) Berorientasi pada keselamatan pasien
- 3) Sesuai dengan kondisi klinis pasien

c. Pembelajaran (Learning Reflection)

Mahasiswa menuliskan pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman tersebut, meliputi:

- 1) Pemahaman baru yang didapat
- 2) Kesadaran terhadap pentingnya keselamatan pasien
- 3) Hal yang sudah dilakukan dengan baik
- 4) Hal yang perlu diperbaiki
- 5) Rencana peningkatan kompetensi ke depan

Contoh pembelajaran:

Mahasiswa menyadari bahwa pengkajian yang tidak lengkap dapat menyebabkan kesalahan dalam menentukan prioritas masalah, sehingga berpotensi membahayakan pasien. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dan sistematika dalam setiap tindakan keperawatan.

3. Contoh Refleksi Patient Safety

- a. Kondisi Pasien: Pasien laki-laki usia 55 tahun dengan hipertensi, keluhan pusing, dan sulit tidur.
- b. Risiko yang Diidentifikasi: Pasien berisiko mengalami krisis hipertensi dan gangguan perfusi jaringan akibat tekanan darah yang tinggi.
- c. Tindakan Pencegahan: Melakukan monitoring tekanan darah secara rutin, memberikan edukasi tentang diet rendah garam, serta mengajarkan teknik relaksasi untuk mengurangi kecemasan.
- d. Pembelajaran: Saya menyadari bahwa penting untuk mengidentifikasi risiko secara dini agar dapat mencegah komplikasi. Saya juga perlu meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengkajian secara sistematis.

F. Ringkasan

Bab ini menegaskan bahwa konsep sehat-sakit, homeostasis, dan kebutuhan dasar manusia merupakan landasan fundamental dalam praktik keperawatan yang harus dipahami secara komprehensif oleh setiap mahasiswa keperawatan. Pemahaman terhadap konsep sehat tidak lagi terbatas pada ketiadaan penyakit, tetapi mencakup kondisi kesejahteraan yang holistik meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Dengan demikian, perawat dituntut untuk mampu melihat pasien sebagai individu yang utuh, bukan hanya sebagai objek penyakit.

Konsep sehat-sakit yang bersifat kontinum menunjukkan bahwa kondisi kesehatan individu bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu, tergantung pada kemampuan adaptasi individu terhadap berbagai faktor internal dan eksternal. Dalam hal ini, peran perawat sangat penting dalam membantu pasien mempertahankan atau mencapai kondisi sehat optimal melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Homeostasis sebagai mekanisme tubuh dalam mempertahankan keseimbangan internal menjadi dasar dalam memahami berbagai perubahan fisiologis yang terjadi pada pasien. Setiap gangguan pada sistem tubuh, seperti peningkatan tekanan darah, gangguan metabolisme, atau ketidakseimbangan oksigenasi, merupakan bentuk terganggunya homeostasis yang dapat menimbulkan berbagai gejala klinis. Oleh karena itu, perawat harus mampu mengidentifikasi tanda dan gejala tersebut secara dini serta mengaitkannya dengan mekanisme fisiologis yang mendasarinya.

Kebutuhan dasar manusia menjadi fokus utama dalam asuhan keperawatan. Teori kebutuhan dasar seperti hierarki Maslow, teori Virginia Henderson, dan teori self-care Orem memberikan kerangka kerja bagi perawat dalam mengidentifikasi kebutuhan pasien yang terganggu dan menentukan prioritas intervensi. Pemenuhan kebutuhan dasar tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga mencakup kebutuhan psikologis dan sosial yang sangat mempengaruhi proses penyembuhan pasien.

Dalam praktik keperawatan, ketiga konsep ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Gangguan homeostasis akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yang pada akhirnya berdampak pada kondisi sehat-sakit pasien. Oleh karena itu, perawat harus mampu mengintegrasikan ketiga konsep tersebut dalam proses pengambilan keputusan klinis.

Kemampuan clinical reasoning menjadi kunci dalam menghubungkan antara data pasien, konsep teoritis, dan tindakan keperawatan. Clinical reasoning memungkinkan perawat untuk menganalisis kondisi pasien secara sistematis, mengidentifikasi masalah utama, serta menentukan prioritas asuhan yang tepat dan aman. Tanpa kemampuan ini, perawat berisiko melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien.

Pendekatan holistik dan berbasis self-care juga menjadi bagian penting dalam praktik keperawatan modern. Perawat tidak hanya berperan sebagai pemberi asuhan, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu pasien dalam meningkatkan kemandirian dan kemampuan merawat dirinya sendiri. Hal ini sangat penting terutama pada pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan pengelolaan jangka panjang.

Melalui pembelajaran pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengaplikasikan konsep sehat-sakit, homeostasis, dan kebutuhan dasar manusia secara terintegrasi dalam praktik keperawatan. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan klinis, serta sikap profesional yang berorientasi pada keselamatan pasien.

Dengan demikian, bab ini tidak hanya memberikan dasar teoritis, tetapi juga membekali mahasiswa dengan kemampuan analitis dan praktis yang diperlukan untuk menjadi perawat profesional yang kompeten, adaptif, dan berorientasi pada kualitas pelayanan kesehatan.

Red Flag dan Eskalasi

Dalam praktik keperawatan, kemampuan untuk mengenali tanda bahaya (red flags) merupakan kompetensi penting yang berkaitan langsung dengan keselamatan pasien (patient safety). Red flags adalah kondisi atau tanda klinis yang menunjukkan adanya gangguan serius pada fungsi tubuh yang memerlukan penanganan segera untuk mencegah terjadinya komplikasi atau kematian.

Perawat memiliki peran strategis dalam melakukan deteksi dini, interpretasi kondisi pasien, serta melakukan eskalasi secara tepat sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan. Ketepatan dalam mengenali red flags dan mengambil tindakan cepat merupakan bagian dari clinical reasoning dan pengambilan keputusan klinis yang krusial dalam praktik keperawatan (Levett-Jones et al., 2021; World Health Organization, 2021).

Pada konteks bab ini, red flags berkaitan erat dengan gangguan homeostasis dan kebutuhan dasar manusia, sehingga setiap perubahan kondisi pasien harus dianalisis secara komprehensif untuk menentukan tindakan yang tepat.

Tabel 2. 1 Red Flags dan Tindakan Eskalasi

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Keperawatan / Eskalasi
Penurunan kesadaran (somnolen, stupor, koma)	Menunjukkan gangguan serius pada sistem saraf pusat, perfusi otak, atau metabolisme	Segera lakukan penilaian tingkat kesadaran (GCS), pastikan airway paten, laporkan ke dokter, dan siapkan tindakan emergensi

Sesak napas (dyspnea)	Gangguan oksigenasi dan ventilasi yang dapat mengancam jiwa	Berikan posisi semi-Fowler/Fowler, pantau saturasi oksigen, berikan oksigen sesuai indikasi, dan segera eskalasi
Tekanan darah ekstrem ($\geq 180/120$ mmHg atau hipotensi berat)	Risiko krisis hipertensi atau syok yang dapat menyebabkan kerusakan organ vital	Lakukan monitoring ketat, observasi tanda vital, laporkan segera, dan siapkan intervensi sesuai protokol
Nyeri dada akut	Indikasi kemungkinan gangguan kardiovaskular seperti sindrom koroner akut	Hentikan aktivitas pasien, observasi tanda vital, berikan oksigen jika diperlukan, dan segera rujuk/eskalasi
Penurunan saturasi oksigen ($< 90\%$)	Gangguan oksigenasi serius yang dapat menyebabkan hipoksia jaringan	Berikan oksigen, pantau saturasi secara kontinu, dan evaluasi penyebab
Perubahan tanda vital yang signifikan (takikardia, bradikardia, takipnea)	Indikasi ketidakseimbangan homeostasis	Lakukan pemantauan intensif dan analisis penyebab
Kecemasan berat atau agitasi	Respons psikologis yang dapat memperburuk kondisi fisiologis	Lakukan komunikasi terapeutik, berikan dukungan emosional, dan evaluasi kondisi pasien secara menyeluruh

Prinsip Eskalasi dalam Keperawatan

Dalam menghadapi kondisi red flags, perawat harus menerapkan prinsip eskalasi yang meliputi:

1. Deteksi dini, yaitu kemampuan mengenali perubahan kondisi pasien secara cepat dan akurat
2. Respons cepat, yaitu melakukan tindakan awal sesuai dengan kondisi pasien
3. Komunikasi efektif, yaitu melaporkan kondisi pasien kepada tim kesehatan secara jelas dan sistematis
4. Kolaborasi interprofesional, yaitu bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain untuk penanganan pasien

5. Dokumentasi yang akurat, sebagai bagian dari tanggung jawab profesional

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keselamatan pasien yang menekankan pencegahan kesalahan dan penanganan cepat terhadap kondisi kritis (World Health Organization, 2021).

Makna Red Flags dalam Clinical Reasoning

Dalam proses clinical reasoning, red flags berfungsi sebagai indikator penting dalam menentukan prioritas masalah pasien. Perawat harus mampu membedakan kondisi yang bersifat stabil dengan kondisi yang memerlukan penanganan segera. Ketidakmampuan mengenali red flags dapat menyebabkan keterlambatan intervensi dan meningkatkan risiko komplikasi.

Oleh karena itu, mahasiswa keperawatan perlu dilatih untuk:

1. Mengidentifikasi red flags secara cepat
2. Mengaitkan dengan gangguan homeostasis
3. Menentukan prioritas tindakan
4. Melakukan eskalasi secara tepat

Integrasi dengan Pembelajaran OBE

Dalam pendekatan OBE, kemampuan mengenali red flags dan melakukan eskalasi termasuk dalam kompetensi tingkat tinggi (high-order thinking skills). Mahasiswa tidak hanya diharapkan mengetahui teori, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi klinik yang dinamis dan berisiko tinggi.

Kemampuan ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan keperawatan serta keselamatan pasien, sehingga menjadi salah satu kompetensi utama yang harus dikuasai oleh mahasiswa keperawatan.

Check List

Checklist ini disusun sebagai alat self-assessment bagi mahasiswa untuk mengevaluasi pencapaian pembelajaran pada Bab 2. Dalam pendekatan Outcome-Based Education (OBE), mahasiswa tidak hanya dinilai oleh dosen, tetapi juga didorong untuk melakukan refleksi diri terhadap kompetensi yang telah dicapai. Melalui checklist ini, mahasiswa dapat mengidentifikasi kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan bermakna (Levett-Jones et al., 2021).

Checklist ini mencakup aspek kognitif, psikomotor, dan afektif yang berkaitan dengan konsep sehat-sakit, homeostasis, dan kebutuhan dasar manusia. Mahasiswa diharapkan mengisi checklist secara jujur sebagai bagian dari proses refleksi dan pengembangan diri.

Petunjuk Pengisian:

Berikan tanda (v) pada kolom yang sesuai dengan kemampuan Anda saat ini.

No	Pernyataan Kompetensi	Sudah mampu	Perlu Latihan
1	Saya mampu menjelaskan konsep sehat-sakit secara holistik (biologis, psikologis, sosial, dan spiritual)		
2	Saya mampu menjelaskan mekanisme homeostasis serta respon adaptasi tubuh terhadap perubahan kondisi		
3	Saya mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia berdasarkan teori Maslow, Henderson, dan Orem		
4	Saya mampu menganalisis kasus pasien dengan mengaitkan konsep sehat-sakit, homeostasis, dan kebutuhan dasar manusia		
5	Saya mampu menentukan prioritas masalah keperawatan berdasarkan kondisi klinis pasien		
6	Saya mampu menggunakan clinical reasoning dalam menginterpretasikan data pasien secara sistematis		
7	Saya mampu mengidentifikasi risiko (red flags) pada pasien dan menentukan tindakan yang tepat		
8	Saya mampu mengkomunikasikan hasil analisis secara jelas dan terapeutik kepada pasien atau tim kesehatan		
9	Saya mampu merefleksikan pengalaman belajar dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki		

Interpretasi Hasil:

1. Jika sebagian besar pernyataan berada pada kolom "Sudah Mampu", maka mahasiswa telah mencapai capaian pembelajaran pada bab ini dengan baik.
2. Jika masih terdapat beberapa poin pada kolom "Perlu Latihan", mahasiswa disarankan untuk:
 - a. Mengulang materi pada bagian terkait
 - b. Berdiskusi dengan dosen atau teman

- c. Melakukan latihan kasus tambahan
- d. Meningkatkan refleksi diri

Makna Checklist dalam OBE

Checklist ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kesadaran diri (self-awareness) dan tanggung jawab profesional mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dalam praktik keperawatan, kemampuan untuk mengevaluasi diri secara jujur merupakan bagian penting dari profesionalisme dan peningkatan kualitas pelayanan (Yardley et al., 2022).

Dengan menggunakan checklist ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengukur pencapaian kompetensi secara mandiri
2. Mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan diri
3. Mengembangkan strategi belajar yang lebih efektif
4. Meningkatkan kesiapan dalam praktik klinik

Refleksi

Mahasiswa dapat menuliskan refleksi singkat setelah mengisi checklist:

- a. Hal yang sudah saya kuasai: _____
- b. Hal yang perlu saya tingkatkan: _____
- c. Rencana perbaikan saya: _____

KESIMPULAN

Checklist "Saya Sudah Bisa" merupakan bagian penting dalam pembelajaran berbasis OBE yang menekankan pada pencapaian kompetensi secara utuh. Melalui checklist ini, mahasiswa tidak hanya mengetahui apa yang telah dipelajari, tetapi juga sejauh mana kemampuan tersebut telah dikuasai dan dapat diterapkan dalam praktik keperawatan.

Referensi

- Biggs, J., & Tang, C. (2022). *Teaching for quality learning at university* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Cant, R. P., & Cooper, S. J. (2021). Simulation-based learning in nurse education: Systematic review. *Journal of Advanced Nursing*, 77(1), 1–14. <https://doi.org/10.1111/jan.14653>
- Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2022). *Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (15th ed.). Wolters Kluwer.
- INACSL Standards Committee. (2021). Healthcare simulation standards of best practice. *Clinical Simulation in Nursing*, 58, 1–32. <https://doi.org/10.1016/j.ecns.2021.08.006>
- Levett-Jones, T., Hoffman, K., Dempsey, J., Jeong, S. Y., Noble, D., Norton, C. A., Roche, J., & Hickey, N. (2021). The five rights of clinical reasoning. *Nurse Education Today*, 97, 104–110. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104110>
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Ten Cate, O., Carraccio, C., Damodaran, A., et al. (2021). Entrustment decision making in competency-based medical education. *Medical Teacher*, 43(6), 1–10.
- World Health Organization. (2021). *Global patient safety action plan 2021–2030*. WHO Press.
- Yardley, S., Teunissen, P. W., & Dornan, T. (2022). Experiential learning in medical education. *Medical Education*, 56(1), 1–10.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2021). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI)*.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2021). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI)*.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2021). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI)*.
- American Nurses Association. (2021). *Nursing: Scope and standards of practice* (4th ed.). ANA.
- Black, J. M., & Hawks, J. H. (2021). *Medical-surgical nursing: Clinical management for positive outcomes* (11th ed.). Elsevier.
- Ignatavicius, D. D., Workman, M. L., & Rebar, C. R. (2021). *Medical-surgical nursing: Concepts for interprofessional collaborative care* (10th ed.). Elsevier.
- Giddens, J. F. (2021). *Concepts for nursing practice* (3rd ed.). Elsevier.

- Berman, A., Snyder, S., & Frandsen, G. (2022). *Kozier & Erb's fundamentals of nursing* (11th ed.). Pearson.
- McEwen, M., & Wills, E. M. (2022). *Theoretical basis for nursing* (5th ed.). Wolters Kluwer.
- Alligood, M. R. (2022). *Nursing theorists and their work* (10th ed.). Elsevier.
- Taylor, C., Lynn, P., & Bartlett, J. L. (2021). *Fundamentals of nursing: The art and science of person-centered care* (10th ed.). Wolters Kluwer.
- Lewis, S. L., Bucher, L., Heitkemper, M. M., & Harding, M. (2021). *Medical-surgical nursing* (11th ed.). Elsevier.
- NANDA International. (2021). *NANDA International nursing diagnoses: Definitions and classification 2021–2023*. Thieme.
- World Health Organization. (2022). *WHO guidelines on self-care interventions for health and well-being*. WHO Press.
- Institute of Medicine. (2021). *Improving diagnosis in health care*. National Academies Press.
- Benner, P., Sutphen, M., Leonard, V., & Day, L. (2021). *Educating nurses: A call for radical transformation*. Jossey-Bass.
- Finkelman, A. (2022). *Leadership and management for nurses* (4th ed.). Pearson.
- Orem, D. E. (2021). *Nursing: Concepts of practice* (updated ed.). Mosby.
- Maslow, A. H. (2021). *Motivation and personality* (updated ed.). Harper & Row.

BAB 3

PROSES KEPERAWATAN: PENGKAJIAN, DIAGNOSA, PERENCANAAN, IMPLEMENTASI, EVALUASI

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar keperawatan, profesionalisme, etika–legal, dan keselamatan pasien sebagai landasan praktik.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6
CPL-2	Mampu menerapkan proses keperawatan secara sistematis (pengkajian–diagnosis–perencanaan–implementasi–evaluasi) berbasis kebutuhan dasar manusia.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-7
CPL-3	Mampu melakukan pengkajian dasar (tanda vital, nyeri, pemeriksaan fisik) serta dokumentasi yang akurat dan dapat diaudit.	CPMK-3; CPMK-7
CPL-4	Mampu melaksanakan keterampilan keperawatan dasar (oksigenasi, nutrisi, eliminasi, mobilisasi, integumen, pemberian obat) secara aman dan sesuai standar.	CPMK-4; CPMK-6
CPL-5	Mampu berkomunikasi terapeutik, memberikan edukasi kesehatan, dan melakukan discharge planning dasar yang berpusat pada pasien–keluarga.	CPMK-5; CPMK-7
CPL-6	Mampu berpikir kritis dan clinical reasoning untuk pengambilan keputusan, pencegahan risiko, serta perbaikan mutu praktik keperawatan dasar.	CPMK-2; CPMK-6; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan pengantar keperawatan dasar, profesionalisme perawat, peran, nilai, dan standar perilaku dalam pelayanan.
CPMK-2	Menjelaskan konsep sehat–sakit, homeostasis, kebutuhan dasar manusia, serta menerapkan berpikir kritis/clinical reasoning dalam pengambilan keputusan keperawatan.
CPMK-3	Melakukan proses keperawatan (pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, evaluasi) dan mendokumentasikan secara sistematis.
CPMK-4	Melaksanakan keterampilan keperawatan dasar untuk pemenuhan kebutuhan dasar (oksigenasi, nutrisi, cairan, eliminasi, istirahat–tidur, mobilisasi, integumen) sesuai standar.
CPMK-5	Menerapkan komunikasi terapeutik dan hubungan perawat–klien secara profesional untuk mendukung asuhan dan edukasi.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Menerapkan etik–hukum, patient safety, PPI, pencegahan jatuh, dan keselamatan medikasi dalam praktik keperawatan dasar.
CPMK-7	Melaksanakan edukasi kesehatan, discharge planning, dan handover SBAR, serta mengevaluasi luaran asuhan dan menyusun perbaikan rencana berbasis data.

E. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 3. Proses Keperawatan: Pengkajian, Diagnosa, Perencanaan, Implementasi, Evaluasi	3.1 Menyusun data pengkajian dan menetapkan diagnosis/prioritas masalah secara sistematis.	3.2 Menyusun rencana asuhan (tujuan SMART, intervensi, evaluasi) dan dokumentasi proses.	CPMK-3	CPMK-2; CPMK-7

F. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	Ujian kasus clinical reasoning	Ketepatan problem list/prioritas (skor rubrik) dan konsistensi alasan berbasis risiko/bukti dasar.	10	Lembar jawaban kasus
CPMK-3	Tugas proses keperawatan tertulis (mini care plan)	Ketepatan diagnosis/prioritas dan kualitas tujuan SMART serta evaluasi terukur (skor rubrik).	15	Mini care plan
CPMK-7	Portofolio edukasi–discharge plan–SBAR	Kelengkapan edukasi (teach-back), kualitas discharge plan, dan kelengkapan SBAR (skor rubrik/checklist).	15	Materi edukasi; discharge plan; SBAR

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep profesionalisme (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.2 Akurasi respons pada skenario perilaku profesional	Respons keliru/berisiko	Respons cukup; alasan lemah	Respons tepat; alasan logis	Respons sangat tepat; alasan kuat & konsisten standar

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan problem list & prioritas	Prioritas tidak sesuai; banyak masalah kunci terlewat	Prioritas cukup; masih ada ketidaktepatan bermakna	Prioritas tepat; masalah kunci tercakup	Prioritas sangat tepat; masalah kunci lengkap & terurut
2.2 Konsistensi alasan berbasis risiko/bukti dasar	Tanpa alasan; tidak berbasis risiko	Alasan umum; risiko belum jelas	Alasan logis; risiko jelas	Alasan sangat kuat; mengaitkan risiko, bukti dasar, dan keselamatan

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Ketepatan diagnosis/prioritas	Tidak sesuai data; prioritas keliru	Sebagian sesuai; prioritas kurang konsisten	Sesuai data; prioritas jelas	Sangat sesuai; prioritas sangat logis & tervalidasi
3.2 Kualitas tujuan SMART & evaluasi terukur	Tujuan tidak SMART; evaluasi tidak jelas	Sebagian SMART; evaluasi terbatas	SMART; evaluasi jelas	SMART sangat kuat; evaluasi komprehensif dan operasional

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan langkah keterampilan dasar (checklist)	≤60% langkah benar; ada kesalahan kritis	61–75% benar; kekurangan bermakna	76–90% benar; kesalahan minor	>90% benar; aman tanpa kesalahan bermakna
4.2 Ketepatan evaluasi respons pasien	Tidak mengevaluasi/keliru	Mengevaluasi terbatas; indikator kurang tepat	Evaluasi jelas; indikator tepat	Evaluasi sangat jelas; indikator tepat & tindak lanjut cepat

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kinerja komunikasi terapeutik (checklist)	≤60% perilaku tercapai; hubungan tidak terbina	61–75% tercapai; hubungan terbina sebagian	76–90% tercapai; hubungan efektif	>90% tercapai; empatik, adaptif, profesional
5.2 Batas profesional & respons terhadap hambatan komunikasi	Tidak menjaga batas; respons tidak tepat	Batas sebagian; respons kurang konsisten	Batas jelas; respons tepat	Batas sangat jelas; respons sangat efektif & aman

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Kepatuhan PPI & kewaspadaan standar	Banyak langkah terlewat; risiko tinggi	Langkah inti ada; kurang konsisten	Langkah tepat; konsisten	Langkah sangat tepat; konsisten tanpa pelanggaran
6.2 Kepatuhan keselamatan jatuh & 6 benar medikasi	Sering melanggar; ada kesalahan kritis	Cukup patuh; masih ada kekurangan	Patuh; tanpa kesalahan kritis	Sangat patuh; antisipatif risiko dan terdokumentasi

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan edukasi–discharge plan (teach-back)	Tidak terstruktur; pemahaman tidak terbukti	Terstruktur sebagian; bukti pemahaman terbatas	Terstruktur; bukti pemahaman memadai	Sangat terstruktur; bukti pemahaman kuat & terdokumentasi
7.2 Kelengkapan SBAR & dokumentasi terintegrasi	Informasi kritis hilang; tidak dapat diaudit	Informasi inti ada; masih kurang spesifik	Lengkap; runtut; dapat ditindaklanjuti	Sangat lengkap; ringkas; risiko terantisipasi; sangat dapat diaudit

Pendahuluan

Perkembangan dunia pelayanan keperawatan modern saat ini telah memiliki banyak tantangan dan harapan dimana perawat tidak hanya sekedar berorientasi pada tindakan semata, melainkan dibutuhkan tahapan proses pemecahan masalah kesehatan yang dapat dikaji secara ilmiah, terencana dan memiliki kesinambungan. Langkah profesional yang dimiliki oleh perawat tentunya harus mampu menjaga keselamatan pasien dan menjamin mutu pelayanan. Tercapainya langkah profesional dengan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, perlu

digunakan metode ilmiah yang dikenal dengan proses keperawatan. Proses keperawatan merupakan dasar dari langkah profesional dengan menghadirkan sebuah metode ilmiah yang tersistematis. Proses ini merupakan sebuah pendekatan yang dinamis dengan mampu mengidentifikasi masalah kesehatan pasien dalam memenuhi kebutuhan diri sehari-hari. Terdapat lima tahap yang menjadi sebuah langkah utama dalam melaksanakan proses keperawatan antara lain pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi dan evaluasi. Dengan memahami dan menerapkan setiap tahapan dari proses keperawatan secara tepat, perawat sebagai tenaga profesional dapat memberikan pelayanan yang terarah dan berorientasi pada peningkatan status kesehatan pasien serta sistem pelayanan kesehatan

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mempelajari materi ini mahasiswa diharapkan mampu memahami proses keperawatan dengan lima tahapan: pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi dan evaluasi.

Tujuan Instruksional Khusus:

1. Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep dan pengertian proses keperawatan sebagai sebuah panduan ilmiah dalam melaksanakan asuhan keperawatan
2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi tahapan-tahapan proses keperawatan yang dimulai dari pengkajian, diagnose keperawatan, perencanaan, implementasi dan evaluasi
3. Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dan prinsip setiap langkah-langkah proses keperawatan dalam praktik keperawatan profesional
4. Mahasiswa melakukan pengkajian yang tersistematis melalui pengumpulan data yang tepat dan akurat
5. Mahasiswa menganalisis data dari hasil temuan pengkajian untuk dapat merumuskan diagnose yang tepat dan akurat
6. Mahasiswa mampu menyusun rencana asuhan keperawatan yang meliputi penetapan tujuan, kriteria hasil dan intervensi keperawatan
7. Mahasiswa dapat melaksanakan tindakan keperawatan (implementasi) selaras dengan rencana yang telah disusun
8. Mahasiswa menentukan evaluasi terhadap tindakan keperawatan agar dapat menilai tingkat keberhasilan dari tujuan asuhan keperawatan

Capaian Pembelajaran:

Kognitif:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep, tujuan dan prinsip proses keperawatan dimana langkah ini dapat dijadikan sebagai pendekatan ilmiah dalam pemberian asuhan keperawatan
2. Menguraikan tahapan proses keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi dan evaluasi

Psikomotor:

1. Mahasiswa mampu menyusun pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi dan evaluasi secara tersistematis, tepat dan sesuai standar praktik keperawatan
2. Mahasiswa mampu secara profesional dan bertanggung jawab terhadap menentukan keputusan keperawatan

Afektif:

1. Mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan teliti dalam menganalisis setiap proses keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi dan evaluasi
2. Memiliki komitmen dalam menyusun asuhan keperawatan sesuai dengan standar praktik keperawatan

Uraian Materi

A. Proses Keperawatan

Pelayanan keperawatan adalah sebuah tindakan dalam penerapan sistem pelayanan keperawatan yang dapat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan baik individu, keluarga dan masyarakat. Salah satu penerapan dari bentuk pelayanan keperawatan yang dimaksud adalah dengan menerapkan proses keperawatan (Melin-Johansson et al., 2017). Adapun penjelasan mengenai proses keperawatan adalah sebagai berikut:

1. Pengertian

Proses keperawatan adalah sebuah penerapan metode ilmiah yang pelaksanaannya digunakan oleh perawat dalam memberikan sebuah asuhan keperawatan kepada pasien yang terlaksana secara terstruktur, terdokumentasi secara sistematis dan berkesinambungan (Adamy et al., 2020). Proses keperawatan akan melahirkan sebuah pendekatan atau penghubung antara perawat-pasien untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan pasien, menentukan apa yang menjadi masalah kesehatan yang dialami serta merencanakan dan melaksanakan tindakan yang tepat untuk kesembuhan pasien. Proses keperawatan juga tentunya menjadi sebuah metode efektif dalam pemecahan

masalah yang dilakukan oleh perawat diruangan. Melalui proses tahapan mulai dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi dan evaluasi yang dilakukan kepada pasien, diharapkan proses keperawatan menjadi sebuah substansi ilmiah yang logis, sistematis, terstruktur dan juga memiliki nilai yang sesuai dengan standart praktik keperawatan (Adamy et al., 2020).

Proses keperawatan juga dapat dinyatakan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat yang diberikan oleh perawat terhadap pasien, dimana hal ini akan berdampak besar terhadap kualitas layanan keperawatan kepada pasien. ketika seorang pasien mengalami hambatan dalam pemenuhan kebutuhan dirinya, perawat akan berperan melaksanakan pengkajian, menentukan diagnosis keperawatan, merencanakan dan melaksanakan tindakan yang berfokus pada pasien serta mengevaluasi hasil dengan berorientasi pada hubungan yang saling ketergantungan (Ho et al., 2019). Proses keperawatan juga dapat dipergunakan sebagai pedoman tertulis dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh pasien dimana posisi perawat sebagai profesi profesional diharapkan dapat dengan segera memenuhi kebutuhan pasien (Alligood, 2017). Berdasarkan beberapa teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan melaksanakan proses keperawatan yang terdiri dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi dan evaluasi maka peran perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan yang terintegritas berdasarkan pendekatan ilmiah yang terstruktur akan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar pasien dan diharapkan dapat dapat berdampak besar terhadap kualitas layanan perawatan kepada pasien.

2. Tujuan Proses Keperawatan

Perawat dalam melaksanakan proses keperawatan secara umum dapat bertujuan agar dapat menghasilkan asuhan keperawatan yang terintegritas dan dapat memenuhi kebutuhan pasien selama pasien dirawat (Toney-Butler & Thayer, 2023). Penerapan proses keperawatan ini diharapkan dapat memastikan bahwa pelayanan keperawatan telah sesuai dan bersifat terarah terhadap kondisi pasien, terencana dan sesuai dengan kebutuhan perawatan pasien (Mousavinasab et al., 2020). Adapun beberapa tujuan dari pelaksanaan proses keperawatan ini antara lain (Masri et al., 2023):

- a. Teridentifikasinya temuan masalah pasien terkait kebutuhan dasar sebagai individu yang mengalami hambatan dalam status kesehatannya saat ini.
- b. Profesionalitas perawat untuk mampu menentukan diagnosa keperawatan.
- c. Tersusunnya rencana keperawatan yang tersistematis dan tepat untuk menjawab masalah/temuan diagnosa keperawatan yang dialami pasien.

- d. Pemantauan dan diperhatikannya perkembangan serta tindakan yang tepat juga terencana akan meningkatkan peluang kesembuhan pasien
 - e. Menyediakan dasar dokumentasi guna meningkatkan kemampuan berpikir kritis perawat
 - f. Adanya rencana asuhan yang jelas, proses keperawatan dapat memudahkan koordinasi antara perawat dan petugas kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kepada pasien (Tadzong-Awasum et al., 2022).
3. Karakteristik Proses Keperawatan

Perawat menggunakan sebuah proses keperawatan dengan karakteristik merancang sebuah metode yang tersistematis dan digunakan kepada perawat dalam mengidentifikasi status kesehatan pasien, merencanakan intervensi yang sesuai dan tepat, melaksanakan tindakan keperawatan dan dapat mengevaluasi hasil temuan dari kondisi pasien (Agritubella et al., 2017). Dalam penerapannya, perawat menampilkan sebuah karakteristik terhadap pelaksanaan proses keperawatan dengan penciri antara lain (Leoni-Scheiber et al., 2020):

- a. Perawat melaksanakan proses keperawatan dengan metode pemecahan masalah yang sifat pendekatannya dilakukan secara terbuka dan juga fleksibel dalam memenuhi kebutuhan pasien dan dapat berkembang terhadap masalah yang ada dan mengikuti perkembangan zaman.
 - b. Perawat melakukan pendekatan secara individual ataupun melibatkan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pasien.
 - c. Proses keperawatan perlu dilakukan perencanaan dalam memecahkan temuan permasalahan pasien.
 - d. Proses keperawatan memiliki arah tujuan pelayanan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia.
 - e. Proses keperawatan memiliki siklus yang saling berhubungan antara tahap satu dengan tahap selanjutnya.
4. Fungsi Proses Keperawatan

Proses keperawatan merupakan sebuah metode yang dibentuk sebagai kerangka kerja dalam praktik keperawatan dengan fungsi untuk membantu perawat dalam melaksanakan pelayanan yang efisien dan efektif. Melalui proses kerangka kerja ini, proses keperawatan dapat difungsikan juga sebagai (Zuyina et al., 2026):

- a. Kerangka Kerja Pemberian Asuhan Keperawatan

Kerangka kerja atau pedoman dalam pemberian asuhan keperawatan berperan penting bagi perawat, dimana perawat dapat bekerja secara sistematis dalam mengidentifikasi masalah kesehatan pasien serta dapat menentukan tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan pasien.

b. Mengidentifikasi Status Kondisi Pasien

Proses keperawatan berfungsi mendukung perawat dalam mengidentifikasi perkembangan pasien secara akurat dan tepat melalui pengumpulan data yang terdapat pada tahap pengkajian sehingga data tersebut dapat dianalisis untuk menentukan apa yang menjadi diagnosa keperawatan yang tepat.

c. Membantu Perencanaan Perawatan Yang Tepat

Perawat dapat menyusun perencanaan yang tepat dan terarah sesuai dengan kebutuhan pasien. Proses ini tentunya memiliki fungsi terencana dalam mengatasi masalah kesehatan pasien.

d. Meningkatkan kualitas pelayanan

Proses keperawatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan melalui pendekatan yang tersistematis dan terstruktur. Dimana tindakan keperawatan yang tepat akan berdampak kepada mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

e. Menjamin keberlangsungan pelayanan keperawatan

Melalui sistem pendokumentasian yang tepat, proses keperawatan dapat memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada pasien akan berlangsung secara berkesinambungan. Hal ini menjadi penting terutama dalam pergantian *shift* perawat atau dalam hal rujukan pasien.

5. Keuntungan Penerapan Proses Keperawatan

Perawat dalam menerapkan proses keperawatan yang dilaksanakan secara tepat tentu saja memperoleh keuntungan baik ke pasien, tenaga medis hingga kerumah sakit. Adapun keuntungan penerapannya antara lain (Mahmud et al., 2025):

a. Mutu dalam pelayanan keperawatan dapat meningkat

b. Pengembangan keterampilan intelektual perawat dan teknis dapat meningkat

c. Citra profesi keperawatan meningkat

d. Meningkatkan peran dan fungsi keperawatan dalam pengelolaan asuhan keperawatan

e. Meningkatkan pengembangan ilmu keperawatan

B. Komponen Proses Keperawatan

Proses keperawatan memiliki tahapan dengan pendekatan yang tersistematis dimana perawat dalam memberikan asuhan keperawatan melakukan proses keperawatan dengan komponen-komponen yang terdiri dari:

1. Pengkajian

a. Pengertian Pengkajian Keperawatan

Perawat dalam melakukan proses keperawatan tentu saja dimulai dari tahap pengkajian, dimana pengkajian merupakan sebuah proses yang diuraikan berbentuk catatan tentang temuan sebuah kajian yang bersumber dari pasien. Perawat membuat sebuah data dasar dan menyusun catatan tentang respon kesehatan pasien (Masri et al., 2023). Menurut beberapa pengertian tentang pengkajian keperawatan antara lain:

- 1) Menurut (Berman et al., 2018) menjelaskan dalam teori Kozier dan Erb bahwa pengkajian keperawatan merupakan sebuah rangkaian proses pengumpulan data yang tersistematis berkaitan dengan status pasien selama dalam perawatan untuk melihat sejauh mana masalah dan kebutuhan pasien dalam masa perawatan.
- 2) Menurut (Perry et al., 2024) menjelaskan pengkajian adalah sebuah pengumpulan, verifikasi dan pengelompokan data mengenai status kesehatan pasien yang dilakukan secara sistematis untuk mencari sejauh mana kondisi dan kebutuhan pasien dalam masa perawatan
- 3) Menurut (Davarpanah et al., 2024) menjelaskan dalam teori Gordon yaitu pengkajian keperawatan merupakan sebuah proses aktivitas perawat dalam mengumpulkan informasi tentang keadaan pasien dengan pendekatan seperti dilakukannya wawancara, observasi, pemeriksaan fisik serta penggunaan dari pola fungsi kesehatan yang diperoleh secara langsung.

b. Tujuan pengkajian Keperawatan

Perawat dalam melakukan proses keperawatan merupakan bagian penting dan mempunyai nilai tanggung jawab dalam mempertahankan nilai profesinya, dalam mengidentifikasi masalah pasien, pengkajian keperawatan memiliki beberapa tujuan (Hawthorne & Gordon, 2020), antara lain:

- 1) Mengumpulkan, mengelompokkan dan mendokumentasikan data yang dijelaskan oleh pasien yang mempengaruhi pola kesehatan pasien
- 2) Hasil dari pendokumentasian pada pengkajian selanjutnya menjadi acuan dari penulisan rencana asuhan keperawatan
- 3) Menyampaikan keyakinan terkait informasi mengenai bagaimana kesehatan pasien saat ini dan masa lalu dengan tujuan menjadikannya sebagai referensi
- 4) Memberikan data yang cukup untuk menggambarkan bagaimana penentuan strategi perawatan yang sesuai dan efektif dengan kebutuhan pasien

c. Jenis-Jenis Sistem Pengkajian

Perawat dalam melaksanakan proses pengkajian perlu mengetahui jenis dokumentasi apa saja yang dapat dilakukan ketika berinteraksi dengan pasien. Menurut (Rodriguez-Suarez et al., 2023) adapun jenis-jenis dari sistem pengkajian, antara lain:

1) *Initial Assessment* (Pengkajian Awal)

Perawat pada tahap ini melakukan pendokumentasi dimana pasien baru pertama sekali masuk kerumah sakit. Data awal merupakan hal yang perlu dikaji secara tersistematis dimana nantinya akan digunakan sebagai acuan dasar dalam pemberian asuhan keperawatan.

2) *Ongoing Assessment* (Pengkajian Tahap Lanjutan)

Perawat pada tahap ini merangkum data dan mengembangkan kelengkapan dari proses pengkajian diawal dengan tujuan agar seluruh data menjadi lengkap sehingga dukungan informasi mengenai status pasien dapat terintegrasi.

3) *Reassessment* (Pengkajian Ulang)

Perawat melakukan pendokumentasian terhadap hasil pengkajian yang diperoleh dari informasi pasien dimana perawat mengevaluasi kemajuan data pengkajian terhadap hasil yang sudah ditentukan.

2. Jenis Data Pengkajian

Perawat dalam melakukan pengumpulan data pengkajian keperawatan kepada pasien memiliki dua cara pendekatan agar data yang diperoleh dapat terpenuhi, Adapun data yang dimaksud antara lain (Rahmi, 2019):

a. Data Subjektif

Data Subjektif dapat diperoleh perawat melalui sebuah hasil pengkajian terhadap pasien dengan pendekatan berupa wawancara, konsultasi, keluarga dan dari riwayat perawatannya. Data ini berupa pendekatan seperti keluhan atau persepsi subjektif pasien (*point of view*) terhadap status kesehatannya.

b. Data Objektif

Data Objektif dapat dilakukan perawat dengan cara diperoleh dari hasil observasi perawat, pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan penunjang dan hasil laboratorium. Fokus dari pengkajian data objektif ini dapat juga berupa bagaimana status kesehatan yang dimiliki pasien, pola koping, fungsi terhadap respon pasien dalam menjalani terapi, resiko terhadap masalah potensial, serta dukungan terhadap pasien. Perawat memperoleh karakteristik data yang diperoleh dari hasil pengkajian diharapkan memiliki penciri yang lengkap, akurat, nyata dan relevan. Data lengkap ini mampu mengidentifikasi temuan permasalahan keperawatan pada klien.

c. Metode Pendekatan Data Pengkajian

Perawat agar dapat mengumpulkan data dari pasien perlu memahami beberapa pendekatan agar proses pengkajian dapat terlaksana secara efektif. Adapun metode agar dapat memperoleh data antara lain:

1) Komunikasi Efektif Kepada Pasien

Perawat dalam mengumpulkan data pasien perlu memiliki kemampuan dalam berkomunikasi. Komunikasi dalam pengkajian keperawatan merupakan hal dasar yang perlu dimiliki oleh perawat dimana hal ini sering dipraktikkan ketika berinteraksi dengan pasien. Komunikasi efektif atau yang sering dikenal dengan komunikasi efektif merupakan sebuah upaya perawat dalam mengajak pasien dan keluarga untuk dapat bertukar pikiran dan juga perasaan. Perawat dalam memperoleh data yang akurat perlu menjadi seorang pendengar yang aktif terhadap keluhan yang dimiliki oleh pasien. Dalam pelaksanaannya pendengar yang aktif perlu memperhatikan lingkungan sekitar untuk meningkatkan rasa kenyamanan yang dirasakan oleh pasien, memperhatikan keluhan yang disampaikan oleh pasien dan menghubungkannya dengan kondisi yang dialami oleh pasien saat ini dengan bersikap empati dan menghindari interupsi (Paju & Dwiantoro, 2018). Data yang lengkap memerlukan upaya yang fokus agar proses pengkajian dapat terlaksana dengan baik dan komprehensif.

2) Melakukan Pengamatan/Observasi

Perawat dalam melakukan pengamatan atau observasi kepada pasien merupakan sebuah perilaku yang penting dalam proses pengkajian. Proses dari pengumpulan data ini perlu juga melibatkan pengamatan dan melakukan observasi terkait perkembangan kondisi kesehatan pasien. Kegiatan observasi melibatkan panca indra perawat seperti dapat melihat bagaimana aspek fisik, mental, sosial dan spiritual dari pasien (Irwanti et al., 2022).

3) Pemeriksaan Fisik

Perawat dalam melakukan proses keperawatan akan menjalani proses pemeriksaan fisik yang dilakukan bersamaan saat proses wawancara terjadi. Tujuan dari pemeriksaan fisik ini adalah agar perawat dalam menentukan bagaimana status kondisi pasien, mengidentifikasi permasalahan kesehatan pasien dan mengambil data dasar untuk dapat menentukan rencana tindakan keperawatan serta sebagai data dasar untuk keperluan kolaborasi di tim kesehatan. Pemeriksaan fisik merupakan sebuah proses inspeksi tubuh dan sistem untuk menentukan ada/tidaknya penyakit yang didasarkan pada hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium. Cara pendekatan

yang dapat dilakukan dalam melakukan pemeriksaan fisik adalah dengan pemeriksaan *head to toe* (pemeriksaan dari rambut hingga ujung kaki) dan pendekatan sistem tubuh (*review of system*) (Rahmi, 2019). Pemeriksaan fisik ini dapat dilakukan dengan menggunakan empat metode seperti *inspeksi*, *auskultasi*, *perkusi* dan *palpasi* (Majchrowicz & Tomaszewska, 2023).

a) *Inspeksi*

Perawat secara sederhana melakukan kegiatan seperti melihat atau memperhatikan secara seksama menggunakan indra penglihatan terkait status kesehatan pasien.

b) *Auskultasi*

Perawat melakukan pendekatan menggunakan indra pendengaran dengan bantuan *stetoskop* yang dapat memaksimalkan pemeriksaan berupa mendengarkan bunyi yang keluar dari rongga tubuh pasien. Pelaksanaan ini perlu dilakukan untuk mendapatkan data tentang kondisi seperti bunyi jantung, bunyi paru dan bunyi saluran pencernaan.

c) *Perkusi*

Perkusi merupakan tindakan mengetuk seperti menggunakan jari tengah sebagai media dalam menentukan posisi, ukuran dan konsistensi struktur organ tubuh pasien.

d) *Palpasi*

Perawat dalam melakukan *palpasi* atau dengan istilah meraba dimana pemeriksaan fisik ini melakukan cara meraba kulit pasien, untuk mengetahui bagaimana struktur yang ada di daerah permukaan atau dibawah kulit.

d. Format Pengkajian

Perawat dalam melakukan proses pengkajian tentunya memiliki format pengisian pengkajian yang nantinya format tersebut akan diisi oleh perawat berdasarkan hasil temuan pada status kesehatan pasien. Format pengkajian ini bertujuan agar mempermudah perawat dalam melakukan pengkajian secara terstruktur dan sistematis dengan pedoman standar praktik keperawatan yang berlaku (Dewi et al., 2021). Selain itu, format pengkajian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dokumentasi keperawatan serta membantu dalam pengambilan keputusan klinis yang tepat. Pada format pengkajian perawat perlu memperhatikan setiap komponen data yang ada pada format tersebut. komponen ini dapat meliputi identitas pasien, riwayat perawatan, pengkajian fisik, data penunjang dan penatalaksanaan medis pasien (Nuryanti, 2020). Berikut adalah format pengkajian dengan model pola fungsional kesehatan (*functional health patterns*) menurut teori (Gordon, 2008):

ASUHAN KEPERAWATAN DASAR

PENGKAJIAN

Tanggal Pengkajian :

Tanggal Masuk :

Ruang / Kelas :

Nomor Register :

Diagnosa Medis :

Identitas Klien

Nama Klien :

Jenis Kelamin :

Usia :

Status Perkawinan :

Agama :

Suku Bangsa :

Pendidikan :

Bahasa Yang Digunakan :

Pekerjaan :

Alamat :

Sumber Biaya (Pribadi, Perusahaan, Lain-lain) :

Sumber Biaya (Pribadi, Perusahaan, Lain-lain) :

Sumber Informasi (Klien / Keluarga /Status) :

Riwayat Kesehatan

Riwayat Kesehatan Sekarang

1) Keluhan Utama:

.....

2) Kronologis Keluhan:

.....

a) Faktor Pencetus :

b) Timbulnya keluhan : () mendadak () bertahap

c) Lamanya :

d) Upaya Mengatasi :

Riwayat Kesehatan Masa Lalu

Riwayat penyakit sebelumnya (termasuk kecelakaan)

.....

Riwayat alergi (obat, makanan, binatang, lingkungan)

.....

Riwayat pemakaian obat

.....

Penyakit yang pernah diderita oleh anggota keluarga yang menjadi faktor resiko

.....

Riwayat Psikososial dan Spiritual

Adakah orang terdekat dengan klien :

.....

Interaksi dalam keluarga :

Pola komunikasi :

Pembuatan keputusan :

Kegiatan kemasyarakatan :

Dampak penyakit klien terhadap keluarga

.....

Masalah yang mempengaruhi klien

.....

Mekanisme koping terhadap stress

() Pemecahan masalah () Minum obat () Makan

() Cari pertolongan () Tidur () Lain-lain (misal: marah, diam)

Persepsi klien terhadap penyakitnya

Hal yang sangat dipikirkan saat ini :

.....

Harapan setelah menjalani perawatan

.....

Perubahan yang dirasakan setelah jatuh sakit

.....

Sistem nilai kepercayaan

Nilai-nilai yang bertentangan dengan kesehatan

.....

Aktivitas agama / kepercayaan yang dilakukan :

.....

Kondisi lingkungan rumah (lingkungan rumah yang mempengaruhi kesehatan saat ini).....

Riwayat Kebutuhan

1). Nutrisi

a. Frekuensi makan : x/hari

b. Nafsu makan : () baik

() tidak nafsu makan, alasan : (mual, muntah, sariawan)

() lain-lain, sebutkan :

() Kesulitan mengunyah / menelan:

Jenis makanan di rumah :

.....

c. Kebiasaan sebelum makan :

d. Makanan yang tidak disukai : Alergi: () ada () tidak ada
() ada () tidak ada Pantangan: () ada () tidak ada

bila ada, sebutkan :

e. Jenis makanan di RS

() Cair () Lunak () Biasa () NGT/sonde

() DLL/sebutkan () Puasa

2). Eliminasi

a) BAK (Buang Air Kecil)

• Frekuensi :x/hari

• Warna :

• Jumlah : cc

• Keluhan yang berhubungan dengan BAK :

.....

• Catheter: () Ya () Tidak Condom Catheter : () Ya () Tidak
() BAK Mandiri () BAK dengan bantuan

• Nyeri tekan Vesika Urinaria: () Ya () Tidak

• Distensi Vesika Urinaria : () Ya () Tidak

b) BAB (Buang Air Besar)

• Frekuensi :x/hari

• Waktu : (Pagi / Siang / Malam / Tak tentu)

• Warna :

• Bau :

• Konsistensi :

• Keluhan yg berhubungan dengan BAB :

() BAB Mandiri () BAB dengan bantuan

Penggunaan Laxatif / pencahar : () ya () tidak

c). Bising usus :x/menit

d). Diare : () Ya () Tidak

- Lamanya : Frekuensi :x/hari
- Warna faeces : () kuning () putih seperti air cucian beras

: () cokelat () hitam () dempul

- Konsistensi faeces : () setengah padat () cair () berdarah
: () terdapat lendir () tidak ada kelainan

e). Konstipasi : () Ya () Tidak Lamanya : hari

f). Kebutuhan Cairan

- Intake per oral : ml
- IVFD/24 jam :
- Muntah () ya () tidak
- Isi : () makanan () Cairan () Darah
- Warna : () Sesuai warna makanan () Kehijauan
() Cokelat () Kuning () Hitam
- Frekuensi :x/hari Jumlah : ml
- Output :
Urine : ml
Cairan drain/NGT : ml dll
- IWL : cc
- Balance Cairan/24 jam : cc

3). Personal Hygiene

a) Mandi

- Frekuensi :x /hari
- Sabun : () ya () tidak
- Pakaian kotor/basah : () ya () tidak

b). Kulit : () halus/kering () bersisik () lecet/memar () Lembab
() Berminyak () keringat banyak () keringat berbau

Turgor kulit: () Elastis () Sedang () Buruk

- Warna : () Pucat () Sianosis () Kemerahan
- Keadaan kulit : () Baik () Gatal-gatal () Bercak merah
- Petechie : () ya () tidak
- Luka : () ya () tidak

Bila ya, sebutkan :

Lokasi :

Keadaan luka :

c). Genitalia

Kebersihan : () ya () tidak

Pemakaian hygiene / Solution : () ya () tidak

d). Oral Hygiene

- Frekuensi :x/hari
- Waktu : () Pagi () Sore () setelah makan
() Mulut kotor/bau
() Bibir pecah pecah/kering/berdarah () gusi merah/bengkak
() Sariawan/stomatitis
- Lidah kotor : () ya () tidak
- Saliva : () normal () abnormal
- Gigi : () caries () ya () tidak
- Penggunaan gigi palsu () ya () tidak

e). Cuci rambut : Frekuensi :x/hari

- Shampo : () ya () tidak
- Keadaan rambut : () Mengkilap () Kering () Kusam () Berminyak ()
Jarang/lebat () Ketombe () Bersih () Kotor

f). Kuku : Bersih () ya () tidak Panjang () ya () tidak

g). Kemampuan melakukan kegiatan sehari – hari :

() Self care () Partial care () Total care

4). Istirahat dan Tidur

- Lama tidur :jam/hari
- Tidur siang : () ya () tidak
- Kebiasaan sebelum tidur / pengantar tidur :
- Keluhan /masalah : () sulit tidur () mudah terbangun
() Merasa tidak puas setelah bangun tidur () Dengan bantuan obat

5). Pola Aktivitas dan Latihan

- Kegiatan dalam pekerjaan :
- Waktu bekerja: () Pagi () Siang () Malam
- Olah raga : () ya () tidak () kadang-kadang
Jenisnya :
Frekuensi :
- Kegiatan waktu luang :
- Keluhan dalam beraktivitas :
Pergerakan tubuh () ya () tidak Mandi () ya () tidak
Mengenakan pakaian () ya () tidak Bersolek () ya
() tidak
Sesak nafas setelah beraktivitas () ya () tidak () dll.....

6). Mobilisasi

() Mandiri () Bantuan Minimal () Bantuan Partial () Bantuan Total

7). Alat bantu

() Kruk () Treeport () Rostulle () Gip () dll,...

8). Rasa aman dan nyaman

- Nyeri: Skala :.....
- Intensitas : () Terus menerus () Hilang timbul () Tajam
() Menjalar () Tumpul
- Durasi :.....
- Faktor pencetus :.....

- Faktor yang dapat mengurangi nyeri:.....
- Faktor Lingkungan :
 Suara bising () ya () tidak
 Cahaya () ya () tidak

9). Kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan

- Merokok : () Ya () Tidak
 Frekuensi : Jumlah : Lama Pemakaian :
- Minuman keras : () Ya () Tidak
 Frekuensi : Jumlah : Lama Pemakaian :
- Ketergantungan obat : () ya () tidak
 Frekuensi : Jumlah : Lama Pemakaian :
 Alasan / keluhan :

Pengkajian Fisik

Pemeriksaan Fisik Umum

- Berat Badan :kg Sebelum sakit BB : kg
- Tinggi badan :cm Peningkatan BB : kg
- IMT (BMI) : Penurunan BB : kg
- Tekanan Darah :mmHg
- Nadi :x/menit
- Frekuensi nafas :x/menit
- Suhu tubuh :⁰C
- Keadaan umum : () Ringan () Sedang () Berat

Penglihatan

- Posisi mata : () Simetri () Asimetris
- Kelopak mata : () Normal () Pterosis
- Pergerakan bola mata : () Normal () Abnormal
- Konjungtiva : () Merah muda () Anemis () Sangat merah
- Kornea : () Normal () Keruh / Berkabut () Terdapat perdarahan
- Sklera : () Ikterik () Anikterik
- Pupil : () Isokor () Anisokor () Midriasis () Miosis
- Otot-otot mata : () Tidak ada kelainan () Juling keluar
 () Juling ke dalam () Berada di atas

- Fungsi penglihatan : () baik () Kabur () Dua bentuk/diplopia
- Tanda-tanda radang :
- Pemakaian kaca mata: () Tidak () Ya, jenis.....
- Pemakaian lensa kontak:
- Reaksi terhadap cahaya :

Pendengaran

- Daun telinga : () Normal () Tidak, Kanan/Kiri.....
- Karakteristik serumen (warna, konsistensi, bau) :
- Kondisi telinga tengah: () Normal () Kemerahan () Bengkak () Terdapat Lesi
- Cairan dari telinga : () Tidak () Ada () Darah, nanah, dll.
- Perasaan penuh di telinga: () Ya () Tidak
- Fungsi pendengaran : () Normal () Kurang () Tuli, kanan/kiri
- Gangguan keseimbangan: () Tidak () Ya,.....
- Pemakaian alat Bantu : () Ya () Tidak

Wicara :

Kesulitan / gangguan wicara () Ya () Tidak dll, sebutkan ,.....

Pernafasan

- Jalan nafas : bersih () ya () tidak () Ada sumbatan,
- Pernafasan : sesak () ya () Tidak
- Menggunakan otot bantu pernafasan : () Ya () Tidak
- Frekuensi :x/menit
- Irama : () Teratur () Tidak teratur
- Jenis Pernafasan : (spontan, Kausmaull, Cheynestoke, Biot, Dll)
- Kedalaman : () Dalam () Dangkal
- Batuk : () Tidak () Ya,.....(Produktif/tidak)
- Sputum : () Tidak () Ya(putih/kuning/hijau)
- Konsistensi : () Kental () Encer

- Terdapat darah : () Ya () Tidak
- Palpasi Dada :
- Perkusi dada :
- Suara nafas : () Vesikuler () Ronkhi () Wheezing () Rales
- Nyeri saat bernafas : () Ya () Tidak
- Penggunaan alat bantu nafas : () Tidak () Ya, sebutkan.....

Sirkulasi

Nadi.....x/menit : Irama : () Teratur () Tidak teratur
Denyut : () Lemah () Kuat

Tekanan darah :mmHg
Temperatur kulit : () Hangat () Dingin
Warna kulit : () Pucat () Cyanosis () Kemerahan
Pengisian kapiler :detik
Edema : () ya () tidak Area Edema

Tingkat Kesadaran

- Tingkat kesadaran : () Compos mentis () Apatis
: () Somnolent () Soporokoma () Koma
- Glasgow coma scale (GCS): E : M : V :
- Pupil : Ukuran () isokor () anisokor
- Reaksi pupil terhadap cahaya:
Kanan : () positif () negative
Kiri : () positif () negative
- Keluhan sakit kepala: () ya () tidak
- Bila ya sebutkan (vertigo/migrain, dll)

Data Penunjang (Pemeriksaan diagnostik yang menunjang masalah : Lab, Radiologi, Endoscopy, dll)

.....
.....

Penatalaksanaan (Therapi / pengobatan termasuk diet)

.....
.....

Data Fokus

Data Subjektif	Data Objektif

Analisa Data

No	D a t a	Masalah	Etiologi

C. Diagnosa Keperawatan

1. Pengertian Diagnosa Keperawatan

Diagnosa Keperawatan merupakan sebuah pengambilan keputusan klinis mengenai individu atau kelompok sebagai akibat dari adanya permasalahan kesehatan atau proses kehidupan yang dialami (PPNI, 2019). Diagnosa keperawatan berfokus pada respon pasien terhadap status kesehatan baik secara aktual maupun potensial dimana bukan dari penyakit itu sendiri (Ordu & Çalışkan, 2023). Hal inilah yang membedakan antara diagnosa keperawatan dengan diagnosa medis dimana lebih berfokus pada identifikasi penyakit atau kondisi patologis (Duan et al., 2024). Diagnosa keperawatan menjadi dasar bagi perawat dalam merencanakan dan melaksanakan asuhan keperawatan, sehingga perawat dapat menentukan secara akurat apa yang menjadi intervensi bagi kebutuhan pasien. Maka dari itu, diagnosa keperawatan lebih menekankan bagaimana pasien merespon kondisi kesehatannya guna mencapai derajat kesehatan yang lebih baik dan berbeda dengan diagnose medis yang lebih menitikberatkan pada suatu penyakit (Doenges et al., 2022).

2. Tujuan Penetapan Diagnosa Keperawatan

Perawat dalam melaksanakan diagnosa keperawatan memiliki tujuan agar dapat mengidentifikasi respon dari individu atau kelompok terhadap suatu situasi yang berkaitan dengan kesehatannya. Menurut (Sanson et al., 2022) adapun hal lain yang menjadi tujuan perawat dalam menegakkan diagnosa keperawatan, antara lain:

- a. Perawat dapat menggali dan menyampaikan informasi permasalahan pasien dalam istilah/pendekatan yang dapat dimengerti semua perawat.
- b. Mengetahui perkembangan keperawatan.
- c. Menyampaikan kepada pasien terkait faktor-faktor yang menunjang atau penyebab timbulnya suatu masalah.
- d. Mengetahui kemampuan pasien untuk dapat mencegah atau menyelesaikan permasalahan kesehatannya.
- e. Sebagai dasar untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi status perkembangan dan kondisi pasien.

3. Jenis Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan merupakan bagian dari proses keperawatan yang merupakan salah satu hal penting yang berfungsi sebagai landasan dalam menegakkan intervensi keperawatan yang tepat (PPNI, 2019). Dalam praktik keperawatan, diagnosa keperawatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa

jenis berdasarkan hasil temuan karakteristik dan kondisi pasien. Menurut (Pujiastuti et al., 2025) terdapat dua jenis diagnosa keperawatan, antara lain:

a. Diagnosis Negatif

Diagnosis Negatif pada dasarnya ditetapkan apabila pasien menunjukkan hal-hal seperti terlihat sedang kondisi sakit (aktual) atau beresiko mengalami sakit (Risiko). Penegakan dari diagnosis ini nantinya akan mengarahkan kepada perencanaan yang bersifat menyembuhkan (kuratif), pemulihan (rehabilitative) dan pencegahan (preventif) (Sulistyawati & Hilfida, 2025).

1) Diagnosis Aktual

Diagnosis aktual merupakan bagian dari beberapa diagnosis keperawatan yang dapat mendeskripsikan respon pasien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupan yang menyebabkan pasien mengalami kelihan terhadap kesehatannya. Pada diagnosis ini tanda dan/atau gejala mayor maupun minor yang ditemukan pada buku SDKI (Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia) sesuai dengan validasi yang bersumber dari pasien.

Bersihkan Jalan Napas Tidak Efektif		D.0001
Kategori: Fisiologis		
Subkategori: Respirasi		
Definisi		
Ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten.		
Penyebab		
Fisiologis		
1. Spasme jalan napas 2. Hipersekresi jalan napas 3. Distungsi neuromuskuler 4. Benda asing dalam jalan napas 5. Adanya jalan napas buatan 6. Sekresi yang tertahan 7. Hiperplasia dinding jalan napas 8. Proses infeksi 9. Respon alergi 10. Efek agen farmakologis (mis. anastesi)		
Situasional		
1. Merokok aktif 2. Merokok pasif 3. Terpajan polutan		
Gejala dan Tanda Mayor		
Subjektif (tidak tersedia)	Objektif	
	1. Batuk tidak efektif atau tidak mampu batuk 2. Sputum berlebih / obstruksi di jalan napas / mekonium di jalan napas (pada neonatus) 3. Mengi, wheezing dan/atau ronkhi kering	
Gejala dan Tanda Minor		
Subjektif	Objektif	
1. Dispnea 2. Sulit bicara 3. Ortopnea	1. Gelisah 2. Sianosis 3. Bunyi napas menurun 4. Frekuensi napas berubah 5. Pola napas berubah	

Gambar 3. 1 Diagnosis Aktual Keperawatan Sumber: (PPNI, 2018a)

Pada gambar diatas merupakan salah satu contoh dari diagnosa aktual dengan masalah "kebersihan jalan nafas tidak efektif (D.0001)" dimana ini merupakan bagian dalam kategori fisiologis dengan subkategori respirasi. Diagnosa ini dapat diartikan sebagai ketidakmampuan membersihkan secret atau obstruksi pada jalan nafas untuk dapat mempertahankan alur pernafasan tetap baik. Faktor penyebab dari kondisi ini dapat beragam, antara lain spasme jalan nafas, peningkatan produksi sekret, gangguan neuromuskular, adanya benda asing, infeksi, reaksi alergi, maupun pengaruh obat-obatan tertentu. Selain itu, faktor lingkungan seperti kebiasaan merokok aktif maupun pasif serta paparan polusi juga dapat berkontribusi terhadap terjadinya kondisi tersebut. Penegakan diagnosis keperawatan didasarkan pada adanya tanda dan gejala yang muncul. Gejala mayor yang sering ditemukan meliputi batuk yang tidak efektif, produksi sputum yang berlebihan atau adanya sumbatan pada jalan nafas, serta bunyi nafas tambahan seperti wheezing atau ronki. Sementara itu, gejala minor dapat berupa sesak nafas (dispnea), kesulitan berbicara, ortopnea, gelisah, sianosis, serta perubahan frekuensi dan pola nafas.

Dengan mengacu pada komponen tersebut, diagnosis keperawatan dapat dirumuskan secara lengkap, misalnya: "Bersihkan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan nafas ditandai dengan batuk tidak efektif, sputum berlebih, mengi, dispnea, dan gelisah."

2) Diagnosis Risiko

Diagnosis Risiko yaitu diagnosis keperawatan yang menjelaskan suatu respon pasien terhadap kondisi status kesehatannya yang dapat menyebabkan pasien dapat beresiko mengalami masalah kesehatan. Pada diagnosis risiko tidak ditemukan tanda/gejala pada pasien, namun perlu diperhatikan bahwa pasien memiliki faktor resiko akan mengalami masalah kesehatan.

Risiko Defisit Nutrisi**D.0032**Kategori: *Fisiologis*Subkategori: *Nutrisi dan Cairan***Definisi**

Berisiko mengalami asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme.

Faktor Risiko

1. Ketidakmampuan menelan makanan
2. Ketidakmampuan mencerna makanan
3. Ketidakmampuan mengabsorpsi nutrisi
4. Peningkatan kebutuhan metabolisme
5. Faktor ekonomi (mis. finansial tidak mencukupi)
6. Faktor psikologis (mis. stres, keengganan untuk makan)

Kondisi Klinis Terkait

1. Stroke
2. Parkinson
3. *Mobius syndrome*
4. *Cerebral palsy*
5. *Cleft lip*
6. *Cleft palate*
7. *Amyotrophic lateral sclerosis*
8. Kerusakan neuromuskuler
9. Luka bakar
10. Kanker
11. Infeksi
12. AIDS
13. Penyakit Crohn's
14. Enterokolitis
15. Fibrosis kistik

Gambar 3. 2 Diagnosis Risiko Keperawatan Sumber: (PPNI, 2018a)

Pada gambar diatas merupakan salah satu dari diagnosis risiko dengan masalah "Risiko Defisit Nutrisi (D.0032)" dimana masuk dalam kategori fisiologis yang berkaitan dengan nutrisi dan cairan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kemungkinan individu atau kelompok mengalami asupan nutrisi yang tidak mencukupi untuk dapat memenuhi kebutuhan metabolisme tubuhnya. Faktor yang berkontribusi terhadap temuan diagnosis ini meliputi adanya gangguan dalam proses menelan, pencernaan dan penyerapan nutrisi. Selain itu, peningkatan kebutuhan dari metabolik tubuh juga dapat memperbesar resiko disertai dengan faktor eksternal seperti keterbatasan ekonomi dan kondisi psikologis misalnya stress atau penurunan nafsu makan. Berbagai kondisi klinis juga dapat berhubungan dengan risiko deficit nutrisi diantaranya adanya penyakit neurologis seperti stroke dan parkinson, gangguan perkembangan seperti *cerebral palsy*, kelainan kongenital seperti bibir sumbing, serta penyakit kronis dan akut seperti kanker, infeksi, AIDS, penyakit *crohn*,, *enterocolitis*, luka bakar dan fibrosis kistik.

b. Diagnosis Positif

Diagnosis positif merupakan suatu diagnosis keperawatan yang menggambarkan bahwa pasien dalam kondisi sehat dan dapat mencapai kondisi yang lebih sehat dan lebih optimal. Penegakan diagnosis ini nantinya akan mengarah pada perencanaan yang sifatnya berbentuk edukasi (promotif), oleh karena itu peletakan diagnosis positif ini sering didengar dengan sebutan promkes (promosi kesehatan) (Pujiastuti et al., 2025).

1) Diagnosis Promosi Kesehatan

Diagnosis promosi kesehatan merupakan satu-satunya diagnosis positif dalam keperawatan yang mendeskripsikan adanya keinginan dan kemampuan pasien untuk dapat meningkatkan kondisi status kesehatannya ke tingkat yang lebih baik atau optimal.

Kesiapan Peningkatan Nutrisi		D.0026
Kategori: Fisiologis		
Subkategori: Nutrisi dan Cairan		
Definisi		
Pola asupan nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme dan dapat ditingkatkan.		
Gejala dan Tanda Mayor		
Subjektif	Objektif	
1. Mengekspresikan keinginan untuk meningkatkan nutrisi	1. Makan teratur dan adekuat	
Gejala dan Tanda Minor		
Subjektif	Objektif	
1. Mengekspresikan pengetahuan tentang pilihan makanan dan cairan yang sehat	1. Penyiapan dan penyimpanan makanan dan minuman yang aman	
2. Mengikuti standar asupan nutrisi yang tepat (mis. piramida makanan, pedoman <i>American Diabetic Association</i> atau pedoman lainnya)	2. Sikap terhadap makanan dan minuman sesuai dengan tujuan kesehatan	
Kondisi Klinis Terkait		
Perilaku upaya peningkatan kesehatan		

Gambar 3. 3 Diagnosis Promosi Kesehatan Sumber: (PPNI, 2018a)

Pada gambar diatas merupakan salah satu dari diagnosis promosi kesehatan dengan masalah "Kesiapan Peningkatan Nutrisi (D.0026)" dimana ini termasuk dalam kategori fisiologis dengan subkategori nutrisi dan cairan. Diagnosis ini menggambarkan bagaimana individu atau kelompok yang telah memiliki pola asupan nutrisi yang cukup untuk dapat memenuhi

kebutuhan metabolisme tubuhnya, namun masih memiliki potensi untuk ditingkatkan ke arah yang lebih optimal. Penegakan diagnosis ini didasarkan pada tanda dan gejala yang muncul, baik subjektif maupun objektif. Gejala mayor secara subjektif ditunjukkan dengan adanya keinginan atau motivasi pasien untuk meningkatkan status nutrisinya. Sementara itu, secara objektif, pasien sudah menunjukkan pola makan yang teratur dan mencukupi kebutuhan dasar tubuh.

Selain itu, terdapat pula gejala minor yang mendukung, seperti secara subjektif pasien mampu mengungkapkan pengetahuan mengenai pilihan makanan dan cairan yang sehat, serta mengikuti pedoman asupan nutrisi yang dianjurkan. Secara objektif, pasien juga menunjukkan perilaku yang baik dalam menyiapkan dan menyimpan makanan maupun minuman secara aman, serta memiliki sikap positif terhadap pola makan yang sesuai dengan tujuan kesehatan. Diagnosis ini umumnya berkaitan dengan kondisi klinis berupa adanya upaya individu dalam meningkatkan derajat kesehatannya. Dengan demikian, peran perawat adalah mendukung dan memfasilitasi pasien agar mampu mengoptimalkan pola nutrisi yang sudah baik menjadi lebih seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tubuh.

4. Komponen diagnosa Keperawatan

Perawat dalam menyusun diagnosa keperawatan memerlukan komponen yang dapat merumuskan secara tepat dan sistematis serta mudah dipahami oleh perawat-perawat lainnya. Komponen ini tentunya dapat membantu perawat dalam mengidentifikasi masalah secara akurat untuk menentukan perencanaan keperawatan yang sesuai. Komponen diagnosa keperawatan terdiri dari dua yaitu masalah/*problem* dan indikator diagnostik (Widuri, 2023).

a. Masalah/*Problem*

Masalah merupakan sebuah inti dari diagnosa keperawatan yang menggambarkan suatu respon pasien terhadap kondisi kesehatan yang sedang dialaminya. Masalah ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis data yang bersumber dari tahap pengkajian. Masalah biasanya menggunakan kalimat yang bersumber dari Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) yang telah ditetapkan dalam sebuah klasifikasi diagnosis keperawatan. Label pada diagnosis ini dibentuk berdasarkan hasil dari deskriptor (penjelasan/ Pernyataan yang menjelaskan bagaimana suatu fokus diagnosa terjadi) dan fokus diagnostik. Berikut **tabel 3.1** penjelasannya:

Tabel 3. 1 Contoh deskriptor dan fokus diagnostik pada diagnosa keperawatan

No	Contoh Diagnosa Keperawatan	Deskriptor	Fokus Diagnostik
1	Menyusui tidak efektif	Tidak efektif	Menyusui
2	Menyusui efektif	Efektif	Menyusui
3	Harga diri rendah kronis	Rendah	Harga diri
4	Penurunan curah jantung	Penurunan	Curah jantung
5	Berat badan lebih	Lebih	Berat badan
6	Gangguan sirkulasi spontan	Gangguan	Sirkulasi spontan
7	Disfungsi motilitas gastrointestinal	Disfungsi	Motilitas gastrointestinal
8	Defisit nutrisi	Defisit	Nutrisi

Sumber : (Widuri, 2023)

Deskriptor merupakan sebuah kata kunci keperawatan yang digunakan untuk dapat memperjelas makna dari suatu diagnosis keperawatan, sehingga dapat membantu perawat dalam merumuskan temuan masalah pada pasien secara lebih spesifik, sistematis dan terstandar. Pada **tabel 3.2** ini, menegaskan bahwa penggunaan deskriptor dalam diagnosa keperawatan sangat penting untuk dapat meningkatkan kejelasan dan ketepatan dalam mengidentifikasi pasien. dengan memahami setiap deskriptor, harapannya perawat dapat merumuskan diagnosa keperawatan yang lebih akurat, sehingga penetapan perencanaan yang akan diberikan menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan yang ada pada pengkajian.

Tabel 3. 2 deskriptor, definisi dan contoh diagnosa keperawatan

No	Deskriptor	Defenisi	Contoh Diagnosa Keperawatan
1	Tidak efektif	Tidak menimbulkan efek yang diharapkan	Menyusui tidak efektif
2	Efektif	Menimbulkan efek yang diharapkan	Menyusui efektif

3	Rendah	Berada diposisi bawah nilai normal dari yang ditentukan	Harga diri rendah kronis
4	Penurunan	Berkurang baik dalam ukuran, jumlah ataupun derajat	Penurunan curah jantung
5	Lebih	Berada diatas nilai normal atau yang telah ditentukan	Berat badan lebih
6	Gangguan	Mengalami hambatan atau kerusakan	Gangguan sirkulasi spontan
7	Disfungsi	Tidak berfungsi normal	Disfungsi motilitas gastrointestinal
8	Defisit	Tidak cukup, tidak adekuat	Defisit nutrisi

Sumber: (Widuri, 2023)

b. Indikator Diagnostik

Indikator diagnostik merupakan dasar dalam mengidentifikasi dan memvalidasi temuan masalah kesehatan yang dimiliki pasien. Indikator ini dipergunakan oleh perawat agar dapat dipastikan bahwa penetapan diagnosa keperawatan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan temuan yang ada pada proses pengkajian (Koerniawan & Daeli, 2020). Terdapat tiga jenis indikator diagnostic dalam penetapan sebuah diagnosa keperawatan, antara lain (Suryono & Nugroho, 2020):

1) Penyebab atau Etiologi

Penyebab merupakan bagian dari faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah perubahan pada status kesehatan pasien. Penyebabnya dapat beragam seperti adanya perubahan fisiologis, biologis atau psikologis yang berkaitan pada fungsi tubuh, kondisi biologis hingga mental. Selain itu ada juga efek terapi/tindakan yang disebabkan oleh suatu pengobatan/prosedur tindakan tertentu, hal-hal yang dipengaruhi lingkungan atau personal hingga situasional dan yang menjadi faktor perubahan lainnya dapat berkaitan dengan proses perkembangan dan pertumbuhan (maturasional).

2) Tanda dan Gejala

Tanda dari temuan pada pasien dapat berupa sebuah data objektif yang diperoleh melalui pemeriksaan fisik, hasil lab ataupun penunjang lainnya. Sedangkan gejala yaitu sebuah data subjektif yang diperoleh dari hasil anamnesa atau keluhan yang telah dipaparkan oleh pasien. terdapat dua kelompok tanda dan gejala yaitu temuan mayor dengan presentasi 80%-100% temuan/kasus untuk dapat menegakkan diagnosa keperawatan dan temuan minor yang sifatnya sebagai data pendukung penegakan diagnosa keperawatan.

3) Faktor Risiko

Temuan faktor risiko yaitu dimana keadaan yang membuat individu/kelompok lebih rentan terhadap masalah kesehatan yang dialami. Hal ini sering ditemui pada pola hidup, riwayat masalalu, keluarga hingga faktor lingkungan.

5. Alur Proses Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan mengambil peran yang penting dalam menentukan arah asuhan keperawatan dimana penetapan suatu alur yang tersistematis dan logis berdasarkan data pada temuan pengkajian pasien menjadi penentu dalam mengidentifikasi masalah pasien secara akurat. Menurut (Sulistyawati & Hilfida, 2025) menjelaskan bahwa penerapan alur dalam menegakkan diagnosa keperawatan berdasarkan buku SDKI terdiri atas tiga tahap, antara lain:

a. Analisa Data

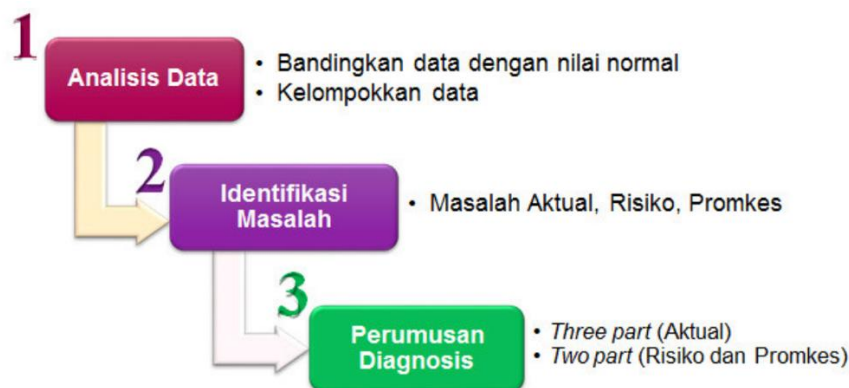
Analisa data merupakan sebuah jembatan penghubung antara proses pengkajian dan diagnosa keperawatan dimana adanya temuan hasil dari membandingkan data objektif dan data subjektif yang telah diperoleh dari hasil temuan proses pengkajian dengan nilai-nilai normal, kemudian mengidentifikasi temuan tanda dan gejala yang bermakna (bernilai normal). Contoh: data subjektif: "Tn.M mengeluhkan sensasi nyeri saat menelan dimana hal ini karena adanya pembengkakan di area leher, sehingga BB turun lebih dari 15kg dalam kurun waktu 5 bulan terakhir". Data objektif: TB=163cm dan BB: 45kg. bila terdapat data antropometri (TB, BB) maka harus menghitung Indeks Masa Tubuh (IMT) yaitu dengan cara: $IMT = BB / (TB \text{ dalam meter})^2 = 45 / (1,63)^2 = 45 / 2,6569 = 16,9kg$. Hasil ini menandakan bahwa pasien memiliki hasil IMT 16,9kg dimana hasil normal IMT adalah 18,5kg-22,9kg (Normal) sehingga temuan data pada proses pengkajian menandakan bahwa Tn.M sedang ada gangguan/masalah pada status gizi.

b. Identifikasi Masalah

Langkah alur proses selanjutnya adalah identifikasi masalah dimana hal ini dilakukan untuk menentukan apakah masalah yang muncul merupakan masalah diagnosa aktual, diagnosa risiko atau promosi kesehatan.

c. Perumusan Diagnosa Keperawatan

Setelah menemukan hasil pengelompokan data pada proses pengkajian dan mengidentifikasi permasalahan pada pasien. Perawat merumuskan diagnosa keperawatan dengan memperhatikan kategori dan subkategori dalam diagnosa keperawatan. Terdapat lima kategori dalam perumusan diagnosa keperawatan yang sesuai dengan panduan buku SDKI yaitu fisiologis, psikologis, perilaku relasional dan lingkungan.



Gambar 3. 4 Alur Proses Diagnosa Keperawatan Sumber: (Widuri, 2023)

6. Tata Cara Penulisan Diagnosa Keperawatan

Pada penulisan diagnosa keperawatan perlu memperhatikan penggunaan model *three part* (penggunaan pada masalah diagnosa aktual) atau *two part* (penggunaan pada masalah diagnosa Risiko dan promosi kesehatan) (Wagner et al., 2023).

a. Penulisan diagnosa keperawatan tiga bagian (*Three part*)

Perawat dalam menulis metode penulisan yang tepat untuk diagnosa aktual yang mencakup adanya temuan masalah, penyebab dan tanda atau gejala dengan formasi sebagai berikut:

(Masalah) berhubungan dengan (Penyebab)
dibuktikan dengan (Tanda/Gejala)

Penulisan "*berhubungan dengan*" dapat disingkat **b.d** dan "*dibuktikan dengan*" dapat disingkat dengan menulis **d.d**.

Contoh: intoleransi aktivitas b.d kelemahan fisik d.d cepat Lelah, sesak saat aktivitas ringan dan nadi meningkat setelah beraktivitas.

b. Penulisan diagnosa keperawatan dua bagian (*two part*)

Perawat dalam menetapkan metode penulisan diagnosa keperawatan dua bagian dilakukan pada diagnosa risiko dan diagnosa promosi kesehatan, dengan formulasi penulisan sebagai berikut:

1) Diagnosa Risiko

Perawat menulis dengan penulisan dua bagian, mencakup sebuah pernyataan masalah dan faktor resiko yang berkontribusi terhadap masalah pasien dengan penulisan:

(Masalah) dibuktikan dengan (Faktor Resiko)

Penulisan "*dibuktikan dengan*" tidak perlu disingkat

Contoh: resiko jatuh dibuktikan dengan kelemahan fisik dan gangguan keseimbangan.

2) Diagnosa Promosi Kesehatan

Diagnosa Promosi kesehatan memiliki ciri dengan menyatakan kesiapan individu tau kelompok untuk dapat meningkatkan kesehatan dan memiliki tanda-tanda kesiapan dengan penulisan:

(Masalah) dibuktikan dengan (Tanda/Gejala)

Penulisan "*dibuktikan dengan*" tidak perlu disingkat

Contoh: kesiapan peningkatan manajemen kesehatan dibuktikan dengan pasien berkomitmen mengikuti anjuran terapi.

7. Format Diagnosa Keperawatan

Perawat dalam merumuskan diagnosa keperawatan tentunya memiliki format yang berisikan diagnosa keperawatan yang telah dirumuskan dan diurutkan sesuai dengan prioritas masalah pada pasien. Setelah menganalisa data dilanjutkan dengan mengidentifikasi temuan masalah dan memformulasikan kedalam diagnosa keperawatan, perawat juga menulis tanggal temuan diagnosa, tanggal teratasi dan paraf/nama jelas (identitas perawat yang merumuskan diagnosa keperawatan) (Sulistyawati & Susmiati, 2020; Widuri, 2023).

Diagnosa Keperawatan:				
No	Diagnosa Keperawatan	Tanggal Ditemukan	Tanggal Teratasi	Nama Jelas dan Paraf

Sumber: (Widuri, 2023)

D. Perencanaan

1. Pengertian Perencanaan Keperawatan

Perawat pada tahap ini akan menyusun rencana dari tindakan keperawatan yang nantinya akan dilakukan untuk mengatasi masalah dan peningkatan kesehatan pasien. Menurut (Kozier et al., 2018) perencanaan keperawatan merupakan sebuah proses tersistematis ketika perawat menentukan prioritas, tujuan serta perencanaan keperawatan berguna untuk membantu pasien mencapai status kesehatan yang optimal. Sedangkan menurut Potter and Perry dalam buku (Crisp et al., 2020) menyatakan bahwa perencanaan keperawatan merupakan sebuah fase dalam komponen proses keperawatan yang melibatkan pengembangan strategi dalam mencegah, mengurangi atau mengatasi masalah kesehatan pasien yang sebelumnya telah diidentifikasi di tahap pengkajian dan perumusan diagnosa keperawatan. Sehingga dari kesimpulan diatas, perencanaan keperawatan yaitu sebuah rangkaian kegiatan dalam menentukan langkah-langkah pemecahan masalah pasien dan diurutkan berdasarkan skala prioritasnya berdasarkan hasil anamnesa, analisa data dan penegakan diagnosa keperawatan.

Defenisi perencanaan keperawatan diatas tentunya memiliki dasar pada pengetahuan dan nilai klinis untuk dapat mencapai kriteria yang diharapkan,

profesi keperawatan memiliki sebuah standar yang diperuntukkan sebagai panduan penyusunan rencana keperawatan, penyeragaman istilah/penyebutan perencanaan keperawatan, perluasan (ekspansi) dalam keilmuan, pengembangan informasi, komunikasi sesama profesi dan tim kesehatan hingga pembelajaran *decision making* bagi mahasiswa keperawatan (PPNI, 2018b). Salah satu keunggulan standar rencana keperawatan adalah adanya komprehensif (area generalis dan spesialis; kuratif dan preventif; fisiologis dan psikososial; keluarga dan komunitas; *direct care and indirect care; independent and collaborative*); perawat mudah menggunakan; berbasis riset; dan menggunakan istilah klinis yang jelas dan dapat dikaitkan dengan diagnosis dan *outcome* keperawatan, dimana standar ini dapat ditemukan pada buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) (PPNI, 2018b).

2. Tujuan Perencanaan Keperawatan

Perawat dalam menyusun perencanaan keperawatan bertujuan agar perawat dapat menentukan arah tindakan keperawatan yang akan diberikan kepada pasien. Penulisan tujuan dalam perencanaan keperawatan ini juga harus dilakukan secara jelas dan terukur agar perawat nantinya dapat melihat perubahan kondisi pasien yang diharapkan setelah diberikan tindakan keperawatan (Sulistiyawati & Susmiati, 2020). Menurut (Fithriyyah et al., 2024) menjelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan perencanaan keperawatan ini harus didasari pada diagnosa keperawatan yang telah ditetapkan sehingga akan relevan dengan masalah yang dialami pasien serta dapat dipertimbangkan baik dari kondisi, kebutuhan dan kemampuan pasien secara individual. Selain itu terdapat beberapa tujuan menurut (Doenges et al., 2022), antara lain:

- a. Perawat dapat mengidentifikasi fokus keperawatan kepada pasien maupun kelompok.
- b. Perawat dapat membedakan mana yang menjadi tanggung jawab profesi dengan keilmuan tim kesehatan lainnya.
- c. Perawat dapat menyediakan kriteria klasifikasi pasien.
- d. Menyediakan suatu pedoman dalam penulisan proses keperawatan.
- e. Proses penulisan perencanaan keperawatan mengandung komponen yang spesifik dan dapat diukur, realistis dan memiliki batas waktu yang jelas.

3. Susunan Penentuan Perencanaan keperawatan

Perawat dalam menyusun perencanaan keperawatan perlu sebuah perumusan yang jelas agar nantinya dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dan tercapai serta perawat dapat menilai tingkat keberhasilan perencanaan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, penulisan susunan perencanaan keperawatan tidak terlepas dari prinsip profesionalisme, termasuk dalam menyusun bahasa yang

tepat, fokus pada pasien, serta mengutamakan keselamatan dan kualitas pelayanan (Potter et al., 1997). Menurut (Muinga et al., 2021) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana keperawatan, antara lain:

a. Menentukan Prioritas Masalah

Perawat dalam menentukan prioritas temuan masalah adalah sebuah upaya untuk mengidentifikasi respon pasien terhadap masalah kesehatannya, baik secara aktual maupun potensial. Pendekatan dalam menetapkan prioritas masalah sering digunakan hierarki kebutuhan dasar manusia (Perera et al., 2023). Pada praktiknya perawat kurang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan pasien secara bersamaan (Paju & Dwiantoro, 2018), maka dari temuan tersebut diperlukan sebuah upaya untuk perawat dalam memprioritaskan temuan masalah (Koerniawan & Daeli, 2020). Adapun prioritas yang dimaksud antara lain:

- 1) Prioritas diagnosa merupakan poin penting untuk segera diatasi, apabila tidak diatasi dan tidak dimasukkan kedalam skala prioritas pertama maka akan berdampak buruk terhadap kondisi status fungsi kesehatan pasien.
- 2) Diagnose penting merupakan temuan masalah yang sifatnya kolaboratif dimana intervensi dapat ditunda tanpa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi status fungsi kesehatan pasien
- 3) Perawat dalam menetapkan hierarki yang dapat dijadikan sebuah dasar untuk penetapan prioritas masalah adalah hirarki maslow yaitu sebuah kegawatdaruratan masalah kesehatan berupa ancaman kesehatan maupun ancaman nyawa, tingkat masalah didasari pada temuan aktual, resiko, potensial dan kesejahteraan sampai sindrom dan yang terakhir adalah adanya keinginan dari pasien yang bersangkutan.

b. Menentukan Luaran (*Outcome*) Keperawatan

keperawatan perlu memperhatikan aspek-aspek yang mampu/dapat diobservasi dan diukur ke pasien seperti: kondisi pasien, perilaku atau persepsi individu, keluarga atau komunitas dimana ini akan menjadi data dalam pemenuhan kebutuhan rencana keperawatan (Brunt & Morris, 2023). Luaran (*Outcome*) keperawatan dapat juga dideskripsikan sebagai hasil akhir rencana keperawatan yang terdiri atas beberapa indikator dari hasil pemulihan masalah pasien. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut (Boudreau & Rhéaume, 2024):

1) Luaran (*Outcome*) Keperawatan Memiliki Prinsip SMART

- S = *Specific* (hindari pemberian makna ganda)
- M = *Measurable* (penulisan pada luaran keperawatan dapat diukur, dilihat, didengar, diraba, dirasakan ataupun dibantu)
- A = *Attainable* (target dapat dicapai)
- R = *Realistic* (perawat dapat mempertanggungjawabkan secara *evidence based*)
- T = *Timed* (memiliki jangkauan waktu yang efisien sesuai kondisi pasien)

2) Jenis Luaran (*Outcome*) Keperawatan

Jenis luaran keperawatan terbagi atas dua bagian, yaitu (Mrayyan et al., 2023):

- Luaran Positif

Luaran positif dapat digambarkan ketika kondisi, perilaku atau persepsi yang sehat, sehingga penetapan dari luaran keperawatan akan mengarah pada pemberian rencana keperawatan dengan tujuan untuk “meningkatkan atau memperbaiki” status kesehatan pasien.

- Luaran Negatif

Luaran negatif dapat ditunjukkan melalui kondisi, perilaku atau persepsi yang tidak sehat, sehingga dari penetapan luaran keperawatan nantinya akan berfokus pada pemberian intervensi keperawatan yang bertujuan untuk “menurunkan”.

Tabel 3. 3 Contoh Jenis Luaran Positif Dan Negatif

No	Jenis luaran	Contoh Luaran
1	Positif	• Citra tubuh • Integritas kulit dan jaringan • Keseimbangan cairan • Bersihan jalan nafas
2	Negatif	• Respon alergi lokal • Tingkat berduka • Tingkat keletihan • Tingkat nyeri • Tingkat ansietas

Sumber: (Widuri, 2023)

3) Komponen Luaran (*Outcome*) Keperawatan

Menurut (Sulistyawati & Hilfida, 2025) komponen luaran keperawatan terdiri atas tiga komponen, antara lain:

- Label

Penempatan pada label di luaran keperawatan merupakan hal yang menggambarkan sebuah kondisi perilaku atau persepsi pasien yang dapat diubah atau diatasi dengan tindakan keperawatan. Label perencanaan ini terdiri atas beberapa kata yang diawali dengan kata benda yang fungsinya sebagai deskriptor atau penjelas dari luaran keperawatan.

Tabel 3. 4 Beberapa Label Intervensi Keperawatan

No	Deskriptor	Defenisi
1	Dukungan	Memfasilitasi, memudahkan atau melancarkan
2	Manajemen	Mengidentifikasi dan mengelola
3	Kolaborasi	Melakukan kerja sama atau interaksi
4	Skrining	Mendeteksi secara dini
5	Perawatan	Mengidentifikasi dan merawat

Sumber: (PPNI, 2018b)

- Ekspetasi

Ekspetasi dalam luaran keperawatan merupakan harapan dari seorang perawat akan hasil yang diharapkan tercapai dengan optimal yang dapat menggambarkan kondisi perilaku atau persepsi pasien akan berubah setelah diberikan rencana keperawatan (Brunt & Morris, 2023). Terdapat tiga kategori ekspetasi yaitu meningkat (penambahan dalam ukuran, jumlah derajat atau tingkatan), menurun (pengurangan dalam sebuah ukuran, jumlah, derajat atau tingkatan), dan membaik (muncul efek yang lebih optimal, adekuat atau efektif) (PPNI, 2018b). Disisi lain, terdapat tiga kemungkinan yang diharapkan oleh perawat, antara lain:

- a. Ekspetasi Menurun

Penggunaan ini terjadi pada luaran negatif seperti pada tingkat ansietas, kelelahan, duka, infeksi, pendaharan hingga adanya respon alergi lokal, dll.

b. Ekspetasi Meningkatkan

Penggunaan ini digunakan pada luaran positif seperti tingkat pengetahuan, curah jantung, perawatan diri, status kenyamanan dll.

c. Ekspetasi Membaik

Penggunaan ini dilakukan pada luaran keperawatan yang tidak dapat diekspetasikan menurut ataupun meningkat seperti penampilan peran, gastrointestinal, fungsi seksual, dll.

- Kriteria Hasil

Perawat dalam menentukan kriteria hasil merupakan bagian dari indikator yang penerapannya spesifik dan terukur ketika digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan intervensi keperawatan. Menurut (Lei et al., 2022) kriteria hasil ini digunakan sebagai dasar dalam mencapai hasil rencana keperawatan, serta dapat membantu perawat dalam menilai aktivitas asuhan keperawatan. Adapun pedoman penulisan kriteria hasil akan berfokus pada temuan yang ada pada pasien, singkat dan jelas, mampu untuk diobservasi dan dapat diukur serta ada batasan waktu yang ditentukan oleh perawat dan pasien.

Tabel 3. 5 Skala Kriteria Hasil Luaran Keperawatan

1	2	3	4	5
Menurun	Cukup menurun	Sedang	Cukup meningkat	Meningkat

1	2	3	4	5
Meningkat	Cukup meningkat	Sedang	Cukup menurun	Menurun

1	2	3	4	5
Memburuk	Cukup memburuk	Sedang	Cukup membaik	Membaik

Sumber: (Widuri, 2023)

Perawat perlu memperhatikan bahwa dalam pelaksanaan kriteria hasil, terdapat karakteristik yang menjadi perhatian, diantaranya berhubungan dengan tujuan perawatan yang telah diterapkan seperti dapat dicapai, nyata dan dapat diukur, menuliskan kata positif, menentukan waktu, penggunaan kata kerja dan

menghindari penggunaan kata seperti normal atau baik (dapat diganti dengan menulis hasil batas ukuran yang ditetapkan atau sesuai) (Fithriyyah et al., 2024).

4) Penetapan Luaran (*Outcome*) Keperawatan

Menurut (Dewi et al., 2021) Perawat dalam menetapkan luaran (*outcome*) keperawatan dapat menggunakan dua pendekatan metode, antara lain:

a) Metode dokumentasi manual/tertulis

Penerapan dokumentasi manual/tertulis diharapkan memperoleh kriteria hasil yang jelas dan dapat dibaca oleh orang lain, contoh: setelah dilakukannya rencana keperawatan selama 3x24 jam, maka nyeri (luaran keperawatan) berkurang (ekspektasi), dengan kriteria hasil:

- Persepsi nyeri menurun (Kriteria 1: Hasil)
- Tekanan pada area nyeri menurun (Kriteria 2: Hasil)
- Kolaborasi farmakologi meningkat (Kriteria 3: Hasil)

b) Metode dokumentasi berbasis komputer

Penerapan dengan dokumentasi berbasis komputer tentunya akan dilakukan dengan berbasis komputer, contoh: setelah dilakukannya rencana keperawatan selama 3x24 jam, maka nyeri (luaran keperawatan) berkurang (ekspektasi), dengan kriteria hasil:

- Persepsi nyeri 10 (Kriteria 1: Skor)
- Tekanan pada area nyeri 10 (kriteria 2: skor)
- Kolaborasi farmakologi (kriteria 3: skor)

Perlu diperhatikan bahwa kalimat "setelah dilakukannya intervensi keperawatan selama 3x24 jam, nyeri" adalah penerapan komponen luaran: label, kemudian "maka nyeri berkurang" merupakan bagian dari ekspektasi dan pada kalimat "dengan kriteria hasil" adalah penempatan kriteria hasil yang merupakan bagian dari komponen luaran. Sehingga penerapan ketiga dari komponen luaran dapat diaplikasikan.

4. Format perencanaan Keperawatan

Perencanaan Keperawatan:					
Hari/ tanggal/ jam	No	Diagnosa keperawatan	Tujuan dan kriteria hasil	Rencana tindakan dan nama prosedur	Paraf dan nama jelas

Sumber: (Sulistyawati & Hilfida, 2025)

E. Implementasi

1. Pengertian Implementasi Keperawatan

Tahap dari proses keperawatan selanjutnya adalah implementasi (pelaksanaan). Implementasi merupakan kegiatan perawat dalam membantu pasien dalam mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi menuju kesehatan yang optimal dengan menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Implementasi keperawatan adalah sebagai bagian inisiatif dari rencana keperawatan untuk mencapai tujuan yang lebih spesifik (Ekaputri et al., 2024). Menurut (Mahmud et al., 2025) menjelaskan bahwa proses pelaksanaan implementasi yang baik harus berpusat kepada kebutuhan pasien yang mempengaruhi keputusan perawatan, strategi implementasi keperawatan dan kegiatan komunikasi. Tahap pelaksanaan dimulai setelah rencana tindakan disusun dan ditujukan pada perawat pelaksana dalam membantu pasien selama perawatan berlangsung, dimana rencana tindakan ini dilaksanakan untuk memodifikasi faktor-faktor yang menjadi masalah kesehatan pasien.

Implementasi keperawatan merupakan sebuah pelaksanaan tindakan keperawatan yang dilakukan perawat untuk membantu pasien selama perawatan dimana implementasi ini meliputi observasi, terapeutik, edukasi dan kolaborasi (PPNI, 2018b). Pengertian implementasi menurut (Cahya et al., 2023) adalah sebuah tahap dimana perawat mengaplikasikan rencana asuhan keperawatan kedalam bentuk intervensi keperawatan guna membantu pasien memperoleh tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan perawat dalam mengatasi masalah medis yang dialami

pasien dan perawat perlu memiliki kemampuan keterampilan kognitif, interpersonal dan psikomotor (Agustina et al., 2024).

2. Tujuan Penerapan Implementasi Keperawatan

Tujuan dalam pelaksanaan implementasi ini yaitu bagaimana perawat dapat membantu pasien dalam mencapai peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan dan coping yang baik apabila pasien mempunyai keinginan untuk berpartisipasi dalam implementasi asuhan keperawatan (Astarini et al., 2025). Adapun tujuan lainnya yaitu perawat mampu melaksanakan hasil keperawatan untuk selanjutnya dapat dievaluasi dengan tujuan mengetahui kondisi pasien dalam periode yang singkat, mampu mempertahankan daya tahan tubuh pasien, mencegah penyakit penyerta untuk timbul, menemukan perubahan pada sistem tubuh dan memberikan lingkungan perawatan yang nyaman bagi pasien (Ekaputri et al., 2024).

3. Jenis Implementasi Keperawatan

Perawat dalam melaksanakan implementasi keperawatan perlu menyusun sebuah pendekatan agar pelaksanaan implementasi berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Implementasi keperawatan dapat dibedakan dalam beberapa jenis berdasarkan peran dan tanggungjawabnya. Secara umum, implementasi keperawatan terdiri atas tiga jenis, antara lain (Semachew, 2018):

a. Implementasi Mandiri (Independent Nursing Intervention)

Implementasi mandiri merupakan sebuah tindakan keperawatan yang dilakukan oleh perawat yang didasari adanya kewenangan dan tanggung jawab profesionalnya tanpa memerlukan instruksi dari tenaga kesehatan lain. Tindakan ini nantinya akan didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Contohnya: edukasi kesehatan, membantu pasien memenuhi kebutuhan dasar seperti kebersihan diri, posisi pasien, serta memberikan dukungan emosional. Implementasi ini pada hakekatnya adalah sebuah penekanan kemandirian perawat dalam memberikan pelayanan yang berfokus pada kebutuhan pasien.

b. Implementasi Kolaboratif (Collaborative Nursing Intervention)

Implementasi kolaboratif adalah sebuah tindakan keperawatan yang dilakukan melalui kerja sama dengan tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Seperti adanya keterlibatan dokter, ahli gizi, fisioterapis, apoteker dan petugas kesehatan lainnya. Dalam pelaksanaannya, perawat akan berperan sebagai bagian dari tim kesehatan yang saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan perawatan pasien. contohnya: kolaborasi antara pemberian terapi nutrisi berdasarkan rekomendasi ahli gizi, pelaksanaan program rehabilitasi

dengan fisioterapis dan sebagainya. implementasi ini menekankan pentingnya komunikasi dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan perawatan pasien.

c. Implementasi Dependen (Dependent Nursing Intervention)

Implementasi dependen merupakan sebuah tindakan keperawatan yang dilakukan berdasarkan adanya sebuah instruksi atau delegasi tugas dari tenaga medis lainnya, seperti dalam praktiknya yaitu dokter. Perawat bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan benar dan sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku. Contohnya: meliputi pemberian obat sesuai resep dokter, memasang infus dan tindakan lainnya yang memerlukan instruksi khusus. Meskipun sifatnya berdasarkan perintah, perawat tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan dan ketepatan prosedur yang diberikan kepada pasien.

4. Prinsip Implementasi Keperawatan

Perawat dalam melakukan implementasi keperawatan perlu menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam memastikan bahwa setiap intervensi yang berikan berlandaskan nilai profesional, etis dan efektif kepada pasien. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain (Moghadas & Sedaghati, 2020):

a. Berorientasi Pada Pasien (*Patient Centered Care*)

Perawat dalam hal ini melakukan tindakan keperawatan harus sesuai dengan kebutuhan, kondisi, nilai dan preferensi pasien. perawat perlu dalam melaksanakan implementasi keperawatan melibatkan pasien maupun keluarga dalam tindakan yang dilakukan guna membangun hubungan terapeutik yang baik.

b. Standar Prosedur Operasional Dan *Evidence-Based Practice*

Perawat pada setiap tindakannya harus mengikuti prosedur yang berlaku serta didasarkan pada ilmu pengetahuan dan bukti ilmiah yang terbaru, sehingga dapat menjamin keamanan dan efektivitas tindakan.

c. Keselamatan Pasien (*Patient Safety*)

Perawat perlu memastikan bahwa setiap pelaksanaan keperawatan dilakukan tidak menimbulkan resiko atau berbahaya bagi pasien. hal ini mencakup ketepatan dalam indentifikasi pasien, dosis obat hingga penggunaan alat yang aman.

d. Aspek Etika Dan Legal

Perawat wajib menjunjung tinggi etika profesi seperti dimulai dari menghormati hak pasien, dapat menjaga kerahasiaan pasien hingga memberikan pelayanan tanpa merugikan atau adanya tindakan diskriminasi. Selain itu, tindakan harus sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab perawat dalam praktik profesional.

e. Komunikasi Terapeutik

Perawat mampu berkomunikasi secara efektif dengan pasien atau keluarga dalam memberikan penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan serta memperoleh kepercayaan guna kerja sama yang baik.

f. Koordinasi Pelayanan

Implementasi keperawatan dilakukan secara berkesinambungan, maka dari itu perawat perlu tetap berkordinasi dengan anggota tim kesehatan lainnya untuk memastikan pelayanan yang optimal.

g. Dokumentasi yang Akurat Dan Lengkap

Dokumentasi merupakan bukti dari tindakan yang telah dilakukan serta sebagai sarana komunikasi antar tenaga kesehatan.

5. Format Implementasi Keperawatan

Perawat melakukan tindakan keperawatan perlu memiliki dokumentasi yang baik dan mudah dibaca oleh tenaga kesehatan lainnya, dimana hal ini diperlukan suatu format yang tersistematis dan terstruktur, format ini berfungsi sebagai pedoman dalam mencatat setiap tindakan yang dilakukan oleh perawat dimana memerlukan isi yang akurat, lengkap dan berkesinambungan. Dalam praktiknya, format implementasi keperawatan ini tidak hanya mencatat bentuk tindakan yang telah dilakukan, tetapi dapat juga sebagai cermin suatu respon pasien serta evaluasi singkat terhadap sebuah intervensi yang telah (Wei et al., 2025). Oleh karena itu, penggunaan format yang tepat dapat mendukung komunikasi tim kesehatan, dapat meningkatkan pelayanan yang berkualitas serta menjadi sebuah bukti legal dalam profesi keperawatan. Adapun format implementasi keperawatan yang dapat disajikan adalah:

Implementasi Keperawatan:				
Hari/ Tanggal/ Jam	o	Tindakan Keperawatan	Evaluasi Formatif/Respon Pasien	Paraf Dan Nama Jelas

Sumber: (Widuri, 2023)

F. Evaluasi

1. Pengertian Evaluasi Keperawatan

Evaluasi merupakan tahap terakhir dari proses keperawatan dimana seorang perawat akan menilai efektivitas tindakan keperawatan yang telah dilakukan dalam mengkaji sejauh mana capaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi merupakan tahap yang sifatnya dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa asuhan keperawatan yang diberikan telah memenuhi kebutuhan pasien. menurut (Crisp et al., 2020) evaluasi adalah ketika seorang perawat dapat menentukan sejauh mana sebuah tujuan dan hasil telah tercapai untuk mengidentifikasi temuan faktor-faktor secara positif atau negatif dapat mempengaruhi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana keperawatan. Pada tahap awal dipengkajian keperawatan, perawat melakukan kajian secara terstruktur dan sistematis dimana hal tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi kemajuan pasien. Evaluasi keperawatan akan menentukan hasil keperawatan dan penetapan kriteria hasil (Jaber et al., 2025).

Tahap evaluasi merupakan sebuah perbandingan yang terencana mengenai kesehatan pasien dengan fokus pemasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya, hal ini dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Menurut (Shi et al., 2025) evaluasi merupakan tahap penting dalam proses keperawatan yang tujuannya akan menilai sejauh mana efektivitas dari intervensi keperawatan yang telah dilakukan dan agar dapat memastikan bahwa pasien telah mendapatkan secara optimal pemenuhan kebutuhan diri yang telah ditetapkan.

2. Tujuan Evaluasi Keperawatan

Perawat dalam melaksanakan evaluasi keperawatan adalah untuk melihat apakah keputusan dalam menetapkan rencana perawatan dapat dihentikan, diubah atau dilanjutkan. Evaluasi ini tentunya bertujuan akan mengarah pada penilaian pencapaian tujuan dan penyesuaian pada rencana keperawatan apabila diperlukan (Uprichard, 2020). Berikut adalah tujuan perlunya melakukan evaluasi keperawatan (Fithriyyah et al., 2024):

- a. Evaluasi keperawatan menilai bagaimana efektivitas perencanaan keperawatan yang telah disusun dimana evaluasi membantu perawat menentuka apakah rencana yang dilakukan memberikan hasil yang diharapkan dalam mencapai tujuan keperawatan
- b. Evaluasi keperawatan menilai bagaimana pencapaian tujuan dimana perawat akan memperoleh hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan kemudian membandingkannya.

- c. Evaluasi keperawatan akan menyesuaikan rencana keperawatan apabila perawat menemukan pada evaluasi keperawatan bahwa pasien belum mencapai atau mengalami perubahan dalam kondisi kesehatannya, perawat harus merencanakan ulang bagaimana kebutuhan pasien dapat berubah.

3. Proses Evaluasi Keperawatan

Proses evaluasi dalam pengaplikasian evaluasi keperawatan terdiri atas pengumpulan data, perbandingan data temuan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, penilaian hasil hingga keputusan dan tindakan (Potter et al., 2025). Berikut adalah penjelasan proses evaluasi:

a. Pengumpulan Data

Perawat mengumpulkan data melalui pendekatan observasi, wawancara dan tes diagnostic untuk melakukan evaluasi pada pasien terhadap perawatan yang telah dijalani.

b. Perbandingan Dengan Tujuan

Perawat melihat data hasil evaluasi kemudian dibandingkan dengan penetapan tujuan keperawatan sebelumnya. Tujuan ini harus spesifik, relevan dan terbatas waktu (SMART)

c. Penilaian Hasil

Perawat menilai apakah sebuah rencana keperawatan yang dilakukan telah efektif atau tidak dalam mencapai tujuan

d. Keputusan Dan Tindakan

Perawat dapat memberi keputusan untuk bagaimana langkah selanjutnya, yang mungkin saja dapat meliputi lanjutan perencanaan, mengubah atau menetapkan tujuan yang baru.

4. Mengukur Pencapaian Tujuan

Perawat dapat mengukur pencapaian tujuan evaluasi keperawatan dimana proses ini dapat membantu perawat dalam menentukan efektivitas intervensi dalam mengambil keputusan apakah melanjutkan, memodifikasi atau menghentikan sebuah rencana asuhan keperawatan. Menurut (Potter et al., 2025) adapun beberapa domain yang dapat dilakukan perawat untuk mengukur pencapaian tujuan keperawatan antara lain:

a. Kognitif

Kegiatan ini dapat dilakukan perawat untuk meliputi sejauh mana pengetahuan pasien terhadap penyakitnya, bagaimana mampu mengontrol gejala, pengobatan, diet, aktivitas, resiko komplikasi, pencegahan hingga mengetahui pengukuran suatu batas nilai normal. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan melalui interview ataupun tes tertulis

b. Afektif

Perawat melakukan pendekatan seperti menanyakan tentang sesuatu seperti, kecemasan, kemauan berkomunikasi dan sebagainya. Perawat dapat melakukannya dengan observasi secara langsung atau memberi umpan balik kepada pasien.

c. Psikomotor

Perawat melakukan observasi langsung terkait apa saja yang dapat dilakukan oleh pasien

d. Perubahan Fungsi Tubuh

Evaluasi pasien terhadap perubahan pada gejala yang spesifik. Hal ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan fisik secara langsung.

5. Jenis Evaluasi Keperawatan

Terdapat beberapa jenis evaluasi keperawatan berdasarkan kualitas dari implementasi yang telah dilaksanakan oleh perawat (Keating et al., 2024). Antara lain:

a. Evaluasi Formatif

Perawat menilai jalannya proses asuhan keperawatan sesuai terhadap situasi, kondisi dan kebutuhan pasien. Evaluasi formatif dapat dilaksanakan segera setelah perencanaan keperawatan dilaksanakan untuk membantu keefektifan terhadap tindakan

b. Evaluasi Sumatif

Perawat menilai hasil asuhan keperawatan yang diperlihatkan dengan adanya sebuah perubahan terhadap tingkah laku/ status kesehatan pasien. Evaluasi sumatif ini dapat dilaksanakan pada akhir tindakan keperawatan

6. Tahap Hasil Evaluasi Keperawatan

Menurut (Hidayat, 2021) adapun hasil evaluasi keperawatan dapat diaplikasikan sebagai berikut:

a. Masalah Pasien Teratasi

Hal ini dapat dilihat apabila pasien menunjukkan perubahan sesuai dengan standar ketetapan yang berlaku

b. Masalah Pasien Belum/Tidak Tercapai

Apabila pasien tidak/belum memperoleh suatu perubahan atau kemajuan sama sekali dan bahkan timbul masalah baru terhadap status kesehatannya

Perawat dalam mengaplikasikan hasil tahap evaluasi keperawatan dapat melakukan pendokumentasian berupa menuliskan masalah keperawatan (hanya problemnya saja), menuliskan tanggal dan jam, perawat kemudian menentukan masalah teratasi atau tidak/belum teratasi dapat melakukan pendekatan dengan membandingkan antara SOAP (*Subjective, Objective, Analisis, Planning*) atau

SOAPIER (*Subjective, Objective, Assessment, Plan, Implementation, evaluation and revision*) dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan sebelumnya serta yang terakhir adalah dengan memberikan paraf.

7. Format Evaluasi Keperawatan

Perawat dalam praktiknya perlu mendokumentasikan hasil evaluasi yang dimana hal ini dapat menjadi dasar untuk menentukan kearah mana rencana asuhan keperawatan dapat diputuskan. Adapun format dalam evaluasi keperawatan antara lain:

Evaluasi Keperawatan dengan pendekatan SOAP:				
Hari/ Tanggal/ Jam	No	Diagnosis Keperawatan	Catatan Perkembangan	Paraf Dan Nama Jelas
			S: O: A: P:	

Evaluasi keperawatan dengan pendekatan SOAPIER:				
Hari/ Tanggal/ Jam	No	Diagnosis Keperawatan	Catatan Perkembangan	Paraf Dan Nama Jelas
			S: O: A: P: I: E: R:	

Sumber: (Widuri, 2023)

Aktivitas 1- *Mini-Case*

Soal kasus:

Tn. A 45 tahun dengan wajah meringis kesakitan datang kerumah sakit dengan keluhan utama nyeri pada bagian ulu hati sejak dua hari yang lalu. Usia pasien tersebut 45 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Supir dengan status perkawinan: menikah. Alamat saat ini berada di depok, Jawa Barat, dengan diagnosa medis gastritis. Pasien masuk ke rumah sakit tanggal 10 Maret 2026. Pada riwayat kesehatan sekarang, pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri pada daerah epigastrium (ulu hati) sejak dua hari yang lalu. Nyeri dirasakan seperti perih dan terbakar, terutama saat terlambat makan. Skala nyeri 6 dari 10. Nyeri terkadang disertai mual dan muntah. Pasien juga mengatakan nafsu makan menurun sejak sakit. Pasien mengatakan dahulu sering mengalami sakit maag sejak beberapa tahun yang lalu terutama jika makan tidak teratur. Tidak ada anggota yang memiliki riwayat yang sama. Pada hasil pemeriksaan fisik: keadaan umum: tampak lemah dengan kesadaran compos mentis. Tanda-tanda vital: TD.110/70 mmHg, Nadi 96x/menit, Respirasi: 20x/menit dan suhu 37°C. Pemeriksaan abdomen: inspeksi: tidak ada distensi abdomen. Palpasi: nyeri tekan pada daerah epigastrium. Auskultasi: peristaltic usus 10x/menit. Perkusi: Timpani. Pasien memiliki BB 55Kg dan Tinggi badan 165cm.

Diskusi kelompok:

1. Kelompok melakukan identifikasi pengkajian
2. Kelompok melakukan penentuan diagnosa keperawatan
3. Kelompok menyusun perencanaan keperawatan
4. Kelompok menjelaskan tindakan/implementasi keperawatan
5. Kelompok menyusun hasil tindakan dan menuliskan evaluasi keperawatan

Soal OSCE dan Rubrik Penilaian

No	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada pasien dengan kasus fraktur
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, implementasi dan evaluasi keperawatan serta demonstrasi perawatan pada pasien dengan fraktur.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Nyeri dan Kenyamanan 2. Mobilitas 3. Keamanan dan Proteksi 4. Integritas Jaringan 5. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang pasien Tn. J usia 33 tahun dirawat di ruang bedah dengan diagnosis medis fraktur femur kanan akibat kecelakaan lalu lintas 1 hari yang lalu. Pasien mengeluh nyeri pada paha kanan dengan skala nyeri 6 (0–10), nyeri bertambah saat digerakkan. Hasil pengkajian: TD: 120/80 mmHg, Nadi 97x/Menit, RR: 22x/Menit, Suhu 36,5°C, Pasien tampak meringis, gelisah, membatasi area gerakan, area paha kanan terpasang bidai, terdapat pembengkakan, dan pasien sulit menggerakkan kaki kanan. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada Kasus 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus.

	Komponen	Isi
		3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario. 4. Tuliskan Implementasi-evaluasi Keperawatan pada lembar jawaban berdasarkan skenario 5. Lakukan demostrasi pemasangan kateter urin kepada pasien
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang pasien Tn. J usia 33 tahun dirawat di ruang bedah dengan diagnosis medis fraktur femur kanan akibat kecelakaan lalu lintas 1 hari yang lalu. Pasien mengeluh nyeri pada paha kanan dengan skala nyeri 6 (0–10), nyeri bertambah saat digerakkan. Hasil pengkajian: TD: 120/80 mmHg, Nadi 97x/Menit, RR: 22x/Menit, Suhu 36,5°C, Pasien tampak meringis, gelisah, membatasi area gerakan, area paha kanan terpasang bidai, terdapat pembengkakan, dan pasien sulit menggerakkan kaki kanan. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada kasus 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario. 4. Tuliskan Implementasi-evaluasi Keperawatan pada lembar jawaban berdasarkan skenario 5. lakukan demostrasi pemasangan kateter urin kepada pasien INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan pengkajian fokus tambahan, yaitu lokasi, intensitas nyeri, keterbatasan gerak, kondisi ekstremitas, tanda inflamasi, dan sirkulasi distal. 2. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan diagnosis keperawatan, seperti: Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik ditandai dengan skala nyeri 6, pasien meringis, dan gelisah. 3. Menilai kemampuan peserta dalam menyusun intervensi keperawatan, seperti:

	Komponen	Isi
		• Monitor skala nyeri • Observasi tanda vital • Anjurkan imobilisasi area fraktur • Ajarkan teknik relaksasi napas dalam • Kolaborasi pemberian analgetik 4. Menilai kemampuan pesesta dalam menyusun implementasi-evaluasi 5. Menilai ketepatan peserta dalam demonstrasi, meliputi: • Pemasangan kateter urin untuk jenis kelamin laki-laki mulai • Edukasi menghindari pergerakan berlebihan 6. Menilai perilaku profesional peserta 7. Penguji tidak diperbolehkan menginterupsi peserta
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas: laki-laki usia 30 tahun 2. Keluhan utama: nyeri pada paha kanan setelah kecelakaan 3. Riwayat penyakit sekarang: nyeri sejak 1 hari, bertambah saat digerakkan 4. Pasien tampak cemas dan takut bergerak 5. Bila ditanya nyeri: skala 6, terasa seperti tertusuk 6. Bila ditanya aktivitas: tidak bisa berjalan 7. Harapan: ingin nyeri berkurang dan bisa bergerak kembali 8. Posisi pasien di tempat tidur dengan kaki kanan terpasang bidai
10	Setting station	Ruang Rawat Bedah - Tempat tidur pasien - Manekin pasien - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin pasien 2. Meja dan kursi penguji 3. Troli alat 4. Alat tulis 5. Washtafel/handrup

	Komponen	Isi
		6. Tempat Sampah
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: • Bak instrumen • Bengkok • Selang kateter urin • Urin bag • Jelly • Pinset sirugis 1 buah • Pinset anatomis 1 buah • Handscoon • Plester • Spuit 10 cc • Gelas • Aquades steril • Perlak • Gunting Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Ns. Yohanes Zenriano Tarigan, S.Kep., M.Kep
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

SOP Demostrasi Pemasangan Kateter Urin Kepada Pasien

No	Aspek Yang Dinilai	Skor		
		0	1	2
Tahap Pra Interaksi				
1.	Identifikasi kebutuhan pemasangan kateter urin pada pasien			
2.	Identifikasi faktor atau kondisi yang dapat menyebabkan kontra indikasi.			
3.	Siapkan alat dan bahan: a. Bak Instrumen b. Bengkok c. Selang kateter urin d. Urin bag e. Jelly f. Pinset sirurgis 1 bh g. Pinset anatomis 1 bh h. Handscon i. Plester j. S spuit 10cc k. Gelas l. Aquades steril m. Gunting n. Perlak			
4.	Mencuci tangan			
Tahap Orientasi				
5.	Beri salam dan panggil nama pasien dengan namanya serta memperkenalkan diri			
6.	Jelaskan tujuan, prosedur dan lamanya tindakan pada pasien atau keluarga			
Tahap Kerja				
7.	Berikan kesempatan pasien atau keluarga bertanya sebelum kegiatan dilakukan			

8.	Menanyakan keluhan utama pasien			
9.	Jaga privasi pasien			
10.	Mencuci tangan			
11.	Mengatur posisi untuk pemasangan kateter : • Wanita : Dorsal recumbent • Pria : Supinasi			
12.	Memasang perlak dibawah bokong pasien			
13.	Mendekatkan bengkak			
14.	Meletakkan set kateter di antara kedua tungkai bawah pasien dengan jarak minimal 4 cm dari perineum pasien			
15.	Membuka set kateter			
16.	Menggunakan sarung tangan steril			
17.	Memasang duk di daerah genitalia pasien			
18.	Membuka daerah meatus • Wanita : Buka labia dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri, lalu sedikit ditarik ke atas • Pria : Pegang daerah di bawah gland penis dengan jari dan telunjuk, preputium ditarik ke bawah			
19.	Mebersihkan daerah meatus dengan kapas dan pinset • Wanita : Bersihkan daerah labia luar terakhir bagian meatus, kapas hanya sekali dipakai • Pria : Bersihkan dengan arah melingkar dari meatus keluar, minimum 3X			
20.	Melumasi ujung kateter dengan pelumas • Wanita : 2,5-5 cm • Pria : 12,5-17,5 cm			
21.	Memasukkan kateter dengan pelan-pelan, dan pasien dianjurkan untuk tarik nafas. • Wanita : Sepanjang 5-7,5 cm sampai urin keluar • Pria : Sepanjang 17,5-23 cm sampai urin keluar Jika waktu memasukkan kateter terasa adanya tahanan jangan dilanjutkan.			
22.	Menampung urin ke dalam bengkak kalau dibutuhkan urin steril maka dialirkan kebotol steril			
23.	Mengisi balon kateter dengan NaCL/aquades sebanyak yang ditentukan, menggunakan spuit tanpa jarum			

24.	Menarik kateter perlahan-lahan sampai ada tahanan balon			
25.	Menghubungkan ujung kateter keselang penampung/urin bag			
26.	Fiksasi kateter menggunakan plester			
27.	Mengantung urin bag dengan posisi lebih rendah dari pada vesica urinaria.			
28.	Melepas sarung tangan			
29.	Merapikan pasien dan mengatur posisi pasien yang nyaman			
Tahap Terminasi				
30.	Evaluasi hasil kegiatan (subjektif dan objektif)			
31.	Beri reinforcement positif pada pasien			
32.	Kontrak pertemuan selanjutnya (kegiatan, waktu dan tempat)			
33.	Mencuci tangan			
Tahap Dokumentasi				
34.	Catat : prosedur pelaksanaan, kondisi perineum dan meatus, waktu, konsistensi, warna, bau, jumlah urin, reaksi pasien pada catatan perawat			

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STASION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN KASUS FRAKTUR

I. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Menggali lokasi, skala, karakteristik nyeri, keterbatasan gerak, kondisi ekstermitas, tanda inflamasi dan sirkulasi distal					1	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis yang tepat dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai					2	
3	Implementasi dan evaluasi keperawatan	Menjelaskan tujuan tindakan, mengajarkan teknik imobilisasi, teknik relaksasi napas dalam, serta pemasangan kateter urin dan meniaai respon pasien terhadap tindakan (penurunan nyeri, peningkatan kenyamanan dan menentukan tindak lanjut					5	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					2	
	Jumlah						10	

Keterangan Skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan lengkap, tepat dan tersistematis

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN KASUS FRAKTUR

II. Rubrik Penilaian

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada pasien dengan fraktur, meliputi lokasi, skala, dan karakteristik nyeri, keterbatasan mobilitas, kondisi ekstremitas yang mengalami cedera, adanya pembengkakan atau deformitas, serta status sirkulasi distal (warna, suhu, CRT, dan nadi perifer). Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis, komunikatif, dan menginterpretasikan hasil temuan dengan benar.					1	
2. Diagnosa dan Perencanaan Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menegakkan diagnosis keperawatan yang sesuai dengan masalah prioritas pasien fraktur serta menyusun rencana keperawatan yang relevan. Peserta diharapkan mampu merumuskan diagnosis secara tepat (misalnya nyeri akut, gangguan mobilitas fisik), serta menyusun tujuan, kriteria hasil, dan intervensi berdasarkan data hasil pengkajian secara jelas dan sistematis.					2	
3. Implementasi dan Evaluasi Keperawatan Aspek pada implementasi menilai kemampuan peserta dalam melaksanakan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Tindakan meliputi monitoring nyeri, mempertahankan imobilisasi area fraktur, membantu posisi yang nyaman, serta melakukan tindakan secara aman, tepat, dan sistematis. Peserta juga diharapkan mampu melakukan edukasi kepada pasien mengenai teknik relaksasi (napas dalam), pentingnya imobilisasi, serta pencegahan komplikasi seperti pergeseran tulang atau cedera lanjutan. Aspek pada evaluasi menilai Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam mengevaluasi hasil tindakan keperawatan					5	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
yang telah dilakukan berdasarkan respon pasien. Evaluasi meliputi penilaian perubahan skala nyeri, tingkat kenyamanan pasien, kemampuan mobilisasi, serta tanda-tanda perbaikan kondisi. Peserta diharapkan mampu menyimpulkan apakah tujuan tercapai, tercapai sebagian, atau belum tercapai, serta menentukan tindak lanjut yang sesuai secara sistematis.						
4. Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menunjukkan sikap profesional selama tindakan, meliputi memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, komunikasi terapeutik, menjaga privasi dan kenyamanan pasien, bekerja secara sistematis, teliti, aman, serta responsif terhadap kondisi pasien.				2		

III. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus fraktur.	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi masalah utama (nyeri/cedera).	Melakukan pengkajian cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting seperti lokasi dan skala nyeri, keterbatasan gerak, dan kondisi	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan meliputi lokasi, skala, dan karakteristik nyeri, keterbatasan mobilitas, kondisi ekstremitas (deformitas/pembengkakan), serta sirkulasi distal, dan mampu menyampaikan hasil dengan tepat

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
			ekstremitas, namun masih ada data yang terlewat atau kurang lengkap	
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis atau diagnosis tidak sesuai dengan data, serta tidak menyusun rencana keperawatan	Menegakkan diagnosis tetapi tidak tepat sebagai prioritas atau tidak sesuai data, serta rencana keperawatan sangat terbatas dan tidak relevan	Menegakkan diagnosis cukup tepat (misalnya nyeri akut/gangguan mobilitas), serta menyusun rencana keperawatan yang cukup sesuai, namun belum lengkap atau kurang spesifik	Menegakkan diagnosis keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data, serta menyusun rencana keperawatan lengkap (tujuan, kriteria hasil, intervensi) yang relevan, sistematis, dan sesuai kebutuhan pasien fraktur
3. Implementasi dan evaluasi Keperawatan	Tidak melakukan tindakan keperawatan atau tindakan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien, serta tidak	Melakukan tindakan terbatas, banyak langkah penting tidak dilakukan (misalnya tidak menjaga imobilisasi), edukasi	Melakukan tindakan cukup baik (monitor nyeri, posisi nyaman, imobilisasi, edukasi napas dalam), namun masih	Melakukan tindakan secara tepat, aman, sistematis (monitor nyeri, menjaga imobilisasi, posisi nyaman, edukasi relaksasi dan pencegahan komplikasi), serta melakukan evaluasi secara tepat berdasarkan respon pasien (penurunan nyeri,

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	melakukan evaluasi	kurang jelas, serta evaluasi tidak berdasarkan respon pasien	ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan, atau teknik, serta evaluasi dilakukan namun belum lengkap	peningkatan kenyamanan) dan menentukan tindak lanjut
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi dan keamanan pasien	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, namun masih kurang dalam komunikasi terapeutik, privasi, atau keselamatan pasien	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi cukup jelas, menjaga privasi dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan dalam sistematika atau respons	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, komunikasi terapeutik baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan pasien, serta bersikap teliti, responsif, dan etis

IV. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan

Skor	Keterangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

V. Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah skor yang didapat}}{\text{Jumlah aspek yang dinilai}} \times 100$$

Jakarta,
Penguji

(.....)

Penerapan *Direct Observation of Procedural Skills* (DOPS)

Komponen	Deskripsi	Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Kasus Fraktur
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan asuhan keperawatan awal pada pasien dengan fraktur di ruang rawat bedah.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa dinilai tidak hanya dari pemahaman tentang fraktur, tetapi juga kemampuan melakukan pengkajian nyeri, kondisi ekstremitas, serta menjelaskan rencana asuhan kepada pasien.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran.	Seorang laki-laki usia 30 tahun dirawat dengan fraktur femur akibat kecelakaan. Pasien mengeluh nyeri skala 6, terdapat pembengkakan, keterbatasan gerak, dan terpasang bidai.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian nyeri dan kondisi ekstremitas, menilai sirkulasi distal, menjelaskan kondisi cedera, serta menyampaikan rencana tindakan seperti imobilisasi, manajemen nyeri, dan pencegahan komplikasi.
Aspek yang dinilai	Aspek meliputi pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai kemampuan mahasiswa dalam menggali nyeri, mobilitas, tanda inflamasi, sirkulasi distal, menetapkan diagnosis (nyeri akut/gangguan mobilitas), serta

Komponen	Deskripsi	Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Kasus Fraktur
		memberikan edukasi yang tepat kepada pasien.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data dengan masalah prioritas, seperti nyeri akut, serta mampu melakukan tindakan aman (imobilisasi) dan edukasi yang tepat.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan pengkajian nyeri, namun perlu meningkatkan ketelitian dalam pemeriksaan sirkulasi distal dan sistematika tindakan.
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten jika mampu melakukan asuhan secara runtut, aman, dan tepat. Perlu supervisi jika masih membutuhkan arahan. Remedial jika belum memenuhi standar.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mencapai level "does" dalam capaian pembelajaran.	Pada kasus fraktur, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu melakukan pengkajian, tindakan imobilisasi, manajemen nyeri, serta edukasi secara langsung dan profesional.

PORTOFOLIO

Komponen	Deskripsi	Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Kasus Fraktur
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu.	Pada asuhan keperawatan pasien fraktur, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian nyeri dan kondisi ekstremitas, menetapkan diagnosis, melakukan imobilisasi, memberikan edukasi, serta meningkatkan performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan pengalaman merawat pasien fraktur, tetapi juga perkembangan kemampuan dalam manajemen nyeri, teknik imobilisasi, dan komunikasi setelah mendapatkan masukan dari pembimbing.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur dan performa nyata di lahan praktik.	OSCE memuat hasil ujian keterampilan imobilisasi dan edukasi nyeri, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan asuhan keperawatan pada pasien fraktur di ruang rawat bedah.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus berisi ringkasan kasus pasien, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan kasus pasien fraktur femur dengan nyeri skala 6, pembengkakan, keterbatasan gerak, diagnosis nyeri akut dan gangguan mobilitas, intervensi imobilisasi dan manajemen nyeri, serta evaluasi respon pasien.

Komponen	Deskripsi	Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Kasus Fraktur
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien dan menyusun langkah pencegahan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya menjaga imobilisasi untuk mencegah pergeseran tulang, memantau sirkulasi distal, mencegah cedera tambahan, serta memastikan tindakan dilakukan dengan aman.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan untuk peningkatan kompetensi.	CI menilai mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan pengkajian nyeri, namun perlu meningkatkan ketelitian dalam pemeriksaan sirkulasi distal dan sistematika tindakan keperawatan.
Karakteristik penilaian	Portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang menekankan konsistensi performa mahasiswa, bukan satu kali penilaian.	Mahasiswa dinilai dari beberapa pengalaman merawat pasien fraktur, menunjukkan konsistensi dalam pengkajian, tindakan imobilisasi, dan edukasi pasien.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio menunjukkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa dalam berbagai situasi praktik.	Dari OSCE, DOPS, catatan kasus, dan refleksi, terlihat mahasiswa konsisten mampu melakukan pengkajian nyeri, menjaga imobilisasi, dan memberikan edukasi kepada pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tercapai pada level "does" melalui performa nyata yang berulang.	Pada kasus fraktur, portofolio menunjukkan mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan asuhan keperawatan secara konsisten, aman, dan profesional dalam praktik klinik.

Tabel *Case Report* Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Kasus Fraktur

Komponen	Deskripsi	Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Kasus Fraktur
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan tentang pasien dengan fraktur, misalnya fraktur femur akibat kecelakaan, dengan keluhan nyeri hebat, pembengkakan, keterbatasan gerak, dan perubahan bentuk ekstremitas.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien fraktur, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas seperti nyeri akut dan gangguan mobilitas, tindakan yang diberikan, serta perkembangan kondisi pasien setelah intervensi.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Mahasiswa menuliskan nyeri skala 6–8, pembengkakan, keterbatasan gerak, hasil pemeriksaan fisik, diagnosis nyeri akut dan gangguan mobilitas fisik, intervensi imobilisasi, manajemen nyeri, edukasi posisi, serta evaluasi penurunan nyeri dan peningkatan kenyamanan pasien.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Dari kasus fraktur, mahasiswa belajar pentingnya pengkajian nyeri, pemeriksaan sirkulasi distal, imobilisasi yang benar,

Komponen	Deskripsi	Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Kasus Fraktur
		serta edukasi pasien untuk mencegah komplikasi.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus diare, mahasiswa belajar bahwa pengkajian intake-output, tanda dehidrasi, dan edukasi keluarga merupakan bagian yang sangat penting dalam asuhan keperawatan anak.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep fraktur, tetapi mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan secara komprehensif, aman, dan profesional.

Tabel Refleksi *Patient Safety* Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Kasus Fraktur

Komponen	Deskripsi	Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Kasus Fraktur
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus fraktur, mahasiswa merefleksikan bahwa cedera tulang yang tidak ditangani dengan tepat dapat menyebabkan komplikasi seperti kerusakan jaringan, gangguan sirkulasi, atau kecacatan permanen.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan seperti imobilisasi yang tidak tepat, kurangnya pemantauan sirkulasi distal, atau keterlambatan penanganan nyeri dapat membahayakan pasien.

Komponen	Deskripsi	Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Kasus Fraktur
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien fraktur meliputi gangguan sirkulasi, nyeri tidak terkontrol, cedera tambahan, dan risiko infeksi (terutama pada fraktur terbuka).
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang diidentifikasi antara lain: gangguan perfusi jaringan distal (pucat, dingin, nadi lemah), peningkatan nyeri, pembengkakan, kesalahan posisi ekstremitas, serta keterlambatan tindakan medis.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya melakukan imobilisasi yang benar, memantau sirkulasi distal (warna, suhu, CRT, nadi), mengkaji nyeri secara berkala, menjaga posisi ekstremitas, serta berkolaborasi dalam pemberian analgesik dan tindakan lanjutan.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa ketelitian dalam pengkajian, keterampilan teknik imobilisasi, dan komunikasi dengan pasien sangat penting untuk mencegah komplikasi pada fraktur.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengidentifikasi risiko, mengevaluasi praktik, dan meningkatkan mutu asuhan keperawatan secara berkelanjutan pada pasien fraktur.

G. Ringkasan

Proses keperawatan merupakan fondasi utama dalam praktik keperawatan profesional yang menyediakan kerangka kerja sistematis bagi perawat dalam memberikan asuhan kepada individu, keluarga, maupun komunitas. Melalui pendekatan ilmiah yang terstruktur dan berkelanjutan, proses ini membantu perawat dalam mengidentifikasi kebutuhan klien secara menyeluruh, menetapkan keputusan klinis yang tepat, serta merancang dan melaksanakan intervensi yang aman, efektif, dan berorientasi pada hasil. Buku ini mengulas secara komprehensif lima tahapan utama proses keperawatan, yaitu pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi, yang disusun secara runtut dan aplikatif guna menunjang pembelajaran serta praktik klinik. Tahap pengkajian sebagai langkah awal menekankan pentingnya pengumpulan data subjektif dan objektif secara sistematis dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, tahap diagnosis keperawatan mengarahkan pembaca untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam mengidentifikasi respons klien terhadap masalah kesehatan, baik yang bersifat aktual, risiko, maupun promosi kesehatan. Pada tahap perencanaan, pembahasan difokuskan pada penyusunan tujuan dan intervensi yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan klien, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan asuhan keperawatan yang efektif.

Tahap implementasi dibahas sebagai bentuk penerapan langsung dari rencana tindakan, dengan penekanan pada aspek keselamatan pasien, komunikasi terapeutik, serta kerja sama antarprofesi. Sementara itu, tahap evaluasi dipaparkan sebagai proses penilaian yang sistematis terhadap hasil intervensi yang telah dilakukan, sekaligus sebagai dasar untuk menentukan langkah tindak lanjut. Dengan mengintegrasikan kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan klinis, serta dokumentasi yang terstruktur, bab ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa dan praktisi keperawatan dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan secara profesional dan berkesinambungan.

Tabel 3. 6 Red Flags & Eskalasi

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Nyeri sangat hebat/tidak terkontrol	Menunjukkan kemungkinan komplikasi, pergeseran fragmen tulang, atau penanganan nyeri tidak adekuat	Segera laporkan ke perawat penanggung jawab/dokter, evaluasi ulang nyeri, kolaborasi pemberian analgesik
Perubahan warna ekstremitas (pucat/kebiruan)	Menandakan gangguan perfusi atau aliran darah	Segera laporkan, lakukan pemeriksaan sirkulasi distal, siapkan tindakan lanjutan
Ekstremitas terasa dingin	Indikasi gangguan sirkulasi perifer	Eskalasi segera, pantau suhu dan perfusi jaringan
CRT memanjang (>3 detik)	Menunjukkan perfusi jaringan tidak adekuat	Laporkan segera, lakukan monitoring ketat
Tidak mampu menggerakkan jari/ekstremitas	Menandakan gangguan neuromuskular atau kerusakan saraf	Laporkan segera untuk evaluasi lebih lanjut
Nyeri bertambah saat digerakkan pasif	Tanda awal sindrom kompartemen	Segera eskalasi untuk evaluasi medis lebih lanjut
Tanda infeksi (kemerahan, panas, nyeri, keluar cairan)	Indikasi infeksi lokal atau sistemik	Laporkan segera, tingkatkan kewaspadaan terhadap perburukan
Tanda syok: nadi cepat lemah, tekanan darah menurun, kulit dingin	Kondisi gawat darurat akibat perdarahan atau trauma berat	Segera panggil bantuan, lakukan tindakan emergensi sesuai protokol
Demam tinggi	Dapat menunjukkan infeksi yang signifikan atau komplikasi	Laporkan dan lanjutkan pemantauan ketat

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab "Proses Keperawatan: Pengkajian, Diagnosa, Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi" dengan kasus Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Kasus Fraktur

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan konsep proses keperawatan: Pengkajian, Diagnosa, Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	☐	☐	
2	Saya sudah bisa melakukan pengkajian pada pasien dengan kasus fraktur	☐	☐	
3	Saya sudah bisa melakukan penegakan diagnosa keperawatan pada pasien dengan kasus fraktur	☐	☐	
4	Saya sudah bisa melakukan proses perencanaan keperawatan pada pasien dengan kasus fraktur	☐	☐	
5	Saya sudah bisa melakukan tahap implementasi dan evaluasi pada pasien dengan kasus fraktur	☐	☐	
6	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi singkat asuhan keperawatan dengan kasus fraktur	☐	☐	
7	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif saat merawat pasien dengan kasus fraktur	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

.....

Referensi

- Adamy, E. K., Zocche, D. A. de A., & Almeida, M. de A. (2020). Contribution of the nursing process for the construction of the identity of nursing professionals. *Revista Gaucha de Enfermagem*, 41(Spe). <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2020.20190143>
- Agritubella, S. M., Arif, Y., & Afriyanti, E. (2017). Karakteristik Individual Perawat Terhadap Kenyamanan Dan Kepuasan Proses Interaksi Pelayanan Keperawatan. *NERS: Jurnal Keperawatan*, 13(2), 15–33.
- Agustina, A., Sillehu, S., Has, E. M. M., & Indarwati, R. (2024). Dokumentasi Keperawatan Elektronik untuk Meningkatkan Kualitas Asuhan Keperawatan. *Jurnal Penelitian Kesehatan" SUARA FORIKES"(Journal of Health Research" Forikes Voice)*, 15(2), 312–316.
- Alligood, M. R. (2017). *Nursing theorists and their work-E-book: nursing theorists and their work-e-book*. Elsevier Health Sciences.
- Astarini, M. I. A., Antonio, C. C., & Manungkalit, M. (2025). Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Oleh Perawat Pelaksana Di Ruang Rawat Inap. *JPK: Jurnal Penelitian Kesehatan*, 15(1), 56–61. <https://doi.org/10.54040/jpk.v15i1.293>
- Berman, A., Snyder, S. J., Levett-Jones, T., Dwyer, T., Hales, M., Harvey, N., Moxham, L., Langtree, T., Parker, B., & Reid-Searl, K. (2018). *Kozier and Erb's Fundamentals of Nursing [4th Australian edition]*. Pearson Australia. <https://researchonline.jcu.edu.au/51992/>
- Boudreau, C., & Rhéaume, A. (2024). Impact of the Work Environment on Nurse Outcomes: A Mediation Analysis. *Western Journal of Nursing Research*, 46(3), 210–218. <https://doi.org/10.1177/01939459241230369>
- Brunt, B. A., & Morris, M. M. (2023). *Nursing professional development evidence-based practice*. <https://doi.org/doi.org/10.1371/journal.pone.0305008>
- Cahya, M. R. F., Iriani, R., La Ramba, H., Yari, Y., Kurniasari, M. D., Desmawati, E., de Fretes, F., Rayanti, R. E., Sholihin, R. M., & Utami, R. A. (2023). *Konsep Dasar Keperawatan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Crisp, J., Douglas, C., Rebeiro, G., & Waters, D. (2020). *Potter & perry's fundamentals of nursing ANZ edition-eBook*. Elsevier Health Sciences.
- Davarpanah, I., Adine, M., Elahi, N., Haghighizadeh, M. H., & Javaherforooshzadeh, F. (2024). The Effect of Implementing Nursing Care Based on Gordon's Model on the Clinical Outcomes of Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery: A Quasi-experimental Study. *Jundishapur Journal of Chronic Disease Care*, 13(2). <https://doi.org/10.5812/jjcdc-139899>

- Dewi, N. H., Suryati, E., Mulyanasari, F., & Yupartini, L. (2021). Pengembangan Format Dokumentasi Asuhan Keperawatan Gawat Darurat Berbasis SDKI, SLKI, dan SIKI. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 4(2), 554–565. <https://doi.org/10.31539/jks.v4i2.1817>
- Doenges, M. E., Moorhouse, M. F., & Murr, A. C. (2022). *Nurse's pocket guide: Diagnoses, prioritized interventions, and rationales*. FA Davis.
- Duan, X., Ding, Y., Ning, Y., & Luo, M. (2024). Application of NANDA-I nursing diagnoses, nursing interventions classification, and nursing outcomes classification in research and practice of cardiac rehabilitation nursing: A scoping review. *International Journal of Nursing Knowledge*, 35(3), 256–271.
- Ekaputri, M., Susanto, G., Paryono, Kusumaningtiyas, D. P. H., Aisyah, & Farisi, M. (2024). *PROSES KEPERAWATAN: KONSEP, IMPLEMENTASI, DAN EVALUASI*.
- Fithriyyah, Y. N., Pradipta, I. D. A. G. F., Pinilih, S. S., & Suryati, S. (2024). *Dasar Keperawatan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Gordon, M. (2008). *Assess Notes Nursing Assessment & Diagnostic Reasoning*. FA Davis. www.fadavis.com/orbycalling800-323-3555
- Hawthorne, D. M., & Gordon, S. C. (2020). The invisibility of spiritual nursing care in clinical practice. *Journal of Holistic Nursing*, 38(1), 147–155.
- Hidayat, A. A. (2021). *Proses Keperawatan; Pendekatan Nanda, Nic, Noc Dan Sdki*. Health Books Publishing.
- Ho, K. F., Ho, C. H., & Chung, M. H. (2019). Theoretical integration of user satisfaction and technology acceptance of the nursing process information system. *PLoS ONE*, 14(6). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217622>
- Irwanti, F., Guspianto, G., Wardiah, R., & Solida, A. (2022). Hubungan komunikasi efektif dengan pelaksanaan budaya keselamatan pasien di RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi. *Jurnal Kesmas Jambi*, 6(1), 32–41.
- Jaber, M. J., Al-Bashair, A. M., Kouri, O., Aldiqs, M. A., Alqudah, O. M., Khraisat, O. M., Bindahmsh, A. A., Alshodukhi, A. M., Almutairi, A. O., & Hakeem, N. A. (2025). Development and Validation of a Workflow Instrument to Evaluate the Success of Electronic Health Records Implementation from a Nursing Perspective: An Exploratory and Descriptive Study. *Global Journal on Quality and Safety in Healthcare*, 8(1), 15–22.
- Keating, M., Ferrada, P., O'Halloran, P. J., Perry, W., Potter, S., Reddy, S. S., Wilder, F. G., & Reynolds, I. S. (2024). Tips for early career academic surgeons. In *The American Journal of Surgery* (Vol. 234, pp. 191–193). Elsevier.

- Koerniawan, D., & Daeli, N. E. (2020). Aplikasi standar proses keperawatan: Diagnosis, outcome, dan intervensi pada asuhan keperawatan. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 3(2), 739–751.
- Kozier, B., Erb, G., Berman, A., Snyder, S. J., Buck, M., Yiu, L., & Stamler, L. L. (2018). Fundamentals of Canadian nursing. *Concepts, Process, and Practice-Pearson*, 1096–1119.
- Lei, Y.-Y., Zhu, L., Sa, Y. T. R., & Cui, X.-S. (2022). Effects of high-fidelity simulation teaching on nursing students' knowledge, professional skills and clinical ability: A meta-analysis and systematic review. *Nurse Education in Practice*, 60, 103306.
- Leoni-Scheiber, C., Mayer, H., & Müller-Staub, M. (2020). Relationships between the Advanced Nursing Process quality and nurses' and patient' characteristics: A cross-sectional study. *Nursing Open*, 7(1), 419–429. <https://doi.org/10.1002/nop2.405>
- Mahmud, Muhammad, D. F., Akbar, I., & Almubarak, A. Z. (2025). *Model Standar 3S Dalam Pendokumentasian Asuhan Keperawatan* (R. J. Sarwadhmana, Ed.). PT. Duta Media Press. <https://journal.dutamediapress.com/index.php/repository/article/view/86/93>
- Majchrowicz, B., & Tomaszewska, K. (2023). Usefulness of physical examination in the professional practice of nurses. *Problemy Pielęgniarstwa*, 31(2), 77–84. <https://doi.org/10.5114/ppiel.2023.130747>
- Masri, M., Marlina, M., & Syarif, H. (2023). Kompetensi dan Motivasi dalam Pelaksanaan Proses Keperawatan. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 6(2), 1563–1569. <https://doi.org/10.31539/jks.v6i2.5262>
- Melin-Johansson, C., Palmqvist, R., & Rönnerberg, L. (2017). Clinical intuition in the nursing process and decision-making—A mixed-studies review. *Journal of Clinical Nursing*, 26(23–24), 3936–3949.
- Moghadas, T., & Sedaghati, K. M. (2020). *Factors influencing implementation of nursing process by nursing students: a qualitative study*.
- Mousavinasab, E. S., Rostam Niakan Kalhori, S., Zarifsanaiey, N., Rakhshan, M., & Ghazisaeedi, M. (2020). Nursing process education: A review of methods and characteristics. In *Nurse Education in Practice* (Vol. 48). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2020.102886>
- Mrayyan, M. T., Abunab, H. Y., Abu Khait, A., Rababa, M. J., Al-Rawashdeh, S., Aljunmeeyn, A., & Abu Saraya, A. (2023). Competency in nursing practice: a concept analysis. *BMJ Open*, 13(6), e067352.
- Muinga, N., Abejirinde, I. O., Paton, C., English, M., & Zweekhorst, M. (2021). Designing paper-based records to improve the quality of nursing

- documentation in hospitals: A scoping review. *Journal of Clinical Nursing*, 30(1–2), 56–71.
- Nuryanti, A. (2020). Uji Coba Instrumen Pengkajian Keperawatan Medikal Bedah Berbasis Pola Fungsional Kesehatan Gordon. *Jurnal Keperawatan*, 9(2), 1–10. <https://doi.org/10.47560/kep.v9i2.243>
- Ordu, Y., & Çalışkan, N. (2023). The effect of virtual game simulation on students' perception of nursing diagnosis and clinical practice: Post-test only randomized controlled trial. *Nurse Education in Practice*, 72, 103792.
- Paju, W., & Dwiantoro, L. (2018). Upaya meningkatkan komunikasi efektif perawat-pasien. *Jurnal Keperawatan*, 10(1), 28–36. <https://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/Keperawatan/article/view/65>
- Perera, A. C., Joseph, S., Marshall, J. L., & Olson, D. M. (2023). Exploring plan of care communication with a multidisciplinary rounding plan to nursing care plans. *Journal of Neuroscience Nursing*, 55(2), 49–53.
- Perry, A. G., Potter, P. A., Ostendorf, W. R., & Laplante, N. (2024). *Clinical Nursing Skills and Techniques-E-Book: Clinical Nursing Skills and Techniques-E-Book*. Elsevier Health Sciences.
- Potter, P. A., Perry, A. G., & Dickenson-Hazard, N. (1997). *Fundamentals of nursing: Concepts, process, and practice* (Vol. 616, Number 083). Mosby St. Louis, MO.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., Hall, A., & Ostendorf, W. R. (2025). *Fundamentals of Nursing-E-Book: Fundamentals of Nursing-E-Book*. Elsevier health sciences.
- PPNI. (2018a). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Defenisi dan Indikator Diagnostik* (DPP PPNI, Vol. 1).
- PPNI. (2018b). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia:Definisi dan Tindakan Keperawatan, Edisi 3. Jakarta: DPP PPNI*. <https://www.inna-ppni.or.id>
- PPNI, T. P. S. D. (2019). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: definisi dan indikator diagnostik*.
- Pujiastuti, M., Fajarnita, N. A., Purba, M. M., Lestari, N. M., Minnesa, N., & Deliana, M. (2025). *Buku ajar Metodologi dan Dokumentasi Keperawatan*. Polkesraya Press.
- Rahmi, U. (2019). *Dokumentasi keperawatan* (B. S. Farmawati, Ed.). Bumi Medika. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=JzFaEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=data+objektif+dan+subjektif+keperawatan&ots=zLFiHpsJCg&sig=fASpQIG2FeqUMeyMmOwlFnOJs0E&redir_esc=y#v=onepage&q=data%20objektif%20dan%20subjektif%20keperawatan&f=false

- Rodriguez-Suarez, C.-A., Gonzalez-de la Torre, H., Hernandez-De Luis, M.-N., Fernandez-Gutierrez, D.-A., Martinez-Alberto, C.-E., & Brito-Brito, P.-R. (2023). Effectiveness of a standardized nursing process using NANDA international, nursing interventions classification and nursing outcome classification terminologies: a systematic review. *Healthcare*, 11(17), 2449.
- Sanson, G., Vellone, E., Takao-Lopes, C., Barrientos-Trigo, S., Porcel-Galvez, A. M., Riegel, B., & D'Agostino, F. (2022). Filling a gap in standardized nursing terminology. Development of a new nursing diagnosis proposal on heart failure self-care. *International Journal of Nursing Knowledge*, 33(1), 18–28.
- Semachew, A. (2018). Implementation of nursing process in clinical settings: the case of three governmental hospitals in Ethiopia, 2017. *BMC Research Notes*, 11(1), 173.
- Shi, Q., Wotherspoon, R., & Morphet, J. (2025). Nursing informatics and patient safety outcomes in critical care settings: A systematic review. *BMC Nursing*, 24(1), 546.
- Sulistyawati, W., & Hilfida, N. H. (2025). *Penerapan SDKI, SLKI, SIKI dalam pendokumentasian asuhan keperawatan*. Nuansa Fajar Cemerlang.
- Sulistyawati, W., & Susmiati, S. (2020). The implementation of 3S (SDKI, SIKI, SLKI) to The quality of nursing care documentation in hospital's inpatient rooms. *STRADA: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 9(2), 1323–1328.
- Suryono, S., & Nugroho, C. (2020). Kompetensi Perawat Mendokumentasikan Diagnosis Keperawatan Berdasarkan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI). *Jurnal ILKES (Jurnal Ilmu Kesehatan) Vol*, 11.
- Tadzong-Awasum, G., Ghislaine, M. M., Adelphine, D., Boris, K. A., & Seraphine, M. N. (2022). Nurses' experiences with the adoption and use of the nursing process in four urban hospitals. *International Journal of Africa Nursing Sciences*, 16. <https://doi.org/10.1016/j.ijans.2022.100411>
- Toney-Butler, T. J., & Thayer, J. M. (2023). Nursing process. In *Statpearls [internet]*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/NBK499937/>
- Uprichard, K. (2020). E-learning in a new era: enablers and barriers to its implementation in nursing. *British Journal of Community Nursing*, 25(6), 272–275.
- Wagner, C. M., Butcher, H. K., & Clarke, M. F. (2023). *Nursing interventions classification (NIC)-E-book: nursing interventions classification (NIC)-E-book*. Elsevier Health Sciences.

- Wei, Q., Pan, S., Liu, X., Hong, M., Nong, C., & Zhang, W. (2025). The integration of AI in nursing: addressing current applications, challenges, and future directions. *Frontiers in Medicine*, 12, 1545420.
- Widuri. (2023). *Buku Ajar Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis*. Lembaga Chakra Brahmanda Lentera. <https://pub.candle.or.id/index.php/pub>
- Zuyina, A., Etlidawati, Suroso, J., & Linggardini, K. (2026). Hubungan Fungsi Controlling Kepala Ruangan dengan Kinerja Perawat Pelaksana dalam Pendokumentasian Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit. *Jurnal Manajemen Asuhan Keperawatan*, 10(1), 52–58. <https://doi.org/10.33655/mak.v10i1.244>

BAB 4

BERPIKIR KRITIS, CLINICAL REASONING, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEPERAWATAN

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar keperawatan, profesionalisme, etika–legal, dan keselamatan pasien sebagai landasan praktik.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6
CPL-2	Mampu menerapkan proses keperawatan secara sistematis (pengkajian–diagnosis–perencanaan–implementasi–evaluasi) berbasis kebutuhan dasar manusia.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-7
CPL-3	Mampu melakukan pengkajian dasar (tanda vital, nyeri, pemeriksaan fisik) serta dokumentasi yang akurat dan dapat diaudit.	CPMK-3; CPMK-7
CPL-4	Mampu melaksanakan keterampilan keperawatan dasar (oksigenasi, nutrisi, eliminasi, mobilisasi, integumen, pemberian obat) secara aman dan sesuai standar.	CPMK-4; CPMK-6
CPL-5	Mampu berkomunikasi terapeutik, memberikan edukasi kesehatan, dan melakukan discharge planning dasar yang berpusat pada pasien–keluarga.	CPMK-5; CPMK-7
CPL-6	Mampu berpikir kritis dan clinical reasoning untuk pengambilan keputusan, pencegahan risiko, serta perbaikan mutu praktik keperawatan dasar.	CPMK-2; CPMK-6; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan pengantar keperawatan dasar, profesionalisme perawat, peran, nilai, dan standar perilaku dalam pelayanan.
CPMK-2	Menjelaskan konsep sehat–sakit, homeostasis, kebutuhan dasar manusia, serta menerapkan berpikir kritis/clinical reasoning dalam pengambilan keputusan keperawatan.
CPMK-3	Melakukan proses keperawatan (pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, evaluasi) dan mendokumentasikan secara sistematis.
CPMK-4	Melaksanakan keterampilan keperawatan dasar untuk pemenuhan kebutuhan dasar (oksigenasi, nutrisi, cairan, eliminasi, istirahat–tidur, mobilisasi, integumen) sesuai standar.
CPMK-5	Menerapkan komunikasi terapeutik dan hubungan perawat–klien secara profesional untuk mendukung asuhan dan edukasi.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Menerapkan etik–hukum, patient safety, PPI, pencegahan jatuh, dan keselamatan medikasi dalam praktik keperawatan dasar.
CPMK-7	Melaksanakan edukasi kesehatan, discharge planning, dan handover SBAR, serta mengevaluasi luaran asuhan dan menyusun perbaikan rencana berbasis data.

F. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 4. Berpikir Kritis, Clinical Reasoning, dan Pengambilan Keputusan Keperawatan	4.1 Menerapkan clinical reasoning untuk membuat problem list dan prioritas tindakan.	4.2 Menetapkan keputusan keperawatan berbasis risiko dan bukti dasar pada skenario.	CPMK-2	CPMK-6; CPMK-3

G. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	Ujian kasus clinical reasoning	Ketepatan problem list/prioritas (skor rubrik) dan konsistensi alasan berbasis risiko/bukti dasar.	10	Lembar jawaban kasus
CPMK-3	Tugas proses keperawatan tertulis (mini care plan)	Ketepatan diagnosis/prioritas dan kualitas tujuan SMART serta evaluasi terukur (skor rubrik).	15	Mini care plan
CPMK-6	OSCE keselamatan (PPI, jatuh, 6 benar medikasi) + checklist	Persentase kepatuhan prosedur keselamatan dan ketiadaan kesalahan kritis.	15	Checklist keselamatan; log error (jika ada)

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep profesionalisme (% miskonsepsi benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Akurasi respons pada skenario perilaku profesional	Respons keliru/berisiko	Respons cukup; alasan lemah	Respons tepat; alasan logis	Respons sangat tepat; alasan kuat & konsisten standar

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan problem list & prioritas	Prioritas tidak sesuai; banyak masalah kunci terlewat	Prioritas cukup; masih ada ketidaktepatan bermakna	Prioritas tepat; masalah kunci tercakup	Prioritas sangat tepat; masalah kunci lengkap & terurut
2.2 Konsistensi alasan berbasis risiko/bukti dasar	Tanpa alasan; tidak berbasis risiko	Alasan umum; risiko belum jelas	Alasan logis; risiko jelas	Alasan sangat kuat; mengaitkan risiko, bukti dasar, dan keselamatan

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Ketepatan diagnosis/prioritas	Tidak sesuai data; prioritas keliru	Sebagian sesuai; prioritas kurang konsisten	Sesuai data; prioritas jelas	Sangat sesuai; prioritas sangat logis & tervalidasi
3.2 Kualitas tujuan SMART & evaluasi terukur	Tujuan tidak SMART; evaluasi tidak jelas	Sebagian SMART; evaluasi terbatas	SMART; evaluasi jelas	SMART sangat kuat; evaluasi komprehensif dan operasional

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan langkah keterampilan dasar (checklist)	≤60% langkah benar; ada kesalahan kritis	61–75% benar; kekurangan bermakna	76–90% benar; kesalahan minor	>90% benar; aman tanpa kesalahan bermakna
4.2 Ketepatan evaluasi respons pasien	Tidak mengevaluasi/keliru	Mengevaluasi terbatas; indikator kurang tepat	Evaluasi jelas; indikator tepat	Evaluasi sangat jelas; indikator tepat & tindak lanjut cepat

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kinerja komunikasi terapeutik (checklist)	≤60% perilaku tercapai; hubungan tidak terbina	61–75% tercapai; hubungan terbina sebagian	76–90% tercapai; hubungan efektif	>90% tercapai; empatik, adaptif, profesional

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.2 Batas profesional & respons terhadap hambatan komunikasi	Tidak menjaga batas; respons tidak tepat	Batas sebagian; respons kurang konsisten	Batas jelas; respons tepat	Batas sangat jelas; respons sangat efektif & aman

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Kepatuhan PPI & kewaspadaan standar	Banyak langkah terlewat; risiko tinggi	Langkah inti ada; kurang konsisten	Langkah tepat; konsisten	Langkah sangat tepat; konsisten tanpa pelanggaran
6.2 Kepatuhan keselamatan jatuh & 6 benar medikasi	Sering melanggar; ada kesalahan kritis	Cukup patuh; masih ada kekurangan	Patuh; tanpa kesalahan kritis	Sangat patuh; antisipatif risiko dan terdokumentasi

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan edukasi–discharge plan (teach-back)	Tidak terstruktur; pemahaman tidak terbukti	Terstruktur sebagian; bukti pemahaman terbatas	Terstruktur; bukti pemahaman memadai	Sangat terstruktur; bukti pemahaman kuat & terdokumentasi
7.2 Kelengkapan SBAR & dokumentasi terintegrasi	Informasi kritis hilang; tidak dapat diaudit	Informasi inti ada; masih kurang spesifik	Lengkap; runtut; dapat ditindaklanjuti	Sangat lengkap; ringkas; risiko terantisipasi; sangat dapat diaudit

Aktivitas Belajar (Scaffolding)

1. Aktivitas 1: Knows/Knows How

Mini-case tertulis dan diskusi kelompok kecil untuk mengidentifikasi data penting, abnormalitas, risiko, serta red flags pasien.

Latihan menyusun problem list, prioritas masalah berdasarkan ABC/Maslow/risiko, dan rasional tindakan keperawatan berbasis evidensi.

2. Aktivitas 2: Shows How

Simulasi/skill lab analisis kasus klinik dengan format *clinical reasoning* dari pengkajian sampai evaluasi.

Presentasi lisan keputusan klinis: fokus urutan tindakan, keselamatan pasien, komunikasi SBAR, dan eskalasi bila muncul red flags.

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check, latihan soal, analisis mini-case, dan penugasan prioritas masalah
Shows How	OSCE/ujian praktik analisis kasus dan clinical reasoning

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical items (wajib lulus):

1. Melakukan pengkajian awal secara sistematis dan mengidentifikasi data klinis yang relevan.
2. Menentukan prioritas masalah pasien secara tepat berdasarkan prinsip ABC, risiko, dan keselamatan pasien.
3. Menjelaskan rasional tindakan/intervensi secara logis dan berbasis evidensi.
4. Melakukan komunikasi klinis yang jelas dan melakukan eskalasi bila ditemukan red flags.
5. Mendokumentasikan keputusan dan hasil pengkajian secara ringkas, tepat, dan aman.

Cuplikan rubrik:

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor issue	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup tepat	Ragu-ragu	Keliru
Komunikasi klinis	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan: Nilai tinggi tidak menutup kegagalan pada aspek keselamatan pasien.

Pendahuluan

Praktik keperawatan modern menuntut perawat tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam menganalisis kondisi pasien dan mengambil keputusan klinis yang tepat. Berpikir kritis dan *clinical reasoning* menjadi fondasi utama dalam memastikan keselamatan pasien, efektivitas intervensi, serta kualitas asuhan keperawatan. Berpikir kritis dalam keperawatan merupakan kemampuan kognitif yang esensial dalam mendukung pengambilan keputusan klinis yang aman dan efektif.

Dalam konteks pelayanan kesehatan yang semakin kompleks, perawat dihadapkan pada situasi klinik yang dinamis, penuh ketidakpastian, serta membutuhkan keputusan cepat dan akurat. Oleh karena itu, kemampuan mengintegrasikan data klinis, pengalaman, serta evidensi ilmiah menjadi sangat penting.

Bab ini dirancang untuk mendukung pencapaian kemampuan berpikir kritis dan *clinical reasoning* dalam pengambilan keputusan keperawatan berbasis risiko dan keselamatan pasien.

Tujuan Intruksional Umum:

Mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan konsep berpikir kritis serta *clinical reasoning* dalam pengambilan keputusan keperawatan secara sistematis, berbasis evidensi, dan berorientasi pada keselamatan pasien dalam praktik klinik

Tujuan Instruksional Khusus:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep berpikir kritis dalam keperawatan
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen dan karakteristik berpikir kritis
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik perawat yang berpikir kritis
4. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan tahapan *clinical reasoning*.
5. Mahasiswa mampu menerapkan *clinical reasoning* dalam proses keperawatan.
6. Mahasiswa mampu melakukan pengambilan keputusan keperawatan secara sistematis dan berbasis bukti.
7. Mahasiswa mampu menentukan prioritas masalah pasien menggunakan pendekatan klinis.

Capaian Pembelajaran:

Kognitif:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep berpikir kritis dalam keperawatan
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep *clinical reasoning* dan pengambilan keputusan keperawatan

3. Mahasiswa mampu menganalisis data pasien untuk mengidentifikasi masalah keperawatan
4. Mahasiswa mampu menentukan prioritas masalah berdasarkan tingkat urgensi (ABC, Maslow, risiko)
5. Mahasiswa mampu menyusun rasional tindakan keperawatan berbasis evidensi
6. Mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas intervensi keperawatan

Psikomotor:

1. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap kritis, teliti, dan bertanggung jawab dalam praktik keperawatan
2. Mahasiswa mampu mengutamakan keselamatan pasien dalam setiap pengambilan keputusan
3. Mahasiswa mampu bersikap terbuka terhadap masukan dan pendapat tim kesehatan
4. Mahasiswa mampu menunjukkan empati dan kepedulian terhadap kondisi pasien
5. Mahasiswa mampu memiliki kesadaran reflektif terhadap tindakan yang dilakukan

Afektif:

1. Melakukan pengkajian pasien secara sistematis
2. Menyusun problem list berdasarkan data klinis
3. Menentukan prioritas tindakan keperawatan
4. Melaksanakan intervensi keperawatan sesuai standar
5. Menerapkan prinsip keselamatan pasien dalam tindakan klinis
6. Mendokumentasikan hasil asuhan keperawatan secara tepat

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari konsep berpikir kritis, clinical reasoning, dan pengambilan keputusan keperawatan. Materi diawali dengan pemahaman dasar tentang berpikir kritis, dilanjutkan dengan karakteristik dan komponennya dalam praktik keperawatan. Selanjutnya, dibahas konsep clinical reasoning beserta tahapan dan komponennya yang menjadi landasan dalam proses keperawatan. Selain itu, bab ini juga menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan berpikir kritis dan clinical reasoning, serta keterkaitannya dengan keselamatan pasien.

A. Berpikir Kritis dalam Keperawatan

1. Pengertian Berpikir Kritis

Berpikir kritis dalam keperawatan merupakan kemampuan kognitif esensial yang mendukung pengambilan keputusan klinis secara aman dan efektif (Alfarolefevre, 2017). Secara konseptual, berpikir kritis didefinisikan sebagai proses berpikir yang disengaja, sistematis, dan reflektif dalam menganalisis informasi, mengevaluasi bukti, serta menentukan tindakan yang tepat dalam situasi klinis (Falcó-Pegueroles et al., 2021). Lebih lanjut, berpikir kritis mencerminkan kemampuan perawat untuk merefleksikan petunjuk klinis, mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan, dan bertindak secara proaktif dalam menghadapi situasi yang kompleks dan dinamis (Gao et al., 2025). Oleh karena itu, berpikir kritis menjadi fondasi utama dalam clinical reasoning dan pengambilan keputusan klinis.

2. Pentingnya Berpikir Kritis dalam Praktik Keperawatan

Berpikir kritis merupakan kompetensi inti yang sangat penting dalam praktik keperawatan karena berperan langsung dalam meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas asuhan keperawatan. Perawat dituntut untuk mampu membuat keputusan yang akurat dan tepat waktu dalam situasi klinis yang seringkali kompleks dan dinamis (Zainal et al., 2025). Kemampuan berpikir kritis terbukti berkontribusi dalam meningkatkan kinerja profesional perawat, termasuk dalam hal pengambilan keputusan klinis, inisiatif kerja, serta akuntabilitas dalam praktik keperawatan (Zuriguel-Pérez et al., 2018). Selain itu, berpikir kritis juga berhubungan positif dengan efikasi diri, fleksibilitas kognitif, serta kesehatan mental yang lebih baik, sehingga mendukung ketahanan dan kepuasan kerja perawat (Martínez-Momblan et al., 2023).

Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa berpikir kritis memiliki peran penting dalam menjamin keselamatan pasien dan meningkatkan kualitas

pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Zainal et al., 2023). Perawat yang memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik cenderung lebih mampu mengidentifikasi masalah secara dini, menentukan prioritas tindakan, serta memberikan asuhan yang tepat dan berpusat pada pasien. Dengan demikian, penguatan kemampuan berpikir kritis tidak hanya berdampak pada peningkatan kompetensi individu perawat, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien.

3. Komponen Berpikir Kritis

Komponen berpikir kritis merupakan unsur-unsur yang membentuk dan memengaruhi kemampuan seseorang dalam berpikir kritis. Menurut (Lawrence, 2020; Potter et al., 2023), berpikir kritis terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu kompetensi, dasar pengetahuan, pengalaman, lingkungan, sikap, dan operasi mental. Keenam komponen tersebut saling berinteraksi dan berkontribusi dalam membentuk kemampuan perawat untuk melakukan penilaian klinis (*clinical judgment*) serta pengambilan keputusan yang tepat dalam praktik keperawatan.

Adapun penjelasan masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

a. Kompetensi (*Competence*)

Kompetensi berpikir kritis merupakan proses kognitif yang penting dalam membantu perawat menerapkan proses keperawatan secara tepat sehingga menghasilkan *clinical judgment* yang akurat. Selain itu, terdapat kompetensi lain yang tidak kalah penting, yaitu kemampuan dalam melakukan keterampilan keperawatan secara terampil, seperti tindakan langsung (*hands-on procedures*) dan teknik pemeriksaan fisik.

Kompetensi perawat akan terus berkembang melalui latihan dan pengalaman dalam melakukan berbagai keterampilan keperawatan. Dengan praktik yang berkelanjutan, perawat tidak hanya semakin terampil secara teknis, tetapi juga semakin mampu mengintegrasikan keterampilan tersebut dengan kemampuan berpikir kritis dalam memberikan asuhan keperawatan yang efektif dan berpusat pada pasien

b. Dasar Pengetahuan (*Knowledge Base*)

Dasar pengetahuan perawat berkembang melalui berbagai proses pendidikan, baik pendidikan dasar, pendidikan berkelanjutan, maupun pendidikan lanjutan. Selain itu, perawat juga memperluas pengetahuan dengan membaca literatur berbasis penelitian untuk mempertahankan pemahaman yang mutakhir mengenai ilmu dan teori keperawatan. Pengetahuan berbasis bukti, yaitu pengetahuan yang berasal dari hasil penelitian dan pengalaman klinis, menjadikan perawat sebagai pemikir kritis

yang lebih baik. Dengan memahami konsep ilmiah, perawat mampu mengantisipasi serta mengidentifikasi masalah pasien secara lebih tepat.

Dasar pengetahuan perawat mencakup berbagai bidang ilmu, seperti ilmu dasar, humaniora, ilmu perilaku, dan ilmu keperawatan. Pengetahuan ini diimplementasikan secara berbeda dibandingkan profesi kesehatan lain karena perawat melihat pasien secara holistik. Artinya, perawat tidak hanya memperhatikan aspek fisik, tetapi juga aspek psikologis, sosial, moral, etika, dan budaya dalam memenuhi kebutuhan pasien.

Sumber pengetahuan yang paling penting dalam berpikir kritis adalah data pasien. Data pasien mencakup berbagai informasi yang diperlukan untuk memahami kondisi klinis dan situasi kehidupan pasien secara menyeluruh, antara lain:

- 1) Observasi perilaku dan tanda klinis pasien
- 2) Pemeriksaan fisik secara langsung
- 3) Wawancara dengan pasien dan keluarga
- 4) Data dari rekam medis
- 5) Hasil pemeriksaan diagnostik

c. Pengalaman (Experience)

Keperawatan merupakan disiplin praktik yang menuntut pengalaman klinis sebagai bagian penting dalam proses pembelajaran. Pengalaman klinis diperlukan untuk mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan, *clinical judgment*, serta meningkatkan kompetensi dalam melakukan keterampilan keperawatan. Dalam situasi klinis, perawat belajar melalui berbagai cara, seperti mengamati kondisi pasien, merasakan situasi klinik, berkomunikasi dengan pasien dan keluarga, memberikan asuhan secara langsung, serta melakukan refleksi terhadap setiap pengalaman yang diperoleh.

Pengalaman klinis dapat diibaratkan sebagai "laboratorium nyata" bagi perawat untuk mengembangkan, menguji, serta menyesuaikan pendekatan asuhan keperawatan sesuai dengan kondisi lingkungan, karakteristik pasien, dan pengalaman sebelumnya. Pengalaman juga membantu perawat membangun pola pikir berbasis kasus (*pattern recognition*), yaitu kemampuan mengenali pola kondisi pasien berdasarkan pengalaman sebelumnya.

d. Lingkungan (*Environment*)

Berpikir kritis selalu dipengaruhi oleh kondisi di sekitar seperti kompleksitas tugas, tekanan waktu, lingkungan kerja, dan gangguan. Salah satu contoh faktor lingkungan adalah kompleksitas tugas. Pasien dengan banyak masalah kesehatan atau yang memerlukan berbagai tindakan

keperawatan dalam waktu singkat dapat menyulitkan proses pengambilan keputusan. Kompleksitas ini memengaruhi bagaimana data pasien (cue) muncul dan dipahami, sehingga secara tidak langsung memengaruhi keputusan yang diambil.

Selain itu, tekanan waktu juga berperan penting. Misalnya, ketika perawat harus menangani pasien lain atau melakukan tindakan yang mendesak (seperti pemberian obat), fokus dalam membuat keputusan yang tepat dapat terganggu. Perawat juga mempertimbangkan risiko dan konsekuensi jika tindakan tidak segera dilakukan. Semakin kompleks kondisi pasien dan semakin sering terjadi perubahan klinis, maka semakin menantang proses berpikir kritis.

Ketepatan waktu dalam pengambilan keputusan sangat memengaruhi hasil pasien. Oleh karena itu, perawat harus mampu bertindak cepat ketika melihat pola data yang mengarah pada masalah serius.

Selain itu, perawat juga perlu memahami dinamika tim dalam pelayanan kesehatan, seperti:

- 1) Cara dan waktu berkomunikasi
- 2) Peran dan kepemimpinan dalam tim
- 3) Harapan tim dalam menangani masalah
- 4) Tingkat kemandirian (autonomi) yang diberikan

Keterlambatan atau keraguan dalam bertindak dapat menyebabkan risiko cedera pada pasien.

e. Sikap (Attitudes)

Salah satu sikap yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk berpikir kritis adalah rasa ingin tahu, yang mendorong seseorang untuk mempertanyakan asumsi-asumsi yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, yang mendorong seseorang untuk mempertanyakan asumsi-asumsi yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

Beberapa sikap mendukung kemampuan berpikir kritis dijelaskan pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel. 4.1

Tabel 4. 1 Sikap Berpikir Kritis dan Aplikasinya dalam Praktik Keperawatan

Sikap Berpikir Kritis	Aplikasi dalam Praktik Keperawatan
Percaya diri (Confidence)	Perawat tidak ragu untuk menyampaikan pendapat atau berbeda pandangan. Selalu memastikan tindakan dilakukan dengan

	aman dan berdasarkan pengetahuan yang cukup.
Berpikir mandiri (Thinking independently)	Perawat tidak hanya mengikuti kebiasaan, tetapi menggunakan bukti ilmiah. Bersikap terbuka terhadap berbagai intervensi dan aktif mencari serta berbagi informasi terbaru.
Keadilan (Fairness)	Perawat mendengarkan semua pihak secara objektif. Tidak langsung memberi label negatif pada pasien, tetapi memberikan asuhan dengan sikap terbuka sesuai kebutuhan pasien.
Tanggung jawab dan otoritas (Responsibility and authority)	Perawat berani meminta bantuan bila diperlukan. Mengikuti standar prosedur dan segera melaporkan masalah yang muncul dalam praktik.
Keberanian mengambil risiko (Risk taking)	Perawat berani mempertanyakan tindakan yang kurang tepat dan mengusulkan alternatif berbasis bukti ilmiah untuk meningkatkan kualitas asuhan.
Disiplin (Discipline)	Perawat melakukan tindakan secara sistematis dan berdasarkan standar praktik. Menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengkajian dan evaluasi.
Ketekunan (Perseverance)	Perawat tidak mudah menerima jawaban yang tidak jelas. Terus mencari informasi yang akurat dan bekerja sama dengan tim untuk menemukan solusi terbaik.
Kreativitas (Creativity)	Perawat mengembangkan berbagai alternatif intervensi. Melibatkan pasien dan keluarga dalam penyesuaian perawatan sesuai kebutuhan.
Rasa ingin tahu (Curiosity)	Perawat selalu bertanya dan mengeksplorasi informasi lebih dalam. Tidak menerima informasi tanpa analisis kritis.

Integritas (Integrity)	Perawat menyadari ketika pendapat pribadi berbeda dengan orang lain dan tetap mengutamakan keputusan terbaik bagi pasien.
Kerendahan hati (Humility)	Perawat menyadari keterbatasan diri dan tidak ragu meminta bantuan atau mencari informasi tambahan untuk meningkatkan kualitas keputusan.

f. Mental operations

Mental operations adalah aktivitas berpikir seperti pengambilan keputusan dan penalaran yang digunakan untuk memahami atau menemukan makna dari suatu situasi. Aktivitas ini terjadi ketika seseorang mencari solusi berdasarkan alasan yang logis dan merencanakan hasil yang ingin dicapai.

Hasil dari proses berpikir ini adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara kreatif dan tepat. Berpikir kritis membantu seseorang membuat keputusan klinis yang baik dengan cara menganalisis informasi dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki.

4. Dimensi berpikir kritis

Dimensi berpikir kritis merupakan kategori atau aspek yang menggambarkan ruang lingkup kemampuan berpikir kritis. Menurut (Alfarolefevre, 2017), berpikir kritis dalam keperawatan terdiri dari empat dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu dimensi personal, dimensi intelektual dan kognitif, dimensi interpersonal dan manajemen diri, serta keterampilan teknis. Keempat dimensi ini menjadi dasar dalam mendukung kemampuan perawat untuk melakukan penilaian klinis dan pengambilan keputusan secara efektif. Keempat dimensi tersebut menjadi dasar dalam mendukung kemampuan perawat untuk melakukan penilaian klinis (*clinical judgment*) dan pengambilan keputusan secara efektif dalam praktik keperawatan.

Adapun penjelasan masing-masing dimensi adalah sebagai berikut:

a. Dimensi personal

Merupakan pola perilaku intelektual yang mencakup sikap, keyakinan, dan nilai yang dimiliki individu. Dimensi ini berperan sebagai pemicu berkembangnya keterampilan berpikir kritis, seperti rasa ingin tahu, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam praktik keperawatan.

b. Dimensi intelektual dan kognitif

Mencakup kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti memahami konsep keperawatan, menganalisis data, mengevaluasi informasi, serta menggunakan penalaran dalam proses pengambilan keputusan klinis.

c. Dimensi interpersonal dan manajemen diri

Berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim, serta mengelola diri dalam situasi klinis. Dimensi ini juga mencakup kemampuan dalam mendokumentasikan informasi pasien secara akurat dan relevan.

d. Keterampilan teknis

Merupakan kemampuan praktis dan keahlian dalam melakukan prosedur keperawatan. Dimensi ini memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat diimplementasikan secara tepat, aman, dan sesuai standar praktik.

5. Karakteristik Perawat yang Berpikir Kritis

Karakteristik berpikir kritis merupakan ciri-ciri atau sifat yang mencerminkan bagaimana seseorang menggunakan kemampuan berpikir kritis dalam praktik. Karakteristik ini mencerminkan kemampuan perawat dalam menganalisis situasi klinis secara mendalam, membuat keputusan yang rasional, serta mempertimbangkan aspek keselamatan pasien dan *Evidence Based Practice* (EBP). Menurut (Dewi et al., 2021), perawat dengan kemampuan berpikir kritis yang kuat menunjukkan penilaian klinis yang lebih baik, lebih sedikit kesalahan medis, dan hasil pasien yang lebih baik

Beberapa karakteristik utama berpikir kritis dalam keperawatan dijelaskan pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4. 2 Karakteristik Berpikir Kritis dalam Keperawatan

No	Karakteristik	Deskripsi Singkat	Implikasi dalam Praktik Keperawatan
1	Analitis	Kemampuan mengidentifikasi, membedakan, dan menganalisis data klinis secara sistematis	Menginterpretasi hasil pemeriksaan dan mengidentifikasi masalah pasien
2	Logis dan rasional	Pengambilan keputusan berdasarkan hubungan sebab-akibat yang jelas dan masuk akal	Menghubungkan tanda dan gejala dengan diagnosis keperawatan
3	Reflektif	Kemampuan mengevaluasi proses berpikir dan tindakan yang telah dilakukan	Menilai efektivitas intervensi dan melakukan perbaikan

4	Terbuka (open-minded)	Bersedia mempertimbangkan berbagai perspektif dan alternatif solusi	Berdiskusi dengan tim kesehatan untuk menentukan tindakan terbaik
5	Berbasis evidence based	Menggunakan data objektif, hasil penelitian, dan pedoman klinis dalam pengambilan keputusan	Mengacu pada guideline dalam menentukan intervensi keperawatan
6	Skeptis profesional	Tidak langsung menerima informasi tanpa verifikasi dan analisis kritis	Memastikan keakuratan data pasien sebelum tindakan
7	Sistematis	Menggunakan langkah-langkah terstruktur dalam pemecahan masalah	Mengikuti proses keperawatan secara runtut
8	Kreatif dalam pemecahan masalah	Mampu mengembangkan solusi inovatif dalam situasi klinis yang kompleks	Menyesuaikan intervensi sesuai kondisi dan kebutuhan pasien

B. *Clinical Reasoning* dalam Keperawatan

1. Pengertian *Clinical Reasoning*

Clinical reasoning adalah proses berpikir yang digunakan dalam konteks klinik untuk memahami kondisi pasien dan menentukan tindakan yang tepat (Alfaro-lefevre, 2017). *Clinical reasoning* menggambarkan proses berpikir dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan praktik klinik

2. Perbedaan Berpikir Kritis dan *Clinical Reasoning*

Dalam konteks praktik klinik, berpikir kritis diwujudkan dalam bentuk clinical reasoning, yaitu proses kognitif yang digunakan perawat untuk memahami kondisi pasien, menginterpretasi data, serta menentukan intervensi yang sesuai. Dengan demikian, clinical reasoning merupakan aplikasi dari berpikir kritis dalam situasi klinis. *Clinical reasoning* terjadi dalam lingkungan klinik yang kompleks dan diatur oleh standar, prosedur, dan hukum praktik (Alfaro-lefevre, 2017).

3. Komponen Clinical Reasoning

Menurut (Berman et al., 2022), *clinical reasoning* dalam keperawatan terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan. Komponen ini menggambarkan bagaimana perawat berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak dalam situasi klinis yang dinamis. Dijelaskan sebagai berikut:

a. Penentuan Prioritas (*Setting Priorities*)

Dalam praktik keperawatan, perawat dituntut untuk mampu berpikir cepat dan tepat dalam menghadapi berbagai masalah pasien. Lingkungan klinik yang dinamis mengharuskan perawat menentukan tindakan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu.

Perawat perlu mengidentifikasi:

- 1) Pengkajian yang paling penting
- 2) Tindakan yang paling mendesak
- 3) Masalah utama pasien

Penentuan prioritas bersifat fleksibel, karena kondisi pasien dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, prioritas harus terus disesuaikan dengan situasi terkini.

Tabel 4. 3 Penentuan Prioritas Keperawatan

Kategori Prioritas	Definisi	Karakteristik	Contoh Masalah Klinis	Contoh Tindakan Keperawatan
Prioritas Tinggi (High Priority)	Masalah yang mengancam jiwa dan membutuhkan tindakan segera	- Gangguan airway, breathing, circulation (ABC) - Risiko kematian - Kondisi akut/kritis	- Sesak napas (SpO₂ rendah) - Syok - Henti jantung - Perdarahan hebat	- Pemberian oksigen - Resusitasi - Monitor ketat tanda vital - Kolaborasi emergensi
Prioritas Sedang (Medium Priority)	Masalah yang tidak langsung mengancam jiwa tetapi dapat memperburuk kondisi jika tidak ditangani	- Penyakit akut/stabil - Gangguan fungsi tubuh - Risiko komplikasi	- Nyeri akut - Infeksi - Gangguan mobilitasi - Gangguan koping	- Manajemen nyeri - Pemberian obat - Edukasi pasien - Monitoring kondisi
Prioritas Rendah (Low Priority)	Masalah yang tidak mendesak dan tidak mengancam keselamatan pasien	- Kebutuhan perkembangan	- Kurang pengetahuan - Kebutuhan edukasi	- Edukasi kesehatan - Konseling

		- Dukungan minimal - Kondisi stabil	- Masalah psikososial ringan	- Dukungan emosional
--	--	--	------------------------------	----------------------

b. Pengembangan Rasional (*Developing Rationales*)

Setelah menentukan prioritas, perawat perlu menjelaskan alasan (rasional) dari setiap tindakan yang akan dilakukan. Pada tahap ini, perawat:

- 1) Menggunakan pengetahuan keperawatan
- 2) Menghubungkan teori dengan kondisi pasien
- 3) Menentukan intervensi yang paling tepat

Kemampuan menjelaskan rasional sangat penting karena:

- 1) Mencegah kesalahan tindakan
- 2) Menjamin keamanan pasien
- 3) Menunjukkan cara berpikir profesional

Dengan demikian, rasional bukan hanya teori, tetapi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis.

c. Pembelajaran Bertindak (*Learning How to Act*)

Perawat harus mengetahui kapan dan bagaimana bertindak dalam situasi klinis, dengan fokus utama tetap pada kesejahteraan dan keselamatan pasien.

Untuk dapat bertindak dengan tepat, perawat perlu:

- 1) Memahami kondisi pasien
- 2) Mengenali tanda bahaya
- 3) Mengantisipasi komplikasi

Contohnya, jika pasien berisiko mengalami komplikasi, perawat harus:

- 1) Mengidentifikasi tanda awal
- 2) Bertindak lebih cepat
- 3) Melakukan intervensi pencegahan

Kemampuan ini membantu perawat meningkatkan keselamatan pasien dan mencegah kondisi menjadi lebih buruk.

d. *Clinical Reasoning-in-Transition*

Kondisi pasien di rumah sakit dapat berubah dengan cepat. Oleh karena itu, perawat harus mampu mengenali perubahan kecil sekalipun pada kondisi pasien.

Pada tahap ini, perawat:

- 1) Memantau perkembangan kondisi pasien
- 2) Membandingkan data sebelumnya dengan kondisi saat ini
- 3) Mengevaluasi efektivitas tindakan

e. Merespons Perubahan Kondisi Pasien (Responding to Changes in the Client's Condition)

Perawat memiliki peran penting karena paling sering berinteraksi dengan pasien. Oleh karena itu, perawat harus mampu:

- 1) Mendeteksi perubahan kondisi pasien
- 2) Menyesuaikan prioritas tindakan
- 3) Mengubah rencana asuhan bila diperlukan
- 4) Melaporkan kondisi pasien kepada tim kesehatan

Dengan melakukan pemantauan yang tepat, perawat dapat mencegah terjadinya komplikasi atau kondisi yang memburuk (*adverse outcomes*).

f. Refleksi (*Reflection*)

Refleksi merupakan bagian penting dalam *clinical reasoning*. Melalui refleksi, perawat dapat:

- 1) Menilai apakah tindakan yang dilakukan sudah tepat
- 2) Mengidentifikasi hal yang perlu diperbaiki
- 3) Mengevaluasi hasil asuhan

Perawat juga perlu bertanya pada diri sendiri:

- 1) Apakah pengkajian sudah akurat?
- 2) Apakah intervensi efektif?
- 3) Apakah kondisi pasien membaik?

Selain itu, pengalaman sebelumnya dapat digunakan sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kualitas asuhan di masa depan.

4. Tahapan Clinical Reasoning

Tahapan *clinical reasoning* dalam keperawatan merupakan proses sistematis yang dimulai dari pengumpulan data, interpretasi informasi, identifikasi masalah, penentuan prioritas, perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga refleksi. Proses ini bersifat dinamis dan berulang, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis yang aman dan efektif. Menurut (Alfaro-lefevre, 2017) tahapan *clinical reasoning* dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (Collecting Cues / Noticing)

Tahapan *clinical reasoning* dalam keperawatan dimulai dari proses pengumpulan data. Pada tahap ini, perawat mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan kondisi pasien, seperti tanda vital, keluhan yang dirasakan, hasil observasi fisik, serta data dari rekam medis. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk mengidentifikasi data yang relevan dan bermakna sebagai dasar dalam pengambilan keputusan klinis.

b. Interpretasi Data (*Interpreting*)

Pada tahap ini, perawat mulai menganalisis informasi yang diperoleh dengan cara mengelompokkan data, mencari pola tertentu, serta mengidentifikasi adanya abnormalitas. Proses ini bertujuan untuk memahami kondisi pasien secara menyeluruh dan menentukan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada pasien.

c. Identifikasi Masalah (Problem Identification / Inference)

Berdasarkan hasil analisis data, perawat menentukan masalah utama pasien dengan menyusun problem list, menetapkan diagnosis keperawatan, serta mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menentukan fokus asuhan keperawatan yang tepat.

d. Penentuan Prioritas (*Prioritizing*)

Tidak semua masalah memiliki tingkat urgensi yang sama, sehingga perawat harus menentukan masalah mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Penentuan prioritas dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan seperti prinsip ABC (airway, breathing, circulation), risiko keselamatan pasien, serta hierarki kebutuhan Maslow. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berfokus pada kebutuhan paling mendesak.

e. Perencanaan (planning/responding)

Pada tahap ini, perawat menyusun rencana asuhan keperawatan dengan menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (*SMART*), serta menentukan intervensi yang sesuai dengan kondisi pasien dan berbasis evidensi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menyiapkan tindakan yang tepat, efektif, dan aman bagi pasien.

f. Tindakan keperawatan (acting/implementation)

Tindakan ini mencakup pelaksanaan intervensi, komunikasi dengan pasien, serta penerapan prinsip keselamatan pasien. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk mengatasi masalah pasien secara langsung dan meningkatkan kondisi kesehatannya.

g. Evaluasi (*Evaluating*)

Pada tahap ini, perawat menilai efektivitas intervensi dengan membandingkan kondisi pasien sebelum dan sesudah tindakan, menilai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi respons pasien terhadap intervensi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan berhasil atau perlu diperbaiki.

h. Refleksi (reflecting/self-regulation)

Merupakan bagian penting dalam clinical reasoning. Pada tahap ini, perawat mengevaluasi proses berpikir dan tindakan yang telah dilakukan, mengidentifikasi kesalahan atau kekurangan, serta mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut. Refleksi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan klinis di masa yang akan datang serta mengembangkan profesionalisme perawat

C. Pengambilan Keputusan Keperawatan

Pengambilan keputusan klinis adalah proses memilih tindakan terbaik dari beberapa alternatif ketika perawat menghadapi masalah klinis yang berkaitan dengan pasien. Fokus utama dari pengambilan keputusan klinis adalah menyelesaikan masalah pasien (Berman et al., 2022). Pengambilan keputusan klinis yang efektif memerlukan:

1. Penalaran induktif: perawat mengumpulkan data spesifik, kemudian menarik kesimpulan umum. Contoh: Pasien dengan kelemahan ekstremitas, berjalan tidak stabil, dan riwayat jatuh, maka disimpulkan pasien berisiko jatuh.
2. Penalaran deduktif: Perawat menggunakan konsep atau teori umum, lalu menerapkannya pada kondisi pasien. Contoh: perawat menggunakan teori kebutuhan atau model keperawatan untuk menentukan prioritas masalah pasien.
3. Kemampuan membuat inferensi (kesimpulan logis).

D. Latihan Soal

1. Seorang pasien laki-laki usia 60 tahun datang dengan keluhan sesak napas. Hasil pengkajian menunjukkan: RR 30x/menit, SpO₂ 88%, pasien tampak gelisah dan menggunakan otot bantu napas. Perawat segera menganalisis kondisi pasien dan memutuskan tindakan awal. Apa bentuk penerapan berpikir kritis yang paling tepat pada kasus tersebut?
 - a. Mendokumentasikan kondisi pasien
 - b. Menunggu hasil pemeriksaan lanjutan
 - c. Mengikuti instruksi dokter tanpa analisis
 - d. Mengumpulkan data tanpa melakukan tindakan
 - e. Mengidentifikasi masalah dan menentukan prioritas tindakan

2. Seorang pasien diabetes mellitus mengalami luka pada kaki yang tidak kunjung sembuh. Perawat mengkaji kondisi luka, kadar gula darah, dan riwayat penyakit pasien sebelum menentukan intervensi. Langkah berpikir kritis yang dilakukan perawat adalah:
 - a. Refleksi
 - b. Evaluasi
 - c. Dokumentasi
 - d. Implementasi
 - e. Interpretasi data
3. Seorang mahasiswa keperawatan melihat pasien dengan tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 120x/menit, dan kulit dingin. Mahasiswa tersebut menyimpulkan pasien mengalami syok dan segera melaporkan kepada perawat senior. Kemampuan berpikir kritis yang paling menonjol pada kasus ini adalah:
 - a. Menghafal teori
 - b. Menghindari kesalahan
 - c. Mendokumentasikan data
 - d. Mengikuti prosedur standar
 - e. Menganalisis data dan menarik kesimpulan
4. Seorang perawat setelah memberikan tindakan kemudian mengevaluasi apakah kondisi pasien membaik dan merenungkan apakah tindakan yang dilakukan sudah tepat. Tahapan berpikir kritis yang dilakukan adalah:
 - a. Refleksi
 - b. Diagnosis
 - c. Pengkajian
 - d. Interpretasi
 - e. Implementasi
5. Seorang pasien perempuan usia 45 tahun dirawat dengan keluhan nyeri dada sejak 1 jam yang lalu. Hasil pengkajian menunjukkan: skala nyeri 8/10, tekanan darah 150/90 mmHg, nadi 110x/menit, dan pasien tampak cemas. Perawat kemudian mengkaji riwayat penyakit, melakukan observasi lebih lanjut, dan mempertimbangkan kemungkinan kondisi yang mengancam jiwa sebelum menentukan tindakan. Langkah berpikir kritis yang paling tepat yang dilakukan perawat adalah:
 - a. Mendokumentasikan data tanpa intervensi
 - b. Menunggu instruksi dokter tanpa melakukan tindakan awal

- c. Langsung memberikan analgesik tanpa pengkajian lanjutan
 - d. Mengabaikan kecemasan pasien dan fokus pada tanda vital
 - e. Mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengantisipasi kondisi serius
6. Seorang pasien laki-laki usia 65 tahun dirawat di ruang rawat inap dengan riwayat hipertensi. Saat pengkajian, perawat menemukan tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 120x/menit, kulit dingin, dan pasien tampak lemah. Perawat segera menganalisis data dan menyimpulkan kemungkinan syok. Langkah *clinical reasoning* yang paling tepat pada kasus tersebut adalah:
- a. Mendokumentasikan semua data pasien
 - b. Menunggu hasil pemeriksaan laboratorium
 - c. Mengabaikan data karena pasien masih sadar
 - d. Mengumpulkan data tanpa melakukan interpretasi
 - e. Menginterpretasi data dan menarik kesimpulan klinis
7. Seorang pasien pasca operasi mengeluh nyeri skala 7/10 dan tampak cemas. Tanda vital dalam batas normal. Perawat mempertimbangkan bahwa kecemasan dapat memperburuk persepsi nyeri sebelum menentukan intervensi. Keputusan perawat tersebut menunjukkan:
- a. Clinical reasoning saja
 - b. Clinical judgment tanpa analisis
 - c. Clinical decision making berbasis prioritas
 - d. Pengkajian tanpa interpretasi
 - e. Implementasi tanpa perencanaan
8. Seorang pasien dengan riwayat stroke mengalami penurunan kesadaran secara tiba-tiba. Perawat segera memeriksa tanda vital, memanggil tim medis, dan memberikan oksigen. Apa dasar utama pengambilan keputusan perawat?
- a. Kebiasaan kerja
 - b. Instruksi dokter sebelumnya
 - c. Analisis data dan prinsip ABC
 - d. Dokumentasi pasien
 - e. Pengalaman saja tanpa data

9. Seorang pasien lansia mengalami kelemahan ekstremitas, berjalan tidak stabil, dan memiliki riwayat jatuh sebelumnya. Perawat menyimpulkan bahwa pasien berisiko jatuh dan merencanakan intervensi pencegahan. Jenis penalaran yang digunakan adalah:
- a. Deduktif
 - b. Induktif
 - c. Reflektif
 - d. Evaluatif
 - e. Intuitif
10. Seorang perawat merawat 3 pasien:
- 1) Pasien A: SpO₂ 85%
 - 2) Pasien B: nyeri skala 5/10
 - 3) Pasien C: membutuhkan edukasi diet
- Perawat memutuskan untuk menangani pasien A terlebih dahulu. Keputusan tersebut didasarkan pada:
- a. Keinginan pasien
 - b. Dokumentasi rekam medis
 - c. Urutan kedatangan pasien
 - d. Prinsip komunikasi terapeutik
 - e. Prioritas berdasarkan ABC dan risiko

Kunci Jawaban:

1. Kunci Jawaban: e
Pembahasan: perawat tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga langsung menganalisis kondisi dan menentukan prioritas sesuai prinsip ABC (Airway, Breathing, Circulation).
2. Kunci Jawaban: e
Pembahasan: perawat sedang menganalisis informasi untuk memahami kondisi pasien.
3. Kunci Jawaban: e
Pembahasan: mahasiswa telah melakukan proses berpikir kritis berupa analisis dan inferensi.
4. Kunci Jawaban: a
Pembahasan: perawat menilai kembali tindakan dan hasil yang dicapai untuk meningkatkan kualitas asuhan
5. Kunci Jawaban: e
Pembahasan: perawat menerapkan berpikir kritis dengan mempertimbangkan kemungkinan kondisi yang mengancam jiwa
6. Kunci Jawaban: e
Pembahasan: Perawat telah melakukan interpretasi data dan inferensi (clinical reasoning) dengan menyimpulkan kondisi pasien.
7. Kunci Jawaban: c
Pembahasan: Perawat menentukan prioritas intervensi berdasarkan analisis kondisi pasien (decision making).
8. Kunci Jawaban: c
Pembahasan: Perawat menggunakan clinical reasoning dan prinsip prioritas ABC dalam decision making.
9. Kunci Jawaban: b
Pembahasan: Perawat menarik kesimpulan umum dari data spesifik → penalaran induktif.
10. Kunci Jawaban: e
Pembahasan: Perawat menggunakan clinical decision making berbasis prioritas (ABC).

Mini Case 1

Kasus

Seorang pasien laki-laki usia 60 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak napas sejak pagi. Hasil pengkajian menunjukkan RR 30x/menit, SpO₂ 88%, nadi 110x/menit, dan pasien tampak gelisah serta menggunakan otot bantu napas. Perawat segera mempertimbangkan kondisi pasien. Apa tindakan keperawatan prioritas yang harus dilakukan?

Mini Case 2

Kasus

Seorang pasien perempuan usia 50 tahun dirawat dengan keluhan nyeri dada sejak 1 jam. Hasil pengkajian menunjukkan nyeri skala 8/10, tekanan darah 150/90 mmHg, nadi 105x/menit, dan pasien tampak cemas. Perawat melakukan pengkajian lanjutan untuk memahami kondisi pasien. Langkah clinical reasoning yang paling tepat dilakukan perawat adalah?

Mini Case 3

Kasus

Seorang pasien lansia tampak lemah, berjalan tidak stabil, dan memiliki riwayat jatuh sebelumnya. Perawat mengamati kondisi pasien dan mengidentifikasi adanya risiko keselamatan. Perawat mulai merencanakan tindakan pencegahan. Apa masalah utama pasien dan tindakan yang paling tepat?

Jawaban

Mini case 1: Memberikan oksigen segera.

Pembahasan: Perawat mengidentifikasi tanda hipoksia (SpO₂ rendah, RR meningkat, gelisah). Berdasarkan prinsip ABC (Breathing), kondisi ini merupakan prioritas utama. Clinical decision making mengarahkan perawat untuk segera meningkatkan oksigenasi pasien.

Mini case 2: Mengumpulkan dan menganalisis data pasien

Pembahasan: Langkah awal dalam clinical reasoning adalah mengumpulkan dan menginterpretasi data. Hal ini penting untuk mengidentifikasi kemungkinan kondisi serius sebelum menentukan tindakan.

Mini case 3: Risiko jatuh dan melakukan pencegahan jatuh

Pembahasan: Perawat menggunakan clinical reasoning dengan menghubungkan data (kelemahan, ketidakseimbangan, riwayat jatuh). Keputusan klinis diarahkan pada pencegahan untuk menjaga keselamatan pasien

Tabel 4. 4 Rubrik Penilaian Clinical Reasoning dan Pengambilan Keputusan

No	Indikator Penilaian	Kriteria Penilaian (Grade)			Skor
		1	2	3	
1	Identifikasi Data:	Tidak mampu mengenali data penting	Mengenali sebagian data penting	Mengenali data penting secara tepat	
2	Analisis	Interpretasi kondisi salah	Interpretasi kondisi kurang tepat	Interpretasi kondisi tepat	
3	Masalah	Tidak mampu mengidentifikasi masalah	Mengidentifikasi sebagian masalah	Mengidentifikasi masalah dengan tepat	
4	Prioritas	Prioritas tidak sesuai	Prioritas kurang tepat	Prioritas tepat sesuai kondisi klinis	
5	Keputusan	Tindakan/intervensi tidak tepat	Tindakan kurang tepat	Tindakan tepat dan sesuai kondisi	
6	Rasional	Tidak memberikan alasan	Alasan kurang jelas	Alasan jelas dan berbasis ilmiah	
Total					

E. Ringkasan

Berpikir kritis merupakan kemampuan kognitif esensial dalam praktik keperawatan yang digunakan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi bukti, serta mengambil keputusan klinis secara tepat dan bertanggung jawab. Kemampuan ini menjadi dasar dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan berpusat pada pasien.

Berpikir kritis terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu kompetensi, dasar pengetahuan, pengalaman, lingkungan, sikap, dan operasi mental. Keenam komponen ini saling berinteraksi dalam membentuk kemampuan perawat dalam melakukan penilaian klinis (*clinical judgment*) dan pengambilan keputusan. Selain itu, berpikir kritis memiliki dimensi, meliputi dimensi personal, intelektual dan kognitif, interpersonal dan manajemen diri, serta keterampilan teknis. Dimensi ini menggambarkan ruang lingkup kemampuan yang harus dimiliki perawat dalam praktik klinik.

Karakteristik perawat yang berpikir kritis antara lain analitis, logis, reflektif, terbuka, berbasis evidensi, sistematis, skeptis profesional, dan kreatif dalam pemecahan masalah. Karakteristik ini mendukung perawat dalam menghadapi situasi klinis yang kompleks dan dinamis. *Clinical reasoning* merupakan proses berpikir yang digunakan perawat untuk memahami kondisi pasien melalui pengumpulan data, interpretasi, identifikasi masalah, penentuan prioritas, perencanaan, tindakan, evaluasi, dan refleksi. Proses ini bersifat dinamis dan menjadi dasar dalam praktik keperawatan.

Pengambilan keputusan klinis (*clinical decision making*) adalah proses memilih tindakan terbaik berdasarkan data pasien, evidensi ilmiah, pengalaman, serta pertimbangan risiko dan keselamatan pasien. Proses ini melibatkan penalaran induktif dan deduktif, serta kemampuan membuat inferensi yang tepat. Dengan demikian, berpikir kritis, clinical reasoning, dan pengambilan keputusan klinis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam praktik keperawatan. Ketiga kemampuan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, keselamatan pasien, serta profesionalisme perawat dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan modern.

Glosarium

Berpikir Kritis: Kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan reflektif dalam menganalisis informasi untuk mengambil keputusan yang tepat dalam praktik keperawatan.

Clinical Reasoning: Proses berpikir yang digunakan perawat dalam memahami kondisi pasien, menganalisis data klinis, dan menentukan tindakan keperawatan secara tepat

Pengambilan Keputusan Klinis: Proses memilih tindakan keperawatan terbaik berdasarkan data pasien, evidensi ilmiah, serta pertimbangan risiko dan keselamatan

Evidence-Based Practice (EBP): Pendekatan praktik keperawatan yang mengintegrasikan bukti penelitian terbaik, pengalaman klinis, dan nilai pasien dalam pengambilan keputusan

Problem List: Daftar masalah pasien yang disusun berdasarkan hasil pengkajian data klinis untuk menentukan prioritas asuhan keperawatan

Prioritas Keperawatan: Urutan masalah pasien berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingan yang harus ditangani terlebih dahulu

ABC (Airway, Breathing, Circulation): Pendekatan dalam menentukan prioritas yang berfokus pada jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi sebagai kebutuhan utama pasien

Clinical Judgment: Kemampuan perawat dalam membuat keputusan klinis yang tepat berdasarkan analisis data, pengalaman, dan pengetahuan

Interpretasi Data: Proses menganalisis dan memberikan makna terhadap data klinis yang diperoleh dari pasien

Referensi

- Alfaro-lefevre, R. (2017). *Critical Thinking, Clinical Reasoning, and Clinical Judgment: A Practical Approach* (6th editio). Elsevier Inc.
- Berman, A., Snyder, S., & Frandsen, G. (2022). Kozier and Erb's Fundamentals of Nursing: Concepts, Process and Practice. In *Nurse Education in Practice* (11th Editi, Vol. 12, Issue 2). <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2011.09.002>
- Carbogim, F. da C., de Oliveira, L. B., & Püschel, V. A. de A. (2016). Critical thinking: Concept analysis from the perspective of Rodger's evolutionary method of concept analysis. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 24(September). <https://doi.org/10.1590/1518-8345.1191.2785>
- Dewi, N. A., Yetti, K., & Nuraini, T. (2021). Nurses' critical thinking and clinical decision-making abilities are correlated with the quality of nursing handover. *Enfermería Clínica*, 31(2), S271–S275. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2020.09.014>
- Falcó-Peguerols, A., Rodríguez-Martín, D., Ramos-Pozón, S., & Zuriguel-Pérez, E. (2021). Critical thinking in nursing clinical practice, education and research: From attitudes to virtue. *Nursing Philosophy*, 22(1), 1–7. <https://doi.org/10.1111/nup.12332>
- Gao, K., Zhong, X., Zhang, Y., Wang, M., Chen, L., Cai, W., & Ren, W. (2025). *The self-assessment of critical thinking disposition and the needs for training: a cross-sectional survey of clinical nurses. August*, 1–9. <https://doi.org/10.3389/fmed.2025.1653991>
- Lawrence, S. C. D. P. K. L. L. M. J. T. J. (2020). *Fundamentals of Nursing: Australian and New Zealand* (2nd Editio). Cengage Learning Australia Pty Limited. <https://doi.org/10.3928/0022-0124-19780901-14>
- Lee, D. S., Khatijah, L. A., Pathmawathi, S., Robert, T. B., & Ong, S. L. (2017). An Integrated Review of the Correlation between Critical Thinking Ability and Clinical Decision-Making in Nursing. In *International Journal of Laboratory Hematology* (Vol. 38, Issue 1). <https://doi.org/10.1111/ijlh.12426>
- Martínez-Momblan, M. A., Aguilar, I. B., Alonso-Fernández, S., García, M. R., Zuriguel-Pérez, E., Falcó-Peguerols, A., & Aracil, L. B. (2023). Critical thinking among institutional academic advisors and sociodemographic, professional and academic variables: A multicenter correlation study.

- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2023). *Fundamentals Nursing* (Edition El). Elsevier, Inc. https://reader.z-library.sk/read/7e0c8245dfc116f12c80a292e0f86ce531e60d4cad5fe74b5fc79fb2841dc244/29507425/15f127/fundamentals-of-nursing.html?client_key=1fFLi67gBrNRP1j1iPy1&extension=pdf&signature=61eeceed8e78290f25c10d05ffacc13a252313731019a4e7e8d4dc5a
- Zainal, N. H., Islam, M. A., Rasudin, N. S., Mamat, Z., Hanis, T. M., Rodzlan Hasani, W. S., & Musa, K. I. (2025). Critical Thinking and Clinical Decision Making Among Registered Nurses in Clinical Practice: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Nursing Reports*, 15(5), 1–19. <https://doi.org/10.3390/nursrep15050175>
- Zainal, N. H., Musa, K. I., Rasudin, N. S., & Mamat, Z. (2023). Multilevel Modeling of Individual and Group Level Influences on Critical Thinking and Clinical Decision-Making Skills among Registered Nurses: A Study Protocol. *MDPI*, 11(1169). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/healthcare11081169>
- Zuriguel-Pérez, E., Lluch-Canut, M. T., Agustino-Rodríguez, S., Gómez-Martín, M. del C., Roldán-Merino, J., & Falcó-Pegueroles, A. (2018). Critical thinking: A comparative analysis between nurse managers and registered nurses. *Journal of Nursing Management*, 26(8), 1083–1090. <https://doi.org/10.1111/jonm.12640>

BAB 5

KOMUNIKASI TERAPEUTIK DAN HUBUNGAN PERAWAT–KLIEN

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar keperawatan, profesionalisme, etika–legal, dan keselamatan pasien sebagai landasan praktik.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6
CPL-2	Mampu menerapkan proses keperawatan secara sistematis (pengkajian–diagnosis–perencanaan–implementasi–evaluasi) berbasis kebutuhan dasar manusia.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-7
CPL-3	Mampu melakukan pengkajian dasar (tanda vital, nyeri, pemeriksaan fisik) serta dokumentasi yang akurat dan dapat diaudit.	CPMK-3; CPMK-7
CPL-4	Mampu melaksanakan keterampilan keperawatan dasar (oksigenasi, nutrisi, eliminasi, mobilisasi, integumen, pemberian obat) secara aman dan sesuai standar.	CPMK-4; CPMK-6
CPL-5	Mampu berkomunikasi terapeutik, memberikan edukasi kesehatan, dan melakukan discharge planning dasar yang berpusat pada pasien–keluarga.	CPMK-5; CPMK-7
CPL-6	Mampu berpikir kritis dan clinical reasoning untuk pengambilan keputusan, pencegahan risiko, serta perbaikan mutu praktik keperawatan dasar.	CPMK-2; CPMK-6; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan pengantar keperawatan dasar, profesionalisme perawat, peran, nilai, dan standar perilaku dalam pelayanan.
CPMK-2	Menjelaskan konsep sehat–sakit, homeostasis, kebutuhan dasar manusia, serta menerapkan berpikir kritis/clinical reasoning dalam pengambilan keputusan keperawatan.
CPMK-3	Melakukan proses keperawatan (pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, evaluasi) dan mendokumentasikan secara sistematis.
CPMK-4	Melaksanakan keterampilan keperawatan dasar untuk pemenuhan kebutuhan dasar (oksigenasi, nutrisi, cairan, eliminasi, istirahat–tidur, mobilisasi, integumen) sesuai standar.
CPMK-5	Menerapkan komunikasi terapeutik dan hubungan perawat–klien secara profesional untuk mendukung asuhan dan edukasi.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Menerapkan etik–hukum, patient safety, PPI, pencegahan jatuh, dan keselamatan medikasi dalam praktik keperawatan dasar.
CPMK-7	Melaksanakan edukasi kesehatan, discharge planning, dan handover SBAR, serta mengevaluasi luaran asuhan dan menyusun perbaikan rencana berbasis data.

G. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 5. Komunikasi Terapeutik dan Hubungan Perawat–Klien	5.1 Menerapkan teknik komunikasi terapeutik sesuai fase hubungan perawat–klien.	5.2 Menunjukkan empati, batas profesional, dan respons terhadap hambatan komunikasi.	CPMK-5	CPMK-1; CPMK-7

H. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (CBT/essay terstruktur)	Persentase jawaban benar konsep profesionalisme dan akurasi respons pada skenario perilaku profesional.	10	Nilai ujian; lembar jawaban
CPMK-5	Simulasi komunikasi terapeutik + checklist	Skor kinerja komunikasi (fase, teknik, empati, batas profesional) berbasis checklist.	10	Video/lembar penilaian
CPMK-7	Portofolio edukasi–discharge plan–SBAR	Kelengkapan edukasi (teach-back), kualitas discharge plan, dan kelengkapan SBAR (skor rubrik/checklist).	15	Materi edukasi; discharge plan; SBAR

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep profesionalisme (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Akurasi respons pada skenario perilaku profesional	Respons keliru/berisiko	Respons cukup; alasan lemah	Respons tepat; alasan logis	Respons sangat tepat; alasan kuat & konsisten standar

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan problem list & prioritas	Prioritas tidak sesuai; banyak masalah kunci terlewat	Prioritas cukup; masih ada ketidaktepatan bermakna	Prioritas tepat; masalah kunci tercakup	Prioritas sangat tepat; masalah kunci lengkap & terurut
2.2 Konsistensi alasan berbasis risiko/bukti dasar	Tanpa alasan; tidak berbasis risiko	Alasan umum; risiko belum jelas	Alasan logis; risiko jelas	Alasan sangat kuat; mengaitkan risiko, bukti dasar, dan keselamatan

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Ketepatan diagnosis/prioritas	Tidak sesuai data; prioritas keliru	Sebagian sesuai; prioritas kurang konsisten	Sesuai data; prioritas jelas	Sangat sesuai; prioritas sangat logis & tervalidasi
3.2 Kualitas tujuan SMART & evaluasi terukur	Tujuan tidak SMART; evaluasi tidak jelas	Sebagian SMART; evaluasi terbatas	SMART; evaluasi jelas	SMART sangat kuat; evaluasi komprehensif dan operasional

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan langkah keterampilan dasar (checklist)	≤60% langkah benar; ada kesalahan kritis	61–75% benar; kekurangan bermakna	76–90% benar; kesalahan minor	>90% benar; aman tanpa kesalahan bermakna
4.2 Ketepatan evaluasi respons pasien	Tidak mengevaluasi/keliru	Mengevaluasi terbatas; indikator kurang tepat	Evaluasi jelas; indikator tepat	Evaluasi sangat jelas; indikator tepat & tindak lanjut cepat

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kinerja komunikasi terapeutik (checklist)	≤60% perilaku tercapai; hubungan tidak terbina	61–75% tercapai; hubungan terbina sebagian	76–90% tercapai; hubungan efektif	>90% tercapai; empatik, adaptif, profesional

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.2 Batas profesional & respons terhadap hambatan komunikasi	Tidak menjaga batas; respons tidak tepat	Batas sebagian; respons kurang konsisten	Batas jelas; respons tepat	Batas sangat jelas; respons sangat efektif & aman

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Kepatuhan PPI & kewaspadaan standar	Banyak langkah terlewat; risiko tinggi	Langkah inti ada; kurang konsisten	Langkah tepat; konsisten	Langkah sangat tepat; konsisten tanpa pelanggaran
6.2 Kepatuhan keselamatan jatuh & 6 benar medikasi	Sering melanggar; ada kesalahan kritis	Cukup patuh; masih ada kekurangan	Patuh; tanpa kesalahan kritis	Sangat patuh; antisipatif risiko dan terdokumentasi

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan edukasi–discharge plan (teach-back)	Tidak terstruktur; pemahaman tidak terbukti	Terstruktur sebagian; bukti pemahaman terbatas	Terstruktur; bukti pemahaman memadai	Sangat terstruktur; bukti pemahaman kuat & terdokumentasi
7.2 Kelengkapan SBAR & dokumentasi terintegrasi	Informasi kritis hilang; tidak dapat diaudit	Informasi inti ada; masih kurang spesifik	Lengkap; runtut; dapat ditindaklanjuti	Sangat lengkap; ringkas; risiko terantisipasi; sangat dapat diaudit

Pendahuluan

"Pernahkah Anda membayangkan seorang perawat dengan keterampilan teknis yang luar biasa—mampu memasang infus dalam sekali tusuk atau menghafal seluruh dosis obat—namun gagal membuat kliennya merasa tenang ? Disinilah letak perbedaan antara 'mengobati' dan 'menyembuhkan'".

Komunikasi dalam keperawatan bukan sekadar pertukaran informasi medis semata, melainkan juga sebagai instrumen penyembuhan itu sendiri. Hubungan terapeutik yang terjalin antara perawat dan klien merupakan 'jembatan' yang memungkinkan asuhan keperawatan dapat diterima dengan baik. Tanpa komunikasi yang efektif, instruksi medis yang paling akurat sekalipun dapat ditolak oleh klien, dan rasa sakit fisik dapat diperburuk oleh kecemasan mental yang dialami klien.

Bab ini membahas tentang komunikasi terapeutik dan hubungan perawat – klien, untuk membekali mahasiswa memiliki kemampuan berkomunikasi dengan

klien tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kehadiran yang menyembuhkan (*healing presence*).\" Tujuan penulisan bab ini adalah peserta didik mampu menerapkan teknik komunikasi terapeutik sesuai fase hubungan perawat–klien, serta mampu menunjukkan sikap terapeutik dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa program studi sarjana Keperawatan.

Pembahasan pada Bab ini meliputi konsep komunikasi terapeutik, teknik komunikasi terapeutik sesuai fase hubungan perawat–klien, dan dinamika hubungan profesional yang meliputi empati, batas profesional, dan respons terhadap hambatan komunikasi. Pada Bab ini juga akan dibahas mengenai keterampilan komunikasi terapeutik yang harus dikuasai peserta didik melalui latihan berbasis kasus. Struktur Bab ini terdiri dari pendahuluan, tujuan instruksional dan capaian pembelajaran, materi yang diuraikan dalam beberapa sub bab, latihan berbasis kasus, penuntun belajar, Standar Prosedur Operasional (SPO) keterampilan terkait dan dilengkapi dengan rangkuman.

Tujuan Instruksional Umum :

Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan komunikasi terapeutik dalam membangun hubungan perawat–klien secara efektif, profesional, dan beretika guna mendukung kualitas asuhan keperawatan.

Tujuan Instruksional Khusus :

1. Menjelaskan konsep komunikasi terapeutik dalam hubungan perawat–klien.
2. Menguraikan tahapan hubungan terapeutik perawat–klien (fase orientasi, kerja, dan terminasi) beserta peran komunikasi pada setiap tahap.
3. Mengidentifikasi teknik-teknik komunikasi terapeutik.
4. Menerapkan komunikasi terapeutik baik verbal maupun nonverbal secara tepat dalam interaksi dengan klien.
5. Menunjukkan sikap profesional dalam hubungan perawat–klien.
6. Menjaga batasan hubungan (boundary) secara profesional.
7. Mengidentifikasi hambatan komunikasi dan cara mengatasinya.
8. Menggunakan komunikasi sebagai intervensi keperawatan untuk membantu klien mengekspresikan perasaan, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kesejahteraan.

Capaian Pembelajaran :

Kognitif :

1. Mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep komunikasi terapeutik dalam hubungan perawat-klien

2. Mahasiswa memahami dan menjelaskan tahapan/fase-fase hubungan komunikasi terapeutik perawat-klien

Psikomotor :

1. Mahasiswa mampu menerapkan komunikasi terapeutik baik verbal maupun nonverbal secara tepat dalam interaksi dengan klien.

Afektif :

1. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional dalam hubungan perawat–klien dan menjaga batasan hubungan (boundary) secara profesional
2. Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan klien sebagai intervensi keperawatan untuk membantu klien mengekspresikan perasaan, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kesejahteraan.

Uraian Materi

A. Konsep Komunikasi Terapeutik

1. Pengertian Komunikasi Terapeutik

Keterampilan berkomunikasi merupakan salah satu kompetensi penting (*critical skill*) yang harus dimiliki oleh perawat, karena komunikasi merupakan proses dinamis yang digunakan untuk mengumpulkan data pengkajian, memberikan intervensi berupa pendidikan kesehatan kepada klien dan mempengaruhi klien untuk menerapkannya dalam hidup, menunjukkan kepedulian (*caring*), menumbuhkan rasa percaya diri dan menghargai nilai-nilai klien. Hendaknya proses komunikasi yang dibangun didasarkan pada hubungan saling percaya antara perawat dengan klien dan keluarga.

Komunikasi dalam pelayanan keperawatan disebut dengan komunikasi terapeutik yaitu komunikasi yang dilakukan oleh perawat saat melaksanakan intervensi keperawatan, dimana komunikasi ini dapat memberikan khasiat terapi dalam proses penyembuhan klien. Menurut Depkes RI (1997), komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang mendorong proses penyembuhan klien. Sementara itu, Northhouse (1998) mendefinisikan komunikasi terapeutik sebagai kemampuan atau keterampilan perawat dalam berkomunikasi untuk membantu klien beradaptasi dengan stress, mengatasi gangguan psikologis, dan belajar menjalin hubungan dengan orang lain.

Komunikasi terapeutik merupakan bentuk komunikasi interpersonal yang dirancang untuk membantu individu memahami dirinya sendiri, mengatasi masalah, dan meningkatkan kesejahteraan emosional serta mental. Dalam konteks kesehatan, komunikasi terapeutik sering digunakan untuk mendukung

proses penyembuhan klien, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam profesi keperawatan, komunikasi menjadi lebih bermakna karena merupakan metode utama dalam mengimplementasikan proses keperawatan. Kualitas asuhan yang diberikan kepada klien sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan antara perawat dengan klien tersebut (Abraham et al., 2024).

Sebagai bentuk komunikasi yang terencana antara perawat dengan klien dalam upaya mencapai kesembuhan fisik dan emosional, komunikasi terapeutik memiliki karakteristik utama yang meliputi keikhlasan, empati, kehangatan, serta berfokus pada kebutuhan klien. Komunikasi ini dibangun atas dasar kepercayaan, kejujuran, dan penghormatan tanpa menghakimi. Berbeda dengan komunikasi sosial biasa, maka fokus utama komunikasi terapeutik berorientasi pada kebutuhan klien dan bagaimana perawat dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut.

2. Prinsip Dasar Komunikasi Terapeutik

Prinsip dasar dari komunikasi terapeutik adalah pendekatan profesional perawat yang berfokus pada klien untuk membangun rasa percaya, empati, dan saling menghormati. Hal ini dimaksudkan guna meningkatkan kesejahteraan psikologis dan fisik klien. Prinsip utama dari komunikasi terapeutik ini meliputi kejujuran, penerimaan tanpa syarat (*acceptance*), kerahasiaan, empati, serta komunikasi yang jelas dan konsisten. Perawat harus menciptakan rasa aman, saling percaya, menghargai keunikan klien, dan menghindari hubungan sosial, dengan tujuan akhir meningkatkan pertumbuhan positif dan kesejahteraan klien.

Menurut Boyd & Nihart (1998, dalam Sri Hastuti, 2017), salah satu prinsip utama komunikasi terapeutik adalah pelayanan yang berpusat pada klien. Dalam hal ini, perawat harus mampu menempatkan kebutuhan, perasaan, dan pengalaman klien sebagai prioritas utama. Perawat tidak hanya mendengarkan secara pasif, tetapi juga berusaha memahami makna di balik setiap ungkapan klien. Dengan demikian, klien merasa dihargai dan didengar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan terhadap perawat. Saat mendengarkan keluhan klien, perawat harus dapat menunjukkan empatinya kepada klien. Empati merupakan kemampuan perawat untuk merasakan dan memahami apa yang dirasakan oleh klien tanpa kehilangan objektivitas profesional. Empati berbeda dengan simpati; empati tidak sekadar merasa kasihan, akan tetapi lebih kepada memahami kondisi emosional klien secara mendalam. Melalui empati, perawat dapat memberikan respon yang tepat dan mendukung, sehingga klien merasa lebih nyaman untuk mengungkapkan perasaannya.

Kejujuran dan keterbukaan juga merupakan prinsip penting dalam komunikasi terapeutik. Perawat harus menyampaikan informasi dengan jujur,

jelas, dan tidak menyesatkan. Sikap terbuka ini akan membangun kepercayaan klien. Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam hubungan terapeutik, karena tanpa adanya kepercayaan, klien cenderung enggan untuk berkomunikasi secara terbuka. Saat kepercayaan klien terhadap perawat sudah terbangun, sering kali klien akan mengungkapkan informasi yang sangat pribadi. Informasi ini menjadi kerahasiaan klien yang harus dijaga (Boyd & Nihart, 1998 dalam Sri Hastuti, 2017). Oleh karena itu, perawat wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut, kecuali dalam kondisi tertentu yang mengharuskan untuk dibagikan demi keselamatan klien. Dengan menjaga kerahasiaan, perawat menunjukkan profesionalisme dan menghormati hak klien.

Komunikasi terapeutik juga menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Perawat harus menyesuaikan cara komunikasi dengan tingkat pendidikan, budaya, dan kondisi emosional klien. Penggunaan istilah medis yang terlalu teknis tanpa penjelasan dapat membuat klien bingung atau bahkan cemas. Oleh karena itu, penyampaian informasi harus dilakukan secara jelas, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan klien.

Selanjutnya, komunikasi terapeutik juga menuntut adanya kesadaran diri (*self-awareness*) dari perawat. Dalam proses komunikasi terapeutik keperawatan, *self-awareness* menjadi sangat penting karena perawat sering kali menghadapi situasi yang memicu stres dan emosi yang tinggi. Menurut De Jong, et al. (2025), perawat yang memiliki kesadaran diri tinggi cenderung lebih mampu mengelola stres, mencegah *burnout*, dan menjaga kesehatan mental mereka. Oleh sebab itu perawat harus memahami nilai, sikap, dan perasaan pribadinya agar tidak memengaruhi interaksi dengan klien. Kesadaran diri membantu perawat untuk tetap bersikap profesional dan tidak membawa masalah pribadi ke dalam hubungan terapeutik. Tidak kalah penting, perawat juga harus mampu mengontrol emosi dan menunjukkan sikap sabar serta tidak menghakimi. Dalam berbagai situasi, klien mungkin menunjukkan perilaku yang sulit atau emosional. Perawat harus tetap tenang dan tidak memberikan respon yang negatif. Sikap tidak menghakimi akan membuat klien merasa aman dan diterima apa adanya.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai beberapa prinsip komunikasi terapeutik yang harus dipahami perawat dalam membangun dan mempertahankan hubungan terapeutik dengan klien (Viliansyah, 2014) :

- a. Hubungan dengan klien Adalah hubungan terapeutik yang saling menguntungkan, didasarkan pada prinsip "*Humanity of Nursing and Clients*".
- b. Perawat harus menunjukkan sikap menghargai klien, dengan melihat latar belakang keluarga, budaya dan keunikan tiap individu.

- c. Komunikasi yang dilakukan harus dapat menjaga harga diri kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima pesan. Dalam hal ini perawat harus mampu menjaga harga dirinya sendiri maupun harga diri klien.
- d. Komunikasi yang menumbuhkan hubungan saling percaya harus dicapai terlebih dahulu sebelum menggali permasalahan klien, maupun memberikan alternatif pemecahan masalah klien.

Prinsip komunikasi terapeutik dalam keperawatan bertujuan untuk menciptakan hubungan yang saling percaya, meningkatkan kenyamanan klien, serta mendukung proses penyembuhan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti empati, kejujuran, kerahasiaan, dan mendengarkan aktif, perawat dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan bermakna. Oleh karena itu, komunikasi terapeutik tidak hanya menjadi keterampilan tambahan, tetapi merupakan kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap perawat profesional.

3. Karakteristik Komunikasi Terapeutik

Karakteristik komunikasi terapeutik dalam keperawatan merupakan ciri khas yang membedakan komunikasi ini dari komunikasi biasa. Komunikasi terapeutik dirancang secara sadar dan terarah untuk membantu proses penyembuhan klien, baik secara fisik maupun psikologis (Abdul Nasir, et al, 2009). Oleh karena itu, komunikasi ini memiliki sejumlah karakteristik khusus yang harus dipahami dan diterapkan oleh perawat dalam praktik sehari-hari.

Menurut Potter and Perry (2017), salah satu karakteristik utama komunikasi terapeutik adalah adanya tujuan yang jelas dan berfokus pada klien. Setiap interaksi yang dilakukan oleh perawat memiliki maksud tertentu, seperti mengurangi kecemasan klien, membantu klien mengungkapkan perasaan, atau memberikan edukasi kesehatan. Komunikasi ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan direncanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan klien. Dengan demikian, komunikasi menjadi lebih efektif dan bermakna.

Karakteristik berikutnya adalah hubungan yang bersifat profesional. Dalam komunikasi terapeutik, hubungan antara perawat dan klien tidak bersifat pribadi, melainkan profesional dengan batasan yang jelas. Perawat harus mampu menjaga jarak yang tepat agar tidak terlalu terlibat secara emosional, namun tetap menunjukkan empati dan kepedulian. Hubungan profesional ini bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak serta menjaga kualitas pelayanan. Selain itu, menurut Arwani (2017), komunikasi terapeutik juga ditandai dengan adanya empati. Empati merupakan kemampuan untuk memahami perasaan dan pengalaman klien dari sudut pandang klien tersebut. Dalam praktiknya, perawat menunjukkan empati melalui sikap mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan respon yang sesuai, serta tidak menghakimi. Dengan adanya empati,

klien akan merasa dihargai, dipahami, dan lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan maupun keluhannya.

Karakteristik lainnya adalah penggunaan teknik komunikasi yang terstruktur. Komunikasi terapeutik tidak dilakukan secara spontan tanpa arah, tetapi menggunakan teknik-teknik tertentu seperti pertanyaan terbuka, klarifikasi, refleksi, dan validasi. Teknik-teknik ini membantu perawat dalam menggali informasi secara lebih mendalam dan memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh klien. Teknik ini juga dapat membantu menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi. Komunikasi terapeutik juga bersifat dinamis dan fleksibel (Anjaswarni. T, 2016). Artinya, perawat harus mampu menyesuaikan cara komunikasi dengan kondisi klien, baik dari segi usia, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, maupun kondisi emosional. Misalnya, komunikasi dengan klien anak tentu berbeda dengan klien lansia. Fleksibilitas ini penting agar komunikasi tetap efektif dan dapat diterima dengan baik oleh klien.

Perawat harus mampu memberikan dukungan kepada klien, baik secara verbal maupun nonverbal sebagai bentuk respon suportif saat pelaksanaan komunikasi terapeutik dengan klien. Respon suportif dapat berupa kata-kata yang menenangkan, sikap tubuh yang terbuka, maupun ekspresi wajah yang menunjukkan perhatian. Dukungan ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi klien dalam menghadapi penyakitnya. Komunikasi terapeutik juga berorientasi pada penyembuhan secara holistik. Artinya, komunikasi tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan spiritual klien. Dengan pendekatan holistik, perawat dapat membantu klien secara menyeluruh sehingga proses penyembuhan menjadi lebih optimal.

Secara keseluruhan, karakteristik komunikasi terapeutik dalam keperawatan mencerminkan suatu proses komunikasi yang terencana, profesional, empatik, dan berorientasi pada kebutuhan klien. Dengan memahami dan menerapkan karakteristik-karakteristik tersebut, perawat dapat membangun hubungan yang efektif dengan klien, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung tercapainya tujuan asuhan keperawatan secara optimal.

Menurut Carl Rogers (dalam Abdul Nasir, 2009 : 144), terdapat tiga hal mendasar dari karakteristik komunikasi terapeutik, yaitu keikhlasan, empati, dan kehangatan. Berikut penjelasannya :

a. Keikhlasan

Perawat diharapkan untuk bersikap baik dan ikhlas dalam menjalin hubungan komunikasi terapeutik dengan klien sehingga perawat dapat

menunjukkan atau mengeluarkan segala perasaan yang dimiliki secara tepat, dan dapat menyikapi perilaku klien tanpa menyalahkan atau menghakiminya. Dengan demikian, hubungan saling menguntungkan dapat meningkat secara bermakna.

b. Empati

Dalam proses keperawatan yang dilaksanakan, perawat akan menghadapi berbagai situasi yang dapat mempengaruhi emosinya. Untuk itu diharapkan perawat mampu mengendalikan perasaannya dengan baik dan dapat menunjukkan sikap empati. Empati merupakan perasaan yang obyektif, jujur dan sensitif terhadap situasi dan kondisi klien. Sikap empati membuat perawat mampu berpartisipasi terhadap situasi yang terkait dengan emosi klien.

c. Kehangatan

Untuk menumbuhkan rasa percaya klien terhadap perawat dibutuhkan kemampuan perawat untuk menunjukkan rasa penerimaan perawat terhadap klien. Suasana yang hangat dalam komunikasi antara perawat dengan klien akan menunjukkan rasa penerimaan perawat terhadap klien. Rasa penerimaan tersebut menjadikan klien membuka diri dan perasaannya secara mendalam, sehingga perawat dapat lebih mudah mengkaji kebutuhan klien. Kehangatan juga dapat ditunjukkan melalui komunikasi nonverbal. Penampilan yang tenang, suara yang meyakinkan klien, dan sentuhan terapeutik yang lembut menunjukkan empati dan rasa kasih sayang terhadap klien.

4. Model Komunikasi Keperawatan Menurut Hildegard Peplau

Model konsep komunikasi keperawatan Hildegard Elizabeth Peplau menekankan hubungan interpersonal terapeutik antara perawat dan klien untuk penyembuhan. Teori ini menekankan empat tahapan yakni orientasi, identifikasi, eksploitasi, dan resolusi, di mana perawat berperan sebagai pemberi informasi, konselor, dan fasilitator. Tujuan akhirnya adalah mendorong perubahan perilaku dan kemandirian klien dalam menghadapi masalah.

Berikut ini merupakan penjelasan mendetail mengenai model konsep Hildegard Peplau (Yayu Anggriani, 2019) :

- a. Fase orientasi : Klien mencari bantuan, dan perawat membantu klien mengenali serta memahami masalahnya.
- b. Fase Identifikasi : Klien merespons bantuan perawat dan mulai terhubung, sementara perawat memfasilitasi motivasi untuk mengatasi masalah.
- c. Fase Eksploitasi/Eksplorasi : Klien menggunakan layanan keperawatan dan saran yang diberikan untuk mengatasi masalah sepenuhnya.

d. Fase Resolusi (Terminasi) : Kebutuhan klien terpenuhi, hubungan terapeutik berakhir, dan klien kembali mandiri.

Menurut Alligood & Toomey (2010)[4], Teori Peplau digunakan untuk membangun proses komunikasi terapeutik dengan tujuan yang sederhana. Dalam teorinya Peplau berpendapat bahwa kurang atau tidak tepatnya teknik dalam berkomunikasi antara perawat dan klien dapat menyebabkan banyak masalah dalam proses keperawatan klien. Peplau mengacu pada pentingnya terapi komunikasi dan peran penting dalam mengurangi kecemasan melalui kerangka kerja komunikasi perawat-klien. Dengan demikian perawat akan mampu merespon kebutuhan klien melalui membangun komunikasi terapeutik yang baik dengan klien (Arnold E, Boggs K, 2011)[3].

B. Komunikasi Terapeutik Sesuai Fase Hubungan Perawat – Klien

1. Hubungan Perawat – Klien

Hubungan terapeutik yang terbina antara perawat dan klien sangat penting dalam pelayanan keperawatan. Perawat terlibat dalam hubungan yang penuh kasih sayang, suportif, dan profesional dengan klien mereka sebagai bagian dari "seni keperawatan" (American Nurses Association, 2021). Dalam pelayanan keperawatan, hubungan terapeutik dianggap sebagai dasar perawatan dan penyembuhan klien (Ross & Goldner, 2009). Hubungan antara perawat-klien dibangun untuk membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan tujuan tertentu; hubungan ini memfasilitasi klien dalam komunikasi terapeutik dan melibatkan klien dalam pengambilan keputusan mengenai rencana perawatan. Hubungan terapeutik antara perawat dan klien bervariasi pada kedalaman, lamanya waktu pertemuan, dan fokus masalah, serta dipengaruhi oleh lingkungan perawatan. Pertemuan terapeutik singkat mungkin hanya berlangsung beberapa menit dan berfokus pada kebutuhan mendesak klien, keselamatan, perasaan saat ini, atau perilaku.

Teori Hildegard Peplau tentang hubungan interpersonal sangat membantu perawat untuk memahami pentingnya komunikasi terapeutik dengan klien. Hubungan perawat – klien ini bersifat profesional dimana perasaan, emosi dan perilaku perawat dan klien dipertimbangkan (Deane & Fain, 2016 : 38). Teori ini bermanfaat bagi mahasiswa keperawatan karena mereka belajar bagaimana berkomunikasi secara efektif dengan klien.

2. Komunikasi Terapeutik dalam Hubungan Perawat – Klien

Komunikasi terapeutik adalah proses interaksi terencana antara perawat dan klien untuk penyembuhan yang terbagi atas empat fase, yaitu : fase Pra-interaksi

(persiapan diri), fase Orientasi (bina rasa percaya/kontrak), fase Kerja (penyelesaian masalah), dan fase Terminasi (evaluasi/penutup). Pendekatan ini wajib dilakukan dengan empati, kehangatan, dan keterbukaan guna mencapai tujuan asuhan keperawatan.

Berikut adalah rincian komunikasi terapeutik berdasarkan fase hubungan perawat-klien (Uthami Citra Lestari. 2018) :

3. Fase Pra-Interaksi (Persiapan)

Fase ini merupakan fase persiapan bagi perawat sebelum memulai interaksi dan berkomunikasi dengan klien. Pada tahap ini perawat mengeksplorasi perasaan, fantasi dan ketakutan diri sendiri, serta menganalisis kekuatan dan kelemahan profesional diri. Memungkinkan juga bagi perawat untuk meninjau rekam medis klien, mencari informasi atau laporan tentang klien dari perawat atau departemen lain, dan merencanakan penilaian awal yang akan dilakukan pada klien.

- a. **Kegiatan** : Perawat mempelajari data klien, menganalisis kekuatan dan kelemahan diri sendiri, serta merencanakan strategi interaksi.
- b. **Tujuan** : Mengurangi kecemasan diri dan mempersiapkan mental sebelum bertemu klien.
- c. **Contoh** : (contoh pertanyaan perawat pada diri sendiri)
 - 1) Apa yang harus saya tanyakan saat bertemu dengan klien nanti ?
 - 2) Bagaimana saya harus berespon selanjutnya ?
 - 3) Bila ada pengalaman yang tidak menyenangkan, bagaimana saya harus bersikap ?
 - 4) Bagaimana tingkat kecemasan saya ?

4. Fase Orientasi / Perkenalan

Fase orientasi adalah fase awal interaksi antara perawat dengan klien yang bertujuan merencanakan apa yang akan dilakukan pada fase selanjutnya. Selama fase singkat ini, klien mungkin akan menyadari bahwa mereka membutuhkan bantuan saat menyesuaikan diri dengan kondisi mereka saat ini. Bersamaan dengan itu, perawat dapat memulai hubungan saling percaya dengan memperkenalkan diri serta menyampaikan tugas dan peran yang diemban saat ini. Hal ini dapat mengindikasikan kesiapan perawat untuk membantu klien. Ketika kepercayaan sudah dibangun, hubungan antara perawat dengan klien mulai berkembang, perawat dapat mulai menggali informasi lebih dalam tentang klien sebagai individu dengan kebutuhan, nilai, kepercayaan, dan prioritas yang unik. Perawat dapat memperjelas keluhan/masalah dan kebutuhan klien dengan mengajukan pertanyaan tentang perasaan klien, merencanakan kontrak atau kesepakatan yang meliputi waktu - tempat - lama pertemuan dan topik, dan juga

mengakhiri hubungan sementara. Saat proses komunikasi berlangsung, perawat harus memastikan lingkungan yang nyaman dan memperhatikan privasi klien, menghormati nilai, dan batasan pribadi klien.

- a. **Kegiatan** : Memberi salam, memperkenalkan diri, menyepakati kontrak (waktu, tempat, topik), dan merumuskan tujuan.
- b. **Tujuan** : Membina hubungan saling percaya (*rapport*), memecah kekakuan, dan mengidentifikasi masalah utama.
- c. **Contoh** : "Selamat pagi bu, saya perawat Andini. Saya yang bertugas jam 7-2 siang nanti. Ibu, bisa tolong sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Apa yang dirasakan saat ini?".

5. Fase Kerja

Fase ini menyangkut kualitas hubungan perawat-klien dalam asuhan keperawatan. Pada fase ini perawat tidak hanya mencapai tujuan yang diinginkan bersama tetapi mencapai tujuan untuk memandirikan klien. Pada fase ini perawat menggunakan teknik-teknik komunikasi dalam berkomunikasi dengan klien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (sesuai kontrak). Fase ini merupakan inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik yang dilaksanakan, dan tugas utama perawat pada tahap ini adalah mengeksplorasi stressor yang sesuai, mendorong perkembangan insight klien, mendorong penggunaan mekanisme koping yang konstruktif pada klien, dan menangani tingkah laku resisten klien.

Fase kerja ini merupakan fase terpanjang yang dijalani perawat dan klien selama proses komunikasi terapeutik. Selama fase ini, perawat menggunakan teknik mendengarkan aktif dan memulai dengan menanyakan alasan klien mencari perawatan untuk menentukan apa yang penting bagi mereka. Perawat menggunakan teknik komunikasi terapeutik untuk memfasilitasi kesadaran klien dan mendorong klien untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka. Perawat juga menggunakan waktu ini untuk mengembangkan tujuan dan rencana perawatan individual. Perawat memberikan umpan balik yang reflektif dan tidak menghakimi kepada klien untuk membantu klien mengklarifikasi pikiran, tujuan, dan strategi mengatasi masalah mereka. Jika rencana perawatan telah ditetapkan saat penerimaan, perawat menggunakan waktu ini untuk menerapkan intervensi yang ditargetkan untuk memenuhi tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Selama fase kerja, klien mulai menerima perawat sebagai pendidik kesehatan, konselor, dan penyedia perawatan. Selama fase ini, perawat juga bertindak sebagai sumber informasi yang membantu klien mengumpulkan lebih banyak informasi tentang penyakit mereka (Deane & Fain, 2016).

- a. **Kegiatan** : Pelaksanaan intervensi, memberikan edukasi, dan membantu klien mengekspresikan perasaan.

b. **Tujuan** : Menyelesaikan masalah kesehatan klien melalui tindakan keperawatan yang terencana.

c. **Contoh** : "Baik Bapak, kita akan latihan napas dalam untuk mengurangi rasa nyeri ya. Ikuti panduan saya...".

6. Fase Terminasi

Fase ini merupakan tahap akhir dari proses komunikasi terapeutik perawat dengan klien. Pada fase ini perawat memberikan kesempatan pada klien untuk mengungkapkan keberhasilan dirinya dalam mencapai tujuan terapi dan ungkapan perasaannya. Selanjutnya perawat merencanakan tindak lanjut pertemuan dan membuat kontrak pertemuan selanjutnya bersama klien. Ada tiga kegiatan utama yang harus dilakukan perawat pada fase terminasi ini yaitu melakukan evaluasi subjektif dan objektif, merencanakan tindak lanjut interaksi, dan membuat kontrak dengan klien untuk melakukan pertemuan selanjutnya.

Tahapan komunikasi pada fase terminasi :

Evaluasi subjektif dan objektif - rencana tindak lanjut - membuat kontrak yang akan datang

a. **Kegiatan** : Evaluasi subjektif (perasaan klien) dan objektif (hasil tindakan), tindak lanjut, dan kontrak waktu pertemuan berikutnya.

b. **Tujuan** : Mengevaluasi pencapaian tujuan dan mengakhiri hubungan terapeutik dengan baik.

c. **Contoh** : "Bagaimana perasaannya setelah latihan tadi? Besok kita akan bertemu lagi jam 10 untuk memantau nyerinya ya".

Komponen Esensial pada setiap fase dalam proses komunikasi terapeutik antara perawat dengan klien adalah menjaga kerahasiaan, mendengarkan aktif, dan menunjukkan sikap menghargai.

C. Empati, Batas Profesional, Dan Respons Terhadap Hambatan Komunikasi

1. Empati

Menurut Potter & Perry (2017), dalam melaksanakan komunikasi terapeutik perawat harus dapat menunjukkan sikap empati, dengan cara memahami perasaan pasien, mendengarkan aktif, dan memberikan respon yang tepat. Selain itu, Varcarolis (2018) menekankan pentingnya penggunaan teknik komunikasi yang terstruktur, seperti pertanyaan terbuka, refleksi, dan klarifikasi, agar pesan dapat dipahami dengan baik. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan kondisi dan perasaan/emosi klien berdasarkan sudut pandang mereka. Dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik, empati memiliki peran penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan saling pengertian

antara perawat dan klien. Saat klien merasa dipahami oleh perawat, maka kepercayaannya terhadap perawat akan meningkat, sehingga komunikasi terapeutik yang dibina dapat berjalan lebih efektif.

Dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik, sikap empati perawat dapat membantu penyelesaian masalah klien secara lebih efektif. Oleh sebab itu, perawat perlu berlatih dalam menunjukkan sikap empati kepada klien agar komunikasi terapeutik dengan klien lebih efektif, hubungan interpersonal menjadi lebih kuat, dan konflik dapat diminimalkan. Beberapa cara meningkatkan empati dalam komunikasi adalah dengan berlatih mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan klarifikasi, dan menghindari asumsi negatif terhadap lawan bicara (Goleman.D., 2006).

Banyak mahasiswa yang sering keliru membedakan antara empati dan simpati. Dalam pelaksanaan asuhan keperawatan, sikap simpati justru dapat menghambat obyektivitas perawat dalam melihat masalah klien, sementara sikap empati dapat memperkuat hubungan terapeutik antara perawat dan klien. Berikut ini adalah perbedaan sikap simpati dan empati pada beberapa dimensi komunikasi terapeutik (Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A., 2020) :

Dimensi	Simpati	Empati
Fokus	Berfokus pada perasaan sendiri (subyektif) terhadap masalah klien. Merasa kasihan pada klien	Berfokus pada masalah klien, mencoba memahami perspektif dan perasaan klien
Keterlibatan	Melibatkan perasaan/emosi pribadi (subyektif) yang lebih sehingga seringkali mengaburkan batasan profesional	Melibatkan pemahaman obyektif. Menjaga jarak/batasan profesional, namun tetap peduli dan perhatian pada klien
Dampak	Dapat menghambat kemandirian dan obyektivitas klien karena perawat terlalu emosional. Perawat pun dapat kehilangan obyektivitas.	Dapat membangun kepercayaan klien (<i>trust</i>), karena perawat dapat memberikan solusi yang baik yang mendukung proses penyembuhan secara psikologis.

Sikap simpati terhadap klien dapat menyebabkan *burnout* pada perawat karena tanpa disadari perawat masih membawa beban emosional dari masalah klien. Sedangkan sikap empati justru dapat melindungi profesionalitas kerja perawat melalui batasan yang jelas (Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A., 2020).

2. Batasan Profesional

Hubungan perawat-klien dalam proses komunikasi pada asuhan keperawatan sewaktu-waktu dapat saja berubah dari profesional dan terapeutik menjadi tidak profesional dan personal. Untuk membantu melindungi hubungan terapeutik perawat-klien, perawat bertanggung jawab untuk menetapkan dan mempertahankan batasan profesional, terlepas dari tindakan atau permintaan klien. Mempertahankan batasan membantu mencegah ketidakseimbangan kekuasaan yang berdampak negatif pada perawatan klien. Harus ada batasan yang jelas pada perilaku perawat dalam pemenuhan kebutuhan terapeutik klien.

Batasan profesional dalam keperawatan adalah garis pemisah antara hubungan terapeutik (profesional) dan hubungan pribadi antara perawat dan pasien. Ini menjaga objektivitas, privasi, dan keamanan pasien, memastikan perawatan berpusat pada kebutuhan pasien, serta menghindari eksploitasi kerentanan pasien atau keterlibatan emosional berlebihan (Jenna Elizabeth, 2025).

Saat menetapkan dan mempertahankan batasan profesional dalam hubungan terapeutik dengan kliennya, perawat harus mempertimbangkan pengalaman unik klien, termasuk budaya, usia, nilai-nilai, atau pengalaman traumatik yang pernah dialami klien. Hubungan ini berada pada suatu spektrum yang berkisar dari perilaku profesional dan tepat hingga perilaku personal dan tidak tepat. Pelanggaran batasan dapat terjadi karena kurangnya keterlibatan (misalnya, ketidakpedulian, pengabaian, atau penelantaran) atau keterlibatan yang berlebihan (misalnya, menyukai klien, atau menghabiskan waktu dengan klien setelah jam kerja). Terlepas dari niatnya, pelanggaran batasan dapat dianggap sebagai pelanggaran profesional.

Spektrum hubungan perawat – klien (NCSBN, 2018) :

- a. *Under-involvement* : kurangnya keterlibatan/kepedulian perawat yang hanya melakukan tugas fisik sehingga mengabaikan kebutuhan psikis klien.
- b. *Zone of Helpfulness* : zona ideal dimana perawat peduli, bersikap profesional dan efektif dalam mencapai tujuan perawatan yang disepakati bersama klien.
- c. *Over-involvement* : keakraban perawat yang berlebihan terhadap klien hingga membagi rahasia pribadi kepada klien, terlibat asmara atau keuntungan finansial dengan klien.

Berikut ini terdapat beberapa tanda-tanda pelanggaran batas profesional yang harus menjadi perhatian mahasiswa untuk tidak dilakukan, sehingga dapat memperkuat sikap profesional saat melaksanakan pelayanan keperawatan :

- Memikirkan klien secara berlebihan diluar jam kerja
- Memberikan nomor telpon pribadi atau media sosial pribadi kepada klien
- Menerima hadiah atau uang dari klien atau keluarga
- Merasa bahwa hanya "saya" yang mengertiklien tersebut dibandingkan rekan perawat lain.

3. Respon Terhadap Hambatan Komunikasi

Dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan, komunikasi terapeutik tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi namun menjadi salah satu aspek penting dalam upaya untuk membantu klien mengatasi masalah yang dihadapinya, baik secara fisik maupun psikologis. Disamping itu, proses komunikasi terapeutik dalam pelayanan keperawatan juga menjadi media untuk membangun hubungan saling percaya antara perawat dan klien. Menurut Potter & perry (2017) dalam buku *Fundamentals of Nursing*, komunikasi terapeutik merupakan bagian integral dari asuhan keperawatan yang efektif, dan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan secara umum.

Seperti halnya komunikasi sosial lain, pelaksanaan komunikasi terapeutik juga sering kali mengalami hambatan yang dapat mengganggu efektivitas interaksi antara perawat dan klien. Hambatan yang muncul dapat berasal baik dari perawat sendiri, dari klien, dari lingkungan, maupun hambatan dari faktor sosial budaya. Hambatan yang berasal dari perawat dapat berupa kurangnya kemampuan berkomunikasi, misalnya tidak menunjukkan sikap empati, terlalu banyak memberikan nasihat dibandingkan edukasi, atau bahkan bersikap menghakimi klien. Selain itu perawat juga sering menggunakan istilah medis yang kompleks, sehingga klien kesulitan dalam memahami informasi yang disampaikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Potter & Perry (2017) yang menyatakan bahwa kegagalan dalam komunikasi dapat menurunkan kualitas hubungan terapeutik perawat-klien, dan berdampak pada hasil perawatan.

Hambatan komunikasi terapeutik yang berasal dari sisi klien sering kali dipengaruhi oleh kondisi emosional seperti kecemasan, rasa takut atau kemarahan, yang dapat menghambat kemampuan klien dalam menerima atau menyampaikan informasi secara efektif. Disamping itu tingkat pendidikan, pengalaman sebelumnya dan tingkat kepercayaan terhadap petugas kesehatan juga mempengaruhi proses komunikasi yang dibina. Menurut Videbeck (2020) dalam bukunya *Psychiatric Mental Health Nursing*, kondisi psikologis klien sangat

menentukan keberhasilan komunikasi terapeutik karena akan mempengaruhi persepsi dan respon individu terhadap pesan yang diterima.

Faktor lingkungan juga merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan karena dapat menghambat proses komunikasi terapeutik antara perawat dan klien. Lingkungan yang tidak kondusif, bising, kurang privasi, dan tidak nyaman bagi klien dapat mengganggu konsentrasi dan fokus klien dalam berkomunikasi. Disamping itu, kemampuan perawat dalam menghargai perbedaan budaya dan nilai-nilai yang dianut klien merupakan hal yang sangat penting dalam membangun hubungan terapeutik dengan klien.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, penting bagi perawat untuk memahami perlunya memberi respon yang tepat dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik, seperti menunjukkan sikap empati tanpa menghakimi, mendengarkan keluhan klien dengan penuh perhatian, dan menunjukkan sikap terbuka saat berkomunikasi. Respon lain yang juga penting adalah kemampuan mengelola emosi klien, dimana perawat harus bersikap tenang, sabar dan tidak terpancing emosi. Perawat juga harus dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, tenang, dan menjaga privasi klien agar klien merasa aman dan dapat lebih terbuka dalam berkomunikasi.

Kemampuan dalam merespon hambatan komunikasi terapeutik merupakan keterampilan penting dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan. Dengan respon yang tepat, hambatan komunikasi dapat diminimalkan sehingga hubungan perawat dengan klien menjadi lebih efektif. Tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga untuk mendukung keberhasilan proses perawatan dan penyembuhan klien secara menyeluruh.

MINI CASE

Seorang pasien laki-laki, usia 55 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis diabetes melitus. Pasien tampak murung, sering diam, dan kurang kooperatif saat perawat memberikan edukasi mengenai diet dan pengobatan. Ia juga beberapa kali menolak makan dan mengatakan bahwa dirinya sudah "capek hidup dengan penyakit ini".

Seorang perawat kemudian mencoba melakukan komunikasi terapeutik untuk membantu kondisi psikologis pasien tersebut.

Tugas mahasiswa :

1. Buatlah skenario pelaksanaan komunikasi terapeutik antara perawat dan klien dengan memperhatikan prinsip dasar dan karakteristik serta teknik dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik. Skenario disusun sesuai tahapan/fase-fase dalam komunikasi terapeutik.
2. Lakukan simulasi komunikasi terapeutik pada pasien sesuai kasus diatas.
3. Buatlah video simulasi komunikasi terapeutik tersebut.

SOAL OSCE KOMUNIKASI TERAPEUTIK

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Komunikasi Terapeutik pada Pasien Diabetes Melitus
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan komunikasi terapeutik pada pasien diabetes melitus.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Perilaku professional
6	Kategori	1. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang pasien laki-laki, usia 55 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis diabetes melitus. Pasien tampak murung, sering diam, dan kurang kooperatif saat perawat memberikan edukasi mengenai diet dan pengobatan. Ia juga beberapa kali menolak makan dan mengatakan bahwa dirinya sudah "capek hidup dengan penyakit ini". Seorang perawat kemudian mencoba melakukan komunikasi terapeutik untuk membantu kondisi psikologis pasien tersebut. Tugas mahasiswa : - Buat skenario pelaksanaan komunikasi terapeutik antara perawat dan klien dengan memperhatikan prinsip dasar dan karakteristik serta teknik dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik. Skenario disusun sesuai tahapan/fase-fase dalam komunikasi terapeutik. - Lakukan simulasi komunikasi terapeutik pada pasien sesuai kasus diatas. - Buat video simulasi komunikasi terapeutik tersebut.
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang pasien laki-laki, usia 55 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis diabetes melitus. Pasien tampak murung, sering diam, dan kurang kooperatif saat perawat memberikan edukasi mengenai diet dan pengobatan. Ia juga

No.	Komponen	Isi
		beberapa kali menolak makan dan mengatakan bahwa dirinya sudah "capek hidup dengan penyakit ini". Seorang perawat kemudian mencoba melakukan komunikasi terapeutik untuk membantu kondisi psikologis pasien tersebut. INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan pengkajian fokus tambahan. 2. Menilai kemampuan peserta dalam melaksanakan komunikasi terapeutik 3. Menilai kemampuan peserta dalam menunjukkan sikap empati. 4. Menilai ketepatan penampilan peserta dalam simulasi. 5. Monitor perilaku profesional peserta. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: laki-laki usia 55 tahun. 2. Riwayat penyakit sekarang: dirawat karena diabetes melitus. 3. Riwayat kebiasaan sosial : Pasien tampak murung, sering diam, dan kurang kooperatif. 4. Harapan terhadap penyakit : pasien hopeless dan mengatakan bahwa dirinya sudah "capek hidup dengan penyakit ini". 5. Menolak makan
10	Setting station	Ruang Rawat Penyakit Dalam - Tempat tidur pasien - KS berperan sebagai pasien - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat

No.	Komponen	Isi
		7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Handrub/hand sanitizer 2. Tisu Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Ria Tri Harini Dwi Rusiawati, S.ST., M.Pd
13	Referensi	

Rubrik Penilaian Kinerja Komunikasi Terapeutik

Kompetensi	Skor 0	Skor 1	Skor 2	Bobot	Skor maks
Kelengkapan fase komunikasi	Mahasiswa hanya melakukan fase kerja tanpa pembukaan dan penutupan yang jelas	Mahasiswa melewati salah satu fase atau urutan fase terbalik, namun tujuan komunikasi utama masih tersampaikan	Mahasiswa melakukan 4 fase (Pra-interaksi, Orientasi, Kerja dan Terminasi) secara berurutan, sistematis, dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti pasien.	3	6
Ketepatan teknik komunikasi	Mahasiswa dominan menggunakan pertanyaan tertutup	Mahasiswa menggunakan campuran	Mahasiswa konsisten menggunakan	3	6

	(Ya/Tidak), menceramahi pasien, atau memberikan janji palsu (false reassurance).	pertanyaan terbuka dan tertutup secara kaku, atau terkadang memotong pembicaraan pasien.	n pertanyaan terbuka, melakukan refleksi perasaan, dan memberikan respons verbal yang sinkron dengan keluhan pasien.		
Kedalaman empati (respon afektif)	Tidak ada kontak mata, posisi tubuh membelakangi pasien, atau mengabaikan ekspresi kesedihan/kemaraha n pasien.	Menunjukkan kontak mata namun posisi tubuh tampak kaku/tidak rileks. Validasi emosi dilakukan secara mekanis/tanp a penjiwaan.	Menunjukkan kontak mata yang hangat, posisi tubuh condong ke depan (S-O- L-E-R), dan secara lisan memvalidasi emosi pasien (misal: "Saya paham Bapak merasa berat...").	2	4
Batas Profesional (<i>Professiona l Boundaries</i>)	Menunjukkan sikap acuh tak acuh (<i>under-involvement</i>) atau justru menangis/marah bersama pasien (<i>over-involvement</i>).	Terlihat sedikit kewalahan menghadapi sikap pasien (hampir <i>under- involved</i>) atau terlalu banyak memberikan opini pribadi	Tetap peduli dan sabar meskipun pasien menolak (berada di <i>Zone of Helpfulness</i>). Tidak membagi masalah pribadi atau	2	4

		yang tidak relevan.	terlibat emosi berlebih.		
--	--	---------------------	--------------------------	--	--

Global Performance

Berikan tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai penilaian penguji secara umum terhadap kemampuan peserta ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Nilai yang diperoleh :

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Total skor yang diraih}}{\text{Total skor maksimal}} \times 100$$

Form Checklist Penilaian Kinerja Komunikasi Terapeutik

Nama Mahasiswa : _____

N I M : _____

No.	Aspek/Indikator Penilaian	Skor (0-2)	Bobot per Sub Indikator	Nilai (S x B)
1	Kelengkapan Fase Komunikasi		3%	
	a. Fase Pra-Interaksi (Persiapan diri dan rencana interaksi)			
	b. Fase Orientasi (Salam, evaluasi/validasi, kontrak waktu & topik).			
	c. Fase Kerja (Penyampaian pesan inti sesuai tujuan).			
	d. Fase Terminasi (Evaluasi subjektif/objektif, rencana tindak lanjut).			
2	Ketepatan Teknik Komunikasi		3%	
	a. Menggunakan pertanyaan terbuka (<i>open-ended questions</i>).			

	b. Melakukan teknik mendengarkan aktif (<i>active listening</i>).			
	c. Memberikan respon verbal yang relevan (tidak memotong pembicaraan).			
3	Kedalaman Empati (Respon Afektif)		2%	
	a. Menunjukkan sikap <i>Attending</i> (Kontak mata, posisi tubuh terbuka).			
	b. Melakukan validasi perasaan pasien (Contoh: "Saya mengerti ini sulit bagi Bapak").			
4	Pemeliharaan Batas Profesional (<i>Professional Boundaries</i>)		2%	
	a. Menghindari <i>Over-involvement</i> (Keakraban yang berlebihan).			
	b. Menghindari <i>Under-involvement</i> (Tetap peduli meskipun pasien menolak).			
	Total Skor Kinerja Komunikasi		10%	

Keterangan :

- **Skor 2 (Dilakukan dengan Sempurna):** Mahasiswa menunjukkan perilaku secara konsisten, alami, dan sesuai konteks pasien.
- **Skor 1 (Dilakukan dengan Kurang Sempurna):** Mahasiswa melakukan namun tampak kaku, ada bagian kecil yang terlewat, atau kurang sinkron antara verbal dan non-verbal.
- **Skor 0 (Tidak Dilakukan/Salah):** Mahasiswa melewatkan indikator tersebut atau melakukan kesalahan komunikasi (misal: menghakimi pasien)

D. Ringkasan

Keterampilan berkomunikasi merupakan salah satu kompetensi penting (*critical skill*) yang harus dimiliki oleh perawat, karena komunikasi merupakan proses dinamis yang digunakan untuk mengumpulkan data pengkajian, memberikan intervensi berupa pendidikan kesehatan kepada klien dan mempengaruhi klien untuk menerapkannya dalam hidup, menunjukkan kepedulian (*caring*), menumbuhkan rasa percaya diri dan menghargai nilai-nilai klien. Hendaknya proses komunikasi yang dibangun didasarkan pada hubungan saling percaya antara perawat dengan klien dan keluarga.

Bab ini menekankan pada mahasiswa mengenai pentingnya memiliki keterampilan berkomunikasi terapeutik sebagai salah satu kompetensi penting dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Melalui komunikasi terapeutik dapat terjalin hubungan yang efektif antara perawat-klien sebagai upaya untuk mendorong proses penyembuhan klien, baik secara fisik maupun psikologis.

Pelaksanaan komunikasi terapeutik dilaksanakan secara bertahap melalui fase-fase dalam komunikasi terapeutik yang meliputi fase pra-interaksi, fase orientasi, fase kerja dan fase terminasi. Prinsip dasar dari komunikasi terapeutik adalah pendekatan profesional perawat yang berfokus pada klien untuk membangun rasa percaya, empati, dan saling menghormati. Hal ini dimaksudkan guna meningkatkan kesejahteraan psikologis dan fisik klien.

Karakteristik komunikasi terapeutik dalam keperawatan mencerminkan suatu proses komunikasi yang terencana, profesional, empatik, dan berorientasi pada kebutuhan klien. Dengan memahami dan menerapkan karakteristik-karakteristik tersebut, perawat dapat membangun hubungan yang efektif dengan klien, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung tercapainya tujuan asuhan keperawatan secara optimal.

Untuk melindungi hubungan terapeutik perawat-klien, perawat bertanggung jawab untuk menetapkan dan mempertahankan batasan profesional. Pelanggaran batasan dapat terjadi karena kurangnya keterlibatan atau keterlibatan yang berlebihan. Intinya pelanggaran batasan dapat dianggap sebagai pelanggaran profesional.

Dengan demikian, inti dari bab ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pentingnya komunikasi terapeutik dalam membantu mendorong proses penyembuhan klien dan meningkatkan kualitas pelayanan. Mahasiswa tidak hanya dituntut memiliki keterampilan teknis keperawatan tetapi juga diharapkan mahasiswa aktif melatih kemampuan berkomunikasi.

Red Flag Komunikasi Terapeutik dan Hubungan Perawat-Klien

Tabel 5. 1 Red Flags dan Eskalasi Komunikasi Terapeutik dan Hubungan Perawat-Klien

Red Flags (Tanda Bahaya)	Makna (Analisis) Klinis	Dampak terhadap Pasien	Tindakan Eskalasi (Intervensi)
Perawat membuka diri secara berlebihan	Fokus beralih dari kebutuhan pasien ke beban perawat.	Pasien merasa terbebani secara emosional dan ragu untuk menyampaikan keluhannya sendiri.	Segera berhenti; kembalikan fokus pada pasien. Lakukan <i>debriefing</i> .
Keterikatan Emosional	Hilangnya objektivitas klinis (<i>Countertransference</i>)	Pasien menjadi sangat bergantung pada satu perawat dan menolak dirawat oleh staf lain (Regresi).	Rotasi penugasan; alihkan asuhan ke perawat lain untuk menjaga objektivitas.
Komunikasi Rahasia (Pribadi)	Pelanggaran batas profesional yang sangat serius.	Pasien kehilangan perlindungan dari tim medis kolektif; risiko eksploitasi meningkat.	Teguran resmi; edukasi ulang mengenai kode etik dan batas profesional.
Pemberian/Penerimaan Hadiah	Hubungan berubah menjadi sosial-transaksional.	Pasien merasa "harus membayar" untuk mendapat perhatian;	Tolak secara halus; laporkan ke komite etik atau ikuti prosedur RS.

		kualitas asuhan menjadi bias.	
Perilaku Seksual / Menggoda	Pelanggaran hukum dan eksploitasi posisi rentan.	Trauma psikologis berat; rusaknya kepercayaan pasien terhadap profesi kesehatan.	Eskalasi ke Hukum/Etik; pemberhentian tugas untuk investigasi.
Defensif terhadap Rekan Sejawat	Perawat merasa "memiliki" pasien secara eksklusif.	Rencana asuhan menjadi tidak terkoordinasi (fragmentasi asuhan) yang membahayakan keselamatan.	Supervisi klinis ketat; observasi langsung oleh <i>Clinical Instructor</i> .

LEMBAR EVALUASI DIRI (REFLEKSI PASCA-SIMULASI)

Bab 5 : Komunikasi Terapeutik dan Hubungan Perawat - Klien

Topik Skenario: Intervensi pada Pasien DM dengan Keputusan

Nama Mahasiswa : _____

Tanggal Praktikum : _____

I. Analisis Performa (Centang yang sesuai)

Silakan nilai diri Anda secara jujur berdasarkan pengalaman simulasi tadi:

Aspek Refleksi **Sangat Yakin** **Cukup Yakin** **Perlu Perbaikan**

Saya mampu mengelola kecemasan diri sebelum menghadapi pasien.

Saya berhasil melakukan fase orientasi (salam & kontrak) dengan jelas.

Saya merasa telah memberikan ruang bagi pasien untuk bercerita.

Saya tetap tenang saat pasien menyatakan "capek hidup".

Saya mampu mengakhiri pertemuan tanpa membuat pasien merasa diabaikan.

Refleksi singkat mahasiswa :

.....

.....

.....

GLOSARIUM

Komunikasi terapeutik = bentuk komunikasi yang digunakan oleh tenaga kesehatan, seperti perawat atau dokter, untuk membangun hubungan yang efektif dan mendukung proses penyembuhan atau pemulihan pasien

Empati = kemampuan perawat untuk merasakan dan memahami apa yang dirasakan oleh klien tanpa kehilangan objektivitas profesional

Burnout = kondisi stres kerja kronis yang tidak terkelola, mengakibatkan kelelahan fisik dan mental ekstrem, sikap sinis atau sinisme terhadap pekerjaan, serta penurunan efektivitas kerja.

Humanity of Nursing and Clients (Kemanusiaan dalam Keperawatan dan Klien) = adalah prinsip dasar dalam komunikasi terapeutik yang menekankan bahwa hubungan antara perawat dan pasien bukan sekadar hubungan penolong dan penerima bantuan profesional, melainkan hubungan antarmanusia yang bermartabat.

Batasan Profesional = adalah garis pemisah antara hubungan terapeutik (profesional) dan hubungan pribadi antara perawat dan pasien.

Critical skill = kompetensi kritis/penting yang harus dimiliki perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatannya

Under-involvement = kurangnya keterlibatan/kepedulian perawat yang hanya melakukan tugas fisik sehingga mengabaikan kebutuhan psikis klien.

Zone of Helpfulness = zona ideal dimana perawat peduli, bersikap profesional dan efektif dalam mencapai tujuan perawatan yang disepakati bersama klien.

Over-involvement = keakraban perawat yang berlebihan terhadap klien hingga membagi rahasia pribadi kepada klien, terlibat asmara atau keuntungan finansial dengan klien.

Referensi

- Abdul Nasir, et al, 2009, Komunikasi dalam keperawatan teori dan aplikasi, Jakarta: Salemba Medika
- Alligood & Toomey, M., Nursing Theory: Utilization and Application, Mosby Elsevier United States of America, 2010
- American Nurses Association. (2021). *Nursing: Scope and standards of practice* (4th ed.). Silver Spring, MD: [American Nurses Association](https://nurses.org).
- Anjaswarni,T. (2016). Komunikasi dalam Keperawatan: Modul Bahan Ajar Keperawatan. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, Kementrian Kesehatan RI
- Arnold E, Boggs K. Interpersonal relationships professional communication skills for nurses. USA: Elsevier-Saunders, 2011.
- Brunero, S., Jeon, Y.-H., & Foster, K. (2021). Mental health nurses' self-awareness and reflective practice: A critical review of literature. *Archives of Psychiatric Nursing*, 35(4), 318–325. <https://doi.org/10.1016/j.apnu.2021.04.010> College of Nurses of Ontario (CNO), 2025, Professional Boundaries and Nurse-Client Relationships – Practice Standard, Ordre Des Infirmieres Et Infirmieres De L’Ontario – OIIO, ISBN 978-1-77116-224-1
- de Jong, E., Pratitis, N. T., & Arifiana, I. Y. (2025). Hubungan Antara Work Life Balance Dengan Burnout Pada Perawat. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 4(2)
- Deane, W. H., & Fain, J. A. (2016). Incorporating Peplau's theory of interpersonal relations to promote holistic communication between older adults and nursing students. *Journal of Holistic Nursing*, 34(1), 35–41. doi.org
- Emhy. (2025). Teori Peplau: Hubungan Terapeutik dalam Keperawatan. [https://www.scribd.com/document/871059927/Model-Teori-Peplau#:~:text=](https://www.scribd.com/document/871059927/Model-Teori-Peplau#:~:text=Diunduh pada 12 Maret 2026) Diunduh pada 12 Maret 2026
- Goleman, D. (2006). *Social Intelligence: The New Science of Human Relationships*. Bantam Books.
- Jenna Elizabeth. (2025). *Boundaries in nursing: A path to professional wellness*. Nursa <https://nursa.com/blog/professional-boundaries-in-nursing#>
- NCSBN. (2018). *A Nurse’s Guide to Professional Boundaries*. Chicago: NCSBN.

- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2020). *Fundamentals of Nursing*. Elsevier.
- Ross, C. A., & Goldner, E. M. (2009). Stigma, negative attitudes and discrimination towards mental illness within the nursing profession: a review of the literature. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*, 16(6), 558-567. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2009.01399.x>
- Sri Hastuti. 2017. Prinsip Komunikasi Terapeutik Perawat. <https://www.scribd.com/document/336647323/Prinsip-Dasar-Komunikasi-Terapeutik> Diunduh pada 12 Maret 2026
- Uthami Citra Lestari. 2018. Tahapan Komunikasi Terapeutik. <https://www.scribd.com/document/392680736/Tahapan-Komunikasi-Terapeutik#:~:text>
- Videbeck, S. L. (2020). *Psychiatric-Mental Health Nursing* (8th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer.
- Viliansyah. 2014. Konsep Komunikasi Terapeutik Keperawatan. <https://www.scribd.com/doc/225534967/Konsep-komunikasi-terapeutik>
- Yayu Anggriani, 2019, Teori Keperawatan Peplau dan Fase Interpersonal <https://www.scribd.com/document/439644813/BAB-2-PEPLAU-1-docx>

BAB 6

ETIKA, HUKUM DAN KESELAMATAN PASIEN DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar keperawatan, profesionalisme, etika–legal, dan keselamatan pasien sebagai landasan praktik.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6
CPL-2	Mampu menerapkan proses keperawatan secara sistematis (pengkajian–diagnosis–perencanaan–implementasi–evaluasi) berbasis kebutuhan dasar manusia.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-7
CPL-3	Mampu melakukan pengkajian dasar (tanda vital, nyeri, pemeriksaan fisik) serta dokumentasi yang akurat dan dapat diaudit.	CPMK-3; CPMK-7
CPL-4	Mampu melaksanakan keterampilan keperawatan dasar (oksigenasi, nutrisi, eliminasi, mobilisasi, integumen, pemberian obat) secara aman dan sesuai standar.	CPMK-4; CPMK-6
CPL-5	Mampu berkomunikasi terapeutik, memberikan edukasi kesehatan, dan melakukan discharge planning dasar yang berpusat pada pasien–keluarga.	CPMK-5; CPMK-7
CPL-6	Mampu berpikir kritis dan clinical reasoning untuk pengambilan keputusan, pencegahan risiko, serta perbaikan mutu praktik keperawatan dasar.	CPMK-2; CPMK-6; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan pengantar keperawatan dasar, profesionalisme perawat, peran, nilai, dan standar perilaku dalam pelayanan.
CPMK-2	Menjelaskan konsep sehat–sakit, homeostasis, kebutuhan dasar manusia, serta menerapkan berpikir kritis/clinical reasoning dalam pengambilan keputusan keperawatan.
CPMK-3	Melakukan proses keperawatan (pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, evaluasi) dan mendokumentasikan secara sistematis.
CPMK-4	Melaksanakan keterampilan keperawatan dasar untuk pemenuhan kebutuhan dasar (oksigenasi, nutrisi, cairan, eliminasi, istirahat–tidur, mobilisasi, integumen) sesuai standar.
CPMK-5	Menerapkan komunikasi terapeutik dan hubungan perawat–klien secara profesional untuk mendukung asuhan dan edukasi.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Menerapkan etik–hukum, patient safety, PPI, pencegahan jatuh, dan keselamatan medikasi dalam praktik keperawatan dasar.
CPMK-7	Melaksanakan edukasi kesehatan, discharge planning, dan handover SBAR, serta mengevaluasi luaran asuhan dan menyusun perbaikan rencana berbasis data.

H. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 6. Etik, Hukum, dan Keselamatan Pasien dalam Praktik Keperawatan	6.1 Mengidentifikasi isu etik–legal dan hak pasien pada pelayanan dasar.	6.2 Menerapkan prinsip patient safety (identifikasi pasien, pencegahan insiden) pada skenario.	CPMK-6	CPMK-1; CPMK-7

I. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (CBT/essay terstruktur)	Persentase jawaban benar konsep profesionalisme dan akurasi respons pada skenario perilaku profesional.	10	Nilai ujian; lembar jawaban
CPMK-6	OSCE keselamatan (PPI, jatuh, 6 benar medikasi) + checklist	Persentase kepatuhan prosedur keselamatan dan ketiadaan kesalahan kritis.	15	Checklist keselamatan; log error (jika ada)
CPMK-7	Portofolio edukasi–discharge plan–SBAR	Kelengkapan edukasi (teach-back), kualitas discharge plan, dan kelengkapan SBAR (skor rubrik/checklist).	15	Materi edukasi; discharge plan; SBAR

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep profesionalisme (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.2 Akurasi respons pada skenario perilaku profesional	Respons keliru/berisiko	Respons cukup; alasan lemah	Respons tepat; alasan logis	Respons sangat tepat; alasan kuat & konsisten standar

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan problem list & prioritas	Prioritas tidak sesuai; banyak masalah kunci terlewat	Prioritas cukup; masih ada ketidaktepatan bermakna	Prioritas tepat; masalah kunci tercakup	Prioritas sangat tepat; masalah kunci lengkap & terurut
2.2 Konsistensi alasan berbasis risiko/bukti dasar	Tanpa alasan; tidak berbasis risiko	Alasan umum; risiko belum jelas	Alasan logis; risiko jelas	Alasan sangat kuat; mengaitkan risiko, bukti dasar, dan keselamatan

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Ketepatan diagnosis/prioritas	Tidak sesuai data; prioritas keliru	Sebagian sesuai; prioritas kurang konsisten	Sesuai data; prioritas jelas	Sangat sesuai; prioritas sangat logis & tervalidasi
3.2 Kualitas tujuan SMART & evaluasi terukur	Tujuan tidak SMART; evaluasi tidak jelas	Sebagian SMART; evaluasi terbatas	SMART; evaluasi jelas	SMART sangat kuat; evaluasi komprehensif dan operasional

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan langkah keterampilan dasar (checklist)	≤60% langkah benar; ada kesalahan kritis	61–75% benar; kekurangan bermakna	76–90% benar; kesalahan minor	>90% benar; aman tanpa kesalahan bermakna
4.2 Ketepatan evaluasi respons pasien	Tidak mengevaluasi/keliru	Mengevaluasi terbatas; indikator kurang tepat	Evaluasi jelas; indikator tepat	Evaluasi sangat jelas; indikator tepat & tindak lanjut cepat

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kinerja komunikasi terapeutik (checklist)	≤60% perilaku tercapai; hubungan tidak terbina	61–75% tercapai; hubungan terbina sebagian	76–90% tercapai; hubungan efektif	>90% tercapai; empatik, adaptif, profesional
5.2 Batas profesional & respons terhadap hambatan komunikasi	Tidak menjaga batas; respons tidak tepat	Batas sebagian; respons kurang konsisten	Batas jelas; respons tepat	Batas sangat jelas; respons sangat efektif & aman

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Kepatuhan PPI & kewaspadaan standar	Banyak langkah terlewat; risiko tinggi	Langkah inti ada; kurang konsisten	Langkah tepat; konsisten	Langkah sangat tepat; konsisten tanpa pelanggaran
6.2 Kepatuhan keselamatan jatuh & 6 benar medikasi	Sering melanggar; ada kesalahan kritis	Cukup patuh; masih ada kekurangan	Patuh; tanpa kesalahan kritis	Sangat patuh; antisipatif risiko dan terdokumentasi

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan edukasi–discharge plan (teach-back)	Tidak terstruktur; pemahaman tidak terbukti	Terstruktur sebagian; bukti pemahaman terbatas	Terstruktur; bukti pemahaman memadai	Sangat terstruktur; bukti pemahaman kuat & terdokumentasi
7.2 Kelengkapan SBAR & dokumentasi terintegrasi	Informasi kritis hilang; tidak dapat diaudit	Informasi inti ada; masih kurang spesifik	Lengkap; runtut; dapat ditindaklanjuti	Sangat lengkap; ringkas; risiko terantisipasi; sangat dapat diaudit

A. Pengertian Etika Keperawatan

Etika berasal dari Bahasa Yunani *Ethos*, yaitu suatu kebiasaan adat istiadat. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup dan tata cara hidup yang baik dalam kehidupan seseorang dan masyarakat. Etika keperawatan merupakan seperangkat prinsip moral, nilai, dan norma yang menjadi pedoman bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan secara profesional, manusiawi, dan bertanggung jawab. Etika keperawatan berfungsi untuk mengarahkan perilaku perawat dalam

menghadapi berbagai situasi klinis, termasuk pengambilan keputusan yang melibatkan aspek moral.

Etika keperawatan berhubungan dengan interaksi di masyarakat yang melibatkan sifat dan perilaku perawat terhadap orang lain. Etika keperawatan berfungsi sebagai pedoman untuk menangani berbagai masalah yang muncul dari tindakan praktisi keperawatan terhadap pasien yang tidak memperhatikan tanggung jawab moral dalam pekerjaan mereka. Etika keperawatan mengacu pada prinsip-prinsip etis yang menjadi acuan dan membimbing perawat dalam aktivitas mereka sehari-hari. Sebagai contoh, sebelum seorang perawat menjalani proses perawatan terhadap pasien, ia harus terlebih dahulu menyampaikan tujuan dari tindakan yang hendak dilakukannya dan sekaligus memastikan apakah pasien bersedia menerima perawatan tersebut. Dalam situasi ini, perawat menunjukkan sikap menghormati hak pasien untuk membuat keputusan. Jika pasien menolak untuk dirawat, perawat tidak diperbolehkan memaksakan tindakan, selama pasien memahami konsekuensi dari penolakannya. Namun, jika seorang perawat memaksakan kehendaknya untuk memberikan perawatan tanpa mengkomunikasikan tujuan tindakan tersebut dan tanpa mendapatkan persetujuan sebelumnya dari pasien, terutama jika pasien tersebut berasal dari daerah terpencil, kurang berpendidikan, kesulitan dalam berargumentasi dengan perawat, dan tidak mampu menolak perlakuan tersebut, pasien jelas akan merasa terpaksa menerima tindakan perawatan tersebut dan tidak memiliki kekuatan untuk menolak (Siregar & sebastianus, 2022).

Aspek etika keperawatan sangat penting bagi perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dengan pelayanan etik yang tepat, perawat bisa memberikan perawatan keperawatan yang terbaik. Karena perawat selalu menghadapi berbagai masalah etika setiap hari, maka penerapan etika keperawatan tidak boleh diabaikan. Agar bisa menjalankan tugas dan perannya dengan baik, perawat perlu memiliki dasar etika yang baik dan memahami aturan-aturan moral yang berlaku dalam bidang keperawatan. Dalam praktik keperawatan, etika tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang benar atau salah, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, martabat pasien, serta hak individu (Nurhidayati et al., 2022).

Etika bertujuan untuk membedakan hal-hal yang benar dan salah, sedangkan moral dimaksudkan kepercayaan dan perilaku yang sebenarnya. Nilai atau value merujuk pada penilaian mengenai apa yang dianggap berharga atau bernilai dalam kehidupan seseorang. Nilai adalah nilai yang diinginkan, menjadi tujuan bagi seseorang, sedangkan etika berkaitan dengan norma yang digunakan untuk menentukan tindakan yang benar atau salah. Etika normatif digunakan untuk menentukan aturan dan menetapkan nilai-nilai perilaku. Etika normatif digunakan

untuk menentukan standar nilai dan moral seseorang. Etika yang baik memandu seseorang dari tindakan seseorang, sedangkan etika deontologis menekankan pada tugas dibandingkan konsekuensi (Butts & Rich, 2020).

B. Prinsip Etika Keperawatan

Seorang perawat dalam menjalankan profesinya wajib memegang teguh prinsip etik sebagai berikut (Feriadi et al., 2020) (Ariga, 2020) (Hidayat & Melani, 2023) :

1. *Autonomy* (Otonomi)

Menghormati hak pasien untuk menentukan keputusan terkait kesehatannya sendiri. Pasien berhak menentukan tindakan-tindakan baru dapat dilakukan atas persetujuan dirinya. Contoh: menghargai keputusan pasien yang menolak tindakan medis.

2. *Beneficence* (Berbuat Baik)

Perawat wajib melakukan tindakan yang memberikan manfaat bagi pasien. Setiap tindakan yang dilakukan oleh perawat harus memiliki manfaat kepada klien maupun keluarga klien. Prinsip ini sangatlah penting dilakukan oleh setiap rumah sakit terutama perawat supaya klien dan keluarga memperoleh informasi, kenyamanan dan memperoleh hak dan kewajibannya secara penuh sebagai pasien

3. *Non-Maleficence* (Tidak Merugikan).

Perawat harus menghindari tindakan yang dapat membahayakan pasien (*do no harm*).

4. *Justice* (Keadilan)

Memberikan pelayanan secara adil tanpa diskriminasi.

5. *Veracity* (Kejujuran)

Perawat harus memberikan informasi yang benar dan jujur kepada pasien. Prinsip ini sangat penting dimiliki dan dilakukan oleh perawat supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara perawat dengan klien dalam pemberian asuhan keperawatan karena kejujuran merupakan dasar dari membangun hubungan saling percaya.

6. *Confidentiality* (Kerahasiaan)

Menjaga privasi dan informasi pasien seperti penerapan kerahasiaan dalam dokumentasi tentang keadaan kesehatan klien hanya bisa dibaca guna keperluan pengobatan, Upaya peningkatan kesehatan klien dan atau permintaan pengadilan.

7. *Fidelity* (Menepati Janji)

Prinsip ini menekankan pada kesetiaan perawat pada komitmennya, menepati janji, menyimpan rahasia, caring terhadap klien dan keluarga.

8. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas Adalah standar yang pasti bahwa tindakan seseorang professional dapat dinilai dalam berbagai kondisi tanpa terkecuali. Contoh perawat bertanggung jawab pada diri sendiri, profesi, klien, sesama teman sejawat, karyawan dan Masyarakat, Jika perawat salah memberi dosis obat kepada klien perawat dapat di gugat oleh klien yang menerima obat, dokter yang memberikan tugas delegative dan Masyarakat yang menuntut kemampuan profesional

Kemampuan membuat keputusan masalah etis merupakan salah satu persyaratan bagi perawat untuk menjalankan praktik keperawatan professional dan dalam membuat keputusan etis perlu memperhatikan beberapa nilai dan kepercayaan pribadi, kode etik keperawatan, konsep moral perawatan dan prinsip-prinsip etis dalam praktik keperawatan. Sebagai contoh aspek moral *fidelity*, perawat berkewajiban untuk melakukan kewajiban dan tugas dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab, sesuai dengan amanah tugas dan profesi keperawatan. Apabila kewajiban tersebut tidak ditunaikan, maka sebenarnya perawat tersebut telah melalaikan sumpah dan kode etik keperawatan. Selanjutnya, dari aspek moral *beneficence* dapat diartikan bahwa perawat harus selalu mempertimbangkan apabila hendak melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, dengan mempertimbangkan baik atau buruknya, benar atau salahnya, dan layak atau tidaknya. Menurut aspek ini pula, perawat tidak diperbolehkan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan pasien (Ose, 2017)

C. Issue Etik Legal

Isu etik adalah masalah yang berkaitan dengan nilai moral, norma, dan prinsip etika dalam praktik keperawatan, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Isu legal adalah masalah yang berkaitan dengan hukum dan peraturan yang mengatur praktik keperawatan, termasuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab perawat. Isu etik–legal merupakan permasalahan yang melibatkan aspek moral dan hukum secara bersamaan dalam praktik keperawatan. Isu etik–legal sering muncul dalam situasi kompleks, seperti penolakan tindakan, keterbatasan sumber daya, serta konflik antara pasien dan keluarga. Oleh karena itu, perawat harus mampu mengenali, menganalisis, dan mengambil keputusan yang tepat (Burkhardt & Nathaniel, 2019). Penelitian (Winarti & Rosiana, 2020) menunjukkan persepsi

terhadap perlindungan hukum mempengaruhi keinginan perawat untuk melakukan CPR pada OCHA. Perawat yang memiliki persepsi perlindungan hukum positif, mayoritas memiliki keinginan positif untuk memberikan CPR pada OCHA. Sebaliknya, perawat yang memiliki persepsi negatif terhadap perlindungan hukum, mayoritas juga memiliki keinginan negatif untuk memberikan CPR

D. Hak Pasien dalam Pelayanan Dasar

Hak pasien merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan yang harus dihormati oleh perawat.

Hak pasien meliputi:

1. Hak mendapatkan informasi yang jelas
2. Hak memberikan persetujuan (informed consent)
3. Hak atas privasi dan kerahasiaan
4. Hak mendapatkan pelayanan yang aman dan bermutu
5. Hak menolak tindakan medis
6. Hak mendapatkan perlakuan yang adil

Hak pasien diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan menjadi bagian dari standar pelayanan

E. Jenis Isu Etik-Legal dalam Pelayanan Dasar

1. Informed Consent

Isu muncul Ketika pasien tidak memahami tindakan , tindakan dilakukan tanpa persetujuan, hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap otonomi pasien

2. Kerahasiaan Pasien

Isu muncul jika Informasi pasien dibocorkan, data pasien tidak dijaga, dimana hal ini menunjukkan adanya pelanggaran prinsip etik dan hukum

3. Penolakan Tindakan

Pasien berhak menolak tindakan meskipun berisiko terhadap kesehatannya. Keadaan ini membuat dilema antara *autonomy* dan *beneficence*

4. Kelalaian

Terjadinya kesalahan dalam pemberian obat, tidak melakukan observasi, dimana hal ini akan berpotensi untuk kasus hukum

5. Komunikasi Tidak Efektif

Kesalahan dalam berkomunikasi dapat menyebabkan kesalahan tindakan dan keadaan pada pasien dan akan berdampak pada keselamatan pasien

6. Pelayanan Tidak Adil

Diskriminasi pada pasien dapat melanggar prinsip justice

7. Malpraktik

Apabila seorang tenaga medis tidak mempunyai wewenang melakukan tindakan medis, tetapi tetap melakukan tindakan tersebut. Kerugian fisik dan psikis yang diakibatkan oleh mal praktek mengakibatkan kerugian moral dan materiil terhadap pihak yang dirugikan

F. Cara Mengidentifikasi Isu Etik-Legal

Langkah-langkah identifikasi:

1. Mengumpulkan data
 - a. Kondisi pasien
 - b. Situasi klinis
 - c. Pihak yang terlibat
2. Mengidentifikasi masalah
 - a. Apakah masalah etik, legal, atau keduanya
3. Menentukan prinsip etik yang terlibat
 - a. Autonomy
 - b. Beneficence
 - c. Non-maleficence
 - d. Justice
4. Menganalisis aspek hukum
Apakah ada pelanggaran hukum
5. Menentukan alternatif tindakan
Berdasarkan standar praktik
6. Mengambil keputusan
Berdasarkan etik dan hukum

G. Kode Etik Keperawatan Di Indonesia

Kode etik memberikan pedoman kepada perawat yang akan membantu mereka ketika mereka perlu mengambil keputusan dan ketika mereka dihadapkan pada tantangan moral. Kode-kode ini dimaksudkan sebagai standar dalam profesi keperawatan, dan masyarakat perlu disadarkan akan hal tersebut. Karena perawat memiliki kontak tertinggi dengan pasien dan dihadapkan pada tantangan moral yang lebih besar dibandingkan dengan anggota tim kesehatan lainnya. Pelanggaran terhadap kode etik keperawatan dapat dikenakan sanksi hukum, selain beberapa sanksi lainnya seperti sanksi moral, sanksi administratif, dan sanksi dari institusi terkait, dan lainnya. Penerapan kode etik keperawatan yang baik akan mempengaruhi hasil kerja. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan dan

mengurangi kesalahan perawat dalam melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga jumlah kasus malpraktik di bidang perawatan berkurang. Perawat yang menjalankan kode etik keperawatan akan terlihat lebih baik. dalam hal: bersikap profesional, berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, dan membuat Keputusan, dan masih banyak lagi (Pattyranie & Andriani, 2024).

Kode Etik untuk Perawat adalah standar definitif untuk praktik keperawatan etis, memandu perawat saat mereka membuat keputusan perawatan pasien dan praktik dalam lingkungan perawatan kesehatan yang kompleks saat ini. Kode etik ini juga mendukung perawat dalam menjaga integritas profesional mereka di semua pengaturan perawatan, menekankan keharusan profesi abad ke-21 untuk memajukan keadilan sosial dan kesetaraan kesehatan (American Nurses Association, 2025).

Pada bidang keperawatan, pengetahuan yang dimiliki oleh perawat memegang peranan kunci dalam memberikan asuhan yang efektif. Semakin mendalam pengetahuan perawat tentang kode etik keperawatan, semakin meningkat pula mutu asuhan yang dapat diberikan. Pengetahuan tidak sekadar berhubungan dengan informasi yang tersimpan dalam ingatan, melainkan juga mencakup kemampuan untuk memproses dan menerapkan informasi tersebut guna memperbarui pengetahuan (Fitria et al., 2024).

H. Penerapan Etika Dalam Praktik Keperawatan

Etika keperawatan merupakan landasan penting dalam praktik profesional perawat. Penerapan etika tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap norma moral, tetapi juga berhubungan dengan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi dengan pasien memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan yang etis, manusiawi, dan bermartabat (Burkhardt & Nathaniel, 2019).

Dalam praktik klinik, etika diwujudkan melalui komunikasi terapeutik, penghormatan terhadap hak pasien, serta pelayanan yang berfokus pada kebutuhan pasien (American Nurses Association, 2025). Namun, dalam praktik sering muncul dilema etik, seperti konflik antara keputusan pasien dan keluarga atau keterbatasan sumber daya. Dalam praktik klinik, penerapan etika keperawatan seringkali dihadapkan pada situasi kompleks yang memerlukan pengambilan keputusan secara tepat. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi prinsip etik menjadi sangat penting untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pasien (Sesrianty et al., 2019)

Penerapan etika dalam praktik keperawatan juga menekankan pentingnya perawat untuk menghormati hak pasien, seperti hak mendapatkan informasi, hak memilih tindakan, hak privasi. Penerapan hak pasien merupakan bagian dari prinsip otonomi dan justice dalam praktik keperawatan (Guido, 2019).

Perawat berperan dalam memastikan bahwa pasien memahami informasi sebelum menyetujui tindakan medis. Informed consent merupakan bentuk penghormatan terhadap otonomi pasien (Westrick, 2024). Perawat harus memberikan pelayanan yang adil kepada semua pasien tanpa diskriminasi. Hal ini sesuai dengan prinsip justice dalam etika keperawatan (Burkhardt & Nathaniel, 2019)(Burkhardt & Nathaniel, 2019).

Etika keperawatan antara perawat dan pasien, saat memberikan layanan kesehatan, perawat harus menghargai martabat setiap individu. Dalam melaksanakan tugasnya, perawat wajib mengenalkan diri dan menjelaskan setiap tindakan yang akan dilakukan kepada pasien, tidak melakukan tindakan terlarang, dan tidak membedakan antara pasien; perawat harus menciptakan lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, tradisi, dan agama; perawat memiliki tanggung jawab terhadap individu yang memerlukan perawatan, seperti memberikan perawatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), melakukan perawatan berdasarkan kompetensi, serta membuat dokumentasi perawatan sesuai dengan SOP; perawat wajib menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan oleh pasien kepadanya, kecuali jika diperlukan oleh pihak berwenang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (Lintang, 2021).

Penerapan Etika dalam Konteks Keselamatan Pasien

Penerapan etika memiliki hubungan erat dengan keselamatan pasien. Prinsip non-maleficence mengharuskan perawat untuk menghindari kesalahan yang dapat membahayakan pasien (World Health Organization, 2021).

Contoh penerapan adalah melakukan identifikasi pasien sebelum tindakan , memberikan obat sesuai prinsip benar (6 benar), elaporkan insiden keselamatan pasien

Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap patient safety dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap perawat (Arini et al., 2019; Hidayah & Anwar, 2022)

I. Hukum Dalam Praktik Keperawatan

Praktik keperawatan tidak hanya berlandaskan pada ilmu dan keterampilan klinis, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum dalam praktik keperawatan bertujuan untuk melindungi pasien dan perawat serta menjamin mutu pelayanan kesehatan (Guido, 2019). Seiring dengan perkembangan

pelayanan kesehatan, risiko terjadinya kesalahan dan sengketa medis semakin meningkat. Oleh karena itu, perawat dituntut untuk memahami aspek hukum sebagai bagian dari tanggung jawab profesionalnya. Hukum berfungsi sebagai pedoman sekaligus perlindungan bagi perawat dan pasien. Dengan adanya hukum, perawat dapat bekerja secara profesional, aman, dan sesuai standar yang berlaku. Di sisi lain, hukum juga memberikan perlindungan kepada pasien dari tindakan yang merugikan (Westrick, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan keperawatan yang baik berhubungan dengan kepuasan pasien, yang menjadi indikator keberhasilan pelayanan kesehatan (Sesrianty et al., 2019). Oleh karena itu, pemahaman hukum menjadi sangat penting dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan.

Hukum keperawatan adalah seperangkat aturan yang mengatur praktik keperawatan, termasuk hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Hukum keperawatan merupakan bagian penting dalam praktik profesional yang bertujuan mengatur tindakan perawat serta memberikan perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan. Penerapan hukum keperawatan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab profesional dalam memberikan asuhan yang aman dan bermutu. Pemahaman dan pelaksanaan aspek hukum dalam profesi keperawatan bukan hanya penting untuk melindungi tenaga kesehatan dari aspek legal, tetapi juga menjadi pondasi penting dalam menjamin mutu pelayanan kepada pasien (Ridhani, 2025)

J. Dasar Hukum Penyelenggaraan Praktik Keperawatan

Dasar hukum penyelenggaraan praktik keperawatan adalah a) Peraturan Perundang-undangan di Indonesia UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, UU No. 17 Tahun 2023 menjadi regulasi terbaru yang memperkuat sistem pelayanan kesehatan termasuk tenaga keperawatan, Permenkes tentang registrasi dan praktik tenaga kesehatan b) Standar Profesi terdiri dari Standar praktik keperawatan, Standar prosedur operasional (SPO), Kode etik keperawatan. Standar ini menjadi dasar dalam menentukan apakah tindakan perawat sesuai hukum atau tidak. Dasar hukum tersebut menjelaskan tentang bagaimana seharusnya perawat melaksanakan praktik keperawatan diantaranya (Siregar & sebastianus, 2022) :

1. Praktik Keperawatan dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat lainnya sesuai dengan Klien sasarannya.

2. Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas a. Praktik Keperawatan mandiri; dan b. Praktik Keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
3. Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional. (2)
4. Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat didasarkan pada prinsip kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau masyarakat dalam suatu wilayah. Keperawatan
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau Keperawatan dalam suatu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Perawat dalam memberikan asuhan keperawatan harus memenuhi standar pelayanan diantaranya yaitu menaati SPO (Standar Prosedur Operasional) agar tidak terjadi kelalaian dalam pemberian asuhan keperawatan yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak klien di rumah sakit yang dapat juga menimbulkan sanksi administratif, sanksi pidana, atau sanksi perdata (Primadita, 2020). Perlindungan hukum bagi profesi tenaga kesehatan keperawatan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan (Irfan & Andriyani, 2025)

K. Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Di Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat data mengenai kejadian keselamatan pasien di rumah sakit untuk tahun 2024. Tingkat kesalahan dalam mengidentifikasi pasien tercatat sebesar 1,5%, sementara kesalahan dalam pemberian obat mencapai 12%. Insiden terkait kesalahan bedah, seperti lokasi yang salah, prosedur yang tidak tepat, atau pasien yang salah, terjadi sebesar 8%. Infeksi pada pasien yang dirawat inap mencapai 5%, serta cedera akibat

terjatuh sebesar 7%. Total laporan insiden keselamatan pasien selama tahun 2024 melebihi 6000 kasus, dimana 40% di antaranya merupakan kejadian hampir cedera (KNC), 35% merupakan kejadian tanpa cedera (KTC), dan 25% tergolong kejadian yang tidak diharapkan (KTD) (Kartika et al., 2022). Dalam konteks ini, peran perawat sebagai pihak yang memberikan layanan keperawatan, yang merupakan bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan, memiliki kontribusi yang signifikan terhadap keselamatan pasien.

L. Sasaran Keselamatan Pasien

Sasaran keselamatan pasien (SKP) adalah persyaratan yang harus diterapkan di semua fasilitas kesehatan. Tujuan SKP adalah untuk mendorong perbaikan tertentu terkait keselamatan pasien. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 mengenai Keselamatan Pasien Pasal 5 ayat (5) dinyatakan bahwa Sasaran Keselamatan Pasien yang dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup pencapaian hal-hal berikut:

1. Meningkatkan identifikasi pasien secara akurat

Sasaran ini bertujuan untuk mencegah kesalahan akibat salah identifikasi pasien. Ini melibatkan proses penandaan atau pembeda yang mencakup nomor rekam medis serta identitas pasien agar dapat membedakan antara satu pasien dengan yang lainnya demi ketepatan dalam memberikan pelayanan, pengobatan, dan tindakan medis.

2. Meningkatkan komunikasi yang efektif

Untuk meningkatkan keselamatan pasien yang dirawat di fasilitas kesehatan, perawat serta tenaga kesehatan lainnya harus dapat dan terampil dalam menerapkan sasaran keselamatan pasien yang kedua, yaitu memperbaiki komunikasi yang efektif sehingga dapat menghindari kesalahan komunikasi antara petugas kesehatan.

3. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai

Obat dengan kewaspadaan tinggi adalah obat-obatan yang memiliki risiko besar untuk membahayakan pasien bila digunakan secara keliru atau dikelola dengan tidak tepat.

4. Memastikan lokasi, prosedur, dan pasien yang benar saat pembedahan

Sasaran ini bertujuan untuk mencegah kesalahan mengenai lokasi, prosedur, dan pasien saat operasi.

5. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan

Mencegah pasien terkena infeksi selama perawatan di fasilitas kesehatan dengan menerapkan kebersihan tangan (hand hygiene) sesuai dengan 5 momen WHO,

penggunaan alat pelindung diri (APD) sesuai kebutuhan, serta meningkatkan program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) secara konsisten.

6. Mengurangi risiko cedera pasien karena terjatuh

Mencegah pasien jatuh saat berada di fasilitas kesehatan dengan langkah-langkah seperti melakukan skrining risiko jatuh saat pasien masuk, memastikan pagar tempat tidur terkunci, menempatkan tanda “berisiko jatuh” pada pasien yang memerlukan pengawasan khusus, dan memberikan edukasi kepada keluarga untuk mendampingi pasien yang berisiko tinggi.

M. Peran Perawat dalam Keselamatan Pasien

Perawat memegang peran sentral dalam keselamatan pasien karena hadir sepanjang waktu dalam asuhan pasien. Peran tersebut mencakup:

1. Melaksanakan asuhan keperawatan yang aman dan sesuai standar
2. Melakukan assesmen risiko pasien secara berkala
3. Melaporkan kejadian insiden keselamatan pasien
4. Berpartisipasi dalam tim kerja untuk perbaikan kualitas pelayanan
5. Mengembangkan komunikasi antar disiplin yang efektif

Studi menunjukkan hubungan positif antara pengetahuan perawat tentang keselamatan pasien dengan penerapan praktik keselamatan di lapangan. Perawat harus menunjukkan sikap yang positif dalam mendukung program keselamatan pasien sehingga melaksanakan praktik keperawatan secara aman (Muslimin et al., 2023)

N. Penerapan Keselamatan Pasien dalam Praktik Keperawatan

Penelitian (Sesrianty & Harahap, 2021) bahwa pengetahuan perawat dan supervisi yang dilakukan oleh kepala ruangan sangat memberikan pengaruh dalam hal pencegahan resiko jatuh sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan keselamatan pasien. Penelitian lain (Sesrianty et al., 2023) tentang perawat dengan motivasi tinggi mampu melakukan komunikasi efektif yang baik meningkatkan keselamatan pasien. Komunikasi yang efektif dapat mengurangi kesalahan dalam komunikasi antara petugas kesehatan dan petugas kesehatan dengan pasien untuk mencegah kejadian tidak diharapkan (KTD) dan meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Komunikasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan proses perawatan untuk mengurangi kesalahan yang jika terdeteksi dapat menyebabkan masalah keselamatan pasien. Kutney-Lee et al (2016) seperti dikutip (Setiawan, 2024) meneliti rumah sakit yang memiliki perawat yang sedikit terlibat

dalam dalam pelaksanaan tatakelola keperawatan memiliki skor keselamatan pasien yang buruk begitupun sebaliknya.

O. Etika dan Penerapan Keselamatan Pasien dalam Praktik Keperawatan

Etika keperawatan memiliki peran fundamental dalam menjamin keselamatan pasien. Setiap prinsip etik menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis untuk mencegah terjadinya kesalahan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Ketidakpatuhan terhadap prinsip etik dapat meningkatkan risiko kejadian tidak diharapkan

Aktivitas 1 – *Knows How*

Mini-Case

Kasus 1

Seorang pasien laki-laki usia 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis hipertensi dan diabetes melitus. Pasien mendapatkan terapi obat antihipertensi dan insulin. Pada suatu pagi, perawat jaga memberikan obat kepada pasien tanpa melakukan verifikasi dua identitas pasien. Setelah beberapa menit, diketahui bahwa obat tersebut sebenarnya milik pasien lain dengan nama yang hampir sama. Pasien mengalami penurunan tekanan darah secara drastis dan harus mendapatkan penanganan segera. Kejadian tersebut tidak langsung dilaporkan oleh perawat karena takut mendapatkan sanksi dari atasan. Selain itu, dokumentasi tindakan juga tidak dilakukan secara lengkap

Tugas Kelompok

Diskusikan kasus di atas dalam kelompok (3–5 orang), kemudian jawab pertanyaan berikut :

1. Analisis Etik
 - a. Prinsip etik apa saja yang dilanggar dalam kasus tersebut?
 - b. Jelaskan alasan pelanggaran berdasarkan konsep etik keperawatan
2. Analisis Hukum
 - a. Apakah kasus ini termasuk kelalaian atau malpraktik? Jelaskan
 - b. Apa konsekuensi hukum yang mungkin terjadi pada perawat?
3. Analisis Keselamatan Pasien
 - a. Sasaran keselamatan pasien mana yang tidak diterapkan?
 - b. Jenis insiden apa yang terjadi (KTD/KNC/KTC/KPC)? Jelaskan
4. Analisis Penyebab (Root Cause)
 - a. Apa faktor penyebab kejadian tersebut? (manusia, sistem, lingkungan)
5. Solusi dan Rekomendasi
 - a. Apa tindakan yang seharusnya dilakukan perawat?
 - b. Bagaimana upaya pencegahan agar kejadian tidak terulang?

Kasus 2

Seorang pasien Bapak Ahmad, usia 72 tahun, dirawat di ruang rawat inap dengan diagnosis hipertensi dan keluhan pusing sejak 2 hari terakhir. Hasil pengkajian menunjukkan tekanan darah 100/60 mmHg, pasien tampak lemah dan berjalan tidak stabil. Pasien menggunakan tongkat di rumah, namun saat ini tidak membawanya. Di ruangan, lantai tampak licin dan side rail tempat tidur belum terpasang. Pasien mengatakan: "Saya ingin ke kamar mandi sendiri, tidak mau merepotkan perawat."

Tugas Kelompok

Diskusikan kasus di atas dalam kelompok (3–5 orang), kemudian jawab pertanyaan berikut :

1. Apakah masalah utama pada kasus tersebut?
2. Sebutkan faktor resiko jatuh pada pasien?
3. Menurut saudara apakah pasien termasuk resiko rendah, sedang tinggi. Jelaskan alasan saudara?
4. Apa saja tindakan yang harus dilakukan?
5. Apa tindakan prioritas yang harus dilakukan?
6. Apakah edukasi yang akan diberikan?
7. Bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan tindakan?

Kasus 3

Seorang pasien perempuan bernama Ibu Siti usia 58 tahun, dirawat di ruang rawat inap dengan diagnosis hipertensi. Dokter meresepkan Amlodipine 10 mg oral pukul 08.00. Di ruangan terdapat dua pasien dengan nama yang hampir sama, yaitu "Siti Aminah" dan "Siti Rahma". Perawat menemukan obat di meja pasien tanpa label yang jelas. Pasien berkata : "Saya belum minum obat pagi ini, tolong diberikan ya."

Tugas Kelompok

Diskusikan kasus di atas dalam kelompok (3–5 orang), kemudian jawab pertanyaan berikut :

1. Apakah potensi masalah pada kasus tersebut
2. Sebutkan resiko yang mungkin terjadi?
3. Jelaskan prinsip 6 benar pada kasus tersebut?
4. Apakah tindakan perta yang harus dilakukan perawat?
5. Apakah yang harus dilakukan sebelum memberikan obat?
6. Apa edukasi yang perlu diberikan kepada pasien?
7. Bagimankah memastikan tindakan sudah aman?

Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi/skill lab kala II

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Catatan untuk penulis:

- Tidak loncat ke ujian
- Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE

Catatan untuk penulis:

- Karena CP Bab = mendemonstrasikan OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Hand hygiene & pencegahan infeksi
- Identifikasi ibu & privasi
- Penilaian kesiapan kala II
- Eskalasi bila red flags muncul

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

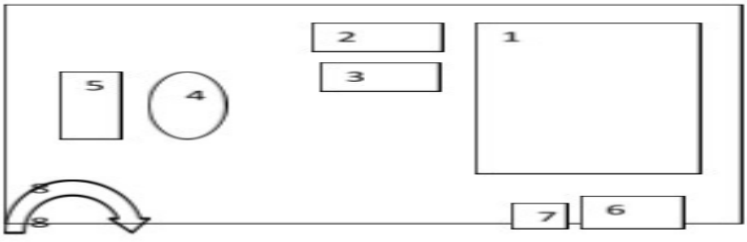
- Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

1.	Nomor station	(Dikosongkan)
2.	Judul station	Kebutuhan aman dan nyaman pada pasien dewasa di ruang rawat inap
3.	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian, menegakkan diagnosa keperawatan, melakukan tindakan cuci tangan dan pemasangan APD (PPI) dan menunjukkan perilaku profesional
5.	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6.	Kategori	1. Oksigenasi 2. Sirkulasi 3. Cairan dan elektrolit 4. Nutrisi 5. Aman dan nyaman 6. Psikososial 7. Eliminasi 8. Aktivitas dan istirahat 9. Seksual dan reproduksi
7.	Instruksi untuk peserta ujian	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Seorang pasien Bapak Andi, usia 55 tahun, dirawat di ruang rawat inap dengan diagnosis Diabetes Mellitus tipe 2 dengan luka ulkus diabetikum pada punggung kaki kanan luas 15 cm. Berdasarkan hasil pengkajian, luka tampak basah, terdapat eksudat kekuningan, dan berbau ringan. Tanda-tanda vital : TD

		130/85 mmHg, Nadi 88 x/menit, Suhu 37,8°C, RR 20 x/menit. Pasien dalam kondisi sadar dan dapat diajak komunikasi. <u>TUGAS :</u> 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS 2. Tuliskan diagnosa keperawatan pasien 3. Lakukan tindakan pencegahan infeksi cuci tangan dan pemasangan APD sesuai standar keselamatan
8.	Instruksi untuk penguji	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Seorang pasien Bapak Andi, usia 55 tahun, dirawat di ruang rawat inap dengan diagnosis Diabetes Mellitus tipe 2 dengan luka ulkus diabetikum pada punggung kaki kanan luas 15 cm. Berdasarkan hasil pengkajian, luka tampak basah, terdapat eksudat kekuningan, dan berbau ringan. Tanda-tanda vital : TD 130/85 mmHg, Nadi 88 x/menit, Suhu 37,8°C, RR 20 x/menit. Pasien dalam kondisi sadar dan dapat diajak komunikasi. <u>TUGAS :</u> 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS 2. Sampaikan kepada penguji diagnosa keperawatan pasien 3. Lakukan tindakan pencegahan infeksi cuci tangan dan pemasangan APD sesuai standar keselamatan <u>INSTRUKSI PENGUJI:</u> 4. Menilai ketepatan peserta dalam melakukan pengkajian luka pada pasien. 5. Menilai diagnosis keperawatan yang disampaikan peserta Resiko infeksi dibuktikan dengan penyakit kronis (diabetes mellitus) 6. Penguji mengamati dan menilai penampilan peserta saat melakukan tindakan PPI cuci tangan dan pemasangan APD 7. Penguji memonitor perilaku profesional peserta

		8. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9.	Instruksi untuk klien standar (KS)	Instruksi KS • Nama : Tn. A • Usia : 55 tahun • Jenis kelamin : Laki-laki • Pekerjaan : Pegawai swasta • Status Pernikahan : Menikah • Pendidikan Terakhir : Sarjana Riwayat penyakit sekarang • Keluhan utama : ada luka dibagian punggung kaki kanan dengan luas 15 cm, ada pus • Sejak kapan : 1 hari yang lalu • Perjalanan penyakit : luka muncul berawal dari gatal dan digaruk • Riwayat penyakit dahulu : tidak ada Riwayat penyakit keluarga • Tidak ada sakit yang serupa dengan klien Pesan yang harus dilakukan • KS berperan sebagai seorang laki-laki umur 55 tahun yang mengalami luka dibagian punggung kaki kanan dengan luas 15 cm, ada pus, mengeluh "luka saya sering keluar cairan dan kadang terasa nyeri" • Jawablah pertanyaan peserta ujian sesuai skenario yang disediakan. Bila peserta ujian bertanya tentang hal diluar skenario, jawablah tidak tahu atau saya tidak memperhatikan.
10.	<i>Setting Station.</i>	Setting ruang unit rawat inap • Tempat Tidur klien • Klien simulasi Keterangan 1. Bed Pasien

		2. Meja Pasien 3. Trolly 4. Meja Penguji 5. Kursi Penguji 6. Washtafel 7. Tempat sampah 8. Pintu masuk 
11	Peralatan yang dibutuhkan	8. Watafel dan air mengalir 9. Sabun/Handrub 10. Tisu 11. Masker 12. Topi/mitella 13. Sepatu boot 14. Kacamata/goggle 15. Skor/gaun operasi
12	Penulis	a. Ns. Vera Sesrianty, M.Kep b. Departemen DKKD Universitas Perintis Indonesia
13	Referensi	• Potter, PA & Perry A,G. (2022) . Fundamentals of nursing 10th ed. St. Louis: mosby • Tim Pokja SDKI DPP PPNI. 2017. Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia Edisi 1 Jakarta : DPP PPNI • Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. • Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

		Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI. 2021. Pedoman Standar Operasional Keperawatan Indonesia Edisi 1 Jakarta : DPP PPNI
--	--	--

SOP CUCI TANGAN

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
1	Menviapkan peralatan yang dibutuhkan				
2	Melepas semua perhiasan yang menempel di				
3	Membasahi kedua belah tangan dengan air				
4	Memberi sabun secukupnya pada kedua belah				
5	Menggosok kedua tangan dan jari				
6	Menggosok punggung tangan secara bergantian				
7	Menggosok sela jari dengan jari-jari tangan yang				
8	Menggosok punggung jari secara bergantian				
9	Menggosok ibu jari secara bergantian				
10	Menggosok ujung jari pada telapak tangan secara				
11	Menggenggam pergelangan tangan dengan				
12	Membilas kedua tangan dengan air bersih yang				
13	Mematikan kran dengan menggunakan siku				
14	Mengeringkan tangan dengan handuk bersih atau				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: KEBUTUHAN AMAN DAN NYAMAN PADA PASIEN DEWASA DI
RUANG RAWAT INAP

I. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Menggali pengkajian luka pada pasien gangguan kebutuhan aman nyaman yang mengalami luka ulkus diabetikum					1	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis yang tepat dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai seperti resiko infeksi, Nyeri akut, hipertermi					2	
3	Implementasi keperawatan : demonstrasi cuci tangan	Menjelaskan tanda dan gejala infeksi dan pencegahan pengendalian infeksi, mendemonstrasikan pencegahan dan pengabdian infeski (cuci tangan sebelum dan setelah tindakan)					5	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION : KEBUTUHAN AMAN DAN NYAMAN PADA PASIEN DEWASA DI
RUANG RAWAT INAP

II. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan, aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada luka ulkus pasien, meliputi lokasi, stadium luka, ukuran luka, warna luka, eksudat, kondisi sekitar luka dan nyeri. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan membaca hasil temuan dengan benar.					1	
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan, aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegaskan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas pada pasien yang mengalami gangguan kebutuhan aman dan nyaman pasien diabetes melitus yang mengalami luka ulkus serta menyusun rencana keperawatan yang relevan. Peserta menuliskan diagnosis dan perencanaan secara jelas berdasarkan data pada skenario dan hasil validasi pengkajian fokus. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	
3. Implementasi Keperawatan, aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Tindakan yang dimaksud adalah demonstrasi pengendalian infesi cuci tangan dan pemasangan APD dengan langkah-langkah kerja yang aman, tepat, sistematis, serta sesuai kondisi anak dan keluarga. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					5	
4. Perilaku Profesional, aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, berkomunikasi terapeutik dengan pasien, menjaga						

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
kenyamanan dan keamanan pasien, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.						
					2	

III. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus gangguan aman nyaman pasien diabetes melitus dengan luka ulkus	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi pengkajian luka meliputi lokasi, stadium luka, ukuran luka	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting seperti luka meliputi lokasi, stadium luka, ukuran luka, warna luka, tetapi masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi luka meliputi lokasi, stadium luka, ukuran luka, warna luka, eksudat, kondisi sekitar luka dan nyeri, kemudian mampu menyampaikan hasil pengkajian dengan tepat.
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis keperawatan, atau diagnosis tidak sesuai dengan data	Menegakkan diagnosis keperawatan tetapi tidak tepat sebagai prioritas, atau diagnosis masih	Menegakkan diagnosis keperawatan yang cukup tepat sesuai masalah utama, dan	Menegakkan diagnosis keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data kasus, serta

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	kasus. Tidak mampu menyusun rencana keperawatan.	kurang sesuai dengan data. Rencana keperawatan sangat terbatas dan tidak relevan.	menyusun rencana keperawatan yang cukup sesuai, namun masih kurang lengkap, kurang spesifik, atau belum sepenuhnya sesuai prioritas klinis.	menyusun rencana keperawatan yang lengkap, relevan, sistematis, dan sesuai kebutuhan anak dengan diare.
3. Implementasi Keperawatan	Tidak melakukan demonstrasi cuci tangan dan pemasangan APD atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Melakukan demonstrasi secara terbatas, banyak langkah penting yang tidak dilakukan, penjelasan kurang jelas, dan teknik belum tepat.	Melakukan demonstrasi dengan cukup baik, sebagian besar langkah sudah benar, namun masih ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan penjelasan, atau teknik demonstrasi.	Melakukan demonstrasi cuci tangan dan pemasangan APD secara tepat, aman, sistematis, dan lengkap
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan,	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi,	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan pasien.	privasi, atau keselamatan pasien.	kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematisa tindakan.	persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan pasien, bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan.

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

II. Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skor

Nilai akhir = ----- x 100 =

30

(Kota),

.....

Penguji :

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada Asuhan Keperawatan Anak dengan Diare
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Keperawatan Gangguan Kebutuhan Aman Nyaman

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan asuhan awal pada anak yang gangguan kebutuhan aman nyaman
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang gangguan kebutuhan aman nyaman, tetapi juga dari kemampuannya melakukan pengkajian, menjelaskan kondisi pasien, dan menyampaikan rencana asuhan pasien.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Seorang pasien Bapak Andi, usia 55 tahun, dirawat di ruang rawat inap dengan diagnosis Diabetes Mellitus tipe 2 dengan luka ulkus diabetikum pada punggung kaki kanan luas 15 cm. Berdasarkan hasil pengkajian, luka tampak basah, terdapat eksudat kekuningan, dan berbau ringan. Tanda-tanda vital : TD 130/85 mmHg, Nadi 88 x/menit, Suhu 37,8°C, RR 20 x/menit.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat namun terarah, memeriksa kondisi luka dan karakteristik luka yang dapat menimbulkan ketidaknyaman pada pasien, serta edukasi tentang tanda-tanda infeksi dan pencegahan pengendalian infeksi melalui cuci tangan.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu memeriksa kondisi luka dan karakteristik luka yang dapat menimbulkan ketidaknyaman pada pasien, serta edukasi tentang tanda-tanda infeksi dan pencegahan pengendalian infeksi melalui cuci tangan, dan menjaga komunikasi yang baik dengan pasien.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas, misalnya defisit resiko infeksi, serta mampu memberikan edukasi yang tepat dan aman kepada keluarga.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan identifikasi memeriksa kondisi luka dan karakteristik luka yang dapat menimbulkan ketidaknyaman pada pasien, memperdalam pengkajian luka dan memperjelas serta tentang pengkajian luka, tanda-tanda infeksi dan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
		pengecambahan pengendalian infeksi melalui cuci tangan.
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus pasien gangguan kebutuhan aman nyaman dengan luka ulkus, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan asuhan keperawatan secara langsung, aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 6. 1 Portofolio pada Asuhan Keperawatan Gangguan Pemenuhan Kebutuhan Aman Nyaman

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus pasien gangguan aman nyaman dengan luka ulkus
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada asuhan keperawatan gangguan pemenuhan kebutuhan aman nyaman, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menetapkan masalah keperawatan, memberikan edukasi, menjaga keselamatan pasien, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah merawat gangguan pemenuhan kebutuhan aman nyaman, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan edukasi pemberian

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus pasien gangguan aman nyaman dengan luka ulkus
	karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	oralit, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan asuhan gangguan pemenuhan kebutuhan aman nyaman.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus, diagnosis keperawatan prioritas, intervensi pencegahan infeksi dengan cuci tangan sebelum dan setelah tindakan, edukasi tanda infeksi, dan evaluasi respons pasien.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memantau tanda dehidrasi, mencatat intake-output dengan teliti, memastikan oralit diberikan dengan cara yang benar, dan mengenali tanda bahaya yang membutuhkan pelaporan segera.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dengan pasien, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam pengkajian luka dan kebutuhan aman nyaman.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus kabutuhan aman nyaman, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan asuhan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus pasien gangguan aman nyaman dengan luka ulkus
		keperawatan secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian melakukan tindakan pencegahan infeksi, dan komunikasi terapeutik dengan pasien dan keluarga.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada asuhan keperawatan gangguan pemenuhan kebutuhan aman nyaman, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep aman nyaman dan penyakit, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel 6. 2 Case Report pada Asuhan Keperawatan Anak dengan Diare

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus pasien gangguan aman nyaman dengan luka ulkus
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang Seorang pasien Bapak Andi, usia 55 tahun, dirawat di ruang rawat inap dengan diagnosis Diabetes Mellitus tipe 2 dengan luka ulkus diabetikum pada punggung kaki kanan luas 15 cm. Berdasarkan hasil pengkajian, luka tampak basah,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus pasien gangguan aman nyaman dengan luka ulkus
	mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	terdapat eksudat kekuningan, dan berbau ringan. Tanda-tanda vital : TD 130/85 mmHg, Nadi 88 x/menit, Suhu 37,8°C, RR 20 x/menit
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan yang diberikan
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus diare, mahasiswa menuliskan Seorang pasien Bapak Andi, usia 55 tahun, dirawat di ruang rawat inap dengan diagnosis Diabetes Mellitus tipe 2 dengan luka ulkus diabetikum pada punggung kaki kanan luas 15 cm. Berdasarkan hasil pengkajian, luka tampak basah, terdapat eksudat kekuningan, dan berbau ringan. , intervensi pencegahan infeksi melalui cuci tangan, edukasi tanda infeksi
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data luka dan resiko infeksi dengan masalah utama, memilih intervensi yang tepat, dan menilai respons pasien setelah dilakukan tindakan.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning,	Dari kasus diare, mahasiswa belajar bahwa pengkajian luka

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus pasien gangguan aman nyaman dengan luka ulkus
	keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	dan tanda infeksi, dan edukasi keluarga merupakan bagian yang sangat penting dalam asuhan keperawatan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep aman nyaman dan infeksi, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan secara utuh.

Tabel 6. 3 Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan Gangguan Pemenuhan Kebutuhan Aman Nyaman

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus gangguan kebutuhan aman nyaman pasien dengan luka ulkus, mahasiswa merefleksikan bahwa kondisi luka yang apabila tidak dilakukan perawatan dengan baik dan dilakukan cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan dapat menimbulkan resiko insi pada pasien.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti tidak melakukan cuci tangan dengan baik sebelum melakukan tindakan kepada pasien, dapat berdampak besar pada keselamatan pasien
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien ini adalah risiko

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
	penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	infeksi, nyeri, dan keterlambatan penanganan bila keluarga tidak memahami tanda bahaya.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain terdapat tanda-tanda infeksi pada luka, nyeri dan ketidaknyaman pada pasien, keterlambatan pelaporan tanda bahaya.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya memantau luka, serta mengedukasi keluarga jika menemukan tanda-tanda infeksi.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada pasien, pengkajian yang teliti, komunikasi yang jelas kepada pasien dan keluarga, dan pemantauan berulang merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan pada pasien secara berkelanjutan.

P. RINGKASAN

Praktik keperawatan adalah suatu pelayanan profesional yang tidak hanya membutuhkan kemampuan klinis, tetapi juga harus berdasarkan prinsip-prinsip etika, hukum, dan keselamatan pasien. Etika dalam keperawatan berfungsi sebagai pedoman moral yang mengarahkan tindakan perawat saat memberikan asuhan dengan cara yang profesional dan bertanggung jawab. Beberapa prinsip etika yang

penting meliputi penghormatan terhadap otonomi, kebaikan, tidak mencelakai, keadilan, kebenaran, dan kerahasiaan. Penerapan prinsip-prinsip ini terlihat dalam cara komunikasi terapeutik, penghormatan pada hak-hak pasien, pelayanan yang bebas dari diskriminasi, serta pengambilan keputusan yang tepat dalam konteks klinis.

Di samping aspek etika, praktik keperawatan juga diatur oleh hukum yang bertujuan untuk melindungi baik pasien maupun perawat itu sendiri. Dasar hukum keperawatan di Indonesia meliputi Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 mengenai Keperawatan, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta berbagai peraturan pelengkap lainnya. Oleh karena itu, perawat harus bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur, memiliki izin praktik yang valid, serta melakukan pencatatan keperawatan secara menyeluruh dan tepat sebagai bukti hukum.

Keselamatan pasien adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk mencegah cedera yang diakibatkan oleh kesalahan dalam pelayanan kesehatan. Aspek keselamatan pasien mencakup identifikasi pasien yang akurat, komunikasi yang efektif, keamanan dalam penggunaan obat, keakuratan prosedur, pencegahan infeksi, dan pencegahan risiko jatuh. Upaya untuk menerapkan keselamatan pasien dilakukan dengan memastikan kepatuhan terhadap standar praktik, menggunakan komunikasi yang efektif, serta melaporkan insiden yang berkaitan dengan keselamatan pasien sebagai bagian dari usaha perbaikan sistem layanan.

Etika, hukum, dan keselamatan pasien adalah tiga pilar utama yang saling berhubungan dalam praktik keperawatan. Prinsip-prinsip etika seperti tidak mencelakakan dan kebaikan merupakan landasan penting dalam mencegah kesalahan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Sementara itu, hukum menyediakan kerangka untuk perlindungan dan kepastian dalam menjalankan praktik profesional. Mengintegrasikan ketiga aspek ini sangat krusial untuk menciptakan pelayanan keperawatan yang aman, berkualitas, dan fokus pada pasien. Dengan demikian, perawat diharapkan memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan prinsip etika, mematuhi hukum, dan menjamin keselamatan pasien dalam setiap tindakan keperawatan.

Tabel 6. 4 Red Flags & Eskalasi

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Luka berbau menyengat	Indikasi infeksi	Monitor dan tingkatkan PPI
Eksudat purulen (kuning/hijau)	Infeksi bakteri	Perawatan luka aseptik dan lapor
Demam	Respon inflamasi/infeksi	Konsultasi dokter
Nyeri meningkat	Perburukan luka	Lapor dokter
Kemerahan & bengkak	Inflamasi	Kolaborasi analgesik
Luka tidak membaik	Risiko komplikasi	Rujuk tim luka
Gula darah tinggi	Hambat penyembuhan luka	Kolaborasi terapi
Pasien lemah	Risiko komplikasi sistemik	Eskalasi segera (urgent)

Form Checklist

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian etika keperawatan, prinsip etika, isu etik legal dalam praktik keperawatan	☐	☐	
2	Saya sudah bisa menjelaskan hukum dan hak pasien dalam praktik keperawatan	☐	☐	
3	Saya sudah bisa menjelaskan keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien dalam praktik keperawatan	☐	☐	
4	Saya sudah bisa mengkaji keadaan luka pada pasien ulkus yang mengalami gangguan kebutuhan aman nyaman	☐	☐	
5	Saya sudah bisa mengenali tanda infeksi dan pencegahan infeksi pada pasien luka ulkus dengan gangguan rasa aman nyaman	☐	☐	
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah keperawatan prioritas pada pasien gangguan aman nyaman pasien dengan luka ulkus	☐	☐	
7	Saya sudah bisa menyusun rencana asuhan keperawatan gangguan aman nyaman dengan luka ulkus	☐	☐	
8	Saya sudah bisa melakukan pencegahan infeksi dan prosedur cuci tangan sebelum dan setelah tindakan pada pasien dengan luka ulkus	☐	☐	
9	Saya sudah bisa memberikan edukasi tanda tanda infeksi dan pencegahan dan pengendalian infeksi	☐	☐	
12	Saya sudah bisa menentukan kapan harus melakukan eskalasi atau melapor	☐	☐	
13	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dengan pasien dan keluarga	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
14	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi singkat asuhan keperawatan gangguan kebutuhan aman nyaman pasien dengan luka ulkus	☐	☐	
15	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif saat merawat pasien gangguan kebutuhan aman nyaman pasien dengan luka ulkus	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

Referensi

- American Nurses Association. (2025). *Code Of Ethic for Nurse*.
<https://codeofethics.ana.org/home>
- Ariga, R. A. (2020). *Buku Ajar: Konsep Dasar Keperawatan*. Deepublish.
- Burkhardt, M. A., & Nathaniel, A. K. (2019). *Ethics & Issues In Contemporary Nursing - E-Book*. Elsevier. <https://books.google.co.id/books?id=htvWDwAAQBAJ>
- Butts, J. B., & Rich, K. L. (2020). *Nursing Ethics : Accros Curriculum Into Practice*. Jones & Bartlett Learning.
<https://books.google.co.id/books?id=nFi0CAAAQBAJ>
- Feriadi, A., Purwanti, E., & Novryana, E. (2020). GAMBARAN TINGKAT PENERAPAN PRINSIP ETIK KEPERAWATAN DI RUANG RAWAT INAP KELAS III RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH GOMBONG. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 16(1), 19–27.
- Fitria, D. I., Faozi, A., & Dolifah, D. (2024). Correlation between knowledge of the nursing code of ethics and non-maleficence behavior of nurses in the inpatient room. *Jurnal Keperawatan Florence Nightingale (JKFN)*, 7(1), 216–222.
- Guido, G. W. (2019). *Legal and Ethical Issues in Nursing*. Pearson Education, Incorporated. <https://books.google.co.id/books?id=D33RtQEACAAJ>
- Hidayat, J., & Melani, P. C. (2023). Etika Dan Kesehatan. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(02).
- Irfan, M., & Andriyani, S. (2025). Pengaturan Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Tenaga Kesehatan Keperawatan Mandiri Di Sarana Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(1), 264–270.
- Kartika, I., Syofia, A., & Rahmatika, D. (2022). STUDI DESKRIPTIF PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN INDIKATOR MUTU KEPERAWATAN DI RUANG RAWAT INAP RSUD M.NATSIR SOLOK. *Human Care Journal*, 7, 351.
<https://doi.org/10.32883/hcj.v7i2.1704>
- Kementerian Kesehatan RI. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien*.
- Lintang, K. (2021). *Tanggung Jawab Hukum Perawat Praktik Mandiri terhadap Kerugian Pasien*. 300–326.
- Muslimin, M., Khasanah, Y., Hikmat, R., & Faridasari, I. (2023). HUBUNGAN

PENGETAHUAN DAN SIKAP PERAWAT DENGAN PELAKSANAAN KESELAMATAN PASIEN (PATIEN SAFETY) DI RUANG RAWAT INAP BEDAH RUMAH SAKIT. *Jurnal Kesehatan*, 14, 59–69. <https://doi.org/10.38165/jk.v14i1.334>

Nurhidayati, T., Armiyati, Y., & Aceh, A. R. (2022). *Keperawatan: Konsep dasar dan Manajemen Pelayanan* (1st ed.). Bintang Semesta Media.

Ose, M. I. (2017). Dilema Etik dalam Merawat Pasien Terlantar yang Menjelang Ajal di IGD. *JURNAL PENDIDIKAN KEPERAWATAN INDONESIA*, 3, 145. <https://doi.org/10.17509/jpki.v3i2.9420>

Pattyranie, H., & Andriani, H. (2024). *Pengetahuan dan sikap perawat tentang kode etik keperawatan rumah sakit x di jakarta*. 5, 5578–5585.

Primadita, A. (2020). Tanggung jawab hukum perawat terhadap hak-hak klien dalam upaya pelayanan asuhan keperawatan di rumah sakit. *Jurnal Juristic*, 1(1), 67–80.

Ridhani, M. (2025). Profesi Keperawatan Dalam Perspektif Hukum Dengan Mutu Pelayanan Di Rsud Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin The Nursing Profession from A Legal Perspective and Service Quality at Sultan Suriansyah Regional General Hospital , Banjarmasin City . *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3627–3642. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7834>

Sesrianty, V., Andriani, Y., & Putra, A. M. (2023). MOTIVASI PERAWAT BERHUBUNGAN DENGAN KOMUNIKASI. *Human Care Journal*, 8(1), 89–97.

Sesrianty, V., & Harahap, H. B. (2021). Hubungan Pengetahuan Dan Supervisi Dengan Penerapan Pengurangan Risiko Pasien Jatuh. *Jurnal Kesehatan Medika Saintika*, 11(1), 51–60.

Sesrianty, V., Machmud, R., & Yeni, F. (2019). Analisa kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan keperawatan. *Jurnal Kesehatan Perintis*, 6(2), 116–126.

Setiawan. (2024). Tatakelola Keperawatan Profesional dan Peran Strategis Perawat Manajer Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit. In *TEORI MODEL DAN INOVASI DALAM KEPERAWATAN: Gagasan Guru Besar Keperawatan Indonesia* (pp. 305–318). Nuansa Fajar Cemerlang (Optimal).

Siregar, H., & sebastianus. (2022). *Buku Ilmu Keperawatan Dasar*. Media Sains Indonesia.

- Westrick, S. J. (2024). *Essentials of nursing law and ethics*. Jones & Bartlett Learning.
- Winarti, W., & Rosiana, R. (2020). Persepsi Perlindungan Hukum dan Aspek Etik terhadap Keinginan Perawat IGD Melakukan CPR pada Out-of-Hospital Cardiac Arrest (OHCA). *JURNAL PENDIDIKAN KEPERAWATAN INDONESIA*, 6(2). <https://doi.org/10.17509/jpki.v6i2.23438>

BAB 7

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI) SERTA KEWASPADAAN STANDAR

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar keperawatan, profesionalisme, etika–legal, dan keselamatan pasien sebagai landasan praktik.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6
CPL-2	Mampu menerapkan proses keperawatan secara sistematis (pengkajian–diagnosis–perencanaan–implementasi–evaluasi) berbasis kebutuhan dasar manusia.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-7
CPL-3	Mampu melakukan pengkajian dasar (tanda vital, nyeri, pemeriksaan fisik) serta dokumentasi yang akurat dan dapat diaudit.	CPMK-3; CPMK-7
CPL-4	Mampu melaksanakan keterampilan keperawatan dasar (oksigenasi, nutrisi, eliminasi, mobilisasi, integumen, pemberian obat) secara aman dan sesuai standar.	CPMK-4; CPMK-6
CPL-5	Mampu berkomunikasi terapeutik, memberikan edukasi kesehatan, dan melakukan discharge planning dasar yang berpusat pada pasien–keluarga.	CPMK-5; CPMK-7
CPL-6	Mampu berpikir kritis dan clinical reasoning untuk pengambilan keputusan, pencegahan risiko, serta perbaikan mutu praktik keperawatan dasar.	CPMK-2; CPMK-6; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan pengantar keperawatan dasar, profesionalisme perawat, peran, nilai, dan standar perilaku dalam pelayanan.
CPMK-2	Menjelaskan konsep sehat–sakit, homeostasis, kebutuhan dasar manusia, serta menerapkan berpikir kritis/clinical reasoning dalam pengambilan keputusan keperawatan.
CPMK-3	Melakukan proses keperawatan (pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, evaluasi) dan mendokumentasikan secara sistematis.
CPMK-4	Melaksanakan keterampilan keperawatan dasar untuk pemenuhan kebutuhan dasar (oksigenasi, nutrisi, cairan, eliminasi, istirahat–tidur, mobilisasi, integumen) sesuai standar.
CPMK-5	Menerapkan komunikasi terapeutik dan hubungan perawat–klien secara profesional untuk mendukung asuhan dan edukasi.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Menerapkan etik–hukum, patient safety, PPI, pencegahan jatuh, dan keselamatan medikasi dalam praktik keperawatan dasar.
CPMK-7	Melaksanakan edukasi kesehatan, discharge planning, dan handover SBAR, serta mengevaluasi luaran asuhan dan menyusun perbaikan rencana berbasis data.

I. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 7. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) serta Kewaspadaan Standar	7.1 Menerapkan kewaspadaan standar (hand hygiene, APD) sesuai risiko tindakan.	7.2 Menetapkan langkah pencegahan infeksi silang dan pengelolaan limbah tajam secara aman.	CPMK-6	CPMK-4; CPMK-7

J. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-4	OSCE keterampilan dasar (TV, oksigenasi, eliminasi, luka) + checklist	Persentase langkah benar pada skill station dan ketepatan evaluasi respons pasien.	25	Checklist OSCE; catatan tindakan
CPMK-6	OSCE keselamatan (PPI, jatuh, 6 benar medikasi) + checklist	Persentase kepatuhan prosedur keselamatan dan ketiadaan kesalahan kritis.	15	Checklist keselamatan; log error (jika ada)
CPMK-7	Portofolio edukasi–discharge plan–SBAR	Kelengkapan edukasi (teach-back), kualitas discharge plan, dan kelengkapan SBAR (skor rubrik/checklist).	15	Materi edukasi; discharge plan; SBAR

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep profesionalisme (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Akurasi respons pada skenario perilaku profesional	Respons keliru/berisiko	Respons cukup; alasan lemah	Respons tepat; alasan logis	Respons sangat tepat; alasan kuat & konsisten standar

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan problem list & prioritas	Prioritas tidak sesuai; banyak masalah kunci terlewat	Prioritas cukup; masih ada ketidaktepatan bermakna	Prioritas tepat; masalah kunci tercakup	Prioritas sangat tepat; masalah kunci lengkap & terurut
2.2 Konsistensi alasan berbasis risiko/bukti dasar	Tanpa alasan; tidak berbasis risiko	Alasan umum; risiko belum jelas	Alasan logis; risiko jelas	Alasan sangat kuat; mengaitkan risiko, bukti dasar, dan keselamatan

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Ketepatan diagnosis/prioritas	Tidak sesuai data; prioritas keliru	Sebagian sesuai; prioritas kurang konsisten	Sesuai data; prioritas jelas	Sangat sesuai; prioritas sangat logis & tervalidasi
3.2 Kualitas tujuan SMART & evaluasi terukur	Tujuan tidak SMART; evaluasi tidak jelas	Sebagian SMART; evaluasi terbatas	SMART; evaluasi jelas	SMART sangat kuat; evaluasi komprehensif dan operasional

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan langkah keterampilan dasar (checklist)	≤60% langkah benar; ada kesalahan kritis	61–75% benar; kekurangan bermakna	76–90% benar; kesalahan minor	>90% benar; aman tanpa kesalahan bermakna
4.2 Ketepatan evaluasi respons pasien	Tidak mengevaluasi/keliru	Mengevaluasi terbatas; indikator kurang tepat	Evaluasi jelas; indikator tepat	Evaluasi sangat jelas; indikator tepat & tindak lanjut cepat

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kinerja komunikasi terapeutik (checklist)	≤60% perilaku tercapai; hubungan tidak terbina	61–75% tercapai; hubungan terbina sebagian	76–90% tercapai; hubungan efektif	>90% tercapai; empatik, adaptif, profesional

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.2 Batas profesional & respons terhadap hambatan komunikasi	Tidak menjaga batas; respons tidak tepat	Batas sebagian; respons kurang konsisten	Batas jelas; respons tepat	Batas sangat jelas; respons sangat efektif & aman

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Kepatuhan PPI & kewaspadaan standar	Banyak langkah terlewat; risiko tinggi	Langkah inti ada; kurang konsisten	Langkah tepat; konsisten	Langkah sangat tepat; konsisten tanpa pelanggaran
6.2 Kepatuhan keselamatan jatuh & 6 benar medikasi	Sering melanggar; ada kesalahan kritis	Cukup patuh; masih ada kekurangan	Patuh; tanpa kesalahan kritis	Sangat patuh; antisipatif risiko dan terdokumentasi

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan edukasi–discharge plan (teach-back)	Tidak terstruktur; pemahaman tidak terbukti	Terstruktur sebagian; bukti pemahaman terbatas	Terstruktur; bukti pemahaman memadai	Sangat terstruktur; bukti pemahaman kuat & terdokumentasi
7.2 Kelengkapan SBAR & dokumentasi terintegrasi	Informasi kritis hilang; tidak dapat diaudit	Informasi inti ada; masih kurang spesifik	Lengkap; runtut; dapat ditindaklanjuti	Sangat lengkap; ringkas; risiko terantisipasi; sangat dapat diaudit

Pendahuluan

LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang mendasar, dan penyediaan layanan Kesehatan yang aman adalah prioritas utama setiap institusi medis. Namun, dalam proses pemberian asuhan, terdapat risiko yang tidak dapat di elakan yaitu *healthcare-Associated Infections* (HAIs) atau infeksi yang dapat di fasilitasi pelayanan Kesehatan. HAIs telah menjadi masalah Kesehatan masyarakat yang serius secara global, karena berdampak pada peningkatan angka morbiditas (kesakitan), mortalitas (kematian), serta pembengkakan biaya perawatan bagi pasien dan rumah sakit.

Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga keselamatan pasien, petugas Kesehatan, serta pengunjung di fasilitas

Kesehatan. PPI bukan sekedar rutinitas administrative, melainkan sebuah komitmen klinis yang melibatkan integrasi antara pengetahuan medis, kepatuhan, perilaku dan manajemen fasilitas yang tepat.

Salah satu komponen yang paling fundamental dalam strategi PPI adalah penerapan kewaspadaan standar (*Standard Precautions*). Kewaspadaan ini didasarkan pada prinsip bahwa semua darah, cairan tubuh, secret, ekskret (kecuali keringat), kulit yang tidak utuh, dan selaput lender, dapat mengandung agen infeksius yang dapat ditularkan. Oleh karena itu, standar ini harus diterapkan secara konsisten kepada seluruh pasien, tanpa memandang diagnose penyakitnya atau status infeksi.

Rumusan Masalah

Tantangan utama saat ini adalah masih terdapat kesenjangan antara kebijakan PPI yang tertulis dengan implementasi nyata di lapangan. Kurangnya pemahaman mendalam mengenai Teknik dekontaminasi yang benar, ketidak konsistenan dalam kebersihan tangan (*hand hygiene*), serta penggunaan alat pelindung diri (APD) yang tidak tepat menjadi celah terjadinya transmisi kuman. Karena itu, diperlukan sebuah panduan komprehensif yang mampu menjembatani teori dan praktik dalam ranah PPI dan kewaspadaan standar

Tujuan Penulisan

Buku ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman mendasar mengenai konsep dan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) di fasilitas Kesehatan
2. Menjabarkan rincian komponen kewaspadaan standar secara mendalam agar dapat di aplikasikan dengan benar oleh petugas Kesehatan
3. Menjadi referensi utama dalam meningkatkan budaya keselamatan pasien melalui pengendalian risiko infeksi yang terukur

Manfaat

Buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- Praktisi keperawatan dan tenaga medis : sebagai pedoman teknis dalam melakukan Tindakan klinis yang aman.
- Mahasiswa Kesehatan: sebagai sumber Referensi akademik dalam memahami dasar-dasar keselamatan pasien.
- Manajemen rumah sakit: sebagai landasan dalam menyusun kebijakan operasional terkait Komite PPI dan mutu pelayanan

A. KEWASPADAAN BERDASARKAN TRANSMISI

1. Konsep Dasar kewaspadaan Berdasarkan Transmisi adalah lapis kedua dari Strategi pencegahan dan penendalian Infeksi (PPI). Berbeda dengan kewaspadaan Standar yang diterapkan pada seluruh pasien, kewaspadaan ini di

terapkan pada seluruh pasien, kewaspadaan ini di terapkan secara khusus pada pasien yang di ketahui atau di curigai terinfeksi oleh pathogen yang sangat menular. Penerapan kewaspadaan ini harus selalu dilakukan bersamaan dengan kewaspadaan Standar. Terdapat tiga jenis Kewaspadaan berdasarkan jalur penularan: Kontak, Droplet, dan Udara (*Airborne*)

2. Kewaspadaan Transmisi Kontak

Diterapkan untuk mencegah penularan infeksi melalui kontak langsung (sentuhan Fisik) atau kontak tidak langsung (melalui benda/permukaan yang terkontaminasi)

- Indikasi penyakit: Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA), *Clostridioides difficile*, scabies, Norovirus, dan luka terbuka dengan Drainase yang luas
- Komponen Utama:
 - 1) Penempatan pasien : kamar tersendiri atau kohorting (mengelompokkan pasien dengan diagnose yang sama)
 - 2) Alat pelindung diri (APD): gunakan sarung tangan dan gaun bersih (non - steril) setiap kali masuk ke kamar pasien. lepaskan APD sebelum keluar dari area perawatan.
 - 3) Peralatan Medis: gunakan peralatan khusus untuk satu pasien (Misalnya :stetoskop, dan tensimeter tunggal). jika harus di gunakan Bersama, lakukan dekontaminasi/desinfeksi sebelum di gunakan ke pasien lain.
 - 4) Kebersihan lingkungan: Focus pada permukaan yang sering di sentuh (*high-touch surfaces*) seperti pagar tempat tidur dan meja samping.

3. kewaspadaan Transmisi Percikan (*Droplet*)

Diterapkan untuk mencegah penularan melalui percikan saluran pernapasan berukuran besar (>5 mikron) yang dihasilkan saat pasien batuk, bersin, atau berbicara. percikan ini biasanya tidak melayang jauh (kurang dari 1-2 meter).

- Indikasi penyakit : influenza, pertusis, Mumps (gondongan) Rubella, dan Meningitis meningokokus.
- Komponen Utama:
 - 1) Penempatan pasien : kamar tersendiri atau jarak minimal antar tempat tidur sejauh 1 meter. pintu kamar boleh tetap terbuka.
 - 2) APD: gunakan masker bedah/masker medis saat berada dalam jarak 1 meter dari pasien atau saat masuk kedalam kamar.
 - 3) Transportasi pasien: batasi pergerakan pasien. jika pasien harus keluar kamar. pasien wajib menggunakan masker Bedah.
 - 4) Etika Batuk : Edukasi pasien untuk menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin

4. Kewaspadaan Transmisi Udara (*Airborne*)

Diterapkan untuk mencegah penularan melalui partikel kecil(<mikron) yang mengandung mikroba dan dapat melayang di udara dalam waktu lama serta berpindah jarak jauh mengikuti arus udara.

- Indikasi Penyakit: Tuberkulosis (TB) paru, Campak (*Measles*), cacar Air (Varicella), dan prosedur medis yang menghasilkan aerosol (seperti nebulisasi atau intubasi)
- Komponen Utama:
 - 1) Penempatan pasien: kamar isolasi tekanan negative atau area dengan pertukaran udara minimal 12 kali per jam. pintu kamar harus selalu di tutup.
 - 2) APD: petugas wajib menggunakan Respirator (N95 atau setara) yang telah melalui *fit test*. respirator di pakai sebelum masuk kamar dan dilepaskan setelah keluar dari kamar (setelah pintu tertutup)
 - 3) Imunisasi: petugas yang merawat pasien Campak atau Cacar Air idealnya memiliki imunitas yang sudah terbukti.
 - 4) Transportasi Pasien: sangat di batasi. pasien harus mengenakan masker bedah (bukan N95) saat berpindah untuk menangkap partikel dari sumbernya

5. Ringkasan Perbedaan

Tabel 7. 1 Perbandingan

Jenis Transmisi	Jalur Utama	Jenis Masker	Penempatan Kamar
Kontak	Sentuhan	Sesuai Standar	Kamar Sendiri/ Kohorting
Droplet	Percikan Besar	Masker Bedah	Jarak > 1 meter
Udara (<i>Airborne</i>)	Inti Droplet Kecil	Respirator N95	Tekanan Negatif

6. capaian pembelajaran

Keberhasilan PPI sangat bergantung pada ketepatan petugas dalam mengidentifikasi jalur transmisi kuman. kesalahan dalam menentukan jenis kewaspadaan dapat mengakibatkan terjadinya wabah (*outbreak*) di fasilitas Kesehatan. oleh karena itu, pengkajian gejala saluran napas dan Riwayat infeksi pada setiap pasien baru menjadi Langkah krusial.

7. Kesimpulan Bab

Keberhasilan PPI sangat bergantung pada ketepatan petugas dalam mengidentifikasi jalur transmisi kuman. Kesalahan dalam menentukan jenis kewaspadaan dapat mengakibatkan terjadinya wabah (*outbreak*) di fasilitas

kesehatan. Oleh karena itu, pengkajian gejala saluran napas dan riwayat infeksi pada setiap pasien baru menjadi langkah krusial.

B. EPIDEMIOLOGI HAIs

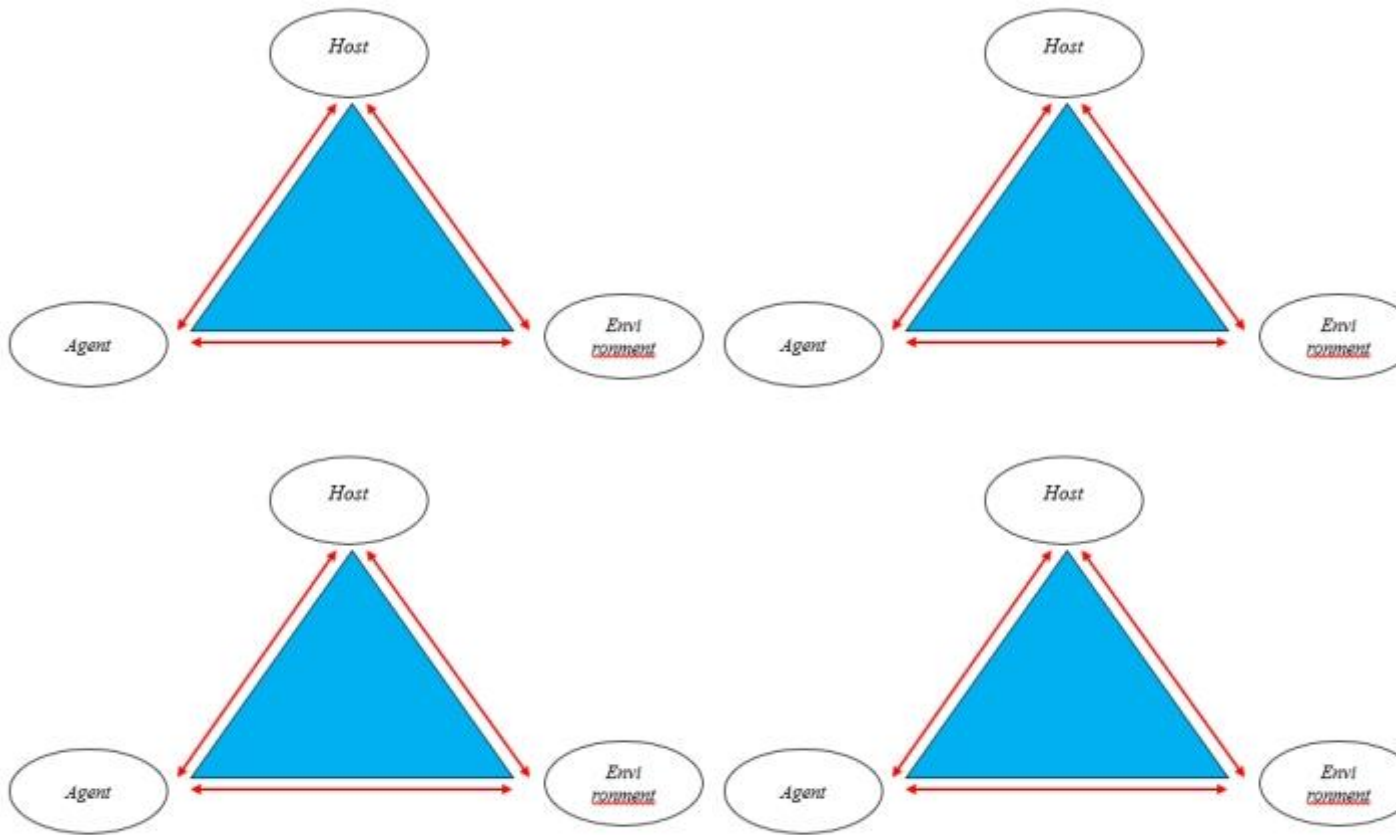
1. DEFENISI

- a. Pengertian *Epidemiologi* : *Epidemiologi* merupakan suatu disiplin ilmu yang berkembang seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat dan munculnya penyakit-penyakit baru serta disiplin ilmu baru yang berkaitan dengan epidemiologi.
- b. Pengertian HAIs : Saat ini penyebutan infeksi nosokomial diubah menjadi Infeksi Terkait Layanan Kesehatan atau "HAI's" (Healthcare Associated Infections) infeksi kepada pasien namun dapat juga kepada petugas kesehatan dan pengunjung yang tertular pada saat berada di dalam lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.
- c. Konsep Dasar HAIs : Berdasarkan sumber infeksi, maka infeksi dapat berasal dari masyarakat/komunitas (*Community Acquired Infection*) atau dari rumah sakit (*Healthcare-Associated Infections/HAIs*). Penyakit infeksi yang didapat di rumah sakit beberapa waktu yang lalu disebut sebagai Infeksi Nosokomial.

2. Faktor Epidemiologi Penyebab HAI's

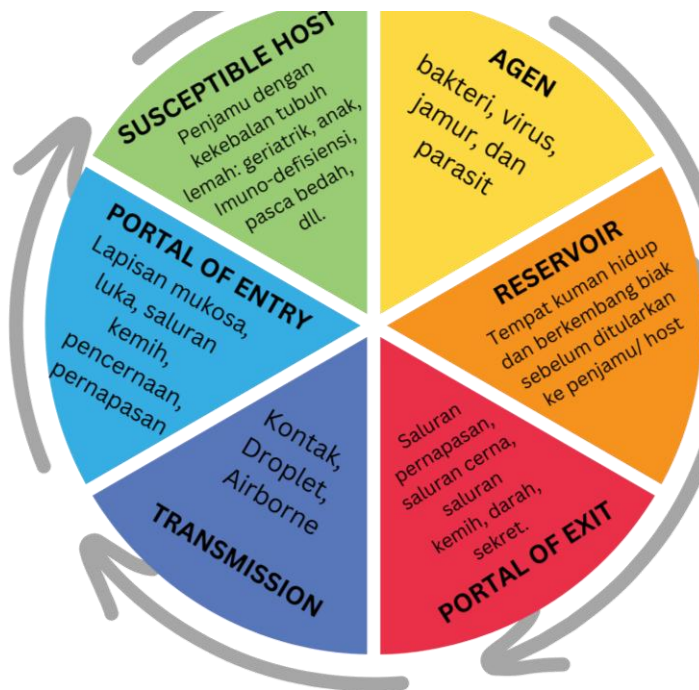
- a. Faktor Host : Orang dengan kekebalan tubuh menurun sehingga tidak mampu melawan agen infeksi. Faktor yang dapat mempengaruhi kekebalan adalah umur, status gizi, status imunisasi, penyakit kronis, luka bakar yang luas, trauma, pasca pembedahan dan pengobatan dengan immunosupresan.
- b. Faktor Agent: Mikroorganisme penyebab infeksi berupa bakteri, virus, jamur dan parasit.
- c. Faktor Lingkungan/*enviromental* : Lingkungan merupakan tempat/sumber agen infeksi dapat hidup, tumbuh, berkembang biak dan siap ditularkan kepada pejamu atau manusia.

RANTAI PENULARAN INFEKSI



Gambar 7. 1 faktor epidemiologi

RANTAI PENULARAN INFEKSI



Gambar 7. 2 penularan infeksi

3. Penemuan

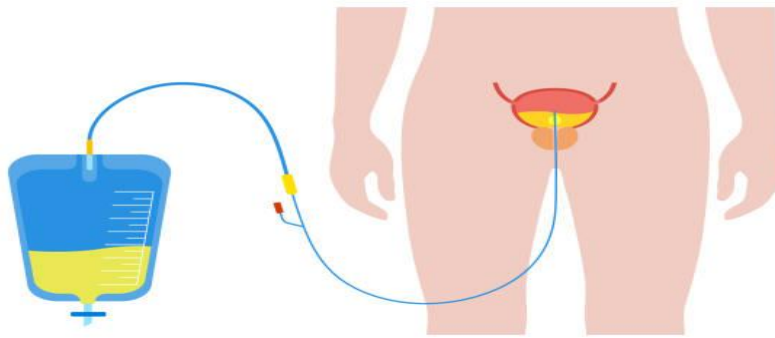
Healthcare Associated Infections (HAIs)

DEFINISI & FAKTOR RESIKO

Catheter-associated Urinary Tract Infection (CAUTI):

Terjadi pada pasien yang terpasang urine kateter >48 jam, diagnosis ISK akan sulit dilakukan pada pasien dengan pemasangan kateter jangka panjang. Oleh karena itu penegakan diagnosa infeksi dilakukan dengan melihat tanda klinis pasien sebagai acuan Faktor risiko tersebut antara lain:

- a. Lama pemasangan kateter > 6 – 30 hari berisiko terjadi infeksi
- b. Jenis kelamin/ *Gender*: Wanita
- c. Kondisi penyerta: diabetes, malnutrisi, *renal insufficiency*
- d. Pemantauan *urine output*
- e. Posisi *drainage* kateter lebih rendah dari kantong urin
- f. Kontaminasi selama pemasangan kateter urin
- g. Inkontinensia fekal (kontaminasi *E.coli* wanita)
- h. Rusaknya sirkuit kateter urin



Gambar 7. 3 pemasangan kateter

4. Central Line-associated Bloodstream Infection (CLABSI)

Infeksi Aliran Darah (Blood Stream Infection/BSI) merupakan infeksi aliran darah primer, dimana tidak ditemukan sumber infeksi lainnya dan terjadi setelah 48 jam pemasangan kateter sentral perlu diingat bahwa kultur pada ujung kateter atau darah perifer bukan merupakan kriteria CLABSI.

5. Ventilator-Associated Pneumonia (VAP)

Ventilator Associated Pneumonia (VAP) merupakan infeksi pneumonia yang terjadi setelah 48 jam pemakaian ventilasi mekanik baik pipa endotracheal maupun trakeostomi.

6. Surgical Site Infection (SSI)

SSI merupakan infeksi yang terjadi di dekat atau di lokasi sayatan dan atau ruangan jaringan dan organ yang lebih dalam di bawahnya dalam waktu 30 hari setelah prosedur pembedahan (atau hingga 90 hari untuk prostetik implan)

7. CAUTI / ISK

Gejala Klinis dan Hasil Pemeriksaan Penunjang *Catheter-associated Urinary Tract Infection* (CAUTI)

- a. Demam ($> 38^{\circ}\text{C}$)
- b. Urgensi
- c. Frekuensi meningkat
- d. Disuria, atau Nyeri supra pubik

Tanda dan gejala ISK anak <1 tahun:

- a. Demam $> (> 38^{\circ}\text{C})$
- b. Hipotermi ($<27^{\circ}\text{C}$) / rektal
- c. Apnea
- d. Bradikardia
- e. Letargia
- f. Muntah

Pemeriksaan Diagnostik:

hasil biakan kuman dengan jumlah $>10^5$ cfu/ml dengan 1 atau 2 jenis mikroorganisme

8. CLABSI / IADP

Gejala Klinis dan Hasil Penunjang Central Line-associated Bloodstream Infection (CLABSI)

- a. Ditemukan pathogen dari biakan spesimen darah dari kateter intravaskuler dan dari darah perifer tidak berkaitan dengan infeksi ditempat lain
- b. Demam $>38^{\circ}\text{C}$
- c. Menggigil
- d. Hipotensi tanpa penyebab lain

Dugaan IAD pada anak <1 tahun:

- a. Demam $>38^{\circ}\text{C}$ /rektal
- b. Hipotermi $<37^{\circ}\text{C}$ /rektal
- c. Tidak ditemukan sumber infeksi selain pemasangan kateter vaskular
- d. Terdapat bakteri pathogen dalam biakan kuman

9. VAP

Gejala Klinis dan Hasil Penunjang *Ventilator Associated Infections* (VAP)

- a. Demam $>38^{\circ}\text{C}$ tanpa ditemui penyebab lainnya
- b. Leukopenia (<4.000 WBC/mm³) atau leukositosis (>12.000 SDP/mm³)
- c. Timbulnya onset baru sputum purulen atau perubahan sifat sputum
- d. Peningkatan fraksi inspirasi oksigen $>0,2$ dari FiO₂ sebelumnya
- e. Peningkatan PEEP setiap hari sebesar $> 3\text{cmH}_2\text{O}$ dari PEEP sebelumnya selama 2 hari berturut-turut

10. SSI / IDO

Gejala Klinis dan Hasil Penunjang *Surgical Site Infections* (SSI)

Infeksi Daerah Operasi Superfisial:

- a. Pus keluar dari luka operasi atau drain yang dipasang diatas fascia.
- b. Biakan positif dari cairan yang keluar dari luka atau jaringan yang diambil secara aseptik.
- c. Terdapat tanda-tanda peradangan seperti : nyeri, bengkak local, kemerahan dan hangat local kecuali jika hasil biakan negative.
- d. Dokter yang menangani menyatakan terjadinya infeksi.

Gejala Klinis dan Hasil Penunjang *Surgical Site Infections* (SSI)

Infeksi Daerah Operasi Profunda/Deep Incision:

- a. Pus keluar dari luka insisi dalam tetapi bukan berasal dari komponen organ/rongga dari daerah pembedahan.

- b. Insisi dalam secara spontan mengalami dehiscens atau dengan sengaja dibuka oleh ahli bedah bila pasien mempunyai paling sedikit dari tanda-tanda atau gejala berikut : demam $>38^{\circ}\text{C}$ atau nyeri lokal, terkecuali biakan insisi negative.
- c. Ditemukan abses atau bukti lain adanya infeksi yang mengenai insisi dalam pada pemeriksaan langsung, waktu pembedahan ulang atau dengan pemeriksaan histopatologis atau radiologis.
- d. Dokter yang menangani menyatakan terjadi infeksi.

Gejala Klinis dan Hasil Penunjang *Surgical Site Infections* (SSI)

Infeksi Daerah Operasi Organ/Rongga

- a. Infeksi tidak mengenai bagian tubuh manapun, kecuali insisi kulit, fascia atau lapisan otot yang dibuka atau dimanipulasi selama prosedur pembedahan.
- b. Paling sedikit pasien menunjukkan gejala:
 - Drainase purulen dari drain yang dipasang melalui luka tusuk ke dalam organ/rongga.
 - Kuman dari biakan yang diambil secara aseptik dari cairan atau jaringan dari dalam organ atau rongga.
 - Abses atau bukti lain adanya infeksi yang mengenai organ/rongga yang ditemukan pada pemeriksaan langsung waktu pembedahan ulang atau dengan pemeriksaan histopatologis atau radiologis.
 - Dokter menyatakan sebagai infeksi daerah operasi organ/rongga

C. KEWASPADAAN STANDAR

INDIKATOR HASIL BELAJAR

Setelah mengikuti peserta mampu memahami dan menerapkan 11 kewaspadaan standar

SUB POKOK MATERI

1. Kebersihan Tangan
2. Penggunaan APD
3. Pengendalian Lingkungan
4. Pengelolaan Limbah & benda tajam
5. Pengelolaan Peralatan Perawatan pasien dan alat Medis lainnya
6. Pengelolaan Linen
7. Penyuntikan yang aman
8. Kebersihan Pernafasan atau Etika batuk
9. Praktek Lumbal Fungsi
10. Penempatan Pasien
11. Perlindungan Kesehatan

1. kebersihan tangan
KEBERSIHAN TANGAN



Gambar 7. 4 langkah cuci tangan

2. KEPATUHAN PENGGUNAAN APD

PEMASANGAN APD

- | | | | | | |
|----------|---|---|-----------|---|---------------------------------|
| 1 |  | Gunakan seragam/baju scrub | 7 |  | Pakailah penutup kepala |
| 2 |  | Siapkan semua APD sesuai ukuran yang dibutuhkan | 8 |  | Pakailah masker |
| 3 |  | Lepaskan semua aksesoris yang dipakai | 9 |  | Pakailah faceshield atau google |
| 4 |  | Lakukan kebersihan tangan | 10 |  | Pakai apron (jika dibutuhkan) |
| 5 |  | Pakailah pelindung kaki | 11 |  | Lakukan kebersihan tangan |
| 6 |  | Pakailah gown atau cover all | 12 |  | Pakailah sepasang sarung tangan |

Gambar 7. 5 kepatuhan penggunaan APD

PELEPASAN APD



Gambar 7. 6 pelepasan APD

- APD adalah peralatan yang di pakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisik, kimia, biologi/bahan infeksius.
 - Tujuan: melindungi kulit dan membran mukosa dari resiko pajanan darah, cairan tubuh, sekret, ekskreta, kulit yang tidak utuh dan selaput lendir dari pasien ke petugas dan sebaliknya.
 - Indikasi: jika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah/cairan tubuh atau kemungkinan pasien terkontaminasi dari petugas.
 - Melepas APD segera dilakukan jika tindakan sudah selesai di lakukan.
 - Tidak dibenarkan menggantung masker di leher, memakai sarung tangan sambil menulis dan menyentuh permukaan lingkungan.
3. PENGENDALIAN LINGKUNGAN

Bertujuan untuk menciptakan lingkungan RS yang bersih dan aman, dan mencegah terjadinya transmisi mikroorganisme dari lingkungan kepada pasien, petugas, dan pengunjung

- Semua ruangan harus dibersihkan sesuai standar RS dan prosedur.
- Pembersihan dilakukan dengan prinsip bersih ke kotor, dan atas ke bawah.
- Untuk area risiko tinggi dibersihkan lebih sering, dengan cairan disinfektan yang lebih pekat

- d. Semua permukaan ditempat pelayanan pasien harus dibersihkan minimal 2x per hari dan bila terlihat kotor. Pembersihan juga harus dilakukan bila pasien sudah keluar.
 - e. Semua kain lap dan mop yang digunakan harus dalam keadaan bersih, dan dilakukan pembersihan setiap selesai dipakai.
 - f. Larutan detergen dan disinfektan, kain lap, dan mop harus diganti per 3 kamar atau jika tampak kotor.
 - g. Meja tindakan dan peralatan medis yang digunakan untuk pasien harus dibersihkan setiap selesai habis digunakan oleh perawat dengan tisu disinfektan.
 - h. *General Cleaning* dilakukan pada kasus infeksius, dan sesuai jadwal setiap unit. GC termasuk juga pembersihan AC dan penggantian gorden.
4. PENGELOLAAN LIMBAH & BENDA TAJAM

Tabel 7. 2 pengelolaan limbah

No	Kategori	Warna kontainer/ kantong plastik	Lambang	Keterangan
1	Radioaktif	Merah		- Kantong boks timbal dengan simbol radioaktif
2	Sangat Infeksius	Kuning		- Katong plastik kuat, anti bocor, atau kontainer yang dapat disterilisasi dengan otoklaf
3	Limbah infeksius, patologi dan anatomi	Kuning		- Plastik kuat dan anti bocor atau kontainer
4	Sitotoksis	Ungu		- Kontainer plastik kuat dan anti bocor
5	Limbah kimia dan farmasi	Coklat	-	- Kantong plastik atau kontainer

5. PENYUNTIKAN YANG AMAN

- a. Untuk melakukan penyuntikan menggunakan spuit dan jarum suntik steril sekali pakai untuk setiap suntikan.
- b. Menggunakan close system untuk mencegah kontaminasi.
- c. Penggunaan vial multidose diusahakan digunakan sekali pakai untuk mencegah timbulnya kontaminasi mikroba saat obat dipakai pasien lain.

1) PRAKTEK LUMBAL PUNGSI AMAN

1. Petugas yang akan melakukan praktik lumbal pungsi, anastesi spinal/epidural/pasang kateter vena sentral yang aman harus menggunakan masker bedah, gaun bersih, sarung tangan steril.
2. Penggunaan masker bedah pada petugas dibutuhkan agar tidak terjadi droplet flora orofaring yang dapat menimbulkan meningitis bacterial.

2) PENEMPATAN PASIEN

Harus sesuai dengan transmisi

PERLINDUNGAN KESEHATAN PETUGAS

- **Alur terkena pajanan**



- **Vaksinasi dan MCU**

Berdasarkan kebijakan dari rumah sakit, dikoordinasikan dengan Human Capital (HC).

D. KEWASPADAAN TRANSMISI

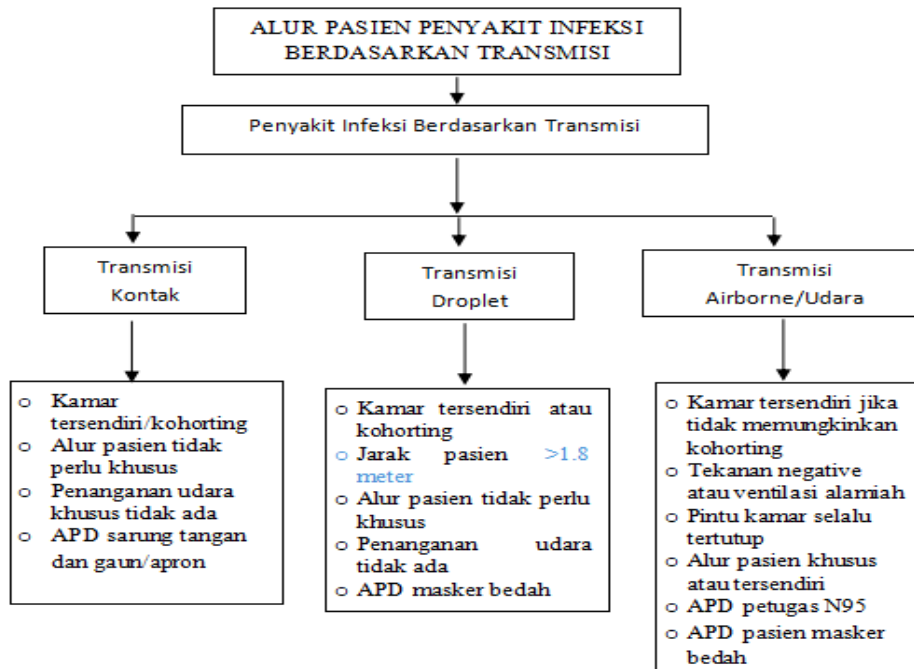
INDIKATOR HASIL BELAJAR

Mata pelatihan ini membahas tentang kewaspadaan transmisi melalui *airborne* (udara), *droplet* (percikan), dan *contact* (kontak)

SUB POKOK MATERI

1. Kewaspadaan Transmisi Melalui Kontak
2. Kewaspadaan Transmisi Melalui Droplet
3. Kewaspadaan Transmisi Melalui Airborne

ALUR BERDASARKAN TRANSMISI



Gambar 7. 7 alur transmisi



Gambar 7. 8 Poster transmisi /precaution di atas ini wajib di pasang depan pintu kamar isolasi/ kamar berisi pasien dengan transmisi.

E. PENGENDALIAN LINGKUNGAN

Bertujuan untuk menciptakan lingkungan RS yang bersih dan aman, dan mencegah terjadinya transmisi mikroorganisme dari lingkungan kepada pasien, petugas, dan pengunjung

1. Semua ruangan harus dibersihkan sesuai standar RS dan prosedur.
2. Pembersihan dilakukan dengan prinsip bersih ke kotor, dan atas ke bawah.
3. Untuk area risiko tinggi dibersihkan lebih sering, dengan cairan disinfektan yang lebih pekat
4. Semua permukaan ditempat pelayanan pasien harus dibersihkan minimal 2x per hari dan bila terlihat kotor. Pembersihan juga harus dilakukan bila pasien sudah keluar.
5. Semua kain lap dan mop yang digunakan harus dalam keadaan bersih, dan dilakukan pembersihan setiap selesai dipakai.
6. Larutan detergen dan disinfektan, kain lap, dan mop harus diganti per 3 kamar atau jika tampak kotor.
7. Meja tindakan dan peralatan medis yang digunakan untuk pasien harus dibersihkan setiap selesai habis digunakan oleh perawat dengan tisu disinfektan.
8. *General Cleaning* dilakukan pada kasus infeksius, dan sesuai jadwal setiap unit. GC termasuk juga pembersihan AC dan penggantian gorden.

F. PENGGUNAAN ANTI MIKROBA RASIONAL PROFILAKSIS DAN TERAUPETIK

INDIKATOR HASIL BELAJAR :

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu memahami dan menerapkan Penggunaan Antimikroba Rasional (Profilkasis dan Teraupetik)

SUB POKOK MATERI

Pemberian antibiotik profilaksis dan empirik yang tepat

1. ANTIBIOTIK PROFILAKSIS (PEMBEDAHAN)

- a. Antibiotik profilaksis diberikan **30-60 menit** sebelum insisi sehingga saat insisi sudah terdapat antibiotik dalam kadar yang efektif di jaringan target operasi.
- b. Antibiotik profilaksis diberikan dalam dosis tunggal. Dosis ulangan diberikan pada operasi yang berlangsung lebih dari 3 jam, kemudian dosis ulangan diberikan 3 jam setelah dosis pertama.
- c. Antibiotik dilarutkan dalam NaCl 0,9% 100 mL, diberikan secara intravena drip selama 15 menit

2. ANTIBIOTIK EMPIRIK

Terapi antibiotik empirik yaitu penggunaan antibiotik pada kasus infeksi atau diduga infeksi yang belum diketahui jenis bakteri penyebabnya. Terapi antibiotik empirik ini dapat diberikan selama 3-5 hari. Antibiotik lanjutan diberikan berdasarkan data hasil pemeriksaan laboratorium dan mikrobiologi.

Sebelum pemberian terapi empirik dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan mikrobiologi. Jenis antibiotik empirik ditetapkan berdasarkan pola mikroba dan kepekaan antibiotik setempat.

3. Surveillance HAIs

INDIKATOR HASIL BELAJAR

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu memahami dan menerapkan *surveillance* HAIs.

SUB POKOK MATERI

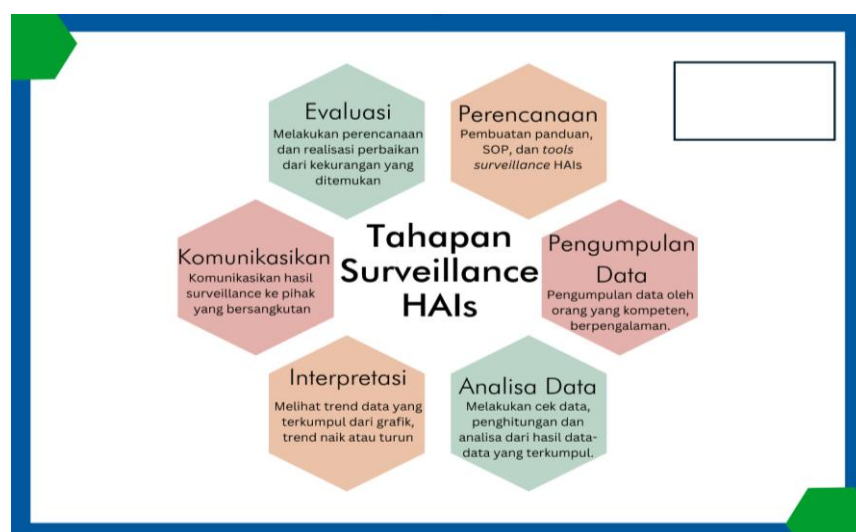
1. Konsep Dasar *Surveillance* HAIs
2. Tahapan *Surveillance* HAIs

a. Pengertian *Surveillance*

Surveilans kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.

b. Surveilans Target (*Targetted Surveillance*)

Metode surveilans ini berfokus pada ruangan atau pasien dengan risiko infeksi spesifik seperti ruang perawatan intensif, ruang perawatan bayi baru lahir, ruang perawatan transplan, ruang perawatan pasien hemodialisa atau pasien dengan risiko: ISK (CAUTI), *Surgical Site Infection* (SSI)/IDO, Blood Stream Infection (BSI)/IAD, Pneumonia (VAP).



Gambar 7. 9 tahapan surveillance

G. Bundle Care HAIs

INDIKATOR HASIL BELAJAR

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu memahami dan menerapkan *bundle care* HAIs

SUB POKOK MATERI

1. Konsep Dasar *bundle care* HAIs
2. Tahapan *bundle care* HAIs

Pengertian *Bundle Care* HAIs

Bundles adalah sekumpulan praktik berbasis bukti sah yang menghasilkan perbaikan keluaran proses pelayanan kesehatan bila dilakukan secara kolektif dan konsisten.

Tujuan *Bundle Care* HAIs

Bundle care HAIs digunakan sebagai acuan melakukan pencegahan dan pengendalian terjadinya HAIs.

Jenis *Bundle Care* HAIs

1. Ventilator Associated Pneumoniae (VAP)
2. Infeksi Aliran Darah (IAD)/ CLABSI
3. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Saluran Kemih (ISK) / CAUTI
4. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Daerah Operasi (IDO) / SSI

[illegible]

Gambar 7. 10 bundle care CAUTI

(Kapsala Unit)

Gambar 7. 11 bundle care VAP

[illegible]

Gambar 7. 12 bundle care CLABSI

Surveillance Bundle Care SSI

contoh

**SURVEILLANCE BUNDLE CARE
PASIENT OPERASI DENGAN LUKA INSISI**

Tempelkan Stiker Nama Pasien Disini

RIwayat	Tanggal MRS (dd/tg/bh/thn)	Suhu Pasien □ 2. 38C □ 4. 38C	Albumin g/dl	Gula Darah □ 2. 200 □ 3. 200	Steroid jangka Panjang □ Ya □ Tidak	Penyakit Infeksi □ Infeksi Kulit □ Infeksi Mata □ Infeksi Mulut/GIP □ Infeksi Paru □ Infeksi THT □ Infeksi GI Tract
	Merokok □ Ya □ Tidak	Penyakit Saat Ini □ DM □ GIGK □ Septik □ Hipertensi □ Alergi □				
	Screening MRSA □ Ya Hasil (+) / (-) □ Tidak	Pencukuran □ Clipper □ Silet □ N/A	Waktu Pencukuran Pukul : / :	Mandi Sebelum Operasi □ Chlorhexidine bodywash □ Sabun lain □ N/A	Profilaksis □ Ya, Nama Obat : □ Tidak	
	Tanggal Operasi / /	Lama Operasi jam/menit : /	Operasi Karena Trauma □ Ya □ Tidak	Prosedur Operasi :	Multi prosedur dgn insisi yg sama □ Ya □ Tidak	
Data Operasi	Jenis Operasi □ Elektif □ CTO	Ruang Operasi □ 3 □ 5 □ 8 □ 2 □ 6 □ 7	Diagnosa :	ASA Score □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5		
	Berat & Tinggi Badan kg / cm	Kualifikasi Dokter Bedah □ Spesialis □ Associate Specialist □ Konsultan □	Kualifikasi Luka □ Bersih □ Bersih Terkontaminasi □ Terkontaminasi □ Kontam	Dokter Operator : Asisten I : Perawat Instrumen : Perawat Sirkuler :		
	Sirkulasi Udara OT □ N/A	Kebersihan Ruang OT □ Ya □ Tidak	Temporing Drain □ Ya, Jenis : □ Tidak	Antibiotik Tambahan □ Ya, Nama Obat : □ Tidak	Indikator Kuli □ Chlorhexidine □ Povidone iodine □ Alkohol 70%	
	Tekanan Udara □ 12 □ 13	Suhu Ruangan °C	Angkat □ Ya, Jenis : □ Tidak □ Dilakukan Sterilisasi di CSSD □ Ya □ Tidak	Jumlah Staff di Ruang OT : □ staff	Indikator Instrumen / Alet Steril □ Internal □ Tidak ada □ Eksternal	

FRM/MHS/PCV/024-00

Gambar 7. 13 bundle care SSI

H. AUDIT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI PPI

INDIKATOR HASI BELAJAR :

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu melakukan pemantauan dengan audit PPI.

SUB POKOK MATERI

1. Konsep pemantauan dan audit PPI
2. Cara melakukan pemantauan dengan audit PPI

Pengertian Pemantauan dan Audit

Monitoring merupakan suatu kegiatan tetap pada jalurnya sesuai pedoman dan perencanaan program dalam rangka pengendalian suatu program.

Tujuan Pemantauan dan Audit

Monitoring dan audit memiliki tujuan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kepatuhan penerapan oleh petugas serta evaluasi angka kejadian HAI's melalui pengkajian risiko infeksi, audit, dan monitoring dan evaluasi lainnya secara berkala.

Prinsip Pemantauan dan Audit

Ruang lingkup audit PPI

1. Audit dilakukan secara periodik selama periode sibuk
2. Mengamati perilaku petugas kesehatan selama tindakan
3. Observasi dilakukan selama 15 – 30 menit

LIST AUDIT PPI

1. Airborne precaution
2. Audit bundle IDO pre OP
3. Audit bundle IDO intra Op
4. Audit Bundle IDO post OP
5. Audit bundle IADP
6. Audit bundle CAUTI
7. Audit CSSD
8. Audit endoscopy decontamination
9. Audit screening pasien masuk
10. Audit lingkungan
11. Audit HD
12. Audit kebersihan tangan (dilakukan oleh IPCLN)
13. Audit unit gizi
14. Audit linen
15. Audit management pembuangan sisa darah dan jaringan tubuh
16. Audit mortuary
17. Audit OT
18. Audit penempatan pasien
19. Audit APD (dilakukan oleh IPCLN)
20. Audit bundle VAP
21. Audit limbah dan benda tajam

I. PENEMPATAN PASIEN

INDIKATOR HASIL BELAJAR :

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menerapkan penempatan pasien sesuai dengan resiko penularan

SUB POKOK MATERI:

Tatalaksana penempatan pasien

Penempatan Pasien

1. Tempatkan pasien infeksius terpisah dengan pasien non infeksius.
2. Penempatan pasien disesuaikan dengan pola transmisi infeksi penyakit pasien (kontak, droplet, airborne) dirawat diruang tersendiri atau isolasi.
3. Pasien dengan penularan penyakit melalui droplet tempatkan diruangan sendiri atau ruangan yang memiliki exhaust fan.
4. Pasien dengan penularan penyakit melalui airborne tempatkan diruangan sendiri atau ruangan bertekanan negatif.
5. Bila tidak tersedia ruang tersendiri, maka pasien dapat dirawat bersama dengan pasien lain yang jenis infeksiya sama dengan menerapkan sistem kohorting.

Jarak antara tempat tidur minimal 1,8 meter. Untuk menentukan pasien yang dapat disatukan dalam satu ruangan, dikonsultasikan terlebih dahulu kepada KPPI,

6. Ruangan yang terkait dengan kohorting harus diberi tanda kewaspadaan berdasarkan jenis transmisinya (kontak, droplet, airborne).
7. Pasien yang tidak dapat menjaga kebersihan diri dan lingkungannya dipisahkan tersendiri.
8. Mobilisasi pasien infeksius yang jenis transmisinya melalui udara (airborne) agar dibatasi untuk menghindari terjadinya transmisi.
9. Transportasi pasien dengan penyakit menular (droplet /airborne) dilakukan pemisahan dengan area umum dan pasien menggunakan APD sesuai indikasi.
10. Pasien dengan immunocompromise ditempatkan diruangan bertekanan positif atau diruangan sendiri.
11. Pasien HIV tidak diperkenankan dirawat bersama dengan pasien TB dalam satu ruangan tetapi pasien TB-HIV dapat dirawat dengan sesama pasien TB.

Catatan:

Untuk perawatan pasien infeksius melalui udara di ruang isolasi, petugas perlu ditaati:

- Pasien dirawat di ruangan dengan tekanan negatif
 - Petugas menggunakan masker respirator
 - Pintu selalu tertutup
1. Penanggulangan

Kejadian Luar Biasa (KLB)

INDIKATOR HASIL BELAJAR:

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menerapkan PPI pada penyakit infeksi *emerging/re-emerging* dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB).

SUB POKOK MATERI:

- a. Konsep PPI pada Penyakit Infeksi Emerging Re-emerging dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - b. Manajemen KLB
 - c. Implementasi KLB
2. Penerapan PPI
Emerging & Re-emerging
Pada kasus emerging re-emerging maka penerapan PPI yang dilakukan antara lain:
 - a. Menjalankan langkah-langkah pencegahan standar di rumah sakit
 - b. Memastikan dilakukannya triase, identifikasi awal dan pengendalian sumber

- c. Menerapkan langkah-langkah pencegahan tambahan empiris
 - d. Menerapkan pengendalian administrative
 - e. Menggunakan pengendalian lingkungan dan rekayasa
 - f. Penerapan Hierarchy of controls (Kontrol Hirarki)
3. Implementasi
- Saat KLB/ Outbreak
- Pembentukan Tim Kesiapsiagaan (Tim SATGAS):
- a. Membuat struktur organisasi penanganan bencana di rumah sakit
 - b. Menetapkan uraian tugas untuk setiap personal dalam struktur organisasi
 - c. Pos penanganan bencana
 - 1) Pos komando
 - 2) Pos pengolahan data
 - d. Pos informasi
 - e. Pos logistik dan donasi
 - f. Pos penanganan jenazah
 - g. Pos relawan
 - h. Area dekontaminasi

4. PPI Pada Unit Gizi

(Penyelenggaraan Makanan)

INDIKATOR HASIL BELAJAR :

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu memahami & menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi di penyelenggaraan makanan

SUB POKOK MATERI:

- a. Konsep PPI Pada Penyelenggaraan Makanan
- b. Prinsip Penyehatan Makanan dalam Penyelenggaraan Makanan
- c. Monitoring dan Evaluasi PPI di Unit GiziC.Implementasi KLB

Konsep PPI Pada Penyelenggaraan Makanan

Konsep PPI dalam penyelenggaraan makanan yang meliputi konsep hygiene, kontaminasi pencemaran makanan dan sumber penyebaran penyakit lewat makanan.

- a. Hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan individu. Misalnya, mencuci tangan, mencuci piring, membuang bagian makanan yang rusak (Permenkes RI No. 1204, 2004).
- b. Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan. Misalnya menyediakan air bersih, menyediakan tempat sampah dan lainlain. (Permenkes RI No. 1204, 2004).

Kontaminasi Penyehatan Makanan dalam Penyelenggaraan Makanan

Kontaminasi atau pencemaran adalah masuknya zat asing ke dalam makanan yang tidak dikehendaki, yang dikelompokkan ke dalam empat macam yaitu pencemaran:

- a. Mikroba, seperti bakteri, jamur, cendawan
- b. Fisik, seperti rambut, debu, tanah dan kotoran lainnya
- c. Kimia, seperti pestisida, logam berat, zat penyedap rasa, zat pemberi aroma, zat pemanis, zat pengawet, zat pengatur keasaman, zat pewarna, zat pengental, zat pengemulsi (emulsifier), sekuestran, anti oksidan, penambah gizi dan vitamin, zat pemutih
- d. Radio aktif, seperti radiasi, sinar alfa, sinar gamma, cosmos, dsb. Terjadinya pencemaran dapat dibagi dalam 3 (tiga) cara:
 - 1) Pencemaran langsung (Direct Contamination) yaitu adanya bahan pencemar yang masuk ke dalam makanan secara langsung karena baik disengaja maupun tidak dengan sengaja. Contoh rambut masuk ke dalam nasi, penggunaan zat penyedap rasa, zat pemberi aroma, zat pemanis, zat pengawet, zat pemutih makanan.
 - 2) Pencemaran silang (Cross Contamination) yaitu pencemaran yang terjadi secara tidak langsung sebagai akibat ketidaktahuan dalam pengelolaan makanan. Contoh makanan mentah bercampur dengan makanan masak, makanan bercampur dengan pakaian atau peralatan kotor.
 - 3) Pencemaran ulang (Re-Contamination) yaitu terjadi pada makanan yang telah dimasak sempurna (nasi tercemar debu / lalat karena tidak dilindungi).

Prinsip Penyehatan Makanan

- 1) Kebersihan peralatan makan dan masak
 - 2) Pengelolaan bahan makanan
 - 3) *Hygiene* tenaga penjamah makanan & lingkungan
 - 4) Perilaku, kebiasaan dan sikap bekerja
5. Pemantauan & Evaluasi PPI
- 1) Kebersihan staff
 - 2) Penerimaan bahan makanan basah & kering
 - 3) Penyimpanan bahan makanan basah & kering
 - 4) Penyimpanan & pembuatan susu
 - 5) Preparasi Makanan (Proses memasak)
 - 6) Penyimpanan makanan matang
 - 7) Lemari pemanas, *freezer*, *chiller* & mesin lainnya
 - 8) Pembersihan dan sanitasi lingkungan dan peralatan dapur
 - 9) Pembuangan limbah yang tepat

10) *Pest control*

6. PPI di Unit CSSD

(Dekontaminasi dan Sterilisasi Instrumen)

INDIKATOR HASIL BELAJAR :

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu memahami & menerapkan PPI pada Pelayanan CSSD.

SUB POKOK MATERI:

- 1) Fungsi unit sterilisasi (CSSD) dalam mendukung PPI di rumah sakit
 - 2) Memahami cara melakukan pemantauan dan pengawasan PPI di CSSD
- a. Pengelolaan Peralatan Perawatan Pasien dan Alat Medis lainnya

Risiko	Definisi	Peralatan	Cara
Tinggi (Critical)	Kontak dengan jaringan steril, sistem peredaran darah (Vaskuler)		DISTERILKAN : Sterilisasi Autoklaf, ETO atau strilisasi temperatur rendah, chemical sterilans Disposable Dilakukan di CSSD
Sedang (Semi Critical)	Kontak dengan membran mukosa yang utuh, mudah terkontaminasi dengan mikroba.		Disinfeksi Tingkat Tinggi: pasteurisasi steam, disinfektan kimiawi Dilakukan di Endoscopy/CSSD
Rendah (Non-Critical)	Kontak dengan kulit yang utuh dan tidak mengenai membran mukosa, lingkungan secara tidak langsung.		pembersihan fisik / disinfeksi tingkat rendah (deterjen dan air), alcohol swab Lakukan setiap kali digunakan

Gambar 7. 14 pengelolaan peralatan

- 1) Alat instrumen di luar kamar operasi hanya dilakukan pembersihan dengan air mengalir atau dengan swab kasa basah kemudian dilakukan pencucian di unit CSSD.
 - 2) Untuk instrumen yang memiliki engsel harus dalam posisi terbuka saat dilakukan steril. Jika instrumen bisa pasang lepas (dapat dirakit) maka harus dilepaskan
 - 3) Instrumen yang tajam ujungnya harus di lapiasi
- b. Prinsip Pembersihan dan Penyimpanan Alat Steril di Unit
- 1) Pembersihan alat
 - 2) Penyimpanan alat steril dilemari tertutup, kering, tidak berdebu, kelembaban 40-60%, suhu 18°C-22°C, alat steril disimpan pada jarak 19 - 24 cm dari lantai dan minimum 43 cm dari langit-langit serta 5 cm dari dinding serta diupayakan untuk menghindari terjadinya penumpukan debu pada

kemasan serta alat steril tidak disimpan dekat wastafel atau saluran pipa lainnya.

c. Singel USE Re-Use

- 1) Setiap alat yang di reuse harus melalui proses setrilisasi.
- 2) Alat reuse yang akan digunakan wajib dinilai kelayakanya oleh operator dan juga perawat instrument.
- 3) Adanya dokumentasi untuk Re-Use ke berapa, serta penanda bahwa alat tersebut adalah reuse ke berapa.

7. PPI DI UNIT ENDOSKOPI

INDIKATOR HASIL BELAJAR :

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menerapkan PPI pada pelayanan Endoskopi

SUB POKOK MATERI:

1. Penerapan PPI dalam proses pelayanan Endoskopi.
2. Penerapan kewaspadaan isolasi di Endoskopi.

Kebersihan Lingkungan Unit Endoskopi

Pembersihan mengikuti standar pembersihan lingkungan, dilakukan pembersihan rutin untuk semua peralatan yang ada di ruang endoskopi, furniture, dinding, lantai, dll. Jika ada cairan tubuh makan menggunakan cairan disinfektan/ cairan *chlorin*.

Penerapan Kewaspadaan Isolasi

1. Kebersihan tangan
2. Penggunaan APD
3. Pengendalian lingkungan
4. Pengelolaan limbah & benda tajam
5. Pengelolaan peralatan perawatan pasien dan alat medis lainnya.

Penerapan Kewaspadaan Isolasi

Hal-hal yang menjadi perhatian dalam dekontaminasi & sterilisasi

1. Tes Kebocoran

- a) Letakan skop kedalam zink, lalu isi air bersih sampai skop terendam sempurna
- b) Hubungkan skop dengan alat tes kebocoran, lalu tekan tombol on dan lihat apakah ada kebocoran pada skop. Jika skop mengalami kebocoran akan keluar gelembung udara seperti air mendidih.
- c) Hentikan pencucian jika skop bocor, angkat skop dan laporkan kebagian teknisi.
- d) Jika skop tidak mengalami kebocoran, keluarkan udara dari dalam skop dengan melepaskan ujung alat tes lalu matikan alat. Lepaskan alat dari skop.

2. Pembersihan Manual

3. Inspeksi visual

Hal-hal yang menjadi perhatian dalam dekontaminasi & sterilisasi

4. Disinfeksi Tingkat Tinggi

5. Pengeringan Setelah DTT

6. Pelabelan

- a) Tandai endoskop dengan label yg berisi (No Scope, Tgl DTT, tanggal expired, Nama dan paraf staff)
- b) Tempelkan label identitas scope dibagian handle scope
- c) Scope yang tidak terpakai selama 7 hari dilakukan DTT ulang, dan label lama dipindahkan di buku dokumentasi khusus

PPI di Unit Mortuary

INDIKATOR HASIL BELAJAR :

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menerapkan PPI pada pelayanan kamar jenazah/ kamar transir jenazah.

SUB POKOK MATERI:

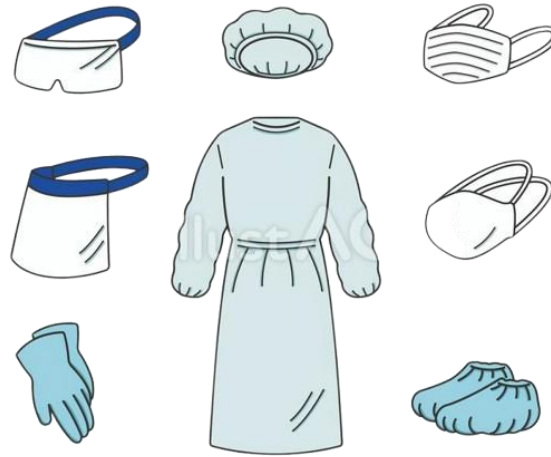
1. Pengertian dan prinsip PPI dalam pemulasaraan
2. Aluran pelayanan kamar jenazah

Pelayanan Kamar Jenazah

Proses pemulasaraan jenazah dilakukan sesuai dengan kebijakan rumah sakit.

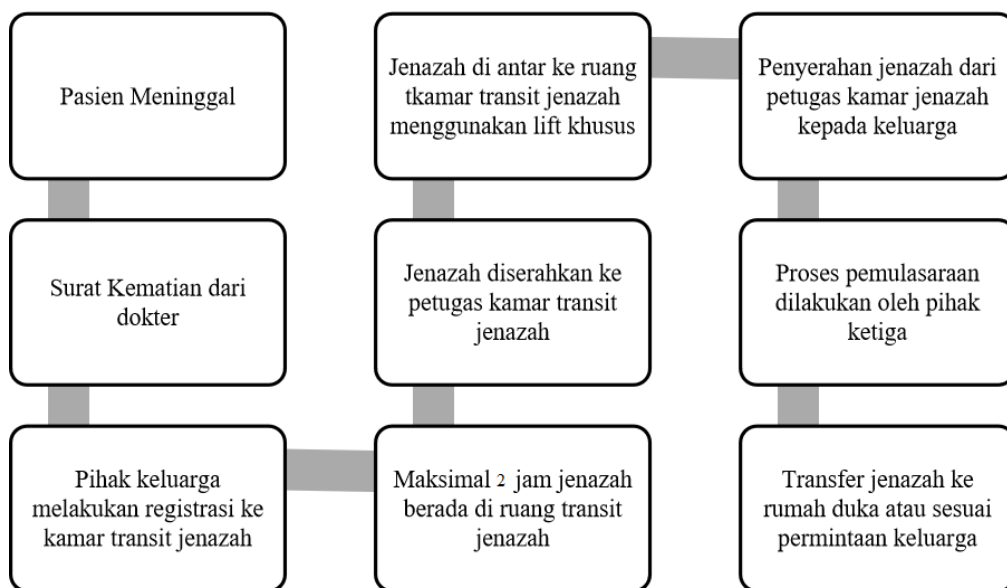
Menerapkan kewaspadaan isolasi di kamar jenazah.

1. Kebersihan tangan: pastikan kelengkapan fasilitas cuci tangan di unit
2. Penggunaan APD: *hair cap*, masker, pelindung mata/pelindung wajah, gaun/apron lengan panjang, *glove*, *boot*.
3. Pengendalian Lingkungan: dilakukan pembersihan rutin dan *general cleaning* yang terjadwal, menggunakan cairan disinfektan/ *chlorine*. Proses pembersihan mengikuti prosedur pembersihan lingkungan area resiko tinggi.
4. Pengelolaan limbah & benda tajam
5. Pengelolaan Linen
6. Perlindungan Kesehatan



Gambar 7. 15 APD lengkap

Alur Pelayanan Kamar Jenazah



Gambar 7. 16 alur pelayanan kamar jenazah

9. PPI di Unit Linen/Laundry

INDIKATOR HASIL BELAJAR :

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menerapkan PPI pada pengelolaan laundry dan linen.

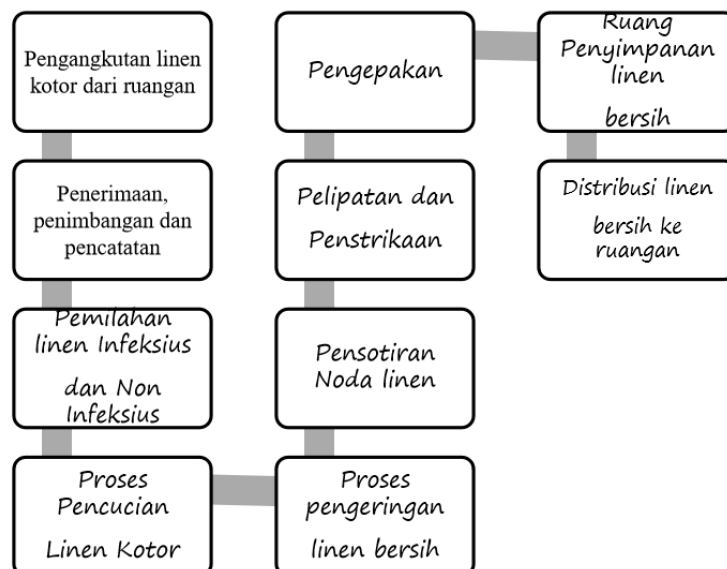
SUB POKOK MATERI:

1. Pengelolaan linen di rumah sakit
2. Pengelolaan linen kotor, linen infeksius, linen bersih

Hal-hal yang harus di perhatikan

- Linen non infeksius adalah linen yang tidak terkontaminasi oleh darah, cairan tubuh dan feses yang berasal dari pasien lainnya secara rutin, meskipun mungkin linen yang diklasifikasikan dari seluruh pasien berasal dari sumber ruang isolasi yang terinfeksi.
- Linen infeksius adalah linen yang terkontaminasi dengan darah, cairan tubuh dan feses.
- Linen dibedakan menjadi infeksius dimasukan kedalam plastik kuning dan non infeksius dimasukan kedalam plastik putih.
- Linen kotor tidak boleh diletakkan dalam posisi diluar wadah, harus masuk kedalam wadah tertutup.
- Petugas yang menangani linen kotor harus menggunakan APD lengkap, dan setiap menangani linen kotor harus melakukan kebersihan tangan.
- Linen kotor tidak boleh melebihi batas saat pengangkutan.
- Trolley* linen bersih dan kotor harus dibedakan, dan dibersihkan setiap habis pakai serta lakukan dokumentasi.
- Linen bersih harus diletakkan dalam lemari yang tertutup dan bebas debu serta dilakukan dokumentasi pencatatan suhu dan kelembaban ruang linen.
- Penyimpanan dan pengambilan linen berdasarkan sistem FIFO

Alur Pengelolaan Linen



Gambar 7. 17 alur pengelolaan linen

Transportasi Linen Kotor, Infeksius dan Linen Bersih

Transportasi menimbulkan potensial penyebaran organism jika linen kotor tidak tertutup dan bahan troli tidak mudah dibersihkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Pemisahan troli linen kotor, linen infeksius, dan linen bersih. Dipisahkan dengan warna yang berbeda
2. Bahan troli dari *stainless steel* (baja anti karat). Troli dapat dilapisi dengan bahan yang mudah dilepas dan mudah dibersihkan setiap saat habis difungsikan (siapkan cadangan), dan pembersihan troli didokumentasikan
3. Wadah mampu menampung beban linen
4. Saat pengangkutan muatan linen kotor/ infeksius / bersih tidak berlebihan.
5. Troli selalu tertutup saat transportasi.

APD Yang Perlu di Gunakan

Pakaian kerja dari bahan yang menyerap keringat, *Hair cap*, Masker (digunakan pada proses pemilihan dan sortir), Apron, *glove*, *boot* (digunakan pada area yang basah)

J. Latihan soal

1. Berapakah ukuran partikel percikan saluran pernapasan pada kewaspadaan transmisi droplet menurut teks tersebut?
A. < 1 mikron
B. < 5 mikron
C. > 5 mikron
D. > 10 mikron
E. 1 - 2 meter

Jawaban: C

2. Manakah di bawah ini yang merupakan komponen utama dalam penerapan kewaspadaan transmisi kontak?
A. Menggunakan masker N95 setiap saat
B. Penempatan pasien di ruang bertekanan negatif
C. Menjaga jarak minimal 2 meter dari pasien
D. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) berupa sarung tangan dan gaun bersih
E. Membatasi ventilasi udara di dalam kamar pasien

Jawaban: D

3. Apa yang dimaksud dengan strategi "kohorting" dalam penempatan pasien
- A. Memisahkan pasien di kamar isolasi mandiri
 - B. Mengelompokkan pasien dengan diagnosis yang sama dalam satu ruangan
 - C. Menempatkan pasien di Lorong rumah sakit agar mudah diawasi
 - D. Mencampur pasien infeksius dan non infeksius untuk efisiensi tempat
 - E. Mengizinkan keluarga pasien menjaga di dalam kamar tanpa APD

Jawaban : B

2. Bakteri apa yang disebutkan dalam teks sebagai indikasi penyakit kewaspadaan transmisi kontak
- A. Influenza
 - B. *Mycobacterium tuberculosis*
 - C. *Methicillin-resistant Staphylococcus aureus* (MRSA)
 - D. Virus SARS-CoV-2
 - E. Bakteri penyebab tipus

Jawaban : C

3. Berdasarkan jalur penularannya, terdapat tiga jenis kewaspadaan transmisi yaitu:
- A. Kontak, Droplet, dan udara (Airborne)
 - B. Kontak, Air, dan makanan
 - C. Standar, primer, dan sekunder
 - D. Fisik, kimia, dan Biologi
 - E. Langsung, tidak langsung, dan Lingkungan

Jawaban : A

4. Berdasarkan teks tersebut, manakah yang merupakan lapis kedua dari Strategi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
- A. Kewaspadaan standar
 - B. Kewaspadaan berdasarkan Transmisi
 - C. Dekontaminasi alat medis
 - D. Kebersihan lingkungan
 - E. Penggunaan APD lengkap

Jawaban : B

5. Penerapan kewaspadaan transmisi kontak diwajibkan bagi pasien yang terinfeksi bakteri yang kebal antibiotik yaitu:
- A. Norovirus
 - B. *Clostridioides difficile*
 - C. Scabies
 - D. Methicillin-resistant *Staphylococcus Aureus* (MRSA)
 - E. Droplet Airborne

Jawaban :D

6. Pada kewaspadaan transmisi droplet,percikan pernapasan biasanya tidak melayang jauh di udara.jarak maksimal jangkauan percikan tersebut adalah:
- A. Kurang dari 1 meter
 - B. Kurang dari 1-2 meter
 - C. Lebih dari 5 meter
 - D. Tepat 3 meter
 - E. Sejauh mata memandang

Jawaban : B

7. Dalam pengelolaan alat medis untuk pasien dengan kewaspadaan kontak jika alat (seperti stetoskop) harus di gunakan Bersama ,Tindakan apa yang wajib di lakukan sebelum di gunakan pasien lain?
- A. Di cuci dengan air mengalir saja
 - B. Dibuang dan di ganti baru
 - C. Dilakukan dekontaminasi atau desinfeksi
 - D. Dilap dengan kain kering
 - E. Di jemur di bawah sinar matahari

Jawaban : C

8. Apa yang dilakukan petugas medis terkait penggunaan APD (sarung tangan dan gaun) pada pasien dengan transmisi kontak?
- A. Digunakan seharian untuk semua pasien
 - B. Dilepaskan setelah keluar dari area perawatan
 - C. Dilepaskan sebelum keluar dari area perawatan
 - D. Boleh tidak digunakan jika pasien terlihat bersih
 - E. Digunakan hanya saat menyentuh luka terbuka saja

Jawaban: C

9. Teks,diagnosis CAUTI di tegakkan pada pasien yang menggunakan kateter urine minimal selama:
- A. > 12 jam
 - B. > 24 jam
 - C. > 48 jam
 - D. 3-5 hari
 - E. > 10 hari

Jawaban :C

10. Manakah dari faktor risiko berikut yang termasuk dalam kondisi penyerta (comorbid) yang memicu terjadinya infeksi pada pasien pemakai kateter?
- A. Hipertensi dan obesitas
 - B. Diabetes ,malnutrisi,dan renal insufficiency
 - C. Jenis kelamin laki-laki
 - D. Pemasangan kateter kurang dari 24 jam
 - E. Penggunaan kantong urin yang baru

Jawaban :B

11. Mengapa posisi Drainage (drainase) kateter yang lebih rendah dari kantong urin di anggap sebagai faktor risiko?
- A. Karena urine akan mengalir terlalu cepat
 - B. Karena memudahkan pergerakan pasien
 - C. Karena beresiko menyebabkan aliran balik (reflux) urine yang terkontaminasi ke kandung kemih
 - D. Karena kantong urine akan cepat penuh
 - E. Karena merusak selang kateter

Jawaban: C

12. Bakteri apa yang sering menjadi penyebab kontaminasi pada Wanita dengan kondisi inkontinensia fekal:
- A. Staphylococcus aureus
 - B. Escherichia coli
 - C. Salmonella typhi
 - D. Mycobacterium
 - E. Candida albicans

Jawaban :B

13. Apa acuan utama dalam penegakan diagnose infeksi pada pasien dengan pemasangan kateter jangka Panjang menurut teks tersebut:
- A. Hasil tes laboratorium urine saja
 - B. Melihat tanda klinis pasien
 - C. Lamanya pasien menginap di rumah sakit
 - D. Jumlah urine yang keluar dalam kantong
 - E. Jenis merk kateter yang di gunakan

Jawaban: B

14. Berapa lama batas waktu minimal pemasangan ventilasi mekanik(pipa endotracheal)hingga dapat di kategorikan sebagai Ventilator-Associated pneumonia(VAP)?

- A. 12 jam
- B. 24 jam
- C. 48 jam
- D. 30 hari
- E. 90 hari

Jawaban: C

15. Pada infeksi surgical site infection (SSI) yang melibatkan prostetik implant,masa pemantauan infeksi dapat berlangsung hingga :

- A. 7 hari
- B. 14 hari
- C. 30 hari
- D. 48 jam
- E. 90 hari

Jawaban: E

16. Manakah yang bukan merupakan gejala klinis ISK pada anak di bawah usia 1 tahun menurut teks tersebut?

- A. Hipotermi (<37 derajat/rektal)
- B. Apnea
- C. Muntah
- D. Urgensi
- E. Bradikardia

Jawaban :D

17. Kriteria diagnostic ISK/CAUTI berdasarkan hasil biakan kuman menunjukan jumlah kuman sebesar:

- A. >cfu/ml
- B. 1 Cfu/ml
- C. > cfu/ml
- D. <Cfu/ml
- E. 0 cfu/ml

Jawaban : C

18. Apa yang dimaksud dengan IADP dalam konteks infeksi rumah sakit

- A. Infeksi akibat luka bakar
- B. Infeksi aliran darah primer
- C. Infeksi akibat alat bantu nafas
- D. Infeksi pada saluran pencernaan
- E. Infeksi pasca operasi besar

Jawaban : B

K. RANGKUMAN

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)

1. Latar Belakang: Bahaya HAIs

- HAIs (Healthcare-Associated Infections) adalah infeksi yang terjadi di fasilitas pelayanan Kesehatan. ini merupakan risiko yang tidak dapat dihindari dalam proses pemberian asuhan medis.
- Dampak Global : HAIs meningkatkan angka kesakitan (Morbiditas) angka kematian (mortalitas),serta menyebabkan pembengkakan biaya perawatan bagi pasien maupun rumah sakit
- Peran PPI: program pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) adalah garda terdepan dalam menjaga keselamatan pasien,petugas,dan pengunjung melalui komitmen klinis dan manajemen yang tepat.

2. Konsep kewaspadaan Standar (Standar Precautions)

- Merupakan komponen paling Fundamental dalam strategi PPI
- Prinsip utama : semua darah,cairan tubuh,sekresi,ekskresi (kecuali keringat),kulit yang tidak utuh,dan selaput lender dianggap mengandung agen infeksius.
- Penerapan standar ini harus di terapkan secara konsisten kepada seluruh pasien,tanpa memandang diagnosa penyakit atau status infeksi

3. Masalah utama dilapangan

- Terdapat kesenjangan antara kebijakan tertulis dengan implementasi nyata
- Celah transmisi kuman di sebabkan oleh kurangnya pemahaman Teknik dekontaminasi,ketidakkonsistenen dalam kebersihan tangan (handHygiene),serta penggunaan alat pelindung diri(APD) yang tidak tepat
- Dengan memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep dasar dan prinsip PPI menjabarkan rincian komponen kewaspadaan standar agar dapat diaplikasikan dengan benar oleh tenaga Kesehatan guna menjembatani antar teori dan praktek.

GLOSARIUM

- APD (Alat Pelindung Diri) perangkat alat yang di rancang untuk melindungi pemakainya dari pemakai dari bahaya Kesehatan atau keselamatan di tempat kerja
- Airborne (Udara): mekanisme penyebaran penyakit melalui partikel kecil (inti droplet) yang tetap melayang di udara dalam waktu lama
- Droplet (percikan): partikel cairan pernapasan berukuran besar (>5 mikron) yang di keluarkan saat batuk, bersin atau bicara.
- Dekontaminasi: proses pembuangan pencemar (mikroorganisme) dari benda mati sehingga aman untuk di tangani.
- Kohorting: penempatan pasien yang terinfeksi oleh pathogen yang sama di dalam satu ruangan yang sama
- MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus): jenis bakteri stafilokokus yang kebal terhadap beberapa jenis antibiotik.
- PPI (Pencegahan Pengendalian Infeksi) upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung dan masyarakat sekitar fasilitas Kesehatan
- Transmisi : proses penularan atau penyebaran penyakit dari satu orang ke orang lain
- CAUTI (*Catheter-associated Urinary Tract Infection*): infeksi saluran kemih yang terjadi akibat penggunaan kateter urine dalam jangka waktu tertentu
- E.Coli (*Escherichia coli*): jenis bakteri yang biasanya di temukan di usus besar manusia; merupakan penyebab umum infeksi saluran kemih jika berpindah ke saluran kemih
- HAIs (*Healthcare Associated Infections*): infeksi yang di dapatkan pasien selama mendapatkan perawatan medis di fasilitas pelayanan Kesehatan
- Inkontinensia fekal: kondisi hilangnya control otot anus yang menyebabkan buang air besar tidak terkendali (beresiko mengkontaminasi kateter)
- ISK (Infeksi Saluran Kemih): kondisi Ketika sistem kemih (ginjal, kandung kemih, atau uretra) mengalami infeksi akibat mikroorganisme.
- *Renal Insfficiency*: penurunan fungsi ginjal dimana ginjal tidak mampu lagi menyaring limbah sisa metabolisme dari darah dengan baik.
- Sirkuit kateter: Rangkaian sistem selang dan kantong penampung urine yang seharusnya tertutup rapat untuk mencegah kuman masuk
- *Urine Output*: Volume atau jumlah cairan urine yang dikeluarkan oleh pasien dalam jangka waktu tertentu.
- High-Touch Surfaces: permukaan benda yang sangat sering di sentuh tangan, seperti pagar tempat tidur atau meja samping
- Apnea: hentinya Nafas sementara untuk beberapa saat
- BSI (Blood Stream Infection): Infeksi yang terjadi Ketika bakteri atau jamur masuk kedalam aliran darah
- Cfu/ml (*Colony Forming Units per milliliter*): unit yang digunakan untuk memperkirakan jumlah sel bakteri atau jamur yang layak dalam sampel cairan

- CABS(*Central Line-associated Bloodstream Infection*): Infeksi aliran darah primer yang terjadi akibat pemasangan kateter vena sentral
- IADP(Infeksi Aliran Darah Primer): istilah Bahasa Indonesia untuk CLABSI; infeksi yang di temukan di darah tanpa ada sumber infeksi di bagian tubuh lain
- SSI (*Surgical Site Infection*): Infeksi yang terjadi pada lokasi sayatan setelah prosedur pembedahan
- VAP(*Ventilator-Associated Pneumonia*): Infeksi paru-paru (Pneumonia) yang terjadi pada pasien yang menggunakan alat bantu napas mekanik (Ventilator)

Referensi

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- World Health Organization. (2021). *Infection prevention and control during health care when coronavirus disease (COVID-19) is suspected or confirmed: Interim guidance*. Geneva: World Health Organization.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan*. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- World Health Organization. (2020). *Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected: Interim guidance*. World Health Organization.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2009). *Guideline for prevention of catheter-associated urinary tract infections*. Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC).
- Centers for Disease Control and Prevention. (2023). *Identifying Healthcare-associated Infections (HAI) for NHSN surveillance*. U.S. Department of Health & Human Services.
- Horan, T. C., Andrus, M., & Dudeck, M. A. (2008). CDC/NHSN surveillance definition of health care–associated infection and criteria for specific types of infections in the acute care setting. *American Journal of Infection Control*, 36(5), 309-332.

Profil Penulis



Tioma Naibaho.S.Kep.,Ns.,M.Kep

lahir di taput 14 juni,1965. Pendidikan tionggi yang telah di tempuh oleh penulis yaitu S 1 pada program studi keperawatan dan Ners di stikes Kesosi Jakarta pada tahun 2013 kemudian melanjutkan Pendidikan S2 ,KMB pada Stikes Carolus dan lulus pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1985-1990 di RS PGI Tjiki sebagai perawat pelaksana di bagian kamar bedah, dan pada tahun 1990 – sampai saat ini di RS Kramat 128 Jakarta sebagai ketua komite keperawatan dan juga sebagai dosen tetap di Akademi Keperawatan Peln mengampu mata kuliah KMB,KDK,dan promosi Kesehatan serta manajemen safety, penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi yaitu sebagai penulis buku,publikasi,seminar sebagai pembicara nasional dan internasional dan sebagai entrepreneur ,praktek mandiri di wilayah Jakarta Barat CEO Tie Hena Wound Care dan sebagai konsultan keperawatan di bidang wound,stoma incontinence Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:tioma1406@gmail.

Motto: “berbuat hal kecil untuk cinta besar”



Dwi Susilowati, APPd., M.Kes

Penulis dilahirkan di Bandung, bulan Juli Tahun 1970. Ketertarikan penulis terhadap ilmu kesehatan, khususnya keperawatan atau kesehatan tentang anak dan remaja dimulai sejak tahun 1998 silam. Penulis berlatar Belakang Pendidikan D3 Keperawatan Depkes di Jl.dr.Otten Bandung (1989-1992), selanjutnya pimpinan di tempat penulis bekerja (Tahun 1994 berubah dari SPK-SJ menjadi Akper Depkes Bogor) memberi kesempatan untuk mengikuti Tugas Belajar di Program Studi D4 Perawat Pendidik – FK UGM Yogyakarta, dengan peminatan Keperawatan Anak (1998-1999), kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Pasca Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat – Universitas Indonesia dan berhasil menyelesaikan studi S2 di jurusan Kesehatan Reproduksi – FKM UI pada tahun 2002. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Program Studi Keperawatan Bogor – Poltekkes Kemenkes Bandung (Perubahan dari Akper Depkes Bogor sejak tahun 2001). Sehari-harinya aktif menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan mengajar sebagai dosen pengampu MK. Konsep Keperawatan, Praktik Keperawatan Dasar, Manajemen Patient Safety, Keperawatan Anak, Metodologi& Dokumentasi Keperawatan serta Promosi Kesehatan; Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pun penulis jalankan. Penulis aktif dalam kegiatan ilmiah dan organisasi keprofesian PPNI dan IAKMI Kota Bogor. Kegiatan menulis yang pernah dihasilkan oleh penulis berupa **Modul Pembelajaran Jarak**

Jauh tentang Promosi Kesehatan (Kerjasama Kemenkes RI dan UT), sebuah **Buku Monograf** terkait Kecemasan pada Remaja. Terlibat dalam tim penulisan **Buku Ajar** (dalam **5 buah judul buku**). Penulis pernah mengambil bagian juga dalam penulisan beberapa **Book Chapter (3 judul)** dan **Buku Referensi (3 judul)**. Pernah terbit juga sebuah **artikel ilmiah kesehatan** di surat kabar lokal.

Email Penulis: dwi@staff.poltekkesbandung.ac.id

Profil Penulis



Ns. Prima Trisna Aji, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB

Lahir di Surakarta pada 22 Maret 1987. Menempuh pendidikan D3 Keperawatan di Akper Panti Kosala Surakarta (lulus 2007), S1 Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Surakarta (2009), Profesi Ners di institusi yang sama (2011), S2 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2017), serta Spesialis Keperawatan Medikal Bedah (KMB) dengan peminatan jantung dan pembuluh darah di Universitas Muhammadiyah Jakarta (2022). Saat ini sedang menempuh studi S3 (PhD in Nursing) di Lincoln College University Malaysia. Memiliki pengalaman kerja sebagai tenaga kesehatan di Rumah Sakit Khusus Bedah Diponegoro Klaten (2008) dan Rumah Sakit Cakra Husada Klaten (2010). Karier akademik dimulai sebagai dosen di Akper Mambaul Ulum Surakarta (2012), kemudian menjabat sebagai Kepala BAAK di STIKES Mambaul Ulum (2014), serta mengajar di berbagai institusi seperti Universitas Kusuma Husada Surakarta, Poltekkes Kemenkes Surakarta, Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan saat ini sebagai dosen Program Studi Spesialis Medikal Bedah di Universitas Muhammadiyah Semarang. Aktif sebagai pembicara seminar nasional (2015–2019), kuliah pakar, serta pernah menjadi pembicara internasional di Guangxi Medical University, China (2016). Prestasi yang diraih antara lain Juara 1 Opini Terbaik Solo Raya (2022), volunteer ASEAN Para Games (2022), berbagai juara lomba video pertolongan pertama, juara lomba artikel ilmiah nasional, Best Paper Presenter pada seminar internasional di Malaysia (2025), serta Juara Penulis Terbaik Nasional Astero Indonesia (2026). Penulis juga aktif menghasilkan berbagai karya ilmiah seperti book chapter, buku ajar, buku referensi, monograf, dan publikasi lainnya di tingkat nasional maupun internasional. Email Penulis: primatrisnaaji@unimus.ac.id achmdfsl@contoh.com Motto: "Living your life well"



Ns. Yohanes Zenriano Tarigan S.Kep., M.Kep lahir di Jakarta, 07 Februari 1995. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Sumatera Utara dan lulus tahun 2016, jenjang profesi Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Sumatera Utara dan lulus tahun 2017 dan melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Manajemen Keperawatan di Universitas Padjadjaran dan lulus tahun 2023. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Universitas Kristen Indonesia dengan mengampu

mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan, Kepemimpinan Manajemen Keperawatan, Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis, Komunikasi Dasar Keperawatan, dsb. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, oral presentasi dalam seminar nasional maupun internasional, pengabdian kepada masyarakat dan tentunya mendidik mahasiswa keperawatan agar dapat menjadi mahasiswa yang memiliki karakter dan pengetahuan sesuai dengan nilai profesi yang berlaku. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yohanes.tarigan@uki.ac.id

Motto: "A Cheerful Heart Is Good Medicine, But A Crushed Spirit Dries Up The Bones"

- Proverbs 17:22

Profil Penulis



Ns. Gita Adelia, M.Kep

Merupakan dosen dan peneliti di Fakultas Keperawatan Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru. Menyelesaikan pendidikan S1 Keperawatan dan Profesi Ners di Fakultas Keperawatan Universitas Riau, kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan pada Program Studi Magister Keperawatan di Universitas Sumatera Utara. Bidang keahliannya meliputi keperawatan dasar, pendidikan keperawatan, berpikir kritis, nilai profesional, serta pengembangan model primary nursing.

Dalam kegiatan akademik dan profesional, aktif melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta publikasi ilmiah. Fokus penelitian mencakup pengembangan kemampuan berpikir kritis mahasiswa keperawatan, penerapan model primary nursing, dan nilai profesional dalam pendidikan keperawatan. Beberapa hasil penelitiannya telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional serta dipresentasikan dalam forum ilmiah. Selain itu, juga terlibat dalam kegiatan penelaahan artikel ilmiah sebagai reviewer jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat

Motto: "Terus belajar, berkarya, dan mengabdikan untuk menciptakan perubahan yang berdampak dan berkelanjutan."



Ria Tri Harini Dwi Rusiawati, S.ST., M.Pd.

Lahir di Merauke, 25 Februari 1968. Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah pendidikan S2 Manajemen Pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha, periode September 2007 sampai Juli 2009. Saat ini penulis bertugas sebagai dosen pada Program Studi Sarjana Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Mata kuliah yang penulisampu adalah Komunikasi Keperawatan, Komunikasi Terapeutik Keperawatan, Farmakologi,

Keperawatan Anak Sehat-Sakit, Sosial dan Budaya dalam Keperawatan, Nursing Entrepreneurship, dan beberapa mata kuliah lain. Penulis aktif melaksanakan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi, sebagai penulis buku, publikasi artikel. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : riabasuki1214@gmail.com

Profil Penulis



Ns.Vera Sesrianty, M.Kep

Lahir di Duri, 2 November 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu Pendidikan Diploma pada Akademi Keperawatan Perintis Bukittinggi lulus tahun 2000, Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Andalas Padang lulus tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Magister Keperawatan Peminatan manajemen Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Andalas dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali Karir pekerjaan bermula sebagai perawat Honorer di RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi (2000-2001), sebagai Dosen di Akper Nabila Padang Panjang (2005-2009). Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Universitas Perintis Indonesia (2009 sekarang). Penulis mengampu pada mata kuliah seperti Manajemen Keperawatan, Manajemen Patient Safety, Keperawatan Dasar, Metodologi Keperawatan, dan mata kuliah lainnya. Mendapatkan hibah penelitian dari Kemenristekdikti dan aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: verasesrianty@gmail.com
Motto: "Belajar Bersabar, Ikhlas dan Tangguh"

Sinopsis

Buku Ajar Keperawatan Dasar ini disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami landasan utama praktik keperawatan profesional. Materi dalam buku ini dirancang secara sistematis untuk membantu mahasiswa mengenal konsep dasar keperawatan, memahami kebutuhan dasar manusia, menerapkan proses keperawatan, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam pengambilan keputusan klinis.

Pembahasan diawali dengan pengantar keperawatan dasar dan profesionalisme perawat yang menjelaskan peran, fungsi, tanggung jawab, serta nilai-nilai profesional dalam praktik keperawatan. Selanjutnya, buku ini menguraikan konsep sehat-sakit, homeostasis, dan kebutuhan dasar manusia sebagai dasar dalam memahami kondisi klien secara holistik, baik dari aspek biologis, psikologis, sosial, maupun spiritual.

Buku ini juga membahas proses keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Melalui pembahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami alur berpikir sistematis dalam memberikan asuhan keperawatan yang tepat, terarah, dan berbasis kebutuhan klien. Selain itu, materi tentang berpikir kritis, *clinical reasoning*, dan pengambilan keputusan keperawatan disajikan untuk memperkuat kemampuan mahasiswa dalam menganalisis masalah keperawatan secara rasional dan bertanggung jawab.

Aspek komunikasi terapeutik dan hubungan perawat-klien turut menjadi bagian penting dalam buku ini, mengingat keberhasilan asuhan keperawatan sangat dipengaruhi oleh kemampuan perawat dalam membangun hubungan profesional, empatik, dan efektif dengan klien. Buku ini juga menekankan pentingnya pemahaman etik, hukum, dan keselamatan pasien sebagai landasan dalam menjalankan praktik keperawatan yang aman, bermutu, dan sesuai standar profesi.

Pada bagian akhir, buku ini membahas pencegahan dan pengendalian infeksi serta kewaspadaan standar sebagai kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh setiap calon perawat. Materi ini memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keselamatan klien, tenaga kesehatan, dan lingkungan pelayanan melalui penerapan prinsip kebersihan, perlindungan diri, serta pencegahan penularan infeksi.

Secara keseluruhan, Buku Ajar Keperawatan Dasar ini diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran yang membantu mahasiswa membangun fondasi pengetahuan, sikap profesional, dan keterampilan dasar dalam praktik keperawatan. Buku ini juga dapat digunakan oleh dosen dan praktisi keperawatan sebagai bahan ajar, sumber diskusi, serta panduan dalam mengembangkan pembelajaran keperawatan dasar yang aplikatif, humanis, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami dasar-dasar keperawatan komunitas, keluarga, serta penerapannya dalam pelayanan kesehatan masyarakat di layanan primer. Buku ini menghadirkan pembahasan yang sistematis, mulai dari konsep dasar, pengkajian, proses keperawatan, intervensi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, hingga manajemen program kesehatan masyarakat. Materi disajikan secara terstruktur agar pembaca mampu memahami keterkaitan antara teori keperawatan, kebutuhan kesehatan keluarga dan komunitas, serta praktik pelayanan kesehatan yang berorientasi pada promotif dan preventif.

Pembahasan diawali dengan konsep dasar keperawatan komunitas dan keluarga yang menjadi landasan penting dalam memahami peran perawat di tengah masyarakat. Selanjutnya, buku ini menguraikan pengkajian komunitas melalui pengumpulan data, pemetaan masalah, serta penetapan diagnosis komunitas sebagai dasar dalam menyusun rencana keperawatan. Pada bagian berikutnya, pembaca diperkenalkan dengan proses keperawatan keluarga yang mencakup pengkajian, perumusan masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi asuhan keperawatan keluarga secara komprehensif.

Buku ini juga membahas intervensi keperawatan keluarga berbasis masalah yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan, sosial, budaya, dan lingkungan keluarga. Selain itu, materi mengenai promosi kesehatan dan perubahan perilaku disajikan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa tentang pentingnya edukasi kesehatan, komunikasi efektif, serta strategi perubahan perilaku dalam meningkatkan derajat kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Pembahasan tentang pemberdayaan masyarakat dan kemitraan turut memperkaya wawasan pembaca mengenai pentingnya partisipasi aktif masyarakat, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan sumber daya lokal dalam menyelesaikan masalah kesehatan.

Pada bagian akhir, buku ini menguraikan manajemen program kesehatan masyarakat di layanan primer, termasuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program kesehatan. Materi ini diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami bagaimana program kesehatan masyarakat dirancang dan dijalankan secara efektif berdasarkan kebutuhan komunitas. Dengan cakupan materi yang menyeluruh, buku ajar ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga membekali mahasiswa dengan cara berpikir kritis, analitis, dan aplikatif dalam menghadapi permasalahan kesehatan keluarga dan komunitas.

Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan, dosen, praktisi kesehatan, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap pengembangan pelayanan keperawatan keluarga dan komunitas. Melalui buku ini, pembaca diharapkan mampu memahami peran strategis perawat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan yang holistik, partisipatif, berbasis masalah, dan berorientasi pada kebutuhan kesehatan masyarakat.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-90-9 (PDF)



9

786347

756909